Optimal Untuk Negeri

Optimal

Buku Ajar

KOMPLIKASI KEHAMILAN

HIPERTENSI, PERDARAHAN, INFEKSI, DAN ANEMIA

Imelda Diana Marsilia • Hikma • Yulia Fatma Nasution
Rya Anastasya Siregar • Ika Lestari Salim

Editor: Prof. Dr. Mufdlilah, S.SIT., M.Sc.



BUKU AJAR:
KOMPLIKASI KEHAMILAN: HIPERTENSI, PERDARAHAN, INFEKSI, DAN ANEMIA

Penulis:
Bdn. Imelda Diana Marsilia, SST., SKM., M.Keb.
Hikma, S.ST., M.Kes.
Bdn. Yulia Fatma Nasution, S.ST., M.Keb.
Rya Anastasya Siregar, SST., M.Kes.
Ika Lestari Salim, S.ST., M.Keb.

Editor:
Prof. Dr. Mufdlilah, S.SIT., M.Sc.

Optimal Untuk Negeri

Buku Ajar: Komplikasi Kehamilan: Hipertensi, Perdarahan, Infeksi, dan Anemia

Penulis:
Bdn. Imelda Diana Marsilia, SST., SKM., M.Keb.
Hikma, S.ST., M.Kes.
Bdn. Yulia Fatma Nasution, S.ST., M.Keb.
Rya Anastasya Siregar, SST., M.Kes.
Ika Lestari Salim, S.ST., M.Keb.

Editor:
Prof. Dr. Mufdlilah, S.SIT., M.Sc.

Desain Sampul: Ivan Zumarano
Penata Letak: Helmi Syaukani, S.Pd.

ISBN: 978-634-7927-95-8

Cetakan Pertama: Oktober, 2026
Hak Cipta 2026
Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
Copyright © 2026
by Penerbit PT Optimal Untuk Negeri
All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.
Website : optimaluntuknegeri.com
Instagram : @bimbel.optimal
Tiktok : @maskokooo

PENERBIT:
PT OPTIMAL UNTUK NEGERI
Kencana Tower Lt. Mezzanine
Jl. Raya Meruya Ilir No. 88
RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta
Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, buku *Komplikasi Kehamilan: Hipertensi, Perdarahan, Infeksi, dan Anemia* ini dapat disusun dengan baik. Buku ini hadir sebagai salah satu sumber bacaan yang diharapkan mampu memberikan pemahaman komprehensif mengenai berbagai komplikasi yang dapat terjadi selama kehamilan, khususnya yang berkaitan dengan hipertensi, perdarahan, infeksi, dan anemia.

Kehamilan merupakan proses fisiologis yang membutuhkan perhatian dan pemantauan secara berkelanjutan. Namun, dalam kondisi tertentu, kehamilan dapat disertai komplikasi yang berisiko terhadap keselamatan ibu maupun janin. Oleh karena itu, tenaga kesehatan, khususnya bidan dan mahasiswa kebidanan, perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam melakukan deteksi dini, pencegahan, penanganan awal, serta rujukan yang tepat sesuai dengan kondisi ibu hamil.

Buku ini membahas berbagai materi penting, mulai dari konsep dasar komplikasi kehamilan, deteksi dini, pencegahan, dan keselamatan ibu serta janin. Selain itu, buku ini juga menguraikan pengkajian ibu hamil dengan komplikasi melalui anamnesis terfokus, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang yang diperlukan. Pembahasan mengenai gangguan hipertensi dalam kehamilan disajikan mencakup definisi, kriteria diagnostik, serta pemantauan kondisi ibu dan janin.

Materi lain yang turut dibahas dalam buku ini adalah perdarahan pada trimester I, meliputi abortus, kehamilan ektopik, dan mola hidatidosa, serta penanganan awal dan rujukan yang sesuai. Buku ini juga mengulas perdarahan pada trimester II–III, seperti plasenta previa dan solusio plasenta, yang merupakan kondisi kegawatdaruratan obstetri dan memerlukan pengenalan gejala secara cepat serta tindakan yang tepat.

Penyusunan buku ini diharapkan dapat membantu pembaca memahami prinsip-prinsip dasar dalam mengenali tanda bahaya kehamilan, melakukan pengkajian secara sistematis, serta menentukan langkah penatalaksanaan awal yang aman sebelum dilakukan rujukan. Dengan demikian, buku ini tidak hanya berorientasi pada penguasaan teori, tetapi juga mendorong penerapan pengetahuan dalam praktik pelayanan kebidanan yang berkualitas, berpusat pada keselamatan pasien, dan sesuai dengan kebutuhan ibu serta janin.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan isi buku pada edisi berikutnya. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa, dosen, praktisi kebidanan, tenaga kesehatan, serta seluruh pihak yang memiliki perhatian terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Juli 2026
Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **iv**

BAB 1 KONSEP DASAR KOMPLIKASI KEHAMILAN DETEKSI DINI, PENCEGAHAN, DAN KESELAMATAN IBU DAN JANIN **1**
A. Komplikasi Kehamilan 2
B. Komplikasi Hipertensi Kehamilan (Preeklampsia/Eklampsia) 2
C. Perdarahan 7
D. Anemia 8
E. Detekni Dini Komplikasi Kehamilan 10
F. Keselamatan Ibu Janin Komplikasi Kehamilan 11
G. Referensi 13

BAB 2 PENGKAJIAN IBU HAMIL DENGAN KOMPLIKASI: ANAMNESIS TERFOKUS, PEMERIKSAAN FISIK DAN PEMERIKSAAN **14**
A. Defenisi 16
B. Tujuan 17
C. Indikasi 17
D. Kontra Indikasi 18
E. Alat dan Bahan 18
F. Persiapan 19
G. Langkah Langkah Tindakan / Prosedur 19
H. Keselamatan/*Patient Safety* 28
I. Evaluasi Hasil 28
J. Dokumentasi 29
K. *Mini Case (Knows How)* 30
L. Ringkasan Bab 47
M. Red Flag 47
N. Form Checklist 48
O. Daftar Pustaka 49

BAB 3 GANGGUAN HIPERTENSI KEHAMILAN: DEFINISI, KRITERIA DIAGNOSTIK, DAN PEMANTAUAN **51**
A. Pre-eklampsia dan Eklampsia 62
B. Hipertensi Kronis pada Kehamilan 66
C. Hipertensi kronis yang disertai pre-eklampsia 67

D. Hipertensi gestasional 68
E. Aktivitas 1 (*Knows How)* 71
Gangguan Hipertensi dalam Kehamilan: Definisi, Kriteria Diagnostik, dan Pemantauan 85
F. Ringkasan Materi 87
G. Alur asuhan singkat 88
H. Tabel Red Flags & Eskalasi 88
I. Referensi 90

BAB 4 PERDARAHAN TRIMESTER I: ABORTUS, KEHAMILAN EKTOPIK, DAN MOLA PENANGANAN AWAL DAN RUJUKAN 91
A. Pengertian Perdarahan 101
B. Abortus 101
C. Kehamilan Ektopik 112
D. Mola Hidatidosa 115
E. Sistem Rujukan 121
F. Aktivitas 1 (*Knows How)* 122
G. Ringkasan Materi 137
H. Alur asuhan singkat 138
I. Tabel Red Flags & Eskalasi 138
J. Daftar pustaka 140

BAB 5 PERDARAHAN TRIMESTER II–III: PLASENTA PREVIA DAN SOLUSIO PLASENTA PENANGANAN AWAL DAN RUJUKAN 141
A. Plasenta Previa 150
B. Solutio Plasenta 167
C. Aktivitas 1 (*Knows How)* 186
D. Ringkasan Materi 203
E. Alur asuhan singkat 204
F. Tabel Red Flags & Eskalasi 204
G. Referensi 206

PROFIL PENULIS 207

BAB 1

KONSEP DASAR KOMPLIKASI KEHAMILAN DETEKSI DINI, PENCEGAHAN, DAN KESELAMATAN IBU DAN JANIN

CPL

CPL 1: Menunjukkan profesionalisme, etika, dan tanggung jawab legal dalam pelayanan ibu hamil dengan komplikasi.

CPMK

CPMK 1: Menganalisis konsep dasar komplikasi kehamilan (hipertensi, perdarahan, infeksi, anemia) untuk deteksi dini, pencegahan, dan keselamatan ibu dan janin sesuai pedoman.

Uraian Materi

A. Komplikasi Kehamilan

Pengertian

Komplikasi kehamilan adalah kondisi patologis yang terjadi selama kehamilan, persalinan, atau nifas yang dapat meningkatkan morbiditas dan mortalitas ibu serta bayi. Komplikasi ini merupakan penyebab utama kematian ibu di dunia, seperti perdarahan, hipertensi, infeksi, dan komplikasi persalinan.

B. Komplikasi Hipertensi Kehamilan (Preeklampsia/Eklampsia)

Kondisi ibu yang disebabkan oleh kehamilan disebut dengan keracunan kehamilan, dengan tanda-tanda oedeme (pembengkakan) terutama tampak pada tungkai dan muka., tekanan darah tinggi, dan dalam air seni terdapat zat putih telur pada pemeriksaan urine dari laboratorium (Rochjati, 2003).

Kematian karena eklampsia meningkat dengan tajam dibandingkan pada tingkat pre-eklampsia berat (Manuaba, 1998).

1. Pengertian

   Hipertensi merupakan salah satu masalah medis yang sering kali muncul selama kehamilan dan dapat menimbulkan komplikasi pada 2-3% kehamilan.

   Kehamilan dengan hipertensi yaitu tekanan darah yang lebih tinggi dari 140/90 mmHg yang disebabkan karena kehamuilan itu sendiri, memiliki potensi yang menyebabkan gangguan serius pada kehamilan.

2. Etiologi

   Hipertensi berdasarkan penyebabnya dibagi menjadi 2 jenis:

   a. Hipertensi primer atau esensial adalah hipertensi yang tidak / belum diketahui penyebabnya (terdapat pada kurang lebih 90 % dari seluruh hipertensi).
   b. Hipertensi sekunder adalah hipertensi yang disebabkan/ sebagai akibat dari adanya penyakit lain.

   Hipertensi primer kemungkinan memiliki banyak penyebab; beberapa perubahan pada jantung dan pembuluh darah kemungkinan bersama-sama menyebabkan meningkatnya tekanan darah.Jika penyebabnya diketahui, maka disebut hipertensi sekunder.Pada sekitar 5-10% penderita hipertensi, penyebabnya adalah penyakit ginjal.Pada sekitar 1-2%, penyebabnya adalah kelainan hormonal atau pemakaian obat tertentu (misalnya pil KB).

   Penyebab hipertensi lainnya yang jarang adalah feokromositoma, yaitu tumor pada kelenjar adrenal yang menghasilkan hormon epinefrin (adrenalin) atau norepinefrin (noradrenalin). Kegemukan (obesitas), gaya hidup yang tidak aktif (malas berolah raga), stres, alkohol atau garam dalam makanan; bisa memicu terjadinya hipertensi pada orang-orang memiliki kepekaan yang

diturunkan. Stres cenderung menyebabkan kenaikan tekanan darah untuk sementara waktu, jika stres telah berlalu, maka tekanan darah biasanya akan kembali normal.

3. Gejala dan tanda
   a. Tekanan darah diastolik merupakan indikator dalam penanganan hipertensi dalam kehamilan oleh karenan tekanan diastolik mengukur tekanan perifer dan tidak tergantung keadaan emosional pasien.
   b. Diagnosis hipertensi dibuat jika tekanan darah diastoli 90 mmHg pada dua pengukuran berjarak 1 jam atau kebih.
   c. Hipertensi dalam kehamilan dapat dibagi dalam :
      1) Hipertensi karena kehamilan, jika hipertensi terjadi pertama kali sesudah kehamilan 20 minggu, selama persalinan, dan/atau dalam 48 jam pasca persalinan.
      2) Hipertensi kronik, jika hipertensi terjadi sebelum kehamilan 20 minggu.
4. Patofisiologi

   Selama kehamilan normal terdapat perubahan-perubahan dalam sistem kardiovaskuler, renal dan endokrin. Perubahan ini akan berbeda dengan respons patologi yang timbul pada HDK. Pada kehamilan trimester kedua akan terjadi perubahan tekanan darah, yaitu penurunan tekanan sistolik rata-rata 5 mmHg dan tekanan darah diastolik 10 mmHg, yang selanjutnya meningkat kembali dan mencapai tekanan darah normal pada usia kehamilan trimester ketiga.

   Selama persalinan tekanan darah meningkat, hal ini terjadi karena respon terhadap rasa sakit dan karena meningkatnya beban awal akibat ekspulsi darah pada kontraksi uterus. Tekanan darah juga meningkat 4-5 hari postpartum dengan peningkatan rata-rata adalah sistolik 6 mmHg dan diastolik 4 mmHg. Pada keadaan istirahat, curah jantung meningkat 40% dalam kehamilan. Perubahan tersebut mulai terjadi pada kehamilan 8 minggu dan mencapai puncak pada usia kehamilan 20-30 minggu. Tahanan perifer menurun pada usia kehamilan trimester pertama. Keadaan ini disebabkan oleh meningkatnya aktifitas sistem renin – angiotensin aldosteron dan juga sistem saraf simpatis.

   Penurunan tahanan perifer total disebabkan oleh menurunnya tonus otot polos pembuluh darah. Volume darah yang beredar juga meningkat 40%, peningkatan ini melebihi jumlah sel darah merah, sehingga hemoglobin dan viskositas darah menurun. Terjadi penurunan tekanan osmotik plasma darah yang menyebabkan peningkatan cairan ekstraseluler, sehingga timbul edema perifer yang biasa timbul pada kehamilan normal.
5. Klasifikasi Diagnosis

Gangguan hipertensi kehamilan meliputi hipertensi yang diinduksi kehamilan dan hipertensi kronik (peningkatan tekanan darah sebelum 20 minggu gestasi).Sakit kepala, pandangan kabur, konvulsi dan penurunan kesadaran seringkali dikaitkan dengan hipertensi dalam kehamilan, tetapi gejala tersebut tidak selalu spesifik menjadi gejala hipertensi dalam kehamilan.kondisilain yang menyebabkan konvulsi atau koma meliputi epilepsy, malaria, dengan komplikasi cedera kepala, meningitis, ensifalitis, dan lain-lain.

a. Tekanan darah diastolic merupakan indicator prognosis yang baik untuk penatalaksanaan gangguan hipertensi dalam kehamilan.
b. Jika tekanan darah diastolik 90 mmHg atau lebih pada dua kali pengukuran yang berurutan dengan jeda waktun empat jam atau lebih diagnosis hipertensi dapat ditegakkan.

Gestasional Hipertensi	**Preeklampsia**		**Hipertensi kronik**	
Tekanan darah lebh dari140/90 mmHg untuk pertama kali selama hamil	TD:160/110 mmHg		TD:140/90 mmHg sebelum kehamilan atau didiagnosis sebelum gestasi 20 minggu	
Tidak ada proteinuria	proteinuria 2gram/24jam		Hipertensi yang pertama kali di diagnosa setelah gestasi 20 minggu dan menetp setelah 12 minggu postpartum.	
Tekanan darah kembali ke normal 12 minggu postpartum	kreatin serum 1,2mg/dl kecuali diketahui telahmeningkat sebelumnya			
Diagnosa akhir dibuat postpartum	Trombosit100.000/mm3			
Mungkin memperlihatkan tanda-tanda lain preeklampsia,	Nyeri kepala menetap atau gangguan serebrum atau penglihatan lainnya			

misalnya nyeri epigastrium				
	Nyeri epigastriummenetap			

6. Manifestasi klinik

   Klasifikasikan hipertensi pada kehamilan

   a. Hipertensi kronik: hipertensi (tekanan darah lebih dari 140/90 mmHg yang diukur setelah beristirahat selama 5-10 menit dalam posisi duduk) yang telah didiagnosis sebelum kehamilan terjadi atau hipertensi yang timbul sebelum mencapai usia kehamilan 20 minggu.
   b. Preeklamsia-Eklamsia: peningkatan tekanan darah yang baru timbul setelah usia kehamilan mencapai 20 minggu, disertai dengan penambahan berat badan ibu yang cepat akibat tubuh membengkak dan pada pemeriksaan laboratorium terdapat protein di dalam air seni (proteinuria). Eklamsia: preeklamsia yang disertai dengan kejang.
   c. Preeklamsia superimposed pada hipertensi kronik: preeklamsia yang terjadi pada perempuan hamil yang telah menderita hipertensi sebelum hamil.
   d. Hipertensi gestasional: hipertensi pada kehamilan yang timbul pada trimester akhir kehamilan, namun tanpa disertai gejala dan tanda preeklamsia, bersifat sementara dan tekanan darah kembali normal setelah melahirkan (postpartum). Hipertensi gestasional berkaitan dengan timbulnya hipertensi kronik suatu saat di masa yang akan datang.

7. Klasifikasi

   Stadium 1 (Hipertensi ringan) 140-159 mmHg 90-99 mmHg
   Stadium 2 (Hipertensi sedang) 160-179 mmHg 100-109 mmHg
   Stadium 3 (Hipertensi berat) 180-209 mmHg 110-119 mmHg
   Stadium 4 (Hipertensi maligna) 210 mmHg atau lebih 120 mmHg atau lebih.

8. Komplikasi

Iskemia uteroplasenta	Spasme arteriolar	Kejang dan koma
1) Pertumbuhan janin terhambat	Perdarahan serebral	Trauma karena kejang
2) Kematian janin	Gagal jant ung, ginjal, hati	Aspirasi cairan, darah, muntahan dan akibat gangguan pernafasan.
3) Persalinan premature	Ablasio retina	
4) Solusio plasenta	Tromboembolisme	
	Gangguan pembekuan darah	

9. Penatalaksanaan
   a. Anjurkan untuk mentaati pemeriksaan antenatal yang teratur, jika perlu konsultasikan ke ahli.
   b. Anjurkan untuk cukup istirahat, menjauhi emosi dan jangan bekerja terlalu berat
   c. Cegah penambahan berat badan yang agresif. Anjurkan untuk diit tinggi protein, rendah hidrat arang, rendah lemak dan rendah garam
   d. Awasi keadaan janin, dengan pemeriksaan seperti biasanya. Dapat juga dilakukan pemeriksaan monitor janin lainnya seperti elektrokardiografi fetal, ukuran biperietal (USG), penentuan kadar estriol, amnioskopi, pH darah janin dan lain-lain

Untuk hipertensi karena kehamilan tanpa proteinuria :Jika kehamilan < 37 minggu, tangani secara rawat jalan

a. Pantau tekanan darah, proteinuria, kondisi janin setiap minggu
b. Apabila tekanan darah meningkat, tangani sebagai pre-eklampsia
c. Apabila kondisi janin memburuk, atau terjadi pertumbuhan janin terhambat (PJT), rawat dan pertimbangkan terminasi kehamilan
d. Jika tekanan darah stabil janin dapat dilahirkan secara normal

e. Pembatasan kalori, cairan dan diet rendah garam tidak dapat mencegah hipertensi karena kehamilan, malah dapat membahayakan janin.

C. Perdarahan

1. Pengertian

   Perdarahan antepartum adalah perdarahan yang terjadi setelah kehamilan 28 minggu. Biasanya lebih banyak dan lebih berbahaya daripada perdarahan kehamilan sebelum 28 minggu (Mochtar, 1998). Prasenta previa adalah plasenta yang letaknya abnormal, yaitu pada segmen bawah uterus sehingga dapat menutupi sebagaian atau seluruh pembukan jalan lahir. Pada keadaan normal plasenta terletak terletak di bagian atas uterus.

2. Plasenta previa
   a. Plasenta previa totalis : seluruh pembukaan tertutup oleh jaringan plasenta
   b. Plasenta previa lateralis : hanya sebagian dari pambukaan tertutup oleh jaringan plasenta
   c. Plasenta previa margenalis : hanya pada pinggir ostium terdapat jaringan palsenta
   d. Plasenta letak rendah : bila Plasenta berada 3-4 cm di atas pinggir pembukaan



3. Gejala Klinik Plasenta Previa dengan solusio plasenta

Plasenta previa	Solusio Plasenta
Perdarahan tanpa nyeri	Perdarahan dengan nyeri
Perdarahan berulang-ulang sebelum partus	Perdarahan segera di susul partus
Perdarahan keluar banyak	Perdarahan keluar hanya sedikit
Bagian depan tinggi	Palpasi sukar
Biasanya ada	Bunyi jantung anak biasanya tidak ada

Teraba jaringan plasenta	Pada toucher tidak teraba plasenta, tapi ketuban yang terus menerus tegang
Robekan selaput marginal	Ada impressi pada jaringan plasenta karena hematome

D. Anemia

1. Pengertian

   Wanita tidak hamil mempunyai nilai normal hemoglobin 12 -15 gr%. Angka tersebut juga berlaku untuk wanita hamil, terutama wanita yang mendapat pengawasan selama hamil. Oleh karena itu, pemeriksaan hemoglobin harus menjadi pemeriksaan darah rutin selama pengawasan antenatal, yaitu dilakukan setiap 3 bulan atau paling sedik it 1 kali pada pemeriksaan pertama atau pada triwulan pertama dan sekali lagi pada triwulan terakhir (Mochtar, 1998).

   Ibu hamil yang mengalami anemia trimester 3 dengan kejadian BBLR dan memiliki peluang 8,936 untuk melahirkan BBLR.(Novianty & Gandirawati, 2022)

2. Nilai ambang batas kadar hemoglobin:
   a. Normal > 11 gr/dl
   b. Ringan 8-11 gr/dl
   c. Berat < 8 gr/dl
3. Tanda Anemia

   Keluhan yang dirasakan ibu hamil adalah: lemas badan, lesu, lekas lelah, mata berkunang-kunang, jantung berdebar.

4. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Anemia Pada Kehamilan

   Anemia pada kehamilan yang terjadi pada trimester pertama sampai ketiga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

   a. Status gizi ibu pada saat hamil mempengaruhi berat badan janin dalam kandungan, apabila status gizi buruk, baik sebelum kehamilan dan selama kehamilan akan menyebabkan berat badan lahir rendah (BBLR), disamping itu akan mengakibatkan terhambatnya otak janin, anemia pada bayi baru lahir. Bayi baru lahir akan mudah terkena infeksi. Asupan gizi sangat menentukan kesehatan ibu dan janin yang dikandungnya. [(21)]
   b. Kebutuhan gizi pada masa kehamilan akan meningkat sebesar 15 % dibandingkan dengan kebutuhan wanita normal, peningkatan gizi untuk (mammae), volume darah, plasenta,air ketuban dan pertumbuhan janin. Makanan yang dikomsumsi ibu hamil akan digunakan untuk pertumbuhan

janin sebesar 40% dan sisanya 60% digunakan untuk pertumbuhan ibunya. Secara normal ibu hamil akan mengalami kenaikan berat badan sebesar 11-13 kg. Hal ini terjadi karena kebutuhan asupan makanan ibu hamil meningkat seiring dengan bertambahnya usia kehamilan.

c. Faktor umur ibu hamil berkontribusi terhadap kejadian anemia selama hamil, Ibu hamil yang berusia kurang dari 20 tahun masih membutuhkan zat besi lebih untuk keperluan kebutuhan pertumbuhan diri sendiri dan juga untuk janinnya. Oleh karena itu, hamil di usia 20 tahun dengan asupan gizi yang tidak adekuat memiliki resiko anemia defisiensi besi.
d. Paritas secara luas mencakup gravid/jumlah kehamilan yaitu kehamilan yang berulang atau jumlah partus yang banyak lebih meningkat kejadian anemia akibat banyaknya darah yang keluar selama proses persalinan, angka kejadian pada kehamilan makin tinggi dengan semakin tingginya paritas.
e. Jarak antara kehamilan yang pendek (kurang dari 2 tahun) mempunyai resiko untuk menderita anemia menurut anjuran yang dikeluarkan oleh badan koordinasi keluarga berencana (BKKBN) jarak kelahiran yang ideal adalah 2 tahun atau lebih karena jarak kelahiran yang pendek akan menyebabkan seorang ibu belum cukup untuk memulihkan kondisi tubuhnya setelah melahirkan sebelumnya. Maka semakin pendek jarak kehamilan resiko terjadi anemia makin meningkat.
f. Faktor yang menggambarkan tingkat sosiol ekonomi salah satunya adalah tingkat pendidikan dan pekerjaan. Tingkat sosio ekonomi yang rendah dapat mempengaruhi kejadian anemia. Angka kejadian anemia pada ibu-ibu dengan kelompok pekerjaan suami (petani, nelayan, pekerja lepas) lebih tinggi dari kelompok pekerjaan suami (pegawai negeri, swasta dan dagang). Hal ini mencakup kemampuan dalam hal membeli dan memenuhi makanan bergizi dan suplemen tambahan yang dibutuhkan pada saat hamil.
g. Pemeriksaan Antenatal Care, pada pemeriksaan antenatal dilakukan pemantauan dan pemeriksaan terhadap keadaan anemia pada ibu hamil sehingga apabila ibu menderita gejala anemia dapat dideteksi sedini mungkin dengan pemeriksaan antenatal yang secara teratur untuk diberi penanganan segera. Pada pemeriksaan ini tablet penambahan darah (tablet Fe) juga diberikan pada ibu yang tidak mengalami anemia untuk mencegah terjadinyaanemia. Pada beberapa penelitian yang sudah dilakukan bahwa jumlah penderita semakin menurun pada kelompok yang sering mengunjungi klinik antenatal dan meningkat pada kelompok yang tidak melakukan pemeriksaan antenatal.

5. Gejala klinis anemia pada kehamilan

   Manifase klinis dari anemia defisiensi besi sangat bervariasi, bisa hampir tanpa gejala, bisa juga gejala-gejala penyakit dasarnya yang menonjol ataupun bisa ditemukan gejala anemia bersama-sama dengan penyakit dasarnya.

   Gejala-gejala dapat berupa kepala pusing, palpitasi, berkunang-kunang, perubahan jaringan epitel kuku, gangguan sitem neuromuscular, lesu, lemah, lelah, siphagia dan pembesaran kelenjar limpa. Bila kadar Hb < 7 gr/dl maka gejala-gejala dan tanda-tanda anemia akan jelas.

6. Pengaruh anemia terhadap kehamilan

   Anemia kekurangan zat besi yang parah atau tidak diobati selama kehamilan dapat meningkatkan risiko: Bayi prematur atau berat lahir rendah, Transfusi darah (jika kehilangan sejumlah besar darah selama persalinan), Depresi pasca melahirkan

   a. Defisiensi folat yang tidak diobati dapat meningkatkan risiko: Bayi prematur atau berat lahir rendah, Bayi dengan cacat lahir yang serius pada tulang belakang atau otak *(neural tube defects)*
   b. Yang tidak diobati kekurangan vitamin B12 juga dapat meningkatkan risiko melahirkan bayi dengan cacat tabung saraf *(neural tube defects).*
   c. Dapat menurunkan daya tahan ibu hamil sehingga ibu mudah sakit
   d. Menghambat pertumbuhan janin
   e. Berat badan rendah
   f. Persalinan prematur (Rochjati, 2003).

E. Detekni Dini Komplikasi Kehamilan

1. Pengertian

   Deteksi dini terhadap komplikasi kehamilan merupakan upaya penjaringan yang dilakukan untuk menemukan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi selama kehamilan ibu secara dini. Kegiatan yang dilakukan untuk menemukan ibu hamil yang mempunyai faktor risiko dan komplikasi kehamilan.

2. Tujuan

   Deteksi dini terhadap komplikasi kehamilan adalah upaya penjaringan yang dilakukan untuk menemukan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi selama kehamilan ibu secara dini.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi upaya deteksi dini seseorang terhadap komplikasi kehamilan

   a. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan merupakan faktor yang mendukung perilaku ibu dalam upaya deteksi dini komplikasi kehamilan. Ibu dengan tingkat Pendidikan tinggi lebih mudah memperoleh informasi tentang kesehatan.

b. Informasi

informasi tentang kesehatan mempengaruhi seseorang dalam hal upaya deteksi dini komplikasi kehamilan. Upaya deteksi dini seseorang yang rendah disebabkan karena tidak atau kurangnya memperoleh informasi yang kuat. Menurut Snehandu B.Kar (Notoatmodjo, 2003)

c. Budaya

Menurut WHO (Notoatmodjo, 2003) upaya deteksi dini seseorang juga dipengaruhi oleh faktor budaya. Kebudayaan ini terbentuk dalam waktu yang lama sebagai akibat dari kehidupan suatu masyarakat bersama.

d. Sosial Ekonomi

Menurut WHO (Notoatmodjo, 2003) faktor ekonomi juga berpengaruh terhadap seseorang dalam upaya deteksi dini komplikasi kehamilan. Status ekonomi keluarga juga berperan bagi seseorang dalam mengambil keputusan bertindak termasuk tindakan yang berhubungan dengan kesehatan.

4. Pencegahan Komplikasi Kehamilan

Model Pencegahan Komplikasi kehamilan

a. Pencegahan primer: edukasi, nutrisi, imunisasi sesuai kebijakan, higienitas, pencegahan anemia, konseling risiko
b. Pencegahan sekunder: deteksi dini (skrining HT/DM/infeksi), intervensi awal, monitoring ketat
c. Pencegahan tersier: stabilisasi, kolaborasi, rujukan, follow-up postpartum



F. Keselamatan Ibu Janin Komplikasi Kehamilan

Keselamatan ibu dan janin merupakan prioritas utama dalam pelayanan kebidanan, terutama pada kondisi komplikasi kehamilan. Komplikasi dapat terjadi secara tiba-tiba dan berpotensi mengancam jiwa, sehingga diperlukan penanganan

yang cepat, tepat, dan terkoordinasi. Upaya peningkatan keselamatan dilakukan melalui penerapan prinsip triase, komunikasi klinis efektif, serta sistem rujukan yang optimal.

1. Prinsip Keselamatan Ibu dan Janin
   a. Triase Obstetri
      Triase obstetri adalah proses pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi untuk menentukan prioritas penanganan.
      Tujuan:
      1) Mengidentifikasi kondisi gawat darurat secara cepat
      2) Menentukan prioritas intervensi
      3) Mengoptimalkan penggunaan sumber daya

      Klasifikasi triase:
      1) Gawat darurat: membutuhkan penanganan segera (misalnya perdarahan hebat, eklampsia)
      2) Mendesak: memerlukan penanganan cepat namun tidak langsung mengancam nyawa
      3) Tidak darurat: kondisi stabil
   b. Golden Time
      Golden time merupakan periode kritis di mana intervensi yang cepat dan tepat dapat menyelamatkan nyawa ibu dan janin.
      Contoh:
      Perdarahan postpartum harus segera ditangani dalam menit-menit awal
      Preeklampsia berat memerlukan stabilisasi segera

      Prinsip utama:
      1) Kecepatan
      2) Ketepatan tindakan
      3) Koordinasi tim
   c. Pencegahan Keterlambatan (Three Delays Model)
      Model ini menjelaskan tiga jenis keterlambatan yang berkontribusi terhadap tingginya angka kematian ibu:
      1) Keterlambatan dalam pengambilan keputusan
         Kurangnya pengetahuan
         Faktor budaya atau ekonomi
      2) Keterlambatan mencapai fasilitas kesehatan
         Akses geografis

Transportasi terbatas

3) Keterlambatan mendapatkan pelayanan
   Keterbatasan tenaga kesehatan
   Fasilitas yang tidak memadai

d. Upaya pencegahan:
   Edukasi kepada ibu dan keluarga
   Penyediaan sistem transportasi rujukan
   Peningkatan kualitas fasilitas kesehatan

G. Referensi

Novianty, A., & Gandirawati, E. M. (2022). The Relationship Between Trimester 3 Anemia Status and Chronic Energy Deficiency In Pregnant Women with Low Birth Weight Incidence. *Journal of Maternal and Child Health Sciences (JMCHS)*, *2*(2), 186–192. https://doi.org/10.36086/maternalandchild.v2i2.1470

Mansur, Arif, dkk. *Kapita Selekta Kedokteran Medis Aes Calpius.* Edisi Ketiga Jilid I Fakultas Kedokteran UI 2001.

Mocthar, Rustam. *Sinopsis Obstetri*, Jakarta, 1998.

Prawiroharjo. Sarwono : Ilmu Kebidanan Jakarta. Yayasan Bina Pustaka 2006

BAB 2

PENGKAJIAN IBU HAMIL DENGAN KOMPLIKASI: ANAMNESIS TERFOKUS, PEMERIKSAAN FISIK DAN PEMERIKSAAN

Pendahuluan

Bab ini membahas pengkajian terfokus pada ibu hamil dengan komplikasi sebagai dasar dalam menentukan prioritas asuhan kebidanan. Fokus pembahasan diarahkan pada kemampuan mahasiswa dalam melakukan anamnesis terfokus, pemeriksaan fisik terarah, memilih pemeriksaan penunjang prioritas, memantau kondisi janin, serta menyusun ringkasan hasil pengkajian yang mendukung pengambilan keputusan klinis. Selain itu, bab ini juga menekankan pentingnya komunikasi terapeutik, edukasi, dan kolaborasi interprofesional yang berpusat pada ibu, janin, dan keluarga. (Organization, 2016), (Karapanos, 2023)

Dalam praktik kebidanan, bidan sering menghadapi ibu hamil yang datang dengan keluhan atau tanda bahaya yang memerlukan respons cepat dan tepat. Pada kondisi tersebut, bidan tidak cukup hanya mampu mengidentifikasi keluhan, tetapi juga harus dapat mengarahkan pengkajian secara sistematis agar diperoleh data yang benar-benar bermakna klinis. Bab ini relevan untuk membekali mahasiswa agar mampu membedakan pengkajian rutin dengan pengkajian terfokus, sehingga setiap data yang dikumpulkan dapat digunakan untuk menentukan prioritas masalah, kebutuhan tindakan segera, dan keputusan kolaborasi atau rujukan. (Organization, 2016), (WHO, (Excellence., 2023)

Kehamilan merupakan proses fisiologis, tetapi dalam praktik klinis kehamilan dapat berkembang menjadi kondisi patologis yang memerlukan deteksi dini dan penatalaksanaan cepat untuk mencegah morbiditas dan mortalitas ibu maupun janin

Pelayanan antenatal yang berkualitas menempatkan pengkajian sebagai langkah awal yang menentukan arah diagnosis, pengambilan keputusan, dan rencana asuhan kebidanan atau kolaboratif berikutnya (Afriani, 2024)

WHO menekankan bahwa pelayanan antenatal yang baik tidak hanya berfokus pada kelangsungan hidup, tetapi juga pada pengalaman kehamilan yang positif, aman, dan berpusat pada Perempuan. (Organization, 2016)

Dalam konteks ibu hamil dengan komplikasi, pengkajian harus dilakukan secara sistematis melalui anamnesis terfokus, pemeriksaan fisik yang tepat, dan pemeriksaan penunjang sesuai indikasi klinis. (Gynecologists., 2020)

Deteksi dini ibu hamil berisiko tinggi juga dipengaruhi oleh kualitas penerapan pedoman antenatal dan kemampuan tenaga kesehatan dalam memanfaatkan instrumen klinis seperti Buku KIA dan format pengkajian yang baku. Dalam pelayanan kebidanan saat ini, pengkajian bukan hanya kegiatan mengumpulkan data, tetapi juga menjadi dasar untuk menentukan keputusan klinis yang tepat bagi ibu, janin, dan keluarga. Karena itu, bidan harus mampu berkomunikasi secara terapeutik, memberikan edukasi sesuai kondisi ibu, dan bekerja sama dengan tenaga kesehatan lain bila ditemukan masalah yang membutuhkan penanganan bersama. Mutu pelayanan antenatal juga tidak hanya dilihat dari jumlah kunjungan, tetapi dari seberapa baik kondisi ibu dan janin dinilai serta bagaimana pengalaman ibu selama mendapatkan pelayanan. (M. Karjono, 2023)

Pada ibu hamil dengan komplikasi, pengkajian terfokus berbeda dengan pengkajian kehamilan rutin. Pengkajian ini harus mampu menjawab empat hal penting, yaitu apa yang perlu ditanyakan, apa yang harus diperiksa, pemeriksaan penunjang apa yang perlu didahulukan, dan bagaimana menuliskan ringkasan hasil pengkajian untuk membantu keputusan klinis. Oleh sebab itu, mahasiswa perlu belajar berpikir klinis sejak tahap anamnesis, bukan hanya mengisi format. Data yang dikumpulkan harus sesuai dengan keluhan utama, tanda bahaya, dan kemungkinan komplikasi yang sedang terjadi.

Bab ini bertujuan membekali mahasiswa agar mampu melakukan pengkajian terfokus pada ibu hamil dengan komplikasi secara praktis dan mudah diterapkan. Materi difokuskan pada keterampilan klinik yang dapat digunakan langsung di laboratorium maupun di lahan praktik. Dengan mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya mengetahui langkah-langkah pemeriksaan, tetapi juga memahami alasan klinis dalam memilih data, melakukan pemeriksaan, dan menentukan prioritas asuhan. Pada akhirnya, mahasiswa diharapkan mampu memberikan asuhan yang aman, cepat, tepat, dan terdokumentasi dengan baik.

CPL

CPL: Menerapkan komunikasi terapeutik, edukasi, dan kolaborasi interprofesional berpusat pada ibu–janin–keluarga.

CPMK

CPMK: Melakukan pengkajian terfokus pada ibu hamil dengan komplikasi (anamnesis, pemeriksaan fisik, penunjang, dan pemantauan janin) serta menginterpretasi hasil untuk penentuan prioritas.

Uraian Materi

A. Defenisi

Konsep Pengkajian Terfokus pada Ibu Hamil dengan Komplikasi

Pengkajian terfokus adalah proses pengumpulan data yang diarahkan pada masalah utama, tanda bahaya, dan dugaan komplikasi yang dialami ibu hamil. Pengkajian ini dilakukan untuk mendapatkan informasi penting secara cepat, akurat, dan relevan, sehingga tenaga kesehatan dapat menentukan prioritas tindakan yang tepat (Afriani, 2024)

Pada ibu hamil dengan komplikasi, pengkajian terfokus menjadi sangat penting karena kondisi ibu dan janin dapat berubah dalam waktu singkat. Oleh sebab itu, bidan harus mampu mengenali data subjektif dan objektif yang paling bermakna klinis. Pengkajian yang baik tidak sekadar mengumpulkan banyak data, tetapi lebih pada kemampuan memilih data yang penting dan menafsirkannya dengan benar (Umar, 2019)

Pengkajian riwayat kesehatan ibu hamil adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, mengelompokkan, dan menafsirkan data subjektif serta objektif mengenai kondisi ibu selama kehamilan untuk mendeteksi masalah aktual maupun potensial secara dini. Pada ibu hamil dengan komplikasi, pengkajian tidak hanya berfungsi sebagai proses pencatatan data, tetapi juga sebagai dasar penentuan prioritas klinis, identifikasi kegawatdaruratan, dan kebutuhan rujukan (Enny Fitriahadi, 2021)

Anamnesis terfokus merupakan bagian penting dari pengkajian karena banyak komplikasi kehamilan, seperti preeklamsia, anemia, infeksi, ketuban pecah dini, dan gangguan pertumbuhan janin, mula-mula dikenali dari keluhan ibu dan riwayat kehamilannya (Ariana Traub, 2024)

Pemeriksaan fisik melengkapi anamnesis dengan menyediakan data objektif mengenai tanda vital, status umum, keadaan obstetri, dan kesejahteraan janin

Pemeriksaan penunjang digunakan untuk mengonfirmasi temuan klinis, menilai derajat keparahan, dan membantu pengambilan keputusan klinis yang lebih akurat (Afriani, 2024)

Pengkajian terfokus memiliki beberapa karakteristik, yaitu:

1. Berorientasi pada keluhan utama.
2. Menekankan pada tanda bahaya.
3. Mengutamakan keselamatan ibu dan janin.
4. Mendukung pengambilan keputusan klinis.
5. Menjadi dasar kolaborasi dan rujukan.

B. Tujuan

Tujuan utama pengkajian ibu hamil dengan komplikasi adalah memastikan keselamatan ibu dan janin melalui deteksi dini risiko, identifikasi gangguan yang sudah terjadi, dan perencanaan asuhan yang tepat waktu (Afriani, 2024)

Pengkajian bertujuan membedakan perubahan fisiologis kehamilan dari tanda-tanda patologis yang membutuhkan intervensi segera atau kolaborasi dengan dokter spesialis Pengkajian juga bertujuan mengenali faktor risiko maternal, obstetri, dan sosial yang dapat meningkatkan kemungkinan komplikasi selama kehamilan, persalinan, dan masa nifas (Umar, 2019)

Pada tingkat pelayanan dasar, pengkajian yang baik membantu tenaga kesehatan menentukan apakah ibu dapat ditangani di fasilitas saat itu, perlu observasi lebih ketat, atau harus segera dirujuk (Kesehatan, 2020)

Dari sisi mutu pelayanan, pengkajian mendukung kesinambungan asuhan karena data yang lengkap memudahkan komunikasi antar tenaga kesehatan dan meningkatkan ketepatan tindak lanjut klinis

C. Indikasi

Pengkajian ibu hamil dengan komplikasi diindikasikan pada semua ibu hamil, terutama pada ibu yang datang dengan keluhan atau tanda bahaya seperti perdarahan pervaginam, nyeri abdomen hebat, sakit kepala berat, pandangan kabur, edema umum, sesak napas, demam, penurunan gerak janin, atau keluarnya cairan dari jalan lahir sebelum waktunya. Pengkajian terfokus juga diindikasikan pada ibu dengan riwayat obstetri buruk, seperti abortus berulang, persalinan prematur, preeklamsia sebelumnya, seksio sesarea, atau kematian janin dalam kandungan (Afriani, 2024)

Ibu dengan penyakit penyerta seperti hipertensi kronis, diabetes melitus, penyakit ginjal, penyakit jantung, anemia, dan infeksi memerlukan pengkajian yang lebih intensif karena risiko komplikasinya lebih tinggi (Ariana Traub, 2024)

Faktor risiko seperti usia terlalu muda atau terlalu tua, obesitas, paparan asap rokok, stres, dan riwayat keluarga preeklamsia juga menjadi alasan penting dilakukannya pengkajian mendalam karena berhubungan dengan peningkatan kejadian komplikasi kehamilan (M. Karjono, 2023)

Deteksi dini risiko tinggi harus dilakukan sejak kunjungan antenatal pertama dan diulang pada kunjungan berikutnya karena profil risiko dapat berubah selama kehamilan berjalan (Umar, 2019)

D. Kontra Indikasi

Secara umum, pengkajian pada ibu hamil tidak memiliki kontraindikasi absolut karena pengkajian merupakan bagian mendasar dari pelayanan antenatal dan penanganan komplikasi

Namun, beberapa komponen pemeriksaan memiliki kontraindikasi relatif, terutama pemeriksaan vaginal atau pemeriksaan dalam pada perdarahan antepartum yang belum jelas penyebabnya karena dapat memperberat perdarahan bila terdapat plasenta previa (Kesehatan, 2020)

Pada kondisi syok, kejang, sesak berat, atau penurunan kesadaran, prioritas awal adalah stabilisasi ibu dengan pendekatan jalan napas, pernapasan, dan sirkulasi, sedangkan pengkajian lengkap dilanjutkan setelah kondisi lebih aman ((Organization, 2016)

Pemeriksaan penunjang invasif atau yang berpotensi menimbulkan risiko tambahan harus dilakukan berdasarkan indikasi klinis, manfaat-risiko, serta persetujuan tindakan yang adekuat, Dengan demikian, yang dikontraindikasikan bukan pengkajiannya, melainkan metode tertentu yang tidak aman pada situasi klinis khusus

E. Alat dan Bahan

Alat dan bahan untuk pengkajian ibu hamil dengan komplikasi mencakup instrumen anamnesis, alat pemeriksaan fisik umum, alat pemeriksaan obstetri, dan sarana pemeriksaan penunjang sederhana maupun lanjutan

Untuk anamnesis dan dokumentasi, petugas memerlukan (Afriani, 2024):

1. Format pengkajian,
2. Rekam medis,
3. Buku KIA,
4. Alat tulis, dan
5. Bila tersedia sistem dokumentasi elektronik.

Untuk pemeriksaan fisik umum, alat yang lazim digunakan ialah.:

1. Tensimeter,
2. Stetoskop,
3. Termometer,
4. Timbangan,
5. Pengukur tinggi badan,
6. Jam dengan jarum detik, dan
7. Pulse oximeter bila tersedia

Untuk pemeriksaan obstetri, diperlukan (:

1. Pita ukur,
2. Doppler atau fetoskop,
3. Sarung tangan,
4. Gel pelumas bila diperlukan,
5. Lampu pemeriksaan, dan
6. Kain penutup untuk menjaga privasi ibu

Pemeriksaan penunjang sederhana dapat memerlukan alat pemeriksaan:

1. Hemoglobin set,
2. Dipstick urine untuk protein dan glukosa,
3. Alat pengambilan sampel darah, serta
4. Formulir laboratorium,
5. Sedangkan pada fasilitas yang lebih lengkap dapat digunakan ultrasonografi dan CTG sesuai indikasi

F. Persiapan

Persiapan pengkajian meliputi persiapan petugas, pasien, lingkungan, dan administrasi agar proses pemeriksaan berlangsung aman, efektif, dan menghormati martabat pasien

Petugas perlu memastikan kebersihan tangan, kesiapan alat, pemahaman terhadap tujuan pemeriksaan, dan kemampuan melakukan komunikasi terapeutik sebelum memulai tindakan

Pasien perlu diidentifikasi dengan benar, diberi penjelasan mengenai tujuan serta tahapan pemeriksaan, dan dimintai persetujuan tindakan sesuai prinsip etik klinik

Lingkungan pemeriksaan harus bersih, cukup penerangan, memberikan privasi, dan memungkinkan posisi ibu yang nyaman serta aman, terutama pada trimester lanjut ketika posisi telentang lama dapat menimbulkan ketidaknyamanan atau hipotensi supinasi (Afriani, 2024)

Persiapan administrasi juga penting karena data kunjungan sebelumnya, hasil laboratorium terdahulu, dan riwayat risiko dapat mempercepat identifikasi komplikasi serta membantu kesinambungan pelayanan (Bonita et al., 2020).

G. Langkah Langkah Tindakan / Prosedur

Prosedur pengkajian dimulai dengan pembukaan komunikasi terapeutik, identifikasi pasien, penjelasan tujuan, dan persetujuan tindakan agar hubungan profesional terbentuk sejak awal, Setelah itu dilakukan anamnesis terfokus yang

mencakup identitas ibu, usia kehamilan, keluhan utama, riwayat keluhan sekarang, riwayat obstetri, riwayat penyakit dahulu, riwayat keluarga, obat yang sedang dikonsumsi, alergi, kondisi psikososial, serta gaya hidup yang relevan seperti merokok, paparan asap rokok, dan pola makan (Afriani, 2024)

Pada ibu dengan dugaan preeklamsia, pertanyaan terarah tentang sakit kepala hebat, pandangan kabur, nyeri ulu hati, edema, dan penurunan gerak janin sangat penting karena gejala tersebut berkaitan dengan keparahan penyakit (Excellence., 2023)

Pada ibu dengan dugaan anemia, anamnesis harus menekankan keluhan cepat lelah, pusing, berdebar, pola makan, kepatuhan konsumsi tablet Fe, dan riwayat perdarahan karena faktor-faktor tersebut berhubungan dengan kejadian anemia dalam kehamilan (Dona Rande Bua, 2024)

Setelah anamnesis, dilakukan pemeriksaan fisik umum yang mencakup keadaan umum, kesadaran, tekanan darah, nadi, laju napas, suhu, status gizi, konjungtiva, edema, dan tanda dehidrasi atau distres napas

Pemeriksaan obstetri dilanjutkan dengan inspeksi abdomen, pengukuran tinggi fundus uteri, palpasi Leopold, penilaian nyeri tekan, serta auskultasi denyut jantung janin untuk menilai kesejahteraan janin dan kesesuaian pertumbuhan terhadap usia kehamilan (Afriani, 2024)

Pemeriksaan dalam hanya dilakukan bila ada indikasi klinis yang jelas dan tidak ada kecurigaan plasenta previa atau kondisi lain yang membuat tindakan tersebut berisiko

Pemeriksaan penunjang dilakukan sesuai indikasi dan dapat meliputi hemoglobin, protein urine, glukosa urine, darah lengkap, fungsi hati, fungsi ginjal, ultrasonografi, dan CTG untuk mendukung analisis klinis (Kesehatan, 2020)

Langkah terakhir adalah analisis data, penentuan masalah aktual dan potensial, keputusan observasi atau rujukan, edukasi singkat, serta dokumentasi hasil secara lengkap

Prosedur awal yang dilakukan adalah dengan melakukan Anamnesis Terfokus yang merupakan langkah awal untuk memperoleh data subjektif yang berkaitan langsung dengan keluhan utama ibu. Dalam anamnesis, mahasiswa perlu memahami bahwa setiap keluhan memiliki arah pertanyaan yang berbeda (Afriani, 2024)

Berikut adalah Hal-hal yang Ditanyakan antara lain (Ari Fahrial Syam, 2013), (Karapanos, 2023):

1. Identitas dan usia kehamilan

   Data identitas diperlukan untuk mengenali ibu, sedangkan usia kehamilan penting untuk menafsirkan kondisi klinis dan risiko yang mungkin terjadi

Keluhan utama

Keluhan utama harus digali secara rinci, mencakup:

a. sejak kapan keluhan dirasakan,
b. frekuensi,
c. intensitas,
d. faktor pencetus,
e. faktor yang memperberat atau mengurangi,
f. gejala penyerta.

2. Riwayat keluhan sekarang

   Beberapa contoh penggalian berdasarkan keluhan:

   a. Perdarahan: warna darah, jumlah, ada gumpalan atau tidak, disertai nyeri atau tidak.
   b. Nyeri kepala: lokasi nyeri, berat-ringannya, pandangan kabur, mual muntah, nyeri ulu hati.
   c. Demam: sejak kapan, ada menggigil, batuk, nyeri saat berkemih, atau keputihan.
   d. Gerak janin berkurang: kapan mulai berkurang, seberapa sering biasanya, kapan terakhir janin dirasakan bergerak.

3. Riwayat obstetri

   a. Gravida, para, abortus,
   b. Riwayat persalinan sebelumnya,
   c. Riwayat komplikasi pada kehamilan terdahulu,
   d. Riwayat bayi lahir kecil, prematur, atau meninggal.

4. Riwayat kesehatan

   a. Hipertensi,
   b. Diabetes mellitus,
   c. Penyakit jantung,
   d. Penyakit ginjal,
   e. Asma,
   f. Anemia,
   g. Infeksi,
   h. Riwayat pengobatan.

5. Riwayat kehamilan sekarang
   a. Hasil pemeriksaan ANC sebelumnya,
   b. Tekanan darah sebelumnya,
   c. Hasil laboratorium atau USG sebelumnya,
   d. Keluhan yang pernah muncul,
   e. Konsumsi obat atau suplemen.

   Prinsip Anamnesis dengan Komunikasi Terapeutik

6. Dalam melakukan anamnesis, mahasiswa harus :
   a. Memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan pemeriksaan,
   b. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami,
   c. Bersikap empatik dan tidak menghakimi,
   d. Memberi kesempatan ibu untuk bercerita,
   e. Menjaga privasi dan kenyamanan ibu,
   f. Melibatkan keluarga bila diperlukan.
7. Pemeriksaan Fisik Terarah

   Pemeriksaan fisik pada ibu hamil dengan komplikasi harus dilakukan secara sistematis, tetapi tetap menyesuaikan kondisi klinis ibu (Ari Fahrial Syam, 2013)

   Pemeriksaan Umum

   Yang dinilai dalam pemeriksaan umum meliputi:
   a. Keadaan Umum,
   b. Kesadaran,
   c. Tekanan darah,
   d. Nadi,
   e. Frekuensi napas,
   f. Suhu,
   g. Saturasi oksigen bila tersedia,
   h. Tanda Pucat,
   i. Edema,
   j. Dehidrasi,
   k. Sesak Aaau sianosis.
8. Pemeriksaan Obstetri

   Pemeriksaan obstetri mencakup:
   a. Inspeksi abdomen,
   b. Palpasi Leopold,
   c. Tinggi fundus uteri,
   d. Penilaian kontraksi,
   e. Nyeri tekan abdomen,

f. Taksiran letak dan presentasi janin,
g. Denyut jantung janin,
h. Gerak janin.

9. Pemeriksaan Khusus Sesuai Keluhan
   a. Pada dugaan preeklamsia
      1) Tekanan darah,
      2) Edema,
      3) Refleks,
      4) Nyeri epigastrium,
      5) Pandangan kabur,
      6) Sakit kepala hebat.
   b. Pada perdarahan
      1) Keadaan umum dan hemodinamik,
      2) Jumlah perdarahan,
      3) Nyeri abdomen,
      4) Kontraksi uterus,
      5) Kondisi janin.
   c. Pada demam atau dugaan infeksi
      1) Suhu,
      2) Nadi,
      3) Frekuensi napas,
      4) Sumber infeksi,
      5) Nyeri tekan,
      6) Kondisi umum.
   d. Pada gerak janin berkurang
      1) Konfirmasi usia kehamilan,
      2) Pola gerak janin,
      3) Denyut jantung janin,
      4) Tanda bahaya lain.
10. Pemeriksaan Penunjang Prioritas

    Pemeriksaan penunjang dipilih berdasarkan keluhan dan dugaan masalah klinis. Tidak semua pemeriksaan harus dilakukan sekaligus. Yang diprioritaskan adalah pemeriksaan yang paling membantu menegakkan interpretasi awal .

11. Pemeriksaan Laboratorium

    Pemeriksaan yang dapat diprioritaskan antara lain:
    a. Hemoglobin,
    b. Hematokrit,
    c. Trombosit,

d. Protein urin,
e. Urinalisis,
f. Gula darah,
g. Fungsi ginjal,
h. Fungsi hati,
i. Golongan darah bila ada perdarahan,
j. Pemeriksaan infeksi sesuai indikasi.

12. Pemeriksaan Penunjang Janin

Pemeriksaan janin yang dapat dipilih:

a. Auskultasi denyut jantung janin,
b. Non-stress test,
c. USG obstetri,
d. Biophysical profile,
e. Doppler jika diperlukan.

13. Prinsip Pemilihan Penunjang

Mahasiswa perlu memahami prinsip berikut:

a. Sesuai dengan keluhan utama,
b. Mendukung keselamatan ibu,
c. Mempertimbangkan kondisi janin,
d. Mempertimbangkan ketersediaan alat dan fasilitas,
e. Mendukung keputusan klinis secara cepat.

14. Pemantauan Janin

Pemantauan janin merupakan bagian penting dari pengkajian pada kehamilan dengan komplikasi. Tujuan pemantauan janin adalah menilai kesejahteraan janin dan mendeteksi tanda gawat janin sedini mungkin (Afriani, 2024)

Hal-hal yang perlu diperhatikan:

a. Denyut jantung janin,
b. Pola gerak janin,
c. Usia kehamilan,
d. Pertumbuhan janin,
e. Hasil pemeriksaan USG atau penunjang lain.

Pada kasus tertentu, seperti hipertensi dalam kehamilan, perdarahan, atau gerak janin berkurang, pemantauan janin harus dilakukan lebih cermat karena kondisi janin dapat terganggu

15. Interpretasi Hasil Pengkajian

Interpretasi hasil pengkajian adalah kemampuan menyusun makna klinis dari seluruh data yang telah diperoleh. Mahasiswa tidak cukup hanya menuliskan data, tetapi harus mampu menyimpulkan masalah utama dan prioritasnya (Ari Fahrial Syam, 2013)

Interpretasi hasil pengkajian meliputi:

a. Mengidentifikasi masalah utama,
b. Mengenali tanda bahaya,
c. Menilai kondisi ibu,
d. Menilai kondisi janin,
e. Menentukan kebutuhan tindakan segera,
f. Menentukan kebutuhan kolaborasi atau rujukan.

Contoh:

a. TD 160/110 mmHg, nyeri kepala hebat, proteinuria -> mengarah pada dugaan preeklamsia.
b. Perdarahan merah segar tanpa nyeri -> perlu kewaspadaan perdarahan antepartum.
c. Demam, nadi cepat, napas cepat -> curiga infeksi atau sepsis.
d. Gerak janin berkurang -> perlu evaluasi kesejahteraan janin.

16. Menyusun Ringkasan Pengkajian

Ringkasan pengkajian harus singkat, jelas, dan langsung menunjukkan masalah utama

Unsur Ringkasan Pengkajian

Ringkasan pengkajian sebaiknya memuat:

a. Identitas singkat ibu,
b. Usia kehamilan,
c. Keluhan utama,
d. Data subjektif penting,
e. Data objektif penting,
f. Hasil penunjang,
g. Interpretasi awal.

17. Komunikasi Terapeutik, Edukasi, dan Kolaborasi Interprofesional

Pengkajian tidak dapat dipisahkan dari komunikasi terapeutik. Ibu hamil dengan komplikasi sering berada dalam kondisi cemas, takut, atau tidak nyaman. Oleh karena itu, bidan harus mampu membangun hubungan saling percaya (Karapanos, 2023)

a. Komunikasi Terapeutik
   Komunikasi terapeutik bertujuan:
   1) Membuat ibu merasa aman,
   2) Membantu ibu menyampaikan keluhan secara terbuka,
   3) Mengurangi kecemasan,
   4) Meningkatkan kerja sama selama pemeriksaan.
b. Edukasi
   Edukasi harus diberikan sesuai kondisi ibu, misalnya:
   1) Penjelasan tentang tanda bahaya,
   2) Alasan pemeriksaan tambahan,
   3) Pentingnya observasi,
   4) Pentingnya rujukan atau kolaborasi.
c. Kolaborasi Interprofesional
   Kolaborasi dilakukan bila:
   1) Ditemukan kegawatdaruratan,
   2) Diperlukan pemeriksaan atau penanganan lanjutan,
   3) Diperlukan rujukan,
   4) Diperlukan kerja sama dengan dokter, perawat, analis laboratorium, atau tenaga kesehatan lain.

18. Hasil Penelitian Terkait

Beberapa hasil penelitian yang mendukung materi bab ini antara lain:

a. Penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang jelas, empatik, dan terstruktur pada komplikasi kehamilan meningkatkan pemahaman serta rasa aman ibu (Karapanos, 2023)
b. Kolaborasi interprofesional yang baik terbukti meningkatkan kualitas pelayanan maternitas dan mempercepat pengambilan keputusan (Liesa Beiera, 2025)
c. Penggunaan penilaian dini berbasis tanda vital membantu mendeteksi perburukan kondisi maternal lebih cepat (Umar, 2019)
d. Keluhan gerak janin berkurang berkaitan dengan peningkatan risiko luaran perinatal buruk sehingga memerlukan pengkajian serius (Aikaterini Bekiou, 2020)
e. Pemeriksaan janin yang dipilih berdasarkan faktor risiko lebih efektif dibanding pemeriksaan yang dilakukan tanpa indikasi (ACOG, 2021)

19. Studi Kasus

Seorang ibu hamil usia 33 minggu datang ke poli dengan keluhan sakit kepala hebat sejak tadi pagi, pandangan kabur, bengkak pada kaki, dan mual. Ibu mengatakan gerak janin masih dirasakan, tetapi lebih sedikit dari biasanya.

Tugas mahasiswa:

a. Tuliskan data subjektif yang perlu digali.
b. Tentukan pemeriksaan fisik yang harus diprioritaskan.
c. Pilih pemeriksaan penunjang yang diperlukan.
d. Susun ringkasan hasil pengkajian.
e. Tentukan prioritas masalah.

Pembahasan Studi Kasus

Data subjektif yang perlu digali

a. usia kehamilan,
b. riwayat hipertensi,
c. riwayat preeklamsia sebelumnya,
d. nyeri epigastrium,
e. muntah,
f. kejang,
g. riwayat ANC,
h. hasil tekanan darah sebelumnya,
i. penurunan gerak janin.

Pemeriksaan fisik prioritas

a. tekanan darah,
b. nadi,
c. frekuensi napas,
d. edema,
e. refleks,
f. pemeriksaan obstetri,
g. denyut jantung janin.

Pemeriksaan penunjang

a. protein urin,
b. trombosit,
c. fungsi hati,
d. fungsi ginjal,
e. pemeriksaan janin sesuai indikasi.

20. Ringkasan pengkajian

Ny. X, hamil 33 minggu, datang dengan keluhan sakit kepala hebat, pandangan kabur, edema tungkai, dan gerak janin berkurang. Hasil pemeriksaan menunjukkan TD meningkat disertai temuan protein urin. Interpretasi awal mengarah pada dugaan preeklamsia dan memerlukan evaluasi maternal-fetal lebih lanjut.

Prioritas masalah : Gangguan hipertensi dalam kehamilan dengan risiko perburukan kondisi ibu dan gangguan kesejahteraan janin.

H. Keselamatan/*Patient Safety*

Keselamatan pasien pada pengkajian ibu hamil dengan komplikasi menuntut identifikasi pasien yang benar, komunikasi efektif, pencegahan infeksi, dan penghormatan terhadap privasi serta martabat ibu . Hand hygiene, penggunaan alat bersih atau steril sesuai kebutuhan, serta pembatasan tindakan invasif yang tidak perlu merupakan langkah dasar untuk mencegah infeksi dan cedera selama pemeriksaan. Pada ibu hamil dengan dugaan komplikasi berat, patient safety juga berarti kemampuan tenaga kesehatan mengenali tanda gawat darurat seperti hipertensi berat, perdarahan aktif, kejang, gawat janin, atau penurunan kesadaran, lalu segera melakukan stabilisasi dan rujukan (Organization, 2016) (Enny Fitriahadi, 2021)

Posisi pemeriksaan harus dibuat senyaman dan seaman mungkin, dengan menghindari posisi telentang yang terlalu lama pada kehamilan lanjut bila menimbulkan ketidaknyamanan atau gejala hipotensi supinasi .Dokumentasi yang cepat, akurat, dan dapat dibaca juga merupakan bagian dari patient safety karena keputusan klinis berikutnya sangat bergantung pada data awal yang dicatat oleh pemeriksa pertama (Enny Fitriahadi, 2021)

I. Evaluasi Hasil

Evaluasi hasil pengkajian bertujuan menilai apakah data yang dikumpulkan telah cukup, relevan, dan mengarah pada identifikasi masalah kebidanan atau medis yang tepat. Kelengkapan data dievaluasi dari terpenuhinya komponen anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan obstetri, dan penunjang yang sesuai dengan keluhan serta faktor risiko ibu (Afriani, 2024)

Ketepatan interpretasi hasil juga harus dinilai, misalnya hipertensi dengan proteinuria perlu diwaspadai sebagai preeklamsia, sedangkan hemoglobin rendah dengan konjungtiva pucat dan keluhan lemah mengarah pada anemia dalam kehamilan (Ariana Traub, 2024)

Evaluasi hasil yang baik juga melihat apakah keputusan tindak lanjut sudah proporsional, yakni observasi, edukasi, kolaborasi, atau rujukan, sesuai derajat risiko ibu dan janin ((Ari Fahrial Syam, 2013). Dalam praktik pendidikan klinik, evaluasi pengkajian

juga dapat mencakup kemampuan mahasiswa atau tenaga kesehatan dalam membangun komunikasi, menjaga keamanan pasien, dan mendokumentasikan temuan secara profesional

J. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pencatatan sistematis seluruh data subjektif, objektif, hasil pemeriksaan penunjang, analisis, dan rencana tindak lanjut yang diperoleh selama pengkajian ibu hamil dengan komplikasi Dokumentasi harus faktual, akurat, jelas, ringkas, tepat waktu, dan menggunakan istilah profesional yang baku agar bermanfaat secara klinis, legal, dan edukatif Format dokumentasi dapat berupa naratif, SOAP, atau format asuhan kebidanan sesuai kebijakan institusi pelayanan dan pendidikan (Afriani, 2024)

Contoh dokumentasi SOAP pada kasus Hipertensi dapat ditulis sebagai berikut:

S (Subjective):

Ny. X, usia 29 tahun, G2P1A0, usia kehamilan 32 minggu, datang ke Puskesmas untuk kontrol kehamilan rutin. Ibu mengeluh tengkuk terasa tegang dan kadang pusing ringan sejak 3 hari terakhir, terutama saat beraktivitas banyak. Ibu tidak mengeluh pandangan kabur, nyeri ulu hati, sesak napas, maupun bengkak pada wajah dan tangan. Gerak janin masih dirasakan aktif. Tidak ada perdarahan pervaginam dan tidak ada cairan keluar dari jalan lahir. Sebelum hamil ibu tidak pernah didiagnosis hipertensi. Riwayat tekanan darah pada kehamilan sebelumnya normal hingga persalinan. Riwayat hipertensi dalam keluarga ada, yaitu ibu kandung pasien menderita hipertensi.

O (Objective):

Keadaan umum baik, kesadaran compos mentis. Tekanan darah 146/94 mmHg pada pemeriksaan pertama dan 148/96 mmHg pada pemeriksaan ulang setelah istirahat. Nadi 88 x/menit, respirasi 20 x/menit, suhu 36,7°C. Tidak tampak edema patologis. Tinggi fundus uteri sesuai usia kehamilan. Denyut jantung janin 145 x/menit, teratur. Hasil pemeriksaan protein urine negatif.

A (Assessment):

G2P1A0 usia kehamilan 32 minggu dengan **hipertensi gestasional**.

P (Plan):

Melakukan pemantauan tekanan darah serial, observasi tanda bahaya hipertensi dalam kehamilan, edukasi ibu untuk istirahat cukup dan mengurangi

aktivitas berat, anjurkan kontrol ulang lebih cepat, pantau gerak janin, serta kolaborasi atau rujukan apabila tekanan darah meningkat atau muncul gejala yang mengarah ke preeklamsia.

K. *Mini Case (Knows How)*

Mini-case tertulis (diskusi kelompok)

Kasus: Hipertensi dalam Kehamilan

Seorang perempuan usia 29 tahun, G2P1A0, usia kehamilan 32 minggu, datang ke Puskesmas pada pukul 09.00 untuk kontrol kehamilan rutin. Ibu mengatakan sejak 3 hari terakhir sering merasa tengkuk terasa tegang dan kadang pusing ringan, terutama saat banyak beraktivitas. Ibu tidak mengeluh pandangan kabur, nyeri ulu hati, sesak, maupun bengkak pada wajah dan tangan. Gerak janin masih dirasakan aktif. Tidak ada perdarahan dari jalan lahir dan tidak ada cairan keluar. Hipertensi gestasional biasanya muncul setelah 20 minggu kehamilan sebagai hipertensi baru tanpa proteinuria atau tanda berat lain.

Pada anamnesis lebih lanjut diketahui bahwa sebelum hamil ibu tidak pernah didiagnosis hipertensi. Pada kehamilan sebelumnya tekanan darah ibu normal sampai persalinan. Kunjungan antenatal dilakukan cukup teratur. Ibu bekerja dengan aktivitas yang cukup padat dan mengaku akhir-akhir ini sering kurang istirahat. Tidak ada riwayat penyakit ginjal, diabetes, atau penyakit jantung. Riwayat hipertensi dalam keluarga ada, yaitu ibu kandung pasien menderita hipertensi. Riwayat maternal dan keluarga seperti ini relevan karena faktor ibu dan komorbid dapat meningkatkan risiko gangguan hipertensi dalam kehamilan.

Hasil pemeriksaan menunjukkan keadaan umum baik, kesadaran compos mentis, tekanan darah 146/94 mmHg pada pemeriksaan pertama dan 148/96 mmHg saat diulang setelah istirahat, nadi 88 x/menit, pernapasan 20 x/menit, suhu 36,7°C. Tidak tampak edema patologis. Tinggi fundus uteri sesuai usia kehamilan dan denyut jantung janin 145 x/menit. Hasil pemeriksaan urine protein negatif. Temuan ini lebih sesuai dengan hipertensi gestasional karena ada hipertensi baru setelah 20 minggu kehamilan tanpa proteinuria dan tanpa tanda berat.

Bidan kemudian melakukan pengkajian lanjutan terhadap kemungkinan faktor risiko, pemantauan tekanan darah serial, kondisi janin, dan kebutuhan tindak lanjut di fasilitas pelayanan dasar atau kolaborasi ke fasilitas yang lebih lengkap. Gangguan hipertensi pada kehamilan tetap perlu dipantau ketat karena dapat berkembang menjadi kondisi yang lebih berat.

Pertanyaan Diskusi

1. Apa masalah utama pada kasus di atas?
2. Data subjektif dan objektif apa saja yang mendukung analisis Anda?
3. Mengapa kasus ini lebih mengarah pada hipertensi gestasional daripada preeklamsia?
4. Faktor risiko apa saja yang mungkin berperan pada kasus ini?
5. Pemeriksaan penunjang apa yang perlu diprioritaskan untuk melengkapi pengkajian?
6. Apa tindakan awal yang harus dilakukan bidan pada kasus ini?
7. Apakah kasus ini masih dapat dipantau di fasilitas pelayanan dasar, atau perlu rujukan segera? Jelaskan alasan Anda.
8. Edukasi apa yang perlu diberikan kepada ibu terkait pemantauan kondisi dan tanda bahaya?
9. Mengapa pemantauan tekanan darah serial penting pada kasus ini?
10. Buat dokumentasi singkat model SOAP untuk kasus ini.

Soal Praktik OSCE

1.	No. stasiun	3
2.	Waktu yang dibutuhkan	10 menit
3.	Judul stasiun: kasus yang akan diujikan	**BOLD** salah satu kategori: 1. Masa Antara/prakonsepsi: normal/deteksi dini 2. Kehamilan Normal 3. **Kehamilan: Deteksi Dini**/Gadar 4. Persalinan Normal 5. Persalinan: Deteksi Dini/Gadar 6. Nifas/Masa Laktasi: Normal/Deteksi Dini 7. Neonatus sd. 28 hari: Normal/Deteksi Dini/Gadar 8. Keluarga Berencana: Normal/Deteksi dini
4.	Kasus	**Pemeriksaan protein urine**
5.	Tujuan: memberi penilaian pada kompetensi yang diujikan	**BOLD** kompetensi yang akan diujikan 1. **Anamnesis** 2. **Pemeriksaan fisik dan/atau laboratorium sederhana** 3. Perumusan diagnosis dan/atau masalah 4. **Prosedur tindakan klinis** 5. KIE/konseling 6. Kolaborasi/Rujukan 7. Pendokumentasian 8. **Perilaku profesional**
6.	Soal: **Skenario** kasus dan **Tugas**	**Skenario klinis:** Seorang ibu (36 tahun, G3P2A0) hamil 36 minggu mengeluh bengkak pada kaki sejak 5 hari yang lalu. Saat ini bidan akan melakukan anamnesis terfokus, dan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan terkait dengan hasil anamnesis **Tugas:** 1. Lakukan anamnesis dengan pertanyaan terfokus tanpa harus menanyakan biodata/hal lain. Bila penguji menyebutkan "tidak ada data", Anda tidak perlu menanyakan atau mengulang dengan pertanyaan serupa. 2. Lanjutkan prosedur selanjutnya. Setelah selesai melakukan pemeriksaan, ambil kertas yang berisikan hasil pemeriksaan dari penguji.

7.	Instruksi penguji	**INSTRUKSI PENGUJI** **Instruksi Umum**: 1. Pastikan identitas peserta sesuai dengan kartu ujian 2. Tulislah 4 digit terakhir atau minimal 2 digit dari nomor peserta ujian pada lembar penilaian. 3. Amati peserta dan beri penilaain pada lembar penilaian yang disesuaikan dengan rubrik penilaian: • Actual mark (0/1/2/3) • Global rating (TL/B/L/S) 4. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi ataupun bertanya kepada peserta selain yang ditentukan. 5. Taat aturan dan laksanakan tugas sebagai penguji UK OSCE. **Instruksi Khusus**: 1. Penguji boleh mendekati peserta ujian bila jarak pandang kurang jelas untuk mengamati peserta ujian ketika melakukan tindakan. Syaratnya, penguji harus menghindari kontak mata dengan cara berdiri di belakang punggung peserta; 2. Setelah peserta ujian selesai melakukan pemeriksaan fisik, **penguji menyerahkan catatan yang berisikan:** • **TD 150/90 mmHg, N 82x/menit, S 36,8 C.** • **TFU 3 jari dibawah proxesus xyphoideus, kepala sudah masuk PAP, DJJ 146 x/menit teratur** • **Edema pada kaki +/+** 3. Penguji menyebutkan **"tidak ada data"** bila pertanyaan atau pernyataan tidak sesuai dengan skenario. Bila peserta ujian telah menanyakan 3 pertanyaan fokus, penguji dapat menyebutkan **"cukup, silakan melanjutkan ke pemeriksaan".** **Tugas tambahan:** Bersama dengan laboran merapikan alat untuk digunakan oleh peserta ujian yang berikutnya

<table>
<tr>
<td>8.</td>
<td>Kebutuhan dan Instruksi pasien/pemeran simulasi yang terstandar</td>
<td>
Ada, seorang perempuan yang dikondisikan sekitar umur 36 tahun, berpakaian rapi, terbaring dihadapan peserta ujian yang dibatasi oleh tempat tidur.
Dialog Peserta Ujian (PU) dengan Pasien Simulasi (PS)
<table>
<tr><th>PU</th><th>PS</th></tr>
<tr><td>Menyapa PS</td><td>Membalas sapaan (tidak dilakukan bila PU tidak menyapa)</td></tr>
<tr><td>Anamnesis :
• Menanyakan keadaan umum ibu
• Menanyakan keluhan yang dirasakan saat ini
• Menanyakan keluhan lain seperti “apakah ada sakit kepala, apakah memiliki gangguan penglihatan dan apakah ada riwayat hipertensi ?”</td><td>• Menjawab “baik” sambil menganggukkan kepala
• Menjawab “bengkak pada kaki sejak 5 hari yang lalu
• Menjawab “tidak ada”</td></tr>
<tr><td>Pemeriksaan fisik
• Mengukur tekanan darah, nadi, suhu</td><td>• Mengukur tekanan darah. Nadi, suhu pada model anatomi lengan yang disediakan</td></tr>
<tr><td>Prosedur tindakan:
• Melakukan leopold, mengukur TFU, menghitung DJJ,melakukan penekanan pada ektermitas dan melakukan pemeriksaan protein urine</td><td>• Melakukan leopold, mengukur TFU, menghitung DJJ, melakukan penekanan pada ektermitas pada model anatomi abdomen yang disediakan dan melakukan pemeriksaan protein urine</td></tr>
</table>
Catatan:
PS diam saja bila:
• Peserta ujian menanyakan diluar skenario
• Penguji mengatakan tidak ada data
</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><td>9.</td><td>Tipe Ruangan</td><td>Ruang pemeriksaan</td></tr>
<tr><td>10.</td><td>Kebutuhan laboran</td><td>Ada, dengan tugas:
Merapikan alat yang telah digunakan seperti semula untuk persiapan peserta yang berikutnya</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Kebutuhan manekin dan alat</td><td>Ada.
- Model anatomi lengan yang dapat digunakan untuk mengukur tekanan darah, nadi, suhu
- Model anatomi abdomen yang dapat digunakan untuk pemeriksaan leopold, mengukur TFU dan DJJ
- Model anatomi kaki yang dapat digunakan untuk dilakukannya penekana pada ektermitas
- Posisi model anatomi lengan, abdomen dan kaki diletakkan di sisi tempat tidur

<table>
<tr><th>Jenis alat dan bahan</th><th>Jumlah</th></tr>
<tr><td>Baki yang dialasi dengan kain berisikan:
▪ sarung tangan
▪ 1 set Tensimeter aneroid
▪ Thermometer digital
▪ 1 set alat Pemeriksaan protein urine
▪ Sample urine dengan hasil protein urine +
▪ Tisu
▪ Hand sanitizer
▪ Jam tangan</td><td>

Sejumlah peserta + cadangan
1
Sejumlah peserta + cadangan
1
10 ml
Secukupnya
1
1</td></tr>
<tr><td>▪ Tempat sampah medis/non-medis</td><td>1/1 buah</td></tr>
<tr><td>▪ Kalender meja yang diletakkan di meja peserta</td><td>1</td></tr>
<tr><td>▪ Selimut</td><td>1</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.</td><td>Penulis</td><td>Septa Dwi Insani, S.Keb, Bd, MMRS</td></tr>
<tr><td>13.</td><td>Referensi</td><td>Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan, 2013, World Health Organization</td></tr>
</table>

RUBRIK PENILAIAN

<table>
<tr><th>No.</th><th>Kompetensi yang diujikan</th><th>Prosedur</th><th>Skoring</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Anamnesis</td><td>Peserta ujian menanyakan data fokus:
1. Menanyakan keadaan umum ibu
2. Menanyakan keluhan yang dirasakan saat ini
3. Menanyakan keluhan lain seperti “apakah ada sakit kepala, apakah memiliki gangguan penglihatan dan apakah ada riwayat hipertensi?”</td><td>
<table>
<tr><th colspan="2">Skor</th><th>Keterangan</th></tr>
<tr><th>Bobot</th><th>AM</th><th></th></tr>
<tr><td rowspan="4">2</td><td>3</td><td>Semua (3) pertanyaan dilakukan dengan tepat</td></tr>
<tr><td>2</td><td>2 dari 3 pertanyaan dilakukan</td></tr>
<tr><td>1</td><td>1 dari 3 pertanyaan dilakukan</td></tr>
<tr><td>0</td><td>Tidak dilakukan</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Pemeriksaan fisik:</td><td>Peserta ujian melakukan langkah-langkah berikut ini:
1. Mempersiapkan alat
2. Mepersiapkan diri
Mengukur tekanan darah
1. Memasang manset pada lokasi yang tepat
2. Menentukan sistolik melalui palpasi
3. Menentukan sistolik dan diastolic dengan auskultasi
4. Menyelesaikan tindakan pengukuran
Menghitung denyut nadi
1. Meletakan jari telunjuk dan jari tengah pada pembuluh darah ateri
2. Tekan sampai merasakan denyut nadi
3. Hitung selama 1 menit
4. Meletakkan thermometer pada axila
5. Tunggu hingga thermometer berbunyi
6. Membaca hasilnya</td><td>
<table>
<tr><th colspan="2">Skor</th><th>Keterangan</th></tr>
<tr><th>Bobot</th><th>AM</th><th></th></tr>
<tr><td rowspan="3">3</td><td>3</td><td>Semua (12) langkah dilakukan dengan tepat</td></tr>
<tr><td>2</td><td>7-11 dari 12 langkah dilakukan atau semua dilakukan tetapi sebagian kecil kurang tepat</td></tr>
<tr><td>1</td><td>1-6 dari 12 langkah dilakukan atau semua dilakukan tetapi sebagian besar kurang tepat</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td>Tidak dilakukan atau semua lanhkah dilakukan tetapi tidak ada satu pun yang tepat</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Prosedur tindakan:
• Melakukan pemeriksaan leopold, mengukur TFU, menghitung DJJ, melakukan penekanan pada ektermitas dan melakukan pemeriksaan protein urine</td><td>Peserta ujian melakukan langkah-langkah berikut ini:
1. Mempersiapkan alat
2. Mepersiapkan diri
3. Mengecek alat yang tersedia
4. Memposisikan manekin dengan baik
5. Meletakkan tangan di fundur uteri untuk melakukan pemeriksaan leopold, mengukur TFU, menghitung DJJ
6. Melakukan penekanan ekstermitas untuk oedema
7. Melakukan pemeriksaan protein urine
8. Menyelesaikan tindakan</td><td colspan="3"><table><tr><th colspan="2">Skor</th><th>Keterangan</th></tr><tr><th>Bobot</th><th>AM</th><th></th></tr><tr><td rowspan="4">2</td><td>3</td><td>Semua (8) langkah dilakukan dengan tepat</td></tr><tr><td>2</td><td>5-7 dari 8 langkah dilakukan atau semua dilakukan tetapi sebagian kecil kurang tepat</td></tr><tr><td>1</td><td>1-4 dari 8 langkah dilakukan atau semua dilakukan tetapi sebagian besar kurang tepat</td></tr><tr><td>0</td><td>Tidak dilakukan atau semua lanhkah dilakukan tetapi tidak ada satu pun yang tepat</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Perilaku professional: komunikasi dan kinerja</td><td>Peserta ujian menunjukkan perilaku profesional seperti berikut ini:
Komunikasi:
1. Mempertahankan kontak mata
2. Menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti
3. Bersuara dengan intonasi</td><td colspan="3"><table><tr><th colspan="2">Skor</th><th>Keterangan</th></tr><tr><th>Bobot</th><th>AM</th><th></th></tr><tr><td rowspan="2">2</td><td>3</td><td>Semua (8) perilaku profesional ditunjukkan oleh peserta ujian</td></tr><tr><td>2</td><td>5-7 dari 8 perilaku</td></tr></table></td></tr>
</table>

		yang jelas 4. Mempertahankan komunikasi 2 arah **Kinerja:** 1. Mengutamakan keselamatan pasien, diri, dan lingkungan 2. Menerapkan prinsip PI 3. Berkomunikasi walaupun berhadapan dengan model anatomi 4. Menjaga privasi			profesional ditunjukkan oleh peserta ujian
				1	**3-4** dari 8 perilaku profesional ditunjukkan oleh peserta ujian
				0	**<2 yang ditunjukkan atau Tidak** ditunjukkan satu pun perilaku professional oleh peserta ujian

Global performance

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan peserta ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

DOPS

Metode penilaian	DOPS merupakan metode penilaian berbasis observasi langsung terhadap keterampilan prosedural mahasiswa pada situasi klinik nyata atau simulasi klinik.	Pembimbing mengamati secara langsung bagaimana mahasiswa melakukan pengkajian ibu hamil dengan hipertensi gestasional sejak anamnesis, pemeriksaan fisik, penilaian janin, sampai perencanaan tindak lanjut.
Tujuan penilaian	Menilai kemampuan mahasiswa dalam melakukan pengkajian hipertensi pada kehamilan secara sistematis, aman, tepat, dan komunikatif.	Mahasiswa dinilai pada kemampuan membedakan hipertensi gestasional dari kondisi yang lebih berat, menilai faktor risiko, dan menentukan pemantauan yang sesuai.
Kasus klinik	Kasus dipilih sesuai capaian pembelajaran kebidanan mengenai deteksi dini komplikasi kehamilan dan pengambilan keputusan awal.	Kasus yang digunakan adalah ibu hamil 32 minggu dengan TD 146/94 mmHg dan 148/96 mmHg, protein urine negatif, tanpa tanda bahaya berat, dan DJJ 145 x/menit.
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Penguji mengamati keterampilan komunikasi, anamnesis terfokus, pemeriksaan fisik, interpretasi data, edukasi, dan dokumentasi.	Mahasiswa diminta menanyakan gejala, riwayat kesehatan, faktor risiko, memeriksa tekanan darah dan tanda vital, menilai DJJ, membaca hasil urine protein, lalu menyimpulkan hipertensi gestasional.
Aspek yang dinilai	Aspek mencakup persiapan, informed consent, keterampilan teknis, clinical reasoning, keselamatan pasien, profesionalisme, dan tindak lanjut.	Penilai memeriksa apakah mahasiswa mampu mengenali hipertensi baru setelah 20 minggu tanpa proteinuria dan tanpa tanda berat sebagai hipertensi gestasional.
Fokus observasi pembimbing	Pembimbing menilai kualitas urutan kerja, ketelitian, komunikasi, dan ketepatan prioritas klinis.	Pembimbing memperhatikan apakah mahasiswa mengulang pemeriksaan tekanan darah setelah istirahat, menilai tanda bahaya, dan tidak

		tergesa menyimpulkan preeklamsia tanpa dasar data.
Umpan balik	Umpan balik diberikan segera setelah tindakan untuk memperkuat hal yang sudah benar dan memperbaiki kekurangan.	Penguji dapat menekankan ketepatan teknik pengukuran tekanan darah, kelengkapan anamnesis, dan kejelasan edukasi kepada ibu.
Keputusan penilaian	Hasil diringkas sebagai kompeten, perlu supervisi, atau remedial.	Mahasiswa dinilai kompeten bila mampu melakukan pengkajian secara runtut, aman, dan dapat menyusun rencana pemantauan serta edukasi yang sesuai.
Makna dalam OBE	DOPS mendukung pembelajaran berbasis capaian karena menilai performa nyata, bukan hanya pengetahuan teoritis.	Kasus ini membuktikan mahasiswa mampu menerapkan pengkajian hipertensi dalam kehamilan secara langsung di praktik klinik.

PORTOPOLIO

1. OSCE + DOPS
2. Catatan kasus singkat
3. Refleksi patient safety
4. Feedback CI/dosen

Catatan untuk penulis: Portofolio bukan sekali ujian, tetapi kumpulan bukti yang menunjukkan konsistensi kompetensi mahasiswa pada berbagai kesempatan belajar.

Tabel 2.1
Portofolio pada Pengkajian Ibu Hamil dengan Hipertensi Gestasional

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Hipertensi Gestasional
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam OBE, portofolio digunakan untuk menilai performa nyata mahasiswa dari waktu ke waktu, bukan hanya dari satu kali ujian.	Pada topik hipertensi gestasional, portofolio memuat bukti bahwa mahasiswa mampu melakukan pengkajian ibu hamil secara sistematis, mengenali hipertensi baru setelah usia kehamilan 20 minggu, menilai ada atau tidaknya tanda bahaya, memantau kesejahteraan janin, memberikan edukasi, serta memperbaiki performa berdasarkan umpan balik.
Tujuan portofolio	Portofolio bertujuan mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, dan tindak lanjut perbaikan mahasiswa selama praktik.	Mahasiswa tidak hanya menunjukkan bahwa ia pernah menangani ibu hamil dengan hipertensi gestasional, tetapi juga menunjukkan bagaimana kemampuannya berkembang setelah mendapat masukan dari dosen atau CI.
OSCE dan DOPS	OSCE dan DOPS dapat menjadi bagian penting dalam portofolio karena memberikan bukti keterampilan terstruktur di laboratorium dan bukti performa nyata di lahan praktik.	OSCE dapat memuat hasil ujian keterampilan pengkajian ibu hamil dengan hipertensi, pemeriksaan tekanan darah yang benar, interpretasi urine protein, dan edukasi tanda bahaya. DOPS memuat hasil observasi langsung saat mahasiswa melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, interpretasi data, dan penentuan tindak lanjut pada kasus hipertensi gestasional.
Catatan kasus singkat	Catatan kasus singkat berisi ringkasan kasus pasien yang pernah ditangani mahasiswa,	Mahasiswa menuliskan ringkasan kasus ibu usia 29 tahun, G2P1A0, usia kehamilan 32 minggu, dengan TD

	data penting, masalah kebidanan, tindakan utama, dan hasil yang dicapai.	146/94 mmHg dan 148/96 mmHg pada pemeriksaan ulang, protein urine negatif, DJJ 145 x/menit, tanpa gejala berat, lalu mencatat tindakan pemantauan, edukasi, dan rencana kontrol ulang.
Refleksi patient safety	Refleksi patient safety menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi kesalahan, dan menyusun langkah pencegahan dalam asuhan kebidanan.	Mahasiswa merefleksikan pentingnya teknik pengukuran tekanan darah yang benar, pengulangan pemeriksaan setelah istirahat, pengkajian gejala bahaya, kewaspadaan terhadap kemungkinan progresi ke preeklamsia, serta komunikasi yang jelas kepada ibu dan keluarga.
Feedback CI/dosen	Umpan balik dari Clinical Instructor (CI) atau dosen menjadi bukti pembinaan yang menunjukkan area kekuatan dan area yang masih perlu ditingkatkan.	CI menuliskan bahwa mahasiswa sudah baik dalam membina komunikasi dan melakukan anamnesis terfokus, tetapi masih perlu meningkatkan ketelitian dalam interpretasi faktor risiko, penjelasan pemantauan serial tekanan darah, dan kejelasan edukasi mengenai tanda bahaya yang mengharuskan ibu segera kembali.
Karakteristik penilaian	Portofolio bukan penilaian sekali selesai, tetapi kumpulan bukti yang dibangun secara berulang dan berkesinambungan. Penekanan utamanya adalah konsistensi performa mahasiswa.	Mahasiswa dinilai bukan hanya dari satu kasus hipertensi gestasional, tetapi dari beberapa pengalaman belajar yang menunjukkan bahwa ia konsisten mampu mengukur tekanan darah dengan benar, mengenali gejala bahaya, menilai kesejahteraan janin, dan membuat keputusan tindak lanjut yang aman.
Bukti konsistensi kompetensi	Portofolio memperlihatkan apakah mahasiswa mampu mempertahankan mutu performa pada berbagai	Dari hasil OSCE, DOPS, catatan kasus, refleksi, dan umpan balik, terlihat bahwa mahasiswa secara konsisten mampu melakukan pengkajian ibu

	kesempatan praktik dan pada waktu yang berbeda.	hamil dengan hipertensi, membedakan hipertensi gestasional dari kondisi yang lebih berat, dan melakukan edukasi serta pemantauan secara tepat.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, portofolio memberikan bukti autentik bahwa capaian pembelajaran tidak hanya dimiliki secara teoritis, tetapi benar-benar tampak dalam performa yang berulang, berkembang, dan terdokumentasi.	Pada topik hipertensi gestasional, portofolio menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya memahami konsep hipertensi dalam kehamilan, tetapi juga konsisten mampu menerapkannya dalam praktik kebidanan nyata secara aman dan profesional.

Tabel 2.2
Case Report pada Hipertensi Gestasional dalam Kehamilan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Hipertensi Gestasional
Hakikat case report	Case report merupakan laporan singkat, sistematis, dan berbasis kasus nyata yang dikelola mahasiswa selama praktik klinik. Dalam OBE, case report menjadi bukti bahwa mahasiswa mampu memahami, menganalisis, dan mendokumentasikan kasus secara ilmiah serta klinis.	Mahasiswa menyusun laporan singkat tentang seorang ibu hamil 32 minggu dengan hipertensi baru setelah usia kehamilan 20 minggu, tanpa proteinuria dan tanpa tanda berat, yang datang untuk kontrol antenatal rutin.
Tujuan	Case report bertujuan menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan data pengkajian, analisis masalah, diagnosis kebidanan, rencana tindak lanjut, implementasi awal, dan evaluasi hasil secara logis.	Mahasiswa tidak hanya menuliskan data ibu, tetapi juga menjelaskan alasan kasus ini lebih mengarah pada hipertensi gestasional, kebutuhan pemantauan serial, edukasi, serta indikator eskalasi bila kondisi memburuk.
Isi laporan	Isi case report umumnya mencakup identitas singkat pasien, keluhan utama, data subjektif dan objektif, analisis masalah, diagnosis/masalah kebidanan, tindakan, implementasi, evaluasi, dan pembelajaran dari kasus.	Pada kasus ini mahasiswa menuliskan tengkuk tegang dan pusing ringan, TD 146/94 mmHg dan 148/96 mmHg pada pemeriksaan ulang, protein urine negatif, DJJ 145 x/menit, analisis hipertensi gestasional, rencana observasi, edukasi, dan pemantauan lanjutan.
Fokus penilaian	Penilaian difokuskan pada ketepatan pengkajian, relevansi analisis masalah, logika penalaran klinik, ketepatan tindakan awal, dan kemampuan mengevaluasi hasil asuhan.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menghubungkan hipertensi baru setelah 20 minggu, tidak adanya proteinuria, dan tidak adanya tanda bahaya sebagai kondisi hipertensi gestasional yang memerlukan pemantauan ketat, bukan preeklamsia.

Nilai edukatif	Case report membantu mahasiswa mengembangkan clinical reasoning, keterampilan dokumentasi, dan kebiasaan merefleksikan praktik klinik secara ilmiah.	Dari kasus ini, mahasiswa belajar bahwa pengukuran tekanan darah yang benar, pengkajian gejala bahaya, dan keputusan follow-up yang tepat merupakan inti keselamatan pada gangguan hipertensi dalam kehamilan.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, case report menjadi bukti bahwa mahasiswa mampu menerapkan teori ke dalam analisis kasus nyata secara sistematis dan bertanggung jawab.	Mahasiswa menunjukkan bahwa ia tidak hanya memahami konsep hipertensi gestasional, tetapi juga mampu menyusun laporan kasus yang menggambarkan asuhan kebidanan secara utuh.

Tabel 2.3
Refleksi Patient Safety pada Hipertensi Gestasional dalam Kehamilan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Hipertensi Gestasional
Hakikat refleksi patient safety	Refleksi patient safety merupakan tulisan singkat yang menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi masalah, dan merencanakan tindakan pencegahan.	Pada kasus hipertensi gestasional, mahasiswa merefleksikan bahwa keterlambatan mengenali kenaikan tekanan darah dan tidak melakukan pemantauan serial dapat menyebabkan kondisi berkembang menjadi lebih berat.
Tujuan	Refleksi ini bertujuan menumbuhkan kesadaran bahwa keselamatan pasien merupakan bagian penting dari setiap tindakan kebidanan.	Mahasiswa memahami bahwa kesalahan kecil seperti teknik pengukuran tekanan darah yang tidak tepat, tidak menanyakan gejala bahaya, atau tidak memberi edukasi yang jelas dapat berdampak pada keselamatan ibu dan janin.
Fokus refleksi	Fokus refleksi meliputi identifikasi risiko, analisis penyebab, tindakan pencegahan, dan	Mahasiswa menuliskan bahwa risiko utama pada kasus ini adalah progresi menjadi hipertensi berat atau preeklamsia, keterlambatan deteksi

	pembelajaran yang diperoleh mahasiswa dari pengalaman klinik.	tanda bahaya, dan keterlambatan eskalasi bila pemantauan tidak dilakukan dengan benar.
Risiko yang diidentifikasi	Mahasiswa perlu menunjukkan kemampuan mengenali situasi yang berpotensi membahayakan pasien.	Risiko yang diidentifikasi antara lain salah menilai hipertensi sebagai keluhan biasa, tidak mengulang pengukuran tekanan darah, tidak memeriksa protein urine, tidak menilai gerak janin, dan tidak menjadwalkan kontrol ulang lebih cepat.
Tindakan pencegahan	Mahasiswa menjelaskan langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko keselamatan pasien.	Mahasiswa menuliskan pentingnya teknik pengukuran tekanan darah yang benar, pemeriksaan ulang setelah istirahat, pengkajian gejala bahaya, pemantauan DJJ, edukasi kepada ibu, dan kolaborasi/rujukan bila muncul tanda perburukan.
Pembelajaran mahasiswa	Refleksi harus menunjukkan apa yang dipelajari mahasiswa dan bagaimana hal itu akan memengaruhi praktik berikutnya.	Mahasiswa menyadari bahwa pada hipertensi dalam kehamilan, pengkajian serial, clinical reasoning yang cermat, dan edukasi yang jelas adalah bagian penting dari praktik bidan yang aman.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, refleksi patient safety menunjukkan perkembangan sikap profesional, tanggung jawab klinik, dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa terhadap keselamatan pasien.	Mahasiswa membuktikan bahwa ia tidak hanya melakukan tindakan, tetapi juga mampu mengevaluasi risiko dan meningkatkan kualitas praktik kebidanan secara berkelanjutan.

L. Ringkasan Bab

Pengkajian ibu hamil dengan komplikasi merupakan fondasi utama asuhan kebidanan dan kolaboratif karena menentukan ketepatan deteksi dini, keselamatan ibu-janin, dan arah penatalaksanaan selanjutnya Anamnesis terfokus, pemeriksaan fisik yang sistematis, dan pemeriksaan penunjang yang sesuai indikasi harus dipandang sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi, bukan sebagai langkah yang berdiri sendiri

Dalam pelayanan maternal modern, mutu pengkajian sangat dipengaruhi oleh kompetensi klinis, kepatuhan pada pedoman, kemampuan komunikasi, dan kedisiplinan dokumentasi tenaga kesehatan Oleh karena itu, penguasaan pengkajian pada ibu hamil dengan komplikasi perlu ditekankan dalam pembelajaran teori, laboratorium keterampilan, dan praktik klinik agar lulusan mampu memberikan asuhan yang aman, bermutu, dan berpusat pada pasien

M. Red Flag

Hipertensi Gestasional dalam Kehamilan

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
Tekanan darah mencapai ≥160/110 mmHg	Menunjukkan hipertensi berat dan risiko progresi cepat	Lapor segera ke pembimbing/DPJP, lakukan penilaian cepat, dan siapkan kolaborasi/rujukan segera.
Muncul proteinuria	Meningkatkan kecurigaan preeklamsia	Ulang evaluasi lengkap, dokumentasikan hasil, dan eskalasi sesuai sistem rujukan.
Sakit kepala hebat menetap atau pandangan kabur	Mengarah pada keterlibatan neurologis	Jangan menunda; nilai cepat ibu dan siapkan eskalasi segera.
Nyeri ulu hati, sesak, atau edema mendadak	Mengarah pada perburukan kondisi maternal	Lakukan penilaian ulang, observasi ketat, dan siapkan rujukan.
Gerak janin berkurang atau DJJ tidak normal	Menunjukkan kemungkinan gangguan kesejahteraan janin	Pantau janin segera, lapor, dan percepat evaluasi lanjutan.

Tekanan darah tetap meningkat pada pemantauan serial	Menunjukkan perlunya re-evaluasi dan tindak lanjut lebih intensif	Jadwalkan follow-up ketat atau kolaborasi sesuai kebijakan layanan.
Keputusan rujukan sudah jelas tetapi proses tertunda	Menambah risiko ibu dan janin	Aktifkan rencana rujukan tanpa delay, lengkapi handover, komunikasikan kepada keluarga dan fasilitas penerima.

N. Form Checklist

- **Form Checklist "Saya sudah bisa…"**
- **Bab : Hipertensi Gestasional dalam Kehamilan**
- **Nama Mahasiswa : _____**
- **NIM : _____**
- **Tanggal : _____**
- **Tempat Praktik / Skill Lab : _____**
- *Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.*

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah bisa menjelaskan pengertian hipertensi gestasional.	☐	☐	_____
2	Saya sudah bisa menjelaskan perbedaan hipertensi gestasional dan preeklamsia.	☐	☐	_____
3	Saya sudah bisa melakukan anamnesis terarah pada ibu hamil dengan tekanan darah meningkat.	☐	☐	_____
4	Saya sudah bisa menanyakan gejala bahaya seperti sakit kepala hebat, pandangan kabur, nyeri ulu hati, dan sesak.	☐	☐	_____
5	Saya sudah bisa mengukur tekanan darah dengan teknik yang benar.	☐	☐	_____
6	Saya sudah bisa melakukan pengukuran ulang tekanan darah setelah istirahat.	☐	☐	_____

7	Saya sudah bisa menilai hasil protein urine pada kasus hipertensi dalam kehamilan.	☐	☐	_____
8	Saya sudah bisa menilai gerak janin dan DJJ sebagai bagian dari pengkajian.	☐	☐	_____
9	Saya sudah bisa mengenali kapan kasus masih dapat dipantau di fasilitas dasar.	☐	☐	_____
10	Saya sudah bisa menentukan kapan kasus harus dikolaborasikan atau dirujuk segera.	☐	☐	_____
11	Saya sudah bisa memberikan edukasi tanda bahaya kepada ibu dan keluarga.	☐	☐	_____
12	Saya sudah bisa menyusun rencana follow-up dan pemantauan serial tekanan darah.	☐	☐	_____
13	Saya sudah bisa mendokumentasikan temuan dan tindakan awal secara ringkas dan tepat.	☐	☐	_____
14	Saya sudah bisa menjaga privasi, keselamatan, dan perilaku profesional selama tindakan.	☐	☐	_____

Refleksi singkat mahasiswa:

_____
_____
_____
_____
_____
_____

O. Daftar Pustaka

Organization, W. H. (2016). WHO recommendations on antenatal care for a positive pregnancy experience. In WHO. WHO.

Karapanos, I. B. (2023). Strategies to communicate pregnancy complications: A systematic review and practical points for healthcare professionals. . Current Opinion in Obstetrics & Gynecology, 411–419.

Excellence., N. I. (2023). Hypertension in pregnancy: Diagnosis and management . National Institute for Health and Care Excellence. .

Afriani, S. M. (2024). Bunga Rampai Pemeriksaan Fisik Ibu Hamil. . Cilacap, Jawa tengah: PT MEDIA PUSTAKA INDO.

Gynecologists., A. C. (2020). Prelabor rupture of membranes . Obstetrics & Gynecology. Practice Bulletin No. 217.

M. Karjono, E. P. (2023). Pemanfaatan Buku Kesehatan Ibu dan Anak dengan Keteraturan Kunjungan Pemeriksaan Kehamilan. Empiricism Journal, 551-557.

Umar, A. A. (2019). Early warning systems in obstetrics: A systematic literature review. PLOS ONE.

Enny Fitriahadi, I. U. (2021). Tata Laksana Deteksi Dini Komplikasi Kehamilan Melalui Standar Pelayanan ANC Terpadu Di Poskesdes Kelurahan Sariharjo, Ngaglik Sleman, Yogyakarta . Uricol Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Klaten , 107-112.

Ariana Traub, A. S. (2024). Gangguan Hipertensi pada Kehamilan: Tinjauan Pustaka – Patofisiologi, Penanganan Saat Ini, Perspektif Masa Depan, dan Kesenjangan Pelayanan Kesehatan. PMC Pubmed Central.

Kesehatan, K. (2020). Pedoman Pelayanan Antenatal, Persalinan, Nifas, Dan Bayi Baru Lahir Di Era Adaptasi Kebiasaan Baru KEMENTRIAN KESEHTAN RI. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

Dona Rande Bua, D. M. (2024). Studi Literatur: Faktor yang Mempengaruhi Kejadian Anemia pada Ibu Hamil . rosiding Seminar Nasional dan Call for Paper Kebidanan Universitas Ngudi Waluyo . Semarang: Universitas Ngudi Waluyo.

Ari Fahrial Syam, M. S. (2013). Anamnesis dan Pemeriksaan Fisis Komprehensif. Jakarta: Interna Publishing.

Aikaterini Bekiou, K. G. (2020). Penurunan Gerakan Janin dan Kematian Perinatal. Materiasociomedica.

ACOG. (2021). Indikasi untuk Pemantauan Janin Antenatal Rawat Jalan. ACOG.

Liesa Beiera, A. L. (2025). Enhancing collaboration between midwives and obstetricians: A qualitative content analysis study. Elsevier Ltd on behalf of Australian College of Midwives.

BAB 3

GANGGUAN HIPERTENSI KEHAMILAN: DEFINISI, KRITERIA DIAGNOSTIK, DAN PEMANTAUAN

CPL

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menunjukkan profesionalisme, etika, dan tanggung jawab legal dalam pelayanan ibu hamil dengan komplikasi.	CPMK-1; CPMK-5; CPMK-7
CPL-2	Menerapkan komunikasi terapeutik, edukasi, dan kolaborasi interprofesional berpusat pada ibu–janin–keluarga.	CPMK-2; CPMK-5; CPMK-7
CPL-3	Menerapkan prinsip keselamatan pasien, PPI, K3, dan manajemen risiko dalam penanganan komplikasi kehamilan.	CPMK-1; CPMK-5; CPMK-6; CPMK-7
CPL-4	Melakukan pengkajian klinis serta interpretasi pemeriksaan penunjang untuk menentukan masalah dan tingkat kegawatan pada komplikasi kehamilan.	CPMK-2; CPMK-3; CPMK-4; CPMK-6
CPL-5	Merancang dan melaksanakan tata laksana awal/stabilisasi serta rujukan terstandar untuk komplikasi hipertensi, perdarahan, infeksi, dan anemia.	CPMK-3; CPMK-4; CPMK-5; CPMK-6; CPMK-7
CPL-6	Melakukan dokumentasi, rencana persalinan/rujukan, continuity of care, dan evaluasi berbasis evidence untuk peningkatan mutu layanan kehamilan komplikasi.	CPMK-1; CPMK-2; CPMK-7

CPMK

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menganalisis konsep dasar komplikasi kehamilan (hipertensi, perdarahan, infeksi, anemia) untuk deteksi dini, pencegahan, dan keselamatan ibu–janin sesuai pedoman.
CPMK-2	Melakukan pengkajian terfokus pada ibu hamil dengan komplikasi (anamnesis, pemeriksaan fisik, penunjang, dan pemantauan janin) serta menginterpretasi hasil untuk penentuan prioritas.

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-3	Menetapkan klasifikasi/derajat anemia kehamilan, melakukan skrining, menyusun tata laksana awal, serta menentukan indikasi rujukan/kolaborasi.
CPMK-4	Menetapkan diagnosis dan rencana pemantauan gangguan hipertensi kehamilan berdasarkan kriteria diagnostik dan risiko maternal–janin.
CPMK-5	Melaksanakan stabilisasi awal kegawatdaruratan terkait hipertensi berat/eclampsia dan infeksi sistemik/sepsis pada kehamilan serta menyiapkan rujukan aman dan tepat waktu.
CPMK-6	Melaksanakan penanganan awal kegawatdaruratan perdarahan trimester I–III dan menyiapkan rujukan sesuai standar.
CPMK-7	Merancang asuhan kolaboratif pada kehamilan dengan infeksi, ketuban pecah dini/persalinan prematur, dan penyakit penyerta; termasuk edukasi, rencana persalinan, dokumentasi, dan continuity of care.

Pemetaan Bab–Sub-CPMK–CPMK

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 1. Konsep Dasar Komplikasi Kehamilan: Deteksi Dini, Pencegahan, dan Keselamatan Ibu–Janin	1.1 Mengidentifikasi faktor risiko dan tanda bahaya utama komplikasi kehamilan berdasarkan trimester.	1.2 Menjelaskan strategi pencegahan primer/sekunder serta prinsip keselamatan ibu–janin (patient safety, PPI, K3) pada pelayanan antenatal.	CPMK-1	CPMK-2; CPMK-7
Bab 2. Pengkajian Ibu Hamil dengan Komplikasi: Anamnesis Terfokus, Pemeriksaan Fisik, dan Pemeriksaan Penunjang	2.1 Melakukan anamnesis terfokus dan penilaian triase kegawatan pada ibu hamil dengan keluhan komplikasi.	2.2 Menginterpretasi temuan pemeriksaan fisik dan penunjang untuk menetapkan masalah prioritas.	CPMK-2	CPMK-1; CPMK-5
Bab 3. Anemia pada Kehamilan: Klasifikasi, Skrining, Tata Laksana, dan Indikasi Rujukan	3.1 Mengklasifikasikan anemia kehamilan berdasarkan kadar Hb dan etiologi tersangka serta menilai derajat risiko.	3.2 Menyusun tata laksana awal anemia dan menentukan kriteria rujukan/kolaborasi serta rencana monitoring.	CPMK-3	CPMK-2; CPMK-7
Bab 4. Gangguan Hipertensi Kehamilan: Definisi,	4.1 Membedakan jenis gangguan hipertensi dalam kehamilan	4.2 Merancang pemantauan tekanan darah, gejala, dan parameter	CPMK-4	CPMK-2; CPMK-1

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Kriteria Diagnostik, dan Pemantauan	berdasarkan definisi dan kriteria diagnostik.	klinis/penunjang untuk deteksi perburukan.		
Bab 5. Preeklamsia Berat dan Eklampsia: Tanda Bahaya, Stabilisasi Awal, dan Rujukan	5.1 Mengidentifikasi tanda bahaya preeklamsia berat/eclampsia dan menilai prioritas stabilisasi (ABCDE).	5.2 Melaksanakan stabilisasi pra-rujukan dan menyiapkan komunikasi rujukan yang aman.	CPMK-5	CPMK-4; CPMK-2; CPMK-7
Bab 6. Perdarahan Trimester I: Abortus, Kehamilan Ektopik, dan Mola—Penanganan Awal dan Rujukan	6.1 Menilai perdarahan trimester I dan menyusun diferensial diagnosis (abortus/ektopik/mola) berbasis temuan klinis.	6.2 Melaksanakan penanganan awal (stabilisasi, pencegahan syok, persiapan rujukan) sesuai standar.	CPMK-6	CPMK-2; CPMK-5
Bab 7. Perdarahan Trimester II–III: Plasenta Previa dan Solusio Plasenta—Penanganan Awal dan Rujukan	7.1 Mengidentifikasi karakteristik perdarahan trimester II–III yang mengarah pada plasenta previa vs solusio plasenta serta risiko gawat janin.	7.2 Melaksanakan penanganan awal aman (stabilisasi, monitoring ibu–janin) dan menyiapkan rujukan emergensi.	CPMK-6	CPMK-2; CPMK-7
Bab 8. Ketuban Pecah Dini dan Persalinan Prematur: Penilaian Risiko, Pencegahan Infeksi, dan Rujukan	8.1 Menilai risiko pada KPD/persalinan prematur berdasarkan usia kehamilan, tanda infeksi, dan kondisi ibu–janin.	8.2 Menyusun tindakan awal pencegahan infeksi, edukasi kewaspadaan, dan alur rujukan/kolaborasi sesuai kriteria.	CPMK-7	CPMK-2; CPMK-1
Bab 9. Infeksi Saluran Kemih pada Kehamilan: Skrining, Tata Laksana Awal, dan Pencegahan Komplikasi	9.1 Melakukan skrining ISK pada kehamilan dan menilai risiko komplikasi (mis. pielonefritis).	9.2 Menyusun tata laksana awal dan edukasi pencegahan ISK serta rencana follow-up.	CPMK-7	CPMK-2; CPMK-1
Bab 10. Infeksi Reproduksi dan IMS pada Kehamilan: Skrining, Tata Laksana, dan Pencegahan Penularan	10.1 Mengidentifikasi indikasi skrining IMS/infeksi reproduksi dan menilai risiko penularan ibu–janin.	10.2 Merancang tata laksana awal/rujukan dan strategi pencegahan penularan (termasuk edukasi pasangan dan PPI).	CPMK-7	CPMK-1; CPMK-2
Bab 11. Infeksi Sistemik pada Kehamilan: Demam, Sepsis, dan Protokol	11.1 Mengidentifikasi kriteria demam/infeksi sistemik dan tanda sepsis untuk penentuan kegawatan.	11.2 Melaksanakan protokol stabilisasi pra-rujukan pada sepsis serta komunikasi rujukan terstandar.	CPMK-5	CPMK-2; CPMK-7; CPMK-1

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Stabilisasi Pra-Rujukan				
Bab 12. Penyakit Penyerta yang Memperberat Kehamilan: Diabetes, Jantung, dan Gangguan Tiroid (Kolaborasi)	12.1 Menilai dampak penyakit penyerta terhadap risiko maternal–janin dan tanda perburukan yang perlu diwaspadai.	12.2 Menyusun rencana asuhan kolaboratif dan rujukan terintegrasi sesuai peran dan kewenangan.	CPMK-7	CPMK-2; CPMK-1
Bab 13. Pemantauan Kesejahteraan Janin pada Kehamilan dengan Komplikasi: Pertumbuhan, DJJ, dan Tanda Gawat	13.1 Melakukan pemantauan kesejahteraan janin (gerak, DJJ, pertumbuhan, tanda gawat) sesuai indikasi.	13.2 Menginterpretasi hasil pemantauan untuk menentukan kebutuhan intervensi segera, eskalasi layanan, atau rujukan.	CPMK-2	CPMK-4; CPMK-6; CPMK-7
Bab 14. Edukasi, Rencana Persalinan, dan Rujukan pada Kehamilan Komplikasi: Komunikasi, Dokumentasi, dan Continuity of Care	14.1 Menyusun edukasi dan rencana persalinan/rujukan (BPCR) bersama ibu–keluarga secara komunikatif.	14.2 Melakukan dokumentasi terstandar, handover, dan rencana continuity of care termasuk jadwal follow-up.	CPMK-7	CPMK-1; CPMK-2; CPMK-5

Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-1	Ujian tulis berbasis kasus (MCQ/SAQ)	Akurasi identifikasi risiko/tanda bahaya ≥80% pada skenario; pilihan strategi pencegahan & keselamatan tanpa kesalahan kritis	10	Lembar jawaban; ringkasan rencana pencegahan (1 halaman)
CPMK-2	OSCE pengkajian terfokus + interpretasi penunjang (checklist)	Anamnesis terfokus ≥80% item; pemeriksaan fisik & penunjang/pemantauan janin tepat; prioritas tindakan/rujukan tepat	20	Checklist OSCE; lembar interpretasi kasus

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-3	Studi kasus tertulis + role-play konseling (lembar observasi)	Klasifikasi anemia & risiko tepat; rencana suplementasi/diet/monitoring sesuai; indikasi rujukan/kolaborasi tepat	10	Laporan studi kasus; lembar observasi role-play
CPMK-4	Ujian skenario + tugas algoritme pemantauan	Penetapan jenis/derajat hipertensi tepat (akurasi ≥80%); rencana pemantauan ibu–janin lengkap; kriteria eskalasi/rujukan tepat	15	Lembar ujian; algoritme pemantauan
CPMK-5	Simulasi kegawatdaruratan (OSCE) dengan checklist kritis	Langkah stabilisasi urut & aman; terapi awal sesuai protokol/kewenangan; komunikasi rujukan (SBAR) dan kesiapan transport aman	15	Checklist simulasi; form SBAR; catatan tindakan
CPMK-6	OSCE perdarahan + analisis kasus singkat	Triase & diferensial diagnosis tepat; stabilisasi syok/perdarahan tepat; menghindari tindakan kontraindikasi; keputusan rujukan tepat	15	Checklist OSCE; lembar analisis kasus
CPMK-7	Proyek rencana asuhan kolaboratif + audit dokumentasi	Care plan terintegrasi dengan trigger rujukan; edukasi BPCR & pencegahan konsisten; dokumentasi, handover, dan follow-up lengkap	15	Care plan; form audit dokumentasi; ringkasan edukasi

Rubrik CPMK (skala 1–4)

Rubrik CPMK-1

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1.1 Ketepatan identifikasi faktor risiko & tanda bahaya pada skenario kasus	Akurasi ≤60%; banyak red flag terlewat; prioritas tidak tepat	Akurasi 61–79%; beberapa red flag terlewat; prioritas kurang konsisten	Akurasi 80–89%; sebagian besar tepat; kekurangan minor	Akurasi ≥90%; lengkap, konsisten, dan memprioritaskan risiko dengan tepat
1.2 Ketepatan pemilihan	Tidak sesuai pedoman;	Sebagian sesuai pedoman; belum	Sesuai pedoman;	Sangat sesuai; lengkap, antisipatif,

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
strategi pencegahan & keselamatan (patient safety, PPI, K3)	ada potensi tindakan tidak aman	lengkap/kurang mempertimbangkan PPI/K3	lengkap dan aman	menyertakan mitigasi risiko & komunikasi keselamatan

Rubrik CPMK-2

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
2.1 Kelengkapan anamnesis terfokus dan triase kegawatan	<60% komponen; tidak sistematis; triase keliru	60–79% komponen; cukup sistematis; triase masih ragu/kurang tepat	80–89% komponen; sistematis; triase tepat	≥90% komponen; sangat sistematis, menggali red flag; triase cepat dan tepat
2.2 Ketepatan pemeriksaan fisik dan pemilihan penunjang/pemantauan janin	Pemeriksaan tidak relevan/tidak aman; penunjang tidak tepat	Pemeriksaan cukup; ada item penting terlewat; penunjang sebagian tepat	Pemeriksaan lengkap & aman; penunjang/pemantauan sesuai indikasi	Sangat lengkap, efisien; pilihan penunjang mempertimbangkan manfaat-risiko dan konteks layanan
2.3 Ketepatan interpretasi temuan dan penentuan prioritas tindakan/rujukan	Interpretasi keliru; prioritas salah/berisiko	Interpretasi sebagian benar; prioritas kurang jelas	Interpretasi benar; prioritas dan rencana tindak lanjut tepat	Interpretasi sangat akurat; reasoning jelas; menetapkan eskalasi/rujukan dan monitoring secara presisi

Rubrik CPMK-3

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
3.1 Ketepatan klasifikasi anemia, interpretasi Hb, dan	Salah klasifikasi; risiko tidak dinilai/keliru	Klasifikasi sebagian tepat; risiko dinilai namun belum lengkap	Klasifikasi tepat; risiko dinilai dengan baik	Klasifikasi sangat tepat; mempertimbangkan etiologi tersangka dan faktor komorbid secara komprehensif

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
penilaian risiko				
3.2 Ketepatan rencana tata laksana awal, monitoring, dan indikasi rujukan	Rencana tidak sesuai; monitoring/rujukan tidak jelas	Rencana sebagian sesuai; monitoring/rujukan masih umum	Rencana sesuai; monitoring jelas; indikasi rujukan tepat	Rencana sangat sesuai; monitoring terukur; indikasi rujukan/kolaborasi jelas dan antisipatif (termasuk edukasi kepatuhan)

Rubrik CPMK-4

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
4.1 Ketepatan penetapan jenis gangguan hipertensi dan derajat keparahan	Salah menetapkan; mengabaikan kriteria kunci	Sebagian tepat; ada kriteria terlewat	Tepat; kriteria utama terpenuhi	Sangat tepat; membedakan varian/derajat secara konsisten dan menyebutkan implikasi risiko
4.2 Kelengkapan rencana pemantauan (ibu–janin) dan kriteria eskalasi/rujukan	Tidak lengkap; tanpa kriteria eskalasi	Cukup; parameter belum menyeluruh; eskalasi kurang jelas	Lengkap; parameter & interval jelas; eskalasi/rujukan tepat	Sangat lengkap; parameter terukur, interval adaptif sesuai risiko; eskalasi/rujukan sangat jelas dan antisipatif

Rubrik CPMK-5

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.1 Kesesuaian langkah stabilisasi ABCDE dan pencegahan komplikasi segera	Urutan tidak tepat; ada tindakan tidak aman/terlewat kritis	Urutan cukup; masih perlu banyak arahan; ada komponen terlewat	Urutan tepat; aman; komponen utama terpenuhi	Urutan sangat tepat; cepat, aman, dan proaktif mencegah komplikasi (monitoring berkelanjutan)
5.2 Ketepatan terapi awal sesuai	Terapi tidak sesuai/berisiko; dosis/langkah keliru	Terapi sebagian sesuai; ada ketidaktepatan minor;	Terapi sesuai protokol/kewenangan; monitoring memadai	Terapi sangat tepat; menyesuaikan kondisi klinis; monitoring ketat dan

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
protokol dan kewenangan		monitoring kurang		mendokumentasikan respon
5.3 Kesiapan rujukan: komunikasi SBAR, dokumentasi, keselamatan transport	SBAR/dokumen tidak lengkap; kesiapan transport tidak aman	SBAR/dokumen cukup; ada data penting terlewat; transport belum optimal	SBAR jelas; dokumentasi lengkap; transport aman	SBAR sangat sistematis; dokumentasi lengkap + ringkasan tindakan/respon; koordinasi transport dan penerimaan rujukan sangat efektif

Rubrik CPMK-6

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
6.1 Ketepatan triase dan diferensial diagnosis perdarahan berdasarkan trimester	Triase keliru; diferensial tidak sesuai	Triase cukup; diferensial masih sempit/kurang tepat	Triase tepat; diferensial sesuai temuan	Triase sangat tepat; diferensial komprehensif dan memprioritaskan kondisi mengancam nyawa
6.2 Ketepatan stabilisasi awal dan kepatuhan tindakan aman (hindari kontraindikasi)	Stabilisasi tidak adekuat; melakukan/merencanakan tindakan kontraindikasi	Stabilisasi cukup; masih ada kekurangan; kontraindikasi dihindari sebagian	Stabilisasi adekuat; kontraindikasi dihindari; monitoring baik	Stabilisasi sangat adekuat; anticipatory management; monitoring ketat; sepenuhnya patuh tindakan aman
6.3 Ketepatan keputusan rujukan dan monitoring ibu–janin pra-rujukan	Keputusan rujukan tidak tepat/terlambat; monitoring minim	Rujukan cukup; monitoring belum terstruktur	Rujukan tepat waktu; monitoring terstruktur	Rujukan sangat tepat; monitoring ibu–janin jelas, terdokumentasi, dan komunikasi penerimaan rujukan efektif

Rubrik CPMK-7

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
7.1 Kualitas rencana asuhan kolaboratif	Care plan tidak terintegrasi; peran/rujukan tidak jelas	Care plan cukup; integrasi/koor	Care plan terintegrasi; koordinasi dan	Care plan sangat terintegrasi; koordinasi lintas layanan kuat; trigger

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
terintegrasi dan koordinasi layanan		dinasi sebagian	trigger rujukan jelas	rujukan, monitoring, dan mitigasi risiko sangat jelas
7.2 Kualitas edukasi dan rencana persalinan/rujukan (BPCR)	Edukasi tidak terarah; rencana tidak realistis	Edukasi cukup; rencana masih umum	Edukasi jelas; rencana disepakati dan aplikatif	Edukasi sangat efektif (teach-back); rencana rinci (tanda bahaya, transport, biaya, kontak) dan berorientasi keselamatan
7.3 Kelengkapan dokumentasi, handover, dan rencana *continuity of care*	Dokumentasi/handover tidak lengkap; tidak ada follow-up	Dokumentasi cukup; follow-up belum spesifik	Dokumentasi lengkap; handover jelas; follow-up terjadwal	Dokumentasi sangat lengkap dan rapi; handover terstruktur; continuity of care rinci (jadwal, indikator evaluasi, jejaring rujukan)

Uraian Materi

Gangguan hipertensi dalam kehamilan (HDK) berfokus pada kondisi di mana tekanan darah ibu hamil mencapai 140/90 mmHg. Kondisi ini merupakan salah satu penyebab utama kematian ibu (sekitar 28% menurut WHO) karena risiko komplikasinya terhadap organ vital. Secara fisiologis, kehamilan normal melibatkan adaptasi kardiovaskular seperti peningkatan volume plasma, penurunan resistensi vaskular, dan perubahan fungsi endotel. Pada hipertensi kehamilan, terjadi kegagalan adaptasi vaskular tubuh terhadap kehamilan, yang memicu vasospasme (penyempitan pembuluh darah) dan disfungsi endotel sehingga terjadi peningkatan tekanan darah, dan gangguan perfusi organ maternal serta plasenta. Akibatnya, dapat timbul komplikasi serius seperti pertumbuhan janin terhambat, solusio plasenta, prematuritas, hingga kematian janin intrauterin. Kondisi ini juga dipahami sebagai sindrom multisistem yang melibatkan ginjal, hati, otak, dan sistem hematologi.

Hipertensi dalam kehamilan didefinisikan sebagai peningkatan tekanan darah sistolik ≥140 mmHg dan/atau tekanan darah diastolik ≥90 mmHg yang terjadi setelah usia kehamilan 20 minggu pada wanita yang sebelumnya memiliki tekanan darah normal. Diagnosis ditegakkan melalui dua kali pengukuran tekanan darah dengan interval minimal empat jam menggunakan teknik pengukuran yang benar. Gangguan hipertensi dalam kehamilan (HDK) merupakan kelompok kondisi patologis yang ditandai dengan peningkatan tekanan darah selama kehamilan, persalinan, atau postpartum, yang berkontribusi signifikan terhadap morbiditas dan mortalitas maternal serta perinatal global. Pendekatan klinis terhadap hipertensi dalam kehamilan harus bersifat komprehensif, tidak hanya berfokus pada evaluasi tekanan darah tetapi juga mencakup pemeriksaan laboratorium, evaluasi kondisi ibu, pemantauan kesejahteraan janin dan tatalaksana terintegrasi, agar dapat mencegah komplikasi berat pada ibu (seperti eklampsia, stroke, atau kerusakan organ target).

Klasifikasi Gangguan Hipertensi dalam Kehamilan :

Gangguan hipertensi dalam kehamilan secara umum didefinisikan sebagai kondisi di mana tekanan darah sistolik mencapai ≥140 mmHg dan/atau tekanan darah diastolik mencapai ≥90 mmHg, yang biasanya memerlukan dua kali pengukuran terpisah untuk penegakan diagnosis (Agustini, R., D., et al., 2023). Klasifikasi gangguan ini terbagi menjadi empat kategori utama, yaitu:

1. Hipertensi Kronis (Hipertensi Esensial): Merupakan hipertensi yang sudah ada sebelum terjadinya kehamilan atau ditemukan sebelum usia kehamilan mencapai 20 minggu. Kondisi ini bersifat permanen dan tidak sembuh setelah proses persalinan.
2. Hipertensi Gestasional: Merupakan hipertensi yang baru muncul setelah usia

kehamilan melewati 20 minggu pada wanita yang sebelumnya memiliki tekanan darah normal, serta tidak disertai dengan proteinuria. Tekanan darah biasanya akan kembali normal setelah masa nifas.

3. Preeklampsia dan Eklampsia: Preeklampsia adalah hipertensi yang muncul setelah usia kehamilan 20 minggu yang disertai dengan proteinuria atau tanda-tanda disfungsi organ lainnya, seperti kerusakan ginjal, gangguan hati, atau gangguan saraf. Jika kondisi preeklampsia ini berlanjut hingga menyebabkan kejang, maka diklasifikasikan sebagai eklampsia.
4. Preeklampsia Superimposed pada Hipertensi Kronis: Kondisi ini terjadi ketika seorang ibu yang sudah memiliki riwayat hipertensi kronis mengalami perburukan kondisi selama kehamilan, yang ditandai dengan munculnya proteinuria atau gejala preeklampsia lainnya setelah usia kehamilan 20 minggu.

Tabel 3.1
Perbedaan Hipertensi kronis, hipertensi gastasional dan pre- eklampsia/eklampsia dan Preeklampsia Superimposed pada kehamilan

Fitur Pembeda	Hipertensi Kronis	Hipertensi Gestasional	Preeklampsia & Eklampsia	Preeklampsia Superimposed
Waktu Munculnya	Sebelum hamil atau usia kehamilan < 20 minggu.	Setelah usia kehamilan > 20 minggu.	Setelah usia kehamilan > 20 minggu.	Riwayat hipertensi kronis sebelum 20 minggu.
Proteinuria	Biasanya tidak ada (kecuali ada penyakit ginjal).	Tidak ada.	Ada (sebagai indikator utama kerusakan organ).	Baru muncul atau meningkat drastis setelah 20 minggu.
Penyebab Utama	Faktor genetik atau gaya hidup sebelum hamil.	Respon vaskular terhadap kehamilan.	Maladaptasi vaskular plasenta.	Komplikasi dari hipertensi kronis yang sudah ada.
Gejala Lain	Seringkali tanpa gejala tambahan.	Biasanya hanya tekanan darah tinggi.	Nyeri kepala, gangguan penglihatan, nyeri perut kanan atas.	Perburukan gejala hipertensi yang sudah ada secara mendadak.
Risiko Kejang	Sangat rendah.	Rendah.	Tinggi (jika menjadi eklampsia).	Tinggi.

Fitur Pembeda	Hipertensi Kronis	Hipertensi Gestasional	Preeklampsia & Eklampsia	Preeklampsia Superimposed
Kondisi Pasca Persalinan	Tetap hipertensi setelah 12 minggu nifas.	Kembali normal setelah masa nifas.	Kembali normal setelah plasenta lahir & nifas.	Tetap hipertensi (kembali ke level kronis awal).

A. Pre-eklampsia dan Eklampsia

Preeklampsia merupakan penyulit kehamilan yang sangat spesifik, ditandai dengan munculnya hipertensi (tekanan darah sistolik ≥140 mmHg atau diastolik ≥90 mmHg) yang disertai dengan proteinuria atau gangguan multisistem lainnya setelah usia kehamilan mencapai 20 minggu pada wanita yang sebelumnya normotensif (Agustini, R., D., et al., 2023).

Secara patofisiologi, kondisi ini berkaitan erat dengan kegagalan invasi trofoblas pada arteri spiralis yang menyebabkan iskemia plasenta dan pelepasan faktor-faktor anti-angiogenik ke dalam sirkulasi ibu, sehingga memicu kerusakan endotel luas dan disfungsi organ seperti ginjal, hati, serta sistem saraf pusat (Rahayu, S., et al., 2025). Apabila kondisi ini tidak tertangani dengan baik dan berkembang menjadi Preeklampsia Berat (PEB), ibu hamil dapat mengalami gejala klinis yang lebih serius seperti nyeri kepala hebat, gangguan penglihatan, hingga edema paru (Siregar, E., P., et al., 2024).

Tingkatan paling fatal dari spektrum gangguan ini adalah Eklampsia, yang didefinisikan sebagai timbulnya kejang tonik-klonik umum dan/atau koma yang terjadi pada penderita preeklampsia tanpa adanya penyebab neurologis lain (Iryaningrum, M., R., et al., 2023). Eklampsia darurat medis yang dapat terjadi pada masa antepartum, intrapartum, maupun postpartum, dan memerlukan penanganan segera karena mengancam nyawa ibu akibat risiko perdarahan otak serta mengancam janin akibat hipoksia berat (Laksono, S., Marshaly, S., M., 2022; Siregar, E., P., et al., 2024).

Tabel 3.2
Faktor risiko timbulnya pre-eklampsia

Kategori Risiko	Faktor Risiko Spesifik
Risiko Tinggi (High Risk)	1. Riwayat preeklampsia pada kehamilan sebelumnya. 2. Kehamilan multipel (kembar). 3. Hipertensi kronis. 4. Diabetes Melitus (Tipe 1 atau 2). 5. Penyakit Ginjal. 6. Penyakit Autoimun (misal: SLE atau sindrom antifosfolipid). (Iryaningrum, M., R., et al., 2023; Rahayu, S., et al., 2025)
Risiko Sedang/Menengah (Moderate Risk)	1. Primigravida (kehamilan pertama). 2. Usia ibu ≥35 tahun. 3. Obesitas (IMT >30 kg/m²). 4. Riwayat keluarga dengan preeklampsia (ibu atau saudara kandung). 5. Jarak antar kehamilan >10 tahun. (Iryaningrum, M., R., et al., 2023; Siregar, E., P., et al., 2024).
Risiko Rendah (Low Risk)	1. Riwayat persalinan sebelumnya normal (aterm) tanpa komplikasi preeklampsia. 2. Tidak memiliki satu pun faktor risiko di atas. (Iryaningrum, M., R., et al., 2023)

Patofisiologi preeklampsia terjadi melalui dua tahap utama yang diawali dengan kegagalan remideling arteri spiralis pada awal kehamilan. Dalam kondisi normal, sel trofoblas menyerbu arteri spiralis ibu untuk mengubahnya menjadi saluran berdiameter besar dengan resistensi rendah guna menjamin aliran darah yang adekuat ke janin. Namun, pada preeklampsia, terjadi kegagalan invasi trofoblas yang menyebabkan arteri spiralis tetap sempit dan kaku, sehingga memicu kondisi iskemia atau kurangnya aliran oksigen pada plasenta (Rahayu, S., et al., 2025; Laksono, S., Marshaly, S., M., 2022). Plasenta yang mengalami iskemia ini kemudian melepaskan berbagai faktor anti-angiogenik dan radikal bebas ke dalam sirkulasi darah ibu sebagai bentuk respon stres oksidatif. Faktor-faktor tersebut menyebabkan kerusakan pada lapisan endotel (lapisan dalam pembuluh darah) di seluruh tubuh ibu, yang dikenal sebagai disfungsi endotel sistemik (Iryaningrum, M., R., et al., 2023).

Disfungsi endotel inilah yang menjadi penyebab munculnya berbagai gejala klinis preeklampsia. Kerusakan pada pembuluh darah menyebabkan kebocoran cairan ke jaringan sekitarnya (edema) dan peningkatan sensitivitas pembuluh darah terhadap zat penyempit darah (vasokonstriktor), yang pada akhirnya mengakibatkan lonjakan tekanan darah atau hipertensi (Laksono, S., Marshaly, S., M., 2022).

Di organ ginjal, kerusakan endotel menyebabkan kebocoran protein ke dalam urine yang kita kenal sebagai proteinuria. Jika kerusakan ini mencapai pembuluh darah di otak, maka akan terjadi edema serebral yang dapat memicu kejang atau eklampsia, sementara kerusakan pada pembuluh darah hati dapat menyebabkan nyeri ulu hati akibat peregangan kapsul organ tersebut (Iryaningrum, M., R., et al., 2023; Rahayu, S., et al., 2025). Seluruh rangkaian proses ini menunjukkan bahwa preeklampsia bukan sekadar penyakit tekanan darah, melainkan penyakit pada plasenta yang berdampak buruk pada seluruh sistem pembuluh darah ibu.

Tabel 3.3
Penanganan Pre-eklampsia pada kehamilan

Jenis Preeklampsia	Strategi Penanganan Utama	Tindakan Spesifik & Farmakologi
Preeklampsia Ringan	Monitoring Ketat (Rawat Jalan/Inap)	1. Pemantauan tekanan darah 2x seminggu. 2. Cek urin (proteinuria) dan kondisi janin (NST/USG) secara berkala. 3. Tirah baring (istirahat cukup) tidak wajib namun disarankan menghindari aktivitas berat (Iryaningrum, M., R., et al., 2023).
Preeklampsia Berat (PEB)	Stabilisasi & Rawat Inap Segera	1. Pemberian Anti-kejang: Magnesium Sulfat ($MgSO_4$) sebagai lini pertama untuk mencegah eklampsia. 2. Pemberian Anti-hipertensi: Nifedipine, Metildopa, atau Labetalol jika TD ≥160/110 mmHg. 3. Pematangan paru janin (Kortikosteroid) jika usia kehamilan <34 minggu (Siregar, E., P., et al., 2024; Iryaningrum, M., R., et al., 2023).
Manajemen Ekspektatif	Mempertahan Kehamilan (Jika Kondisi Stabil)	1. Dilakukan pada usia kehamilan preterm (<34 minggu) untuk memberikan waktu pematangan paru janin. 2. Dilakukan observasi ketat terhadap tanda-tanda "Impending Eclampsia" (Iryaningrum, M., R., et al., 2023)
Manajemen Aktif (Terminasi)	Persalinan/Melahirkan Bayi & Plasenta	1. Dilakukan jika usia kehamilan ≥37 minggu (aterm). 2. Segera dilakukan tanpa memandangusia

Jenis Preeklampsia	Strategi Penanganan Utama	Tindakan Spesifik & Farmakologi
		kehamilan jika ada tanda kegawatan ibu (eklampsia, edema paru, solusio plasenta) atau gawat janin (Siregar, E., P., et al., 2024; Iryaningrum, M., R., et al., 2023)

Waktu persalinan untuk pre-eklampsia :

1. Persalinan pada kasus preeklampsia tanpa gejala berat atau preeklampsia ringan sangat disarankan untuk dilakukan saat usia kehamilan sudah mencapai masa aterm, yaitu 37 minggu. Selama usia kehamilan belum mencapai batas tersebut, tenaga kesehatan biasanya akan menerapkan manajemen ekspektatif atau pemantauan ketat guna memberikan waktu bagi janin untuk tumbuh lebih matang di dalam rahim, sembari terus memantau kondisi tekanan darah dan kesejahteraan janin secara berkala agar tidak terjadi perburukan kondisi yang mendadak (Iryaningrum, M., R., et al., 2023)
2. Untuk kondisi Preeklampsia Berat (PEB), waktu persalinan sangat bergantung pada stabilitas kondisi ibu dan usia kehamilan saat terdiagnosis. Jika usia kehamilan telah mencapai atau melebihi 34 minggu, persalinan harus segera direncanakan setelah dilakukan stabilisasi kondisi ibu melalui pemberian anti-kejang Magnesium Sulfat (MgSO4) dan obat anti-hipertensi. Namun, jika usia kehamilan masih di bawah 34 minggu, dokter dapat mempertimbangkan penundaan persalinan selama kurang lebih 48 jam hanya untuk memberikan waktu bagi pemberian suntikan kortikosteroid guna mematangkan paru janin, dengan catatan kondisi ibu dan janin tetap stabil selama pemantauan tersebut (Iryaningrum, M., R., et al., 2023; Siregar, E., P., et al., 2024).
3. Terminasi atau persalinan harus segera dilakukan tanpa memandang usia kehamilan apabila ditemukan tanda-tanda kegawatdaruratan medis yang mengancam nyawa. Kondisi kritis tersebut meliputi terjadinya kejang atau eklampsia, munculnya edema paru (cairan di paru-paru), terjadinya solusio plasenta (plasenta terlepas sebelum waktunya), gawat janin, serta munculnya sindrom HELLP yang merusak sel darah dan fungsi hati ibu. Dalam situasi ini, melahirkan bayi dan plasenta adalah satu-satunya jalan untuk menghentikan proses penyakit dan menyelamatkan ibu, karena plasenta merupakan sumber utama dari gangguan endotel yang terjadi selama preeklampsia (Siregar, E., P., et al., 2024; Laksono, S., Marshaly, S., M., 2022).

Eklamsia merupakan komplikasi akut dan paling berat dalam spektrum gangguan hipertensi kehamilan yang didefinisikan sebagai timbulnya kejang tonik-klonik umum dan/atau koma pada wanita hamil yang sebelumnya telah didiagnosis preeklamsia, tanpa adanya penyebab neurologis lain seperti epilepsi (Iryaningrum, M., R., et al., 2023). Secara patofisiologi, kondisi ini berakar pada kegagalan remideling arteri spiralis yang menyebabkan iskemia plasenta, yang kemudian memicu kerusakan endotel pembuluh darah secara sistemik akibat pelepasan faktor inflamasi ke darah ibu (Rahayu, S., et al., 2025). Ketika kerusakan ini mencapai otak, terjadi kegagalan otoregulasi aliran darah serebral yang menyebabkan edema otak (pembengkakan), sehingga memicu aktivitas listrik saraf yang berlebihan berupa kejang hebat yang dapat mengancam nyawa ibu akibat risiko perdarahan otak dan mengancam janin akibat hipoksia berat (Iryaningrum, M., R., et al., 2023; Siregar, E., P., et al., 2024).

Gejala eklamsia dapat muncul secara mendadak, namun sering kali didahului oleh tanda-tanda bahaya seperti nyeri kepala hebat yang menetap, gangguan penglihatan serta nyeri ulu hati yang hebat akibat edema organ hati. Penanganan utama dalam kondisi darurat ini adalah stabilisasi ibu melalui pemberian Magnesium Sulfat (MgSO4) sebagai obat lini pertama untuk menghentikan kejang serta pemberian obat anti-hipertensi jika tekanan darah sangat tinggi. Setelah kondisi ibu stabil, satu-satunya terapi definitif untuk menghentikan proses penyakit ini adalah dengan segera melakukan persalinan atau terminasi kehamilan tanpa memandang usia janin (Iryaningrum, M., R., et al., 2023).

B. Hipertensi Kronis pada Kehamilan

Hipertensi kronis didefinisikan sebagai tekanan darah sistolik ≥140 mmHg dan/atau tekanan darah diastolik ≥90 mmHg yang sudah ada sebelum kehamilan atau ditemukan sebelum usia kehamilan mencapai 20 minggu. Kondisi ini bersifat permanen dan tidak hilang setelah masa nifas berakhir, jika hipertensi baru ditemukan setelah usia 20 minggu namun tetap menetap hingga lebih dari 12 minggu pasca persalinan, maka kondisi tersebut juga dikategorikan sebagai hipertensi kronis. Diagnosis yang akurat memerlukan pengukuran tekanan darah minimal dua kali dengan jarak waktu minimal 4 jam untuk memastikan angka yang konsisten (Iryaningrum, M., R., et al., 2023).

Penyebab utama hipertensi kronis pada sebagian besar ibu hamil adalah hipertensi esensial atau primer, yang sangat dipengaruhi oleh faktor genetik, pola hidup, serta usia ibu yang sudah lanjut saat hamil (di atas 35 tahun). Selain itu, terdapat pula hipertensi sekunder yang dipicu oleh penyakit penyerta seperti gangguan ginjal kronis, penyakit pembuluh darah, atau gangguan endokrin seperti

diabetes melitus. Riwayat keluarga dengan hipertensi dan adanya obesitas juga menjadi faktor risiko signifikan yang dapat memperburuk kondisi vaskular ibu selama masa kehamilan (Rahayu, S., et al., 2025).

Dalam kehamilan normal, tubuh seharusnya menurunkan resistensi pembuluh darah agar aliran darah ke janin meningkat, namun pada penderita hipertensi kronis, mekanisme adaptasi ini terganggu sehingga beban kerja jantung menjadi jauh lebih berat. Kondisi pembuluh darah yang sudah tidak sehat ini juga berisiko tinggi memicu gangguan pada plasenta (iskemia), yang pada tahap lanjut dapat menyebabkan *superimposed preeclampsia*, yaitu munculnya gejala preeklampsia tambahan yang memperparah kerusakan organ ibu (Laksono, S., Marshaly, S., M., 2022).

Penanganan difokuskan pada pengendalian tensi agar tetap berada pada rentang yang aman bagi ibu dan janin, yaitu sekitar 130-145/80-95 mmHg. Penggunaan obat anti-hipertensi seperti Metildopa, Nifedipine, atau Labetalol biasanya dimulai jika tekanan darah mencapai ≥150/100 mmHg guna mencegah risiko stroke atau gagal jantung pada ibu. Selain pengobatan, ibu dengan hipertensi kronis juga disarankan untuk mengonsumsi Aspirin dosis rendah sejak awal kehamilan untuk mencegah terjadinya kerusakan endotel yang lebih parah atau perkembangan menuju preeklampsia berat (Iryaningrum, M., R., et al., 2023; Laksono, S., Marshaly, S., M., 2022).

Waktu persalinan ditentukan oleh stabilitas kondisi ibu dan ada tidaknya komplikasi tambahan. Jika hipertensi kronis terkendali dengan baik tanpa komplikasi, persalinan direkomendasikan pada usia kehamilan 38 hingga 39 minggu. Namun, jika kondisi memburuk menjadi *superimposed preeclampsia* tanpa gejala berat, persalinan dilakukan di usia 37 minggu. Jika muncul gejala berat atau kondisi darurat seperti tekanan darah yang sulit dikontrol, gangguan fungsi ginjal, atau gawat janin, maka terminasi kehamilan harus segera dilakukan tanpa memandang usia janin guna menyelamatkan nyawa ibu (Iryaningrum, M., R., et al., 2023; Laksono, S., Marshaly, S., M., 2022).

C. Hipertensi kronis yang disertai pre-eklampsia

Superimposed preeclampsia adalah kondisi di mana preeklampsia muncul pada ibu hamil yang sebelumnya sudah memiliki riwayat hipertensi kronis. Diagnosis ini ditegakkan apabila pada ibu dengan hipertensi kronis (sudah ada sebelum hamil atau sebelum usia 20 minggu) ditemukan adanya proteinuria yang baru muncul, atau terjadi peningkatan tajam tekanan darah secara mendadak yang sebelumnya terkontrol. Selain itu, munculnya gejala sistemik seperti gangguan fungsi hati (peningkatan enzim hati), penurunan trombosit, atau nyeri kepala hebat

juga menjadi indikator kuat meskipun proteinuria tidak ditemukan (Iryaningrum, M., R., et al., 2023).

Patofisiologi kondisi ini jauh lebih berbahaya karena merupakan penggabungan dari kerusakan pembuluh darah kronis (menahun) dengan disfungsi endotel akut akibat iskemia plasenta. Pada ibu dengan hipertensi kronis, pembuluh darah sudah mengalami kekakuan, sehingga ketika terjadi kegagalan invasi trofoblas, respon inflamasi sistemik yang dilepaskan plasenta akan merusak organ tubuh ibu dengan jauh lebih cepat dan berat dibandingkan preeklampsia biasa. Hal ini meningkatkan risiko terjadinya solusio plasenta, gagal ginjal akut, hingga perdarahan otak pada ibu (Rahayu, S., et al., 2025).

Penanganan utama untuk kondisi ini melibatkan pemantauan ketat dan pemberian terapi profilaksis. Karena risiko perburukannya sangat tinggi, ibu dengan hipertensi kronis sangat dianjurkan untuk mengonsumsi Aspirin dosis rendah (80–150 mg) yang dimulai sebelum usia kehamilan 16 minggu guna melindungi lapisan endotel pembuluh darah. Jika tekanan darah melonjak drastis hingga mencapai hipertensi berat (≥160/110 mmHg), pemberian anti-hipertensi agresif dan Magnesium Sulfat (MgSO4) harus segera dilakukan untuk mencegah terjadinya kejang atau eklamsia (Rahayu, S., et al., 2025).

Waktu persalinan untuk *superimposed preeclampsia* ditentukan berdasarkan beratnya gejala klinis. Jika kondisi ini tidak disertai gejala berat (preeklampsia ringan di atas hipertensi kronis), persalinan dapat dilakukan pada usia kehamilan 37 minggu. Namun, jika kondisi berkembang menjadi *superimposed preeclampsia* dengan gejala berat, maka terminasi kehamilan harus segera dilakukan pada usia 34 minggu. Jika muncul kegawatdaruratan seperti sindrom HELLP atau gawat janin sebelum usia tersebut, persalinan harus dilakukan segera tanpa memandang usia janin guna mencegah kematian ibu (Iryaningrum, M., R., et al., 2023; Laksono, S., Marshaly, S., M., 2022).

D. Hipertensi gestasional

Hipertensi gestasional adalah tekanan darah tinggi yang baru muncul pertama kali setelah usia kehamilan mencapai 20 minggu, tanpa disertai adanya proteinuria (protein dalam urin) atau tanda-tanda kerusakan organ sistemik lainnya. Kondisi ini ditandai dengan angka tekanan darah sistolik ≥140 mmHg dan/atau diastolik ≥90 mmHg. Salah satu karakteristik utama dari hipertensi gestasional adalah tekanan darah akan kembali menjadi normal (normotensi) dalam waktu kurang dari 12 minggu setelah persalinan. Jika tekanan darah tetap tinggi setelah melewati masa 12 minggu pasca persalinan, maka diagnosisnya akan berubah menjadi hipertensi kronis (Iryaningrum, M., R., et al., 2023).

Secara patofisiologi, hipertensi gestasional dianggap sebagai bentuk gangguan hipertensi yang lebih ringan karena belum terjadi kerusakan endotel pembuluh darah yang luas sebagaimana pada preeklampsia. Kondisi ini diduga terjadi akibat ketidakmampuan sistem kardiovaskular ibu untuk beradaptasi sepenuhnya terhadap peningkatan volume darah dan curah jantung selama kehamilan. Meskipun tidak disertai proteinuria, peningkatan resistensi pembuluh darah tetap terjadi, yang jika tidak dipantau dengan baik, dapat berkembang menjadi preeklampsia pada sekitar 15% hingga 25% kasus, terutama jika hipertensi muncul lebih awal di trimester kedua (Laksono, S., Marshaly, S., M., 2022).

Faktor risiko yang memicu timbulnya hipertensi gestasional serupa dengan preeklampsia, meliputi kehamilan pertama (primigravida), usia ibu yang ekstrem (terlalu muda atau di atas 35 tahun), serta obesitas. Karena hipertensi gestasional berisiko berubah menjadi preeklampsia, ibu hamil dengan kondisi ini memerlukan pemantauan ketat berupa pemeriksaan tekanan darah rutin dan cek urin berkala untuk mendeteksi munculnya proteinuria sedini mungkin. Pemantauan kesejahteraan janin melalui USG juga penting dilakukan untuk memastikan tidak terjadi hambatan pertumbuhan janin akibat gangguan aliran darah plasenta (Rahayu, S., et al., 2025).

Manajemen utama pada hipertensi gestasional adalah observasi dan pengendalian tekanan darah. Penggunaan obat anti-hipertensi seperti Metildopa atau Nifedipine biasanya dipertimbangkan jika tekanan darah mencapai angka ≥150/100 mmHg guna mencegah lonjakan ke arah hipertensi berat (≥160/110 mmHg). Target terapi adalah menjaga tensi pada kisaran yang aman bagi ibu namun tetap menjamin aliran darah yang cukup ke janin. Jika kondisi ibu tetap stabil dan tidak muncul tanda-tanda preeklampsia, ibu biasanya diperbolehkan untuk rawat jalan dengan anjuran istirahat yang cukup (Iryaningrum, M., R., et al., 2023).

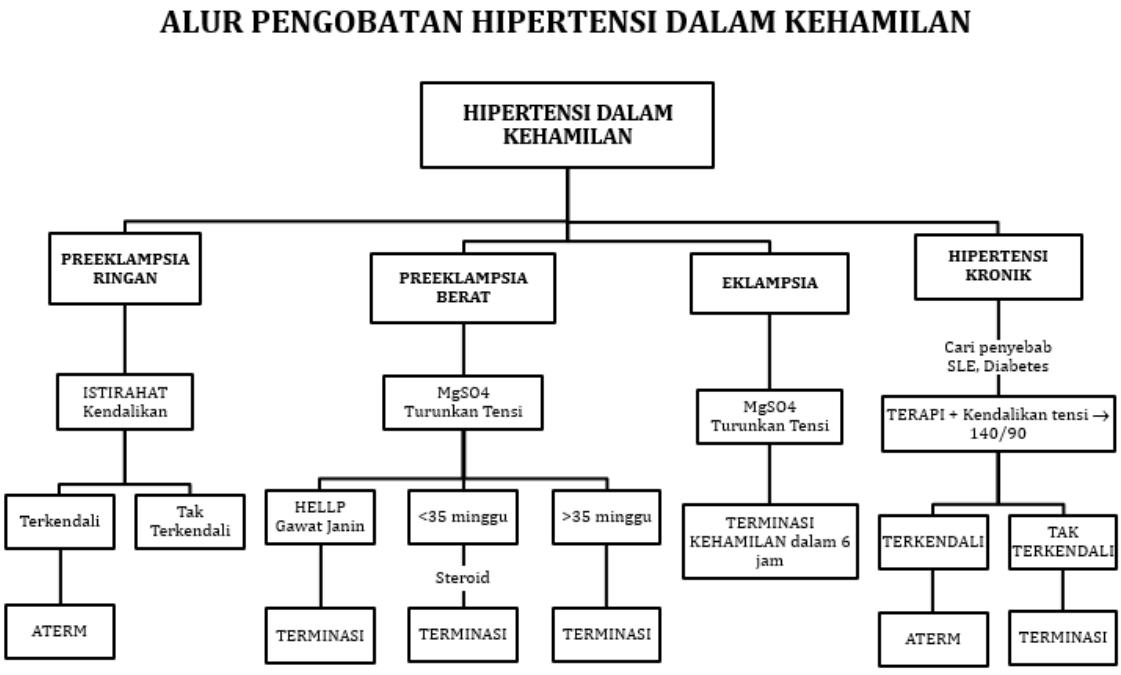
Pada waktu persalinan yang direkomendasikan untuk ibu dengan hipertensi gestasional yang terkendali adalah pada usia kehamilan 37 minggu (aterm). Namun, jika dalam masa pemantauan terjadi perburukan kondisi seperti tekanan darah yang tidak terkontrol atau munculnya gejala preeklampsia berat (seperti nyeri kepala hebat atau gangguan penglihatan), maka persalinan harus dilakukan lebih awal tanpa menunda, demi keselamatan ibu dan bayi (Laksono, S., Marshaly, S., M., 2022).

Alur Rujukan Untuk Kasus Hipertensi Dalam Kehamilan

Apabila dalam masa pemantauan ditemukan tanda-tanda kegawatdaruratan seperti Preeklampsia Berat (PEB) atau Eklamsia, rujukan harus dilakukan secara cepat dan tepat menggunakan ambulans dengan pendampingan tenaga kesehatan. Sebelum pasien dipindahkan, bidan atau dokter di Puskesmas wajib

melakukan stabilisasi terlebih dahulu dengan memberikan dosis muat Magnesium Sulfat (MgSO4) untuk mencegah terjadinya kejang selama perjalanan, serta memberikan obat anti-hipertensi jika tekanan darah mencapai ≥160/110 mmHg. Selain itu, pemasangan kateter urin harus dilakukan untuk memantau output cairan secara ketat guna menghindari risiko komplikasi sistemik seperti gagal ginjal akut atau edema paru saat proses pemindahan pasien berlangsung (Iryaningrum, M., R., et al., 2023; Siregar, E., P., et al., 2024).

Setelah dilakukan penanganan di Rumah Sakit, alur manajemen dilanjutkan dengan rujukan terencana untuk menentukan waktu persalinan yang paling aman; bagi kasus hipertensi kronis tanpa komplikasi, persalinan biasanya direncanakan pada usia 38–39 minggu, sedangkan jika muncul tanda preeklampsia, rujukan terminasi dipercepat ke usia 37 minggu. Proses rujukan ini tidak berhenti saat persalinan usai, melainkan dilanjutkan dengan sistem rujukan balik ke fasilitas kesehatan primer setelah kondisi ibu dinyatakan stabil. Hal ini dilakukan agar bidan dapat terus memantau ibu selama masa nifas, mengingat risiko komplikasi neurologis seperti eklamsia postpartum tetap mengintai hingga 12 minggu setelah melahirkan, sehingga koordinasi antar tingkat fasilitas kesehatan tetap harus terjaga secara berkesinambungan (Iryaningrum, M., R., et al., 2023; Laksono, S., Marshaly, S., M., 2022).



Gambar 3.1
Alur Pengobatan Hipertensi dalam Kehamilan
(Sumber ; google)

E. Aktivitas 1 — *Knows How*

Mini-case tertulis (diskusi kelompok)

Seorang perempuan usia 27 tahun, G2P1A0, usia kehamilan 34 minggu datang ke puskesmas untuk pemeriksaan antenatal rutin. Ibu mengeluh sakit kepala sejak dua hari terakhir dan merasa penglihatannya terkadang kabur. Hasil pemeriksaan di dapatkan : keadaan umum baik, TD 150/100 mmHg, nadi 92 x/menit, suhu 36,9°C, TFU sesuai usia kehamilan, DJJ 148 x/menit, urine dipstick : Protein +1. Bidan kemudian melakukan pemeriksaan lanjutan dan memberikan edukasi kepada ibu mengenai kondisi yang dialami.

Pertanyaan Diskusi

1. Apa diagnosis yang paling mungkin pada kasus tersebut?
2. Data apa saja yang mendukung diagnosis tersebut?
3. Pemeriksaan tambahan apa yang perlu dilakukan?
4. Apa saja tanda bahaya yang harus dipantau pada ibu?
5. Bagaimana rencana pemantauan ibu dan janin?
6. Kapan ibu perlu dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap?
7. Edukasi apa yang perlu diberikan kepada ibu dan keluarga?

Soal OSCE Kebidanan

No.	Komponen	Isi
1	No. Stasiun	1
2	Judul	Komplikasi Kehamilan : Gangguan Hipertensi dalam Kehamilan / Suspek Preeklampsia
3	Kasus	Deteksi dini hipertensi kehamilan pada pelayanan antenatal dan penatalaksanaan awal
4	Tujuan	Untuk mengetahui bahwa peserta dapat menunjukkan kriteria sebagai calon bidan yang kompeten dalam penanganan kasus hipertensi pada kehamilan
5	Kompetensi	1. Anamnesis 2. Pemeriksaan fisik dan/atau laboratorium sederhana 3. Perumusan diagnosis dan/atau masalah 4. Prosedur tindakan klinis 5. KIE/konseling 6. Kolaborasi/rujukan 7. Perilaku profesional
6	Soal: Skenario dan tugas peserta ujian	SKENARIO KLINIK Seorang perempuan usia 27 tahun, G2P1A0, usia kehamilan 34 minggu, datang ke Puskesmas untuk pemeriksaan antenatal rutin. Ibu mengeluh sakit kepala sejak dua hari terakhir dan penglihatan terkadang kabur. Hasil anamnesis: gerakan janin masih dirasakan, tidak

No.	Komponen	Isi
		ada riwayat hipertensi sebelum hamil, tidak ada riwayat penyakit kronis. Hasil pemeriksaan: TD 150/100 mmHg, N 92 x/menit, P 22 x/menit, S 36,9°C, TFU sesuai usia kehamilan, DJJ 148 x/menit, protein urine +1. Bidan melakukan pemeriksaan lanjutan dan memberikan edukasi kepada ibu mengenai kondisi yang dialami. TUGAS 1. Lakukan anamnesis terarah sesuai kasus. 2. Lakukan pemeriksaan fisik/obstetri terfokus sesuai kasus. 3. Sampaikan diagnosis/masalah kebidanan berdasarkan data yang diperoleh. 4. Lakukan tindakan awal yang tepat pada kasus tersebut. 5. Berikan KIE singkat kepada ibu/keluarga mengenai kondisi yang di alami ibu 6. Jelaskan rencana pemantauan dan kemungkinan rujukan bila di perlukan.
7	Instruksi penguji	INSTRUKSI UMUM 1. Pastikan identitas peserta ujian sesuai dengan kartu ujian. 2. Tulislah nomor peserta berdasarkan jumlah peserta yang ikut: a Ujian institusi- 2 digit jika peserta berjumlah 01–99-3 digit jika peserta berjumlah 100–999-4 digit terakhir jika menggunakan NIM peserta b Ujian nasional- 4 digit jika peserta berjumlah ribuan- atau 4 digit terakhir bila nomor mengikutkan kode area dan lebih dari 4 angka 3. Amati peserta dan beri penilaian pada lembar penilaian yang disesuaikan dengan format penilaian: • Actual mark (0/1/2/3) • Global rating (1/2/3/4) 4. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interaksi apa pun kepada peserta selain yang ditentukan. 5. Taatilah peraturan dan laksanakan tugas sebagai penguji OSCE. INSTRUKSI KHUSUS 1. Jika peserta melakukan anamnesis dengan benar, PS menjawab sesuai dialog PS. 2. Jika peserta melakukan palpasi abdomen (Leopold), penguji memberikan data : - TFU 34 cm - Punggung kiri - Presentasi kepala - Kepala 4/5 di atas PAP 3. Jika peserta meminta pemeriksaan tambahan, penguji memberikan data: - Edema ekstremitas (+/-)

No.	Komponen	Isi
		- Refleks patella normal - Protein urin +1 4. Tindakan awal yang diharapkan dari peserta meliputi: - Menilai ulang kondisi ibu dan janin - Mengidentifikasi tanda hipertensi dalam kehamilan/preeklampsia - Memposisikan ibu miring kiri - Melakukan pemantauan tekanan darah - Memberikan edukasi mengenai tanda bahaya preeklampsia - Menganjurkan kontrol lebih sering - Menyiapkan kolaborasi atau rujukan jika kondisi memburuk 5. Penguji memberikan data tambahan hanya jika diminta oleh peserta. INSTRUKSI TAMBAHAN 1. Rapikan alat yang telah digunakan oleh peserta ujian seperti keadaan semula agar siap digunakan oleh peserta berikutnya. 2. Siapkan lembar baru untuk lembar habis pakai dan pastikan lembar yang sudah diisi peserta sebelumnya telah diambil dan diberi identitas peserta.
8	Kebutuhan dan instruksi PS	Instruksi PS: 1. PS berperan sebagai ibu hamil usia kehamilan 34 minggu yang datang kontrol kehamilan 2. PS tampak sedikit cemas karena sakit kepala dan penglihatan kabur. 3. Bila peserta memberikan penjelasan mengenai kondisi ibu, PS merespons kooperatif. 4. Bila peserta menjelaskan kemungkinan rujukan, PS bertanya apakah bayi dalam kondisi baik.
9	Dialog PS	Peserta: Selamat pagi/siang, Bu. PS: Pagi/siang, Bu. Peserta: Saya bidan yang akan memeriksa ibu. Apakah ibu bersedia? PS: Iya, Bu, saya bersedia. Peserta: Apa keluhan utama ibu? PS: Kepala saya sering sakit sejak dua hari ini, Bu. Peserta: Apakah ada keluhan lainnya bu? PS: Kadang penglihatan saya agak kabur. Peserta: Apakah bayi masih terasa bergerak ibu? PS: Iya, masih terasa bergerak bu . Peserta: Apakah ibu pernah punya tekanan darah tinggi sebelumnya? PS: Tidak pernah, Bu. Peserta: Ibu, tekanan darah ibu agak tinggi dan ada sedikit protein pada urine. PS: Apakah ini berbahaya untuk saya dan bayi?

No.	Komponen	Isi
		Peserta: Kami akan melakukan pemantauan dan memberikan penjelasan agar kondisi ibu tetap terkontrol. PS: Baik, Bu. Catatan: Jika ada pertanyaan lain terkait riwayat penyakit, riwayat obstetri-ginekologi, sosial, spiritual, ekonomi, dan ADL, PS memberi jawaban normatif dan tidak mengarah ke diagnosis lain.
10	Kebutuhan manikin	- Phantom abdomen hamil/manekin Leopold - Tensimeter - Doppler / Pinard - Lembar pemeriksaan antenatal
11	Kebutuhan laboran	Peran laboran: - Menyiapkan alat dan manikin - Memastikan station siap digunakan - Mengganti lembar instruksi jika diperlukan
12	Kebutuhan alat	1. Tempat tidur/periksa — 1 2. Phantom abdomen hamil/manekin Leopold — 1 3. Tensimeter — 1 4. Stetoskop — 1 5. Doppler/Pinard — 1 6. Termometer — 1 7. Jam tangan/stopwatch — 1 8. Sarung tangan bersih — 1 pasang 9. Handrub — 1 botol 10. Urine dipstick dummy — 1 11. Formulir rujukan — 1 12. Lembar jawaban peserta — 1 13. Pena — 1
13	Penulis	Bdn. Yulia Fatma Nasution, SST., M.Keb
14	Referensi	1. Alvionita, V., et al. 2023. Analisis Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Deteksi Risiko Perdarahan Hamil Muda dan Hamil Tua. Ahmar Metastasis Health Journal, Vol.2 No. 4 2. Andarwulan, S., et al. 2022. Gizi Pada Ibu Hamil. Bandung: Media Sains Indonesia 3. Agustini, R., D., et al. 2023. Asuhan Kebidanan Kehamilan. Bandung: Media Sains Indonesia 4. Hartono, D., & Mariani. 2024. Implementasi Pendidikan Kesehatan Anemia Menuju Kehamilan Sehat Bebas Anemia Pada Ibu Hamil. Jurnal Peduli Masyarakat Vol. 6 No. 4, 5. Iryaningrum, M., R., et al. 2023. Hipertensi Dalam Kehamilan. Damianus Journal of Medicine, Vol.22 No.3 6. Kasmiati, et al. 2023. Asuhan Kehamilan. Malang: Literasi Nusantara Abadi Grup

No.	Komponen	Isi
		7. Laksono, S., & Marshaly, S., M. 2022. Hipertensi Dalam Kehamilan: Tinjauan Narasi. Herb- Medicine Journal, Vol. 5 No. 2 8. Pondaang, M., F., et al. 2025. Bunga Rampai Pengelolaan Kesehatan Ibu Hamil Dengan Komplikasi. Jakarta Barat: Nuansa Fajar Cemerlang. 9. Paramitha, Y., S., et al. 2025. Perdarahan Antepartum, Solusio Plasenta Dan Intrauterine Fetal Death (Iufd) : Laporan Kasus. Jurnal Kesehatan Tambusai Vol. 6 No. 4 10. Rahayu, S., et al. 2025. Literature Review: Faktor-Faktor Risiko Pre eklamsia pada Kehamilan. Prosiding Seminar Nasional dan Call for Paper Kebidanan, Vol.4 No.1 11. Sari, M., H., et al. 2022. Penyakit Dan Kelainan Dari Kehamilan. Padang: Global Eksekutif Teknologi 12. Siregar, E., P., et al. 2024. Preeklampsia Berat Kehamilan dalam Kebidanan. Banten: A.A Rizky. 13. Utomo, D., et al. 2023. Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Anemia pada Ibu Hamil. JIK (Jurnal Ilmu Kesehatan), Vol.7 No.2 14. Wahyuni, R., et al. 2025. Penyuluhan Dampak Anemia Terhadap Kesehatan Ibu Dan Janin.

RUBRIK PENILAIAN DAN KELULUSAN

Stase 1: Gangguan Hipertensi Kehamilan: Definisi, Kriteria Diagnosa, dan Pemantauan

KOMPETENSI 1. Pengumpulan Data Subjektif

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Keluhan utama (sakit kepala, penglihatan kabur)		
2. Riwayat keluhan sekarang (sejak kapan sakit kepala, frekuensi, faktor yang memperberat)		
3. Riwayat gejala preeklampsia lain (nyeri epigastrium, mual muntah, bengkak)		
4. Gerak janin		
5. Riwayat hipertensi sebelumnya		
6. Riwayat obstetri (GPA, usia kehamilan, ANC)		
7. Riwayat penyakit/komplikasi kehamilan/obat-obatan		
8. Aktivitas harian relevan (asupan makan, istirahat, dukungan keluarga)		

Skoring KOMPETENSI 1

- 3= Jika peserta ujian melakukan semua 8 langkah dengan benar.
- 2= Jika peserta melakukan 5–7 dari 8 langkah dengan benar.
- 1= Jika peserta melakukan 1–4 dari 8 langkah dengan benar.
- 0= Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

KOMPETENSI 2. Prosedur Tindakan Klinis

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Persiapan		
a Menyapa klien dengan sopan dan ramah		
b Memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan tindakan		
c Memastikan klien memahami prosedur dan meminta persetujuan		
d Menjaga privasi ibu		
e Mencuci tangan/hand hygiene		
f Menyiapkan alat pemeriksaan		
2. Langkah-langkah		
a Menilai keadaan umum ibu		
b Mengukur tekanan darah dengan teknik benar		
c Menilai nadi		
d Menilai suhu tubuh		
e Melakukan pemeriksaan abdomen (Leopold)		
f Menilai TFU sesuai usia kehamilan		
g Menilai DJJ		
h Menilai adanya edema		
i Meminta atau mengevaluasi pemeriksaan protein urin		
j Menginterpretasi hasil pemeriksaan		
k Menegakkan diagnosis suspek preeklampsia		
l Memposisikan ibu miring kiri		
m Melakukan pemantauan tekanan darah		
n Merencanakan kolaborasi/rujukan jika diperlukan		
3. Pasca tindakan		
a Menjelaskan hasil pemeriksaan kepada ibu		
b Mencatat hasil pemeriksaan		
c Mencuci tangan kembali dan merapikan alat/ibu		

Skoring KOMPETENSI 2

- 3= Jika peserta ujian melakukan 15–20 langkah dengan tepat dan sistematis.
- 2= Jika peserta melakukan 9–14 langkah dengan tepat, atau semua langkah dilakukan tetapi sebagian kecil tidak tepat.
- 1= Jika peserta melakukan 1–8 langkah dengan tepat, atau semua langkah dilakukan tetapi sebagian besar tidak tepat.
- 0= Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun, atau semua langkah dilakukan tetapi tidak tepat.

KOMPETENSI 3. KIE/Konseling

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Sapa dan salam		
2. Menjelaskan hasil pemeriksaan		
3. Menjelaskan kondisi hipertensi dalam kehamilan		
4. Menjelaskan tanda bahaya preeklampsia		
5. Menjelaskan perlunya pemantauan atau rujukan		
6. Memberi kesempatan bertanya		

Skoring KOMPETENSI 3

- 3= Jika peserta ujian melakukan semua 6 langkah dengan benar.
- 2= Jika peserta melakukan 4–5 dari 6 langkah dengan benar.
- 1= Jika peserta melakukan 1–3 dari 6 langkah dengan benar.
- 0= Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

KOMPETENSI 4. Perilaku Profesional

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Melaksanakan secara sistematis		
2. Menjaga privasi dan keselamatan pasien		
3. Memberikan perhatian dan responsif terhadap kondisi ibu		
4. Suara lantang, jelas, tenang, dan informatif		
5. Percaya diri dan tidak ragu-ragu		

Skoring KOMPETENSI 4

- 3= Jika peserta ujian melakukan semua 5 langkah dengan benar.
- 2= Jika peserta melakukan 4 dari 5 langkah dengan benar.
- 1= Jika peserta melakukan 1–3 dari 5 langkah dengan benar.
- 0= Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

TOTAL SKOR DAN KELULUSAN

TOTAL SKOR = jumlah skor kompetensi 1 + 2 + 3 + 4 / 3
(dicatat di rubrik penilaian)

IV. Global Performance

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

$$\text{Nilai akhir} = \frac{\text{Jumlah total skor}}{30} \times 100 =$$

Kota : .....
Tanggal :.....
Penguji : .....

Contoh Penerapan Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) pada Gangguan Hipertensi Kehamilan : Definisi, Kriteria Diagnostik, dan Pemantauan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Gangguan Hipertensi Kehamilan : Definisi, diagnosis, dan pemantauan
Metode penilaian	DOPS merupakan metode penilaian berbasis observasi langsung terhadap keterampilan prosedural mahasiswa di lingkungan klinik. Penilai mengamati tindakan yang dilakukan mahasiswa secara langsung dan memberikan umpan balik segera setelah prosedur selesai. Domain yang dinilai meliputi informed consent, persiapan tindakan, kemampuan teknis, komunikasi terapeutik, profesionalisme, serta keselamatan pasien.	Pembimbing mengamati secara langsung bagaimana mahasiswa melakukan pengkajian pada ibu hamil dengan tekanan darah tinggi, melakukan pemeriksaan antenatal terfokus, menginterpretasikan hasil pemeriksaan tekanan darah dan protein urin, serta memberikan edukasi dan rencana pemantauan kepada ibu.
Tujuan penilaian	Tujuan DOPS pada topik ini adalah menilai kemampuan mahasiswa dalam melakukan deteksi dini gangguan hipertensi dalam kehamilan secara aman, sistematis, dan berbasis evidence. Penilaian juga menekankan pentingnya komunikasi yang baik, pengambilan keputusan klinik yang tepat dalam mencegah komplikasi maternal dan perinatal.	Mahasiswa tidak hanya dinilai dari pengetahuannya tentang hipertensi dalam kehamilan, tetapi juga dari kemampuannya melakukan pengkajian gejala, mengukur tekanan darah dengan teknik yang benar, mengidentifikasi proteinuria, serta menjelaskan rencana pemantauan dan kemungkinan rujukan kepada ibu dan keluarga.
Kasus klinik	Kasus dipilih dari situasi klinik yang sering dijumpai dalam praktik pelayanan kebidanan dan sesuai dengan capaian pembelajaran profesi bidan, khususnya deteksi dini hipertensi dalam kehamilan dan pencegahan komplikasi preeklampsia	Seorang perempuan usia 27 tahun, G2P1A0, usia kehamilan 34 minggu datang ke puskesmas untuk pemeriksaan antenatal rutin. Ibu mengeluh sakit kepala sejak dua hari terakhir dan penglihatannya terkadang kabur. Hasil pemeriksaan didapatkan tekanan darah 150/100 mmHg dan protein urin +1.
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Dalam DOPS, mahasiswa diamati ketika melakukan prosedur klinik secara langsung, bukan sekadar mendiskusikan kasus. Pada topik ini, keterampilan yang dinilai meliputi kemampuan melakukan anamnesis terarah, pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan obstetri dasar, interpretasi hasil pemeriksaan, serta	Mahasiswa memperkenalkan diri, meminta persetujuan tindakan, menanyakan keluhan utama, melakukan pemeriksaan tekanan darah, menilai kondisi janin, mengevaluasi hasil protein urin, menyimpulkan adanya hipertensi dalam kehamilan atau suspek preeklampsia, kemudian

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Gangguan Hipertensi Kehamilan : Definisi, diagnosis, dan pemantauan
	pemberian edukasi kepada ibu mengenai kondisi yang dialami.	memberikan edukasi mengenai tanda bahaya dan rencana pemantauan.
Aspek yang dinilai	Aspek yang dinilai meliputi pemahaman indikasi pemeriksaan, kemampuan teknis melakukan pemeriksaan tekanan darah dan obstetri, komunikasi dengan pasien, kemampuan analisis klinik, serta profesionalisme, kemampuan mengenali tanda awal preeklampsia dan menentukan kebutuhan pemantauan atau rujukan.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menghubungkan keluhan sakit kepala, gangguan penglihatan, tekanan darah tinggi, dan proteinuria sebagai tanda gangguan hipertensi dalam kehamilan yang memerlukan pemantauan ketat.
Fokus observasi pembimbing	Fokus observasi pembimbing adalah kualitas performa mahasiswa saat melakukan pemeriksaan antenatal pada ibu dengan risiko hipertensi. Penilaian mencakup ketepatan teknik pemeriksaan, ketepatan interpretasi hasil, serta kemampuan menentukan langkah tindak lanjut yang tepat..	Pembimbing memperhatikan apakah mahasiswa melakukan pemeriksaan tekanan darah dengan benar, mampu menginterpretasikan hasil pemeriksaan secara tepat, serta memberikan edukasi yang jelas mengenai pentingnya pemantauan tekanan darah selama kehamilan.
Umpan balik	Umpan balik dalam DOPS diberikan segera setelah tindakan selesai dan berisi komentar mengenai kekuatan mahasiswa serta area yang perlu ditingkatkan.	Pembimbing dapat menyampaikan bahwa mahasiswa sudah baik dalam Teknik komunikasi, teknik pengukuran tekanan darah, mengidentifikasi tanda bahaya preeklampsia serta ketegasan dalam menentukan rencana pemantauan atau rujukan.
Keputusan penilaian	Hasil penilaian DOPS biasanya diringkas menjadi tiga kategori yaitu kompeten, perlu supervisi, atau remedial. Penilaian didasarkan pada ketepatan langkah, keselamatan pasien, komunikasi, dan kemampuan analisis klinik.	Mahasiswa dinyatakan kompeten apabila mampu melakukan pemeriksaan antenatal secara sistematis, mengenali tanda hipertensi dalam kehamilan, serta memberikan edukasi yang tepat.
Makna dalam OBE	Dalam pendekatan Outcome Based Education, DOPS memberikan bukti autentik bahwa mahasiswa mampu menunjukkan capaian pembelajaran pada level does, yaitu mampu melakukan tindakan klinik secara nyata di lahan praktik.	Pada kasus hipertensi dalam kehamilan, mahasiswa dinilai bukan hanya memahami teori mengenai preeklampsia, tetapi juga mampu menerapkan keterampilan deteksi dini dan pemantauan tekanan darah secara langsung dalam pelayanan kebidanan.

Portofolio

Bukti yang dikumpulkan

1. OSCE + DOPS

Catatan kasus singkat

Refleksi patient safety

Feedback CI/dosen

Catatan untuk penulis:

1. Penilaian tidak hanya dilakukan sekali

Portofolio menunjukkan konsistensi kompetensi mahasiswa

Tabel 3.4
Portofolio pada Gangguan Hipertensi dalam Kehamilan : Definisi, Kriteria Diagnostik, dan Pemantauan

Komponen	**Deskripsi**	**Gangguan Hipertensi dalam Kehamilan : Definisi, Kriteria Diagnostik, dan Pemantauan.**
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam pendekatan Outcome Based Education (OBE), portofolio digunakan untuk menilai performa nyata mahasiswa dari waktu ke waktu, bukan hanya dari satu kali ujian.	Pada topik hipertensi dalam kehamilan, portofolio memuat bukti bahwa mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan tekanan darah secara tepat, mengidentifikasi gejala preeklampsia, menilai hasil pemeriksaan urin, serta memberikan edukasi kepada ibu mengenai pentingnya pemantauan tekanan darah selama kehamilan.
Tujuan portofolio	Portofolio bertujuan mendokumentasikan proses belajar mahasiswa, capaian kompetensi, refleksi diri, serta tindak lanjut perbaikan selama praktik klinik.	Mahasiswa tidak hanya menunjukkan bahwa ia pernah menangani ibu haml dengan tekanan darah tinggi, tetapi juga menunjukkan bagaimana kemampuannya meningkat setelah mendapatkan umpan balik dari dosen atau *Clinical Instructor.*
OSCE dan DOPS	OSCE dan DOPS merupakan bagian penting dari portofolio karena memberikan bukti keterampilan klinik mahasiswa baik di laboratorium keterampilan maupun di lahan praktik.	OSCE dapat memuat hasil ujian keterampilan pemeriksaan antenatal, pengukuran tekanan darah, dan interpretasi hasil pemeriksaan urin. DOPS memuat hasil observasi langsung ketika mahasiswa melakukan pemeriksaan ibu hamil

Komponen	Deskripsi	Gangguan Hipertensi dalam Kehamilan : Definisi, Kriteria Diagnostik, dan Pemantauan.
		dengan hipertensi di fasilitas pelayanan kesehata
Catatan kasus singkat	Catatan kasus singkat berisi ringkasan kasus pasien yang pernah ditangani mahasiswa selama praktik klinik, meliputi data subjektif, objektif, analisis masalah, tindakan, dan hasil yang dicapai.	Mahasiswa menuliskan ringkasan kasus seorang ibu hamil usia kehamilan 34 minggu dengan tekanan darah 150/100 mmHg dan protein urin +1, termasuk hasil pemeriksaan fisik, analisis suspek preeklampsia, serta rencana pemantauan dan edukasi yang diberikan.
Refleksi patient safety	Refleksi patient safety menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien serta menyusun langkah pencegahan untuk meningkatkan kualitas asuhan kebidanan.	Mahasiswa merefleksikan pentingnya deteksi dini hipertensi dalam kehamilan untuk mencegah komplikasi seperti preeklampsia berat dan eklampsia serta menekankan pentingnya pemantauan tekanan darah secara rutin selama kehamilan.
Feedback CI/dosen	Umpan balik dari Clinical Instructor (CI) atau dosen merupakan bagian penting dalam proses pembelajaran klinik karena membantu mahasiswa memahami kekuatan dan kelemahan performanya..	CI memberikan komentar bahwa mahasiswa sudah mampu melakukan pemeriksaan tekanan darah dengan baik dan memberikan edukasi kepada ibu, tetapi masih perlu meningkatkan ketelitian dalam menginterpretasi tanda bahaya preeklampsia.
Karakteristik penilaian	Penilaian portofolio tidak dilakukan hanya sekali, tetapi dilakukan secara berulang dan berkesinambungan selama periode praktik klinik. Penilaian menekankan konsistensi performa mahasiswa serta kemampuannya memperbaiki diri berdasarkan umpan balik yang diterima.	Mahasiswa dinilai dari beberapa pengalaman praktik yang menunjukkan bahwa ia secara konsisten mampu melakukan pemeriksaan antenatal pada ibu hamil dengan risiko hipertensi serta mampu mengenali tanda bahaya secara tepat.
Bukti konsistensi kompetensi	Portofolio memberikan gambaran apakah mahasiswa mampu mempertahankan kualitas performa pada berbagai kesempatan praktik klinik. Bukti ini diperoleh dari hasil OSCE, DOPS, catatan kasus, refleksi,	Dari berbagai bukti portofolio terlihat bahwa mahasiswa secara konsisten mampu melakukan pengukuran tekanan darah dengan teknik yang benar, mengenali gejala hipertensi dalam kehamilan, serta

Komponen	Deskripsi	Gangguan Hipertensi dalam Kehamilan : Definisi, Kriteria Diagnostik, dan Pemantauan.
	serta umpan balik dari pembimbing klinik.	memberikan edukasi kepada ibu mengenai tanda bahaya preeklampsia.
Makna dalam OBE	Dalam pendekatan OBE, portofolio merupakan bukti autentik bahwa mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi mampu menunjukkan kompetensi secara nyata dan konsisten dalam praktik klinik. Portofolio juga menunjukkan perkembangan kemampuan mahasiswa dari waktu ke waktu.	Pada topik hipertensi dalam kehamilan, portofolio menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya memahami konsep preeklampsia secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkan keterampilan deteksi dini dan pemantauan tekanan darah secara sistematis dalam pelayanan kebidanan.

Tabel 3.5
Case Report pada Gangguan Hipertensi dalam Kehamilan: Definisi, Kriteria Diagnostik, dan Pemantauan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Gangguan Hipertensi dalam Kehamilan: Definisi, Kriteria Diagnostik, dan Pemantauan
Hakikat case report	Case report merupakan laporan singkat dan sistematis mengenai satu kasus klinik yang ditangani mahasiswa selama praktik. Dalam pendekatan Outcome Based Education (OBE), case report menjadi bukti kemampuan mahasiswa dalam memahami, menganalisis, serta mendokumentasikan kasus secara ilmiah dan klinis.	Mahasiswa menyusun laporan singkat mengenai seorang ibu hamil yang mengalami peningkatan tekanan darah pada trimester ketiga disertai gejala sakit kepala dan gangguan penglihatan.
Tujuan	Case report bertujuan menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan data pengkajian, masalah kebidanan, rencana tindakan, implementasi, dan evaluasi hasil asuhan.	Mahasiswa tidak hanya mencatat data ibu hamil, tetapi juga menjelaskan analisis masalah, kemungkinan diagnosis hipertensi dalam kehamilan, serta rencana pemantauan dan edukasi yang diberikan kepada pasien
Isi laporan	Isi case report biasanya meliputi identitas pasien secara singkat, keluhan utama, data subjektif dan objektif, analisis masalah, diagnosis atau masalah kebidanan, rencana	Pada kasus ini mahasiswa menuliskan data ibu hamil usia 27 tahun dengan usia kehamilan 34 minggu yang mengeluh sakit kepala dan penglihatan kabur. Hasil pemeriksaan menunjukkan tekanan darah 150/100 mmHg dan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Gangguan Hipertensi dalam Kehamilan: Definisi, Kriteria Diagnostik, dan Pemantauan
	tindakan, implementasi, serta evaluasi hasil asuhan.	protein urin +1. Mahasiswa kemudian menganalisis kemungkinan hipertensi dalam kehamilan atau suspek preeklampsia serta merencanakan pemantauan tekanan darah dan edukasi kepada ibu.
Fokus penilaian	Penilaian difokuskan pada ketepatan pengkajian, kemampuan analisis masalah, ketepatan penalaran klinik, serta kesesuaian tindakan kebidanan yang dilakukan.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menghubungkan gejala sakit kepala, gangguan penglihatan, tekanan darah tinggi, dan proteinuria sebagai tanda gangguan hipertensi dalam kehamilan yang memerlukan pemantauan lebih lanjut.
Nilai edukatif	Case report membantu mahasiswa mengembangkan kemampuan clinical reasoning, keterampilan dokumentasi klinik, serta kemampuan merefleksikan pengalaman praktik secara ilmiah.	Dari kasus ini mahasiswa belajar bahwa pengukuran tekanan darah secara rutin dan deteksi dini proteinuria merupakan langkah penting dalam mencegah komplikasi preeklampsia dan eklampsia.
Karakteristik penilaian	Penilaian case report tidak hanya berfokus pada kelengkapan laporan, tetapi juga pada kemampuan mahasiswa mengintegrasikan teori dengan praktik klinik serta kemampuan berpikir kritis dalam menganalisis kasus	Mahasiswa dinilai dari kemampuannya menginterpretasi hasil pemeriksaan tekanan darah dan protein urin serta menentukan rencana pemantauan yang sesuai dengan kondisi ibu.
Bukti konsistensi kompetens	Case report menjadi salah satu bukti bahwa mahasiswa mampu menerapkan konsep teoritis secara konsisten dalam berbagai situasi klinik yang berbeda.	Dari beberapa laporan kasus yang dibuat selama praktik, terlihat bahwa mahasiswa secara konsisten mampu melakukan pengkajian antenatal, mengenali tanda bahaya hipertensi dalam kehamilan, serta memberikan edukasi kepada ibu hamil.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, case report menjadi bukti bahwa mahasiswa mampu menerapkan teori ke dalam analisis kasus nyata secara sistematis dan bertanggung jawab.	Pada topik hipertensi dalam kehamilan, case report menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya memahami konsep definisi dan kriteria diagnostik, tetapi juga mampu melakukan pemantauan kondisi ibu serta memberikan asuhan kebidanan yang tepat.

Tabel 3.6
Refleksi Patient Safety pada Gangguan Hipertensi dalam Kehamilan: Definisi, Kriteria Diagnostik, dan Pemantauan

Komponen	Deskripsi	Gangguan Hipertensi dalam Kehamilan: Definisi, Kriteria Diagnostik, dan Pemantauan
Hakikat refleksi patient safety	Refleksi patient safety merupakan tulisan singkat yang menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi masalah, serta merencanakan langkah pencegahan dalam asuhan kebidanan. Refleksi ini mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis terhadap keselamatan ibu dan janin dalam praktik klinik.	Pada kasus hipertensi dalam kehamilan, mahasiswa merefleksikan bahwa keterlambatan mengenali peningkatan tekanan darah dan gejala preeklampsia dapat menyebabkan komplikasi serius seperti preeklampsia berat, eklampsia, atau gangguan pertumbuhan janin.
Tujuan	Refleksi ini bertujuan menumbuhkan kesadaran mahasiswa bahwa keselamatan pasien merupakan prioritas utama dalam setiap tindakan kebidanan. Mahasiswa diharapkan mampu memahami bahwa deteksi dini dan pemantauan kondisi ibu merupakan langkah penting dalam mencegah komplikasi.	Mahasiswa memahami bahwa kesalahan seperti tidak mengukur tekanan darah secara rutin, tidak mengenali gejala sakit kepala dan gangguan penglihatan sebagai tanda bahaya, atau tidak melakukan pemeriksaan protein urin dapat meningkatkan risiko komplikasi pada ibu dan janin.
Fokus refleksi	Fokus refleksi meliputi identifikasi risiko keselamatan pasien, analisis penyebab terjadinya risiko, tindakan pencegahan, serta pembelajaran yang diperoleh mahasiswa dari pengalaman klinik..	Mahasiswa menuliskan bahwa risiko utama pada kasus ini adalah perkembangan hipertensi gestasional menjadi preeklampsia, kemungkinan terjadinya eklampsia, gangguan pertumbuhan janin, serta keterlambatan penanganan jika kondisi tidak dipantau secara tepat.
Risiko yang diidentifikasi	Mahasiswa harus mampu mengidentifikasi situasi klinik yang berpotensi membahayakan ibu dan janin. Identifikasi risiko merupakan langkah penting dalam upaya pencegahan komplikasi obstetri.	Risiko yang dapat diidentifikasi antara lain keterlambatan diagnosis hipertensi dalam kehamilan, kegagalan mengenali tanda preeklampsia, pemantauan tekanan darah yang tidak adekuat, keterlambatan pemeriksaan protein urin, serta keterlambatan rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih mampu.
Tindakan pencegahan	Mahasiswa menjelaskan langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mencegah risiko keselamatan pasien	Mahasiswa menuliskan pentingnya pemeriksaan tekanan darah secara rutin pada setiap kunjungan

Komponen	Deskripsi	Gangguan Hipertensi dalam Kehamilan: Definisi, Kriteria Diagnostik, dan Pemantauan
	serta meningkatkan kualitas asuhan kebidanan.	antenatal, pemeriksaan protein urin bila dicurigai preeklampsia, edukasi kepada ibu mengenai tanda bahaya seperti sakit kepala hebat dan penglihatan kabur, serta pengaturan rujukan tepat waktu jika kondisi ibu memburuk.
Pembelajaran mahasiswa	Refleksi harus menunjukkan apa yang dipelajari mahasiswa dari pengalaman klinik dan bagaimana pembelajaran tersebut akan memengaruhi praktik kebidanan selanjutnya.	Mahasiswa menyadari bahwa pada kasus hipertensi dalam kehamilan, pengkajian yang teliti, pemantauan tekanan darah secara berkala, serta komunikasi yang baik dengan ibu dan keluarga merupakan bagian penting dalam menjaga keselamatan ibu dan bayi.
Karakteristik penilaian	Penilaian refleksi patient safety tidak hanya melihat isi tulisan, tetapi juga kedalaman analisis mahasiswa terhadap risiko keselamatan pasien serta kemampuannya merumuskan tindakan pencegahan	Mahasiswa dinilai dari kemampuannya menjelaskan hubungan antara gejala klinis, hasil pemeriksaan tekanan darah, dan risiko komplikasi serta kemampuannya menyusun rencana pemantauan yang tepat.
Bukti konsistensi kompetensi	Refleksi patient safety juga menunjukkan apakah mahasiswa mampu mempertahankan kesadaran terhadap keselamatan pasien secara konsisten dalam berbagai situasi klinik.	Dari beberapa refleksi yang dibuat selama praktik klinik, terlihat bahwa mahasiswa secara konsisten mampu mengidentifikasi risiko hipertensi dalam kehamilan serta menerapkan prinsip keselamatan pasien dalam asuhan kebidanan..
Makna dalam OBE	Dalam pendekatan Outcome Based Education (OBE), refleksi patient safety menunjukkan perkembangan sikap profesional, tanggung jawab klinik, serta kemampuan berpikir kritis mahasiswa terhadap keselamatan pasien.	Pada topik hipertensi dalam kehamilan, refleksi patient safety menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya mampu melakukan pemeriksaan klinik, Dari beberapa refleksi yang dibuat selama praktik klinik, terlihat bahwa mahasiswa secara konsisten mampu mengidentifikasi risiko hipertensi dalam kehamilan serta menerapkan prinsip keselamatan pasien dalam asuhan kebidanan.tetapi juga mampu mengevaluasi risiko keselamatan ibu

Komponen	Deskripsi	Gangguan Hipertensi dalam Kehamilan: Definisi, Kriteria Diagnostik, dan Pemantauan
		dan janin serta meningkatkan kualitas praktik kebidanan secara berkelanjutan..

F. Ringkasan Materi

Gangguan hipertensi dalam kehamilan merupakan salah satu komplikasi obstetri yang paling sering terjadi dan menjadi penyebab utama morbiditas serta mortalitas maternal dan perinatal di seluruh dunia. Gangguan ini mencakup beberapa kondisi, yaitu hipertensi kronik, hipertensi gestasional, preeklampsia, dan eklampsia. Secara umum, hipertensi dalam kehamilan didefinisikan sebagai peningkatan tekanan darah dengan nilai ≥140/90 mmHg yang terjadi sebelum kehamilan atau setelah usia kehamilan 20 minggu. Kondisi ini dapat disertai dengan proteinuria atau tanda disfungsi organ maternal seperti gangguan fungsi ginjal, gangguan fungsi hati, trombositopenia, atau gangguan neurologis.

Preeklampsia merupakan bentuk gangguan hipertensi yang paling sering menimbulkan komplikasi serius pada ibu dan janin. Kondisi ini ditandai dengan hipertensi setelah usia kehamilan 20 minggu disertai dengan proteinuria atau tanda kerusakan organ maternal. Manifestasi klinis yang sering muncul meliputi sakit kepala hebat, gangguan penglihatan, nyeri epigastrium, edema, serta peningkatan tekanan darah yang menetap. Apabila tidak ditangani dengan baik, preeklampsia dapat berkembang menjadi eklampsia yang ditandai dengan kejang pada ibu hamil.

Pemantauan hipertensi dalam kehamilan merupakan bagian penting dalam pelayanan antenatal care. Pemantauan ini meliputi pemeriksaan tekanan darah secara rutin, evaluasi gejala klinis, pemeriksaan protein urin, dan pemantauan kondisi janin. Deteksi dini hipertensi dalam kehamilan memungkinkan tenaga kesehatan untuk melakukan intervensi yang tepat sehingga dapat mencegah komplikasi yang lebih berat.

Dalam praktik kebidanan, bidan memiliki peran penting dalam melakukan deteksi dini hipertensi dalam kehamilan melalui pengkajian yang komprehensif, pemeriksaan tekanan darah secara tepat, serta edukasi kepada ibu mengenai tanda bahaya. Apabila ditemukan tanda perburukan kondisi, bidan harus segera melakukan kolaborasi atau rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih mampu untuk memastikan keselamatan ibu dan janin.

G. Alur asuhan singkat

Ibu hamil pada kunjungan antenatal → lakukan pengkajian keluhan dan riwayat kesehatan → ukur tekanan darah dengan teknik yang benar → evaluasi gejala klinis (sakit kepala, gangguan penglihatan, nyeri epigastrium, edema) → lakukan pemeriksaan urin untuk mendeteksi proteinuria → identifikasi kemungkinan hipertensi gestasional atau preeklampsia → lakukan pemantauan tekanan darah dan kondisi ibu serta janin → berikan edukasi mengenai tanda bahaya → tentukan kebutuhan kolaborasi atau rujukan → lakukan dokumentasi dan tindak lanjut pemantauan.

H. Tabel Red Flags & Eskalasi

Gangguan Hipertensi dalam Kehamilan: Definisi, Kriteria Diagnostik, dan Pemantauan

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
Tekanan darah ≥140/90 mmHg pada pemeriksaan berulang	Menunjukkan kemungkinan hipertensi dalam kehamilan	Lakukan evaluasi lanjutan dan pemantauan tekanan darah secara berkala
Protein urin positif	Mengarah pada kemungkinan preeklampsia	Lakukan evaluasi kondisi ibu dan janin serta pemantauan ketat
Sakit kepala hebat yang tidak hilang	Tanda kemungkinan gangguan neurologis akibat preeklampsia	Lapor ke dokter/pembimbing dan evaluasi segera
Gangguan penglihatan (kabur, kilatan cahaya)	Indikasi iritasi sistem saraf pusat	Observasi ketat dan siapkan kolaborasi atau rujukan
Nyeri epigastrium atau nyeri perut kanan atas	Mengarah pada gangguan fungsi hat	Lakukan evaluasi segera dan rujuk bila perlu
Edema pada wajah dan tangan yang meningkat	Dapat mengindikasikan preeklampsia	Pantau kondisi ibu secara ketat
Penurunan gerakan janin	Mengarah pada kemungkinan gangguan perfusi plasenta	Lakukan pemantauan kondisi janin
Kejang pada ibu hamil	Menunjukkan kemungkinan eklampsia	Lakukan penanganan kegawatdaruratan dan rujuk segera

Form Checklist "Saya sudah bisa..."

Bab: Gangguan Hipertensi dalam Kehamilan – Definisi, Kriteria Diagnostik, dan Pemantauan

Nama Mahasiswa : _____

NIM : _____

Tanggal : _____

Tempat Praktik / Skill Lab : _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah bisa menjelaskan definisi hipertensi dalam kehamilan	☐	☐	_____
2	Saya sudah bisa menyebutkan jenis hipertensi dalam kehamilan	☐	☐	_____
3	Saya sudah bisa menjelaskan kriteria diagnostik hipertensi dalam kehamilan	☐	☐	_____
4	Saya sudah bisa melakukan anamnesis terarah pada ibu hamil dengan tekanan darah tinggi	☐	☐	_____
5	Saya sudah bisa melakukan pengukuran tekanan darah dengan teknik yang benar	☐	☐	_____
6	Saya sudah bisa mengenali gejala preeklampsia	☐	☐	_____
7	Saya sudah bisa menilai hasil pemeriksaan protein urin	☐	☐	_____
8	Saya sudah bisa mengidentifikasi tanda bahaya hipertensi dalam kehamilan	☐	☐	_____
9	Saya sudah bisa melakukan pemantauan kondisi ibu dan janin	☐	☐	_____
10	Saya sudah bisa memberikan edukasi kepada ibu mengenai tanda bahaya preeklampsia	☐	☐	_____
11	Saya sudah bisa menentukan kapan kasus harus dikolaborasikan atau dirujuk	☐	☐	_____
12	Saya sudah bisa menyiapkan rujukan dengan komunikasi yang jelas	☐	☐	_____
13	Saya sudah bisa melakukan dokumentasi asuhan kebidanan dengan baik.	☐	☐	_____
14	Saya sudah bisa menjaga privasi dan keselamatan pasien selama pemeriksaan	☐	☐	_____
15	Saya sudah bisa berkomunikasi dengan ibu dan keluarga secara efektif	☐	☐	_____
16	Saya sudah bisa menunjukkan perilaku profesional dalam praktik kebidanan	☐	☐	_____

Refleksi singkat mahasiswa:

I. Referensi

Agustini, R., D., et al. 2023. Asuhan Kebidanan Kehamilan. Bandung: Media Sains Indonesia

Alvionita, V., et al. 2023. Analisis Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Deteksi Risiko Perdarahan Hamil Muda dan Hamil Tua. Ahmar Metastasis Health Journal, Vol.2 No. 4

Andarwulan, S., et al. 2022. Gizi Pada Ibu Hamil. Bandung: Media Sains Indonesia

Hartono, D., & Mariani. 2024. Implementasi Pendidikan Kesehatan Anemia Menuju Kehamilan Sehat Bebas Anemia Pada Ibu Hamil. Jurnal Peduli Masyarakat Vol. 6 No. 4,

Iryaningrum, M., R., et al. 2023. Hipertensi Dalam Kehamilan. Damianus Journal of Medicine, Vol.22 No.3

Kasmiati, et al. 2023. Asuhan Kehamilan. Malang: Literasi Nusantara Abadi Grup

Laksono, S., & Marshaly, S., M. 2022. Hipertensi Dalam Kehamilan: Tinjauan Narasi. Herb-Medicine Journal, Vol. 5 No. 2

Paramitha, Y., S., et al. 2025. Perdarahan Antepartum, Solusio Plasenta Dan Intrauterine Fetal Death (Iufd) : Laporan Kasus. Jurnal Kesehatan Tambusai Vol. 6 No. 4

Pondaang, M., F., et al. 2025. Bunga Rampai Pengelolaan Kesehatan Ibu Hamil Dengan Komplikasi. Jakarta Barat: Nuansa Fajar Cemerlang.

Rahayu, S., et al. 2025. Literature Review: Faktor-Faktor Risiko Pre eklamsia pada Kehamilan. Prosiding Seminar Nasional dan Call for Paper Kebidanan, Vol.4 No.1

Sari, M., H., et al. 2022. Penyakit Dan Kelainan Dari Kehamilan. Padang: Global Eksekutif Teknologi Selama Kehamilan Di Desa Waluyojati Tahun 2024. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Ungu (ABDI KE UNGU), Vol.7 No.1

Siregar, E., P., et al. 2024. Preeklampsia Berat Kehamilan dalam Kebidanan. Banten: A.A Rizky.

Utomo, D., et al. 2023. Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Anemia pada Ibu Hamil. JIK (Jurnal Ilmu Kesehatan), Vol.7 No.2

Wahyuni, R., et al. 2025. Penyuluhan Dampak Anemia Terhadap Kesehatan Ibu Dan Janin

BAB 4

PERDARAHAN TRIMESTER I: ABORTUS, KEHAMILAN EKTOPIK, DAN MOLA PENANGANAN AWAL DAN RUJUKAN

Tabel CPL

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menunjukkan profesionalisme, etika, dan tanggung jawab legal dalam pelayanan ibu hamil dengan komplikasi.	CPMK-1; CPMK-5; CPMK-7
CPL-2	Menerapkan komunikasi terapeutik, edukasi, dan kolaborasi interprofesional berpusat pada ibu–janin–keluarga.	CPMK-2; CPMK-5; CPMK-7
CPL-3	Menerapkan prinsip keselamatan pasien, PPI, K3, dan manajemen risiko dalam penanganan komplikasi kehamilan.	CPMK-1; CPMK-5; CPMK-6; CPMK-7
CPL-4	Melakukan pengkajian klinis serta interpretasi pemeriksaan penunjang untuk menentukan masalah dan tingkat kegawatan pada komplikasi kehamilan.	CPMK-2; CPMK-3; CPMK-4; CPMK-6
CPL-5	Merancang dan melaksanakan tata laksana awal/stabilisasi serta rujukan terstandar untuk komplikasi hipertensi, perdarahan, infeksi, dan anemia.	CPMK-3; CPMK-4; CPMK-5; CPMK-6; CPMK-7
CPL-6	Melakukan dokumentasi, rencana persalinan/rujukan, continuity of care, dan evaluasi berbasis evidence untuk peningkatan mutu layanan kehamilan komplikasi.	CPMK-1; CPMK-2; CPMK-7

Tabel CPMK

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menganalisis konsep dasar komplikasi kehamilan (hipertensi, perdarahan, infeksi, anemia) untuk deteksi dini, pencegahan, dan keselamatan ibu–janin sesuai pedoman.
CPMK-2	Melakukan pengkajian terfokus pada ibu hamil dengan komplikasi (anamnesis, pemeriksaan fisik, penunjang, dan pemantauan janin) serta menginterpretasi hasil untuk penentuan prioritas.
CPMK-3	Menetapkan klasifikasi/derajat anemia kehamilan, melakukan skrining, menyusun tata laksana awal, serta menentukan indikasi rujukan/kolaborasi.
CPMK-4	Menetapkan diagnosis dan rencana pemantauan gangguan hipertensi kehamilan berdasarkan kriteria diagnostik dan risiko maternal–janin.
CPMK-5	Melaksanakan stabilisasi awal kegawatdaruratan terkait hipertensi berat/eclampsia dan infeksi sistemik/sepsis pada kehamilan serta menyiapkan rujukan aman dan tepat waktu.
CPMK-6	Melaksanakan penanganan awal kegawatdaruratan perdarahan trimester I–III dan menyiapkan rujukan sesuai standar.
CPMK-7	Merancang asuhan kolaboratif pada kehamilan dengan infeksi, ketuban pecah dini/persalinan prematur, dan penyakit penyerta; termasuk edukasi, rencana persalinan, dokumentasi, dan continuity of care.

Tabel Pemetaan Bab–Sub-CPMK–CPMK

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 1. Konsep Dasar Komplikasi Kehamilan: Deteksi Dini, Pencegahan, dan Keselamatan Ibu–Janin	1.1 Mengidentifikasi faktor risiko dan tanda bahaya utama komplikasi kehamilan berdasarkan trimester.	1.2 Menjelaskan strategi pencegahan primer/sekunder serta prinsip keselamatan ibu–janin (patient safety, PPI, K3) pada pelayanan antenatal.	CPMK-1	CPMK-2; CPMK-7
Bab 2. Pengkajian Ibu Hamil dengan Komplikasi: Anamnesis Terfokus, Pemeriksaan Fisik, dan Pemeriksaan Penunjang	2.1 Melakukan anamnesis terfokus dan penilaian triase kegawatan pada ibu hamil dengan keluhan komplikasi.	2.2 Menginterpretasi temuan pemeriksaan fisik dan penunjang untuk menetapkan masalah prioritas.	CPMK-2	CPMK-1; CPMK-5
Bab 3. Anemia pada Kehamilan:	3.1 Mengklasifikasikan anemia kehamilan	3.2 Menyusun tata laksana awal anemia	CPMK-3	CPMK-2; CPMK-7

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Klasifikasi, Skrining, Tata Laksana, dan Indikasi Rujukan	berdasarkan kadar Hb dan etiologi tersangka serta menilai derajat risiko.	dan menentukan kriteria rujukan/kolaborasi serta rencana monitoring.		
Bab 4. Gangguan Hipertensi Kehamilan: Definisi, Kriteria Diagnostik, dan Pemantauan	4.1 Membedakan jenis gangguan hipertensi dalam kehamilan berdasarkan definisi dan kriteria diagnostik.	4.2 Merancang pemantauan tekanan darah, gejala, dan parameter klinis/penunjang untuk deteksi perburukan.	CPMK-4	CPMK-2; CPMK-1
Bab 5. Preeklamsia Berat dan Eklampsia: Tanda Bahaya, Stabilisasi Awal, dan Rujukan	5.1 Mengidentifikasi tanda bahaya preeklamsia berat/eclampsia dan menilai prioritas stabilisasi (ABCDE).	5.2 Melaksanakan stabilisasi pra-rujukan dan menyiapkan komunikasi rujukan yang aman.	CPMK-5	CPMK-4; CPMK-2; CPMK-7
Bab 6. Perdarahan Trimester I: Abortus, Kehamilan Ektopik, dan Mola—Penanganan Awal dan Rujukan	6.1 Menilai perdarahan trimester I dan menyusun diferensial diagnosis (abortus/ektopik/mola) berbasis temuan klinis.	6.2 Melaksanakan penanganan awal (stabilisasi, pencegahan syok, persiapan rujukan) sesuai standar.	CPMK-6	CPMK-2; CPMK-5
Bab 7. Perdarahan Trimester II–III: Plasenta Previa dan Solusio Plasenta—Penanganan Awal dan Rujukan	7.1 Mengidentifikasi karakteristik perdarahan trimester II–III yang mengarah pada plasenta previa vs solusio plasenta serta risiko gawat janin.	7.2 Melaksanakan penanganan awal aman (stabilisasi, monitoring ibu–janin) dan menyiapkan rujukan emergensi.	CPMK-6	CPMK-2; CPMK-7
Bab 8. Ketuban Pecah Dini dan Persalinan Prematur: Penilaian Risiko, Pencegahan Infeksi, dan Rujukan	8.1 Menilai risiko pada KPD/persalinan prematur berdasarkan usia kehamilan, tanda infeksi, dan kondisi ibu–janin.	8.2 Menyusun tindakan awal pencegahan infeksi, edukasi kewaspadaan, dan alur rujukan/kolaborasi sesuai kriteria.	CPMK-7	CPMK-2; CPMK-1
Bab 9. Infeksi Saluran Kemih pada Kehamilan: Skrining, Tata Laksana Awal, dan Pencegahan Komplikasi	9.1 Melakukan skrining ISK pada kehamilan dan menilai risiko komplikasi (mis. pielonefritis).	9.2 Menyusun tata laksana awal dan edukasi pencegahan ISK serta rencana follow-up.	CPMK-7	CPMK-2; CPMK-1

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 10. Infeksi Reproduksi dan IMS pada Kehamilan: Skrining, Tata Laksana, dan Pencegahan Penularan	10.1 Mengidentifikasi indikasi skrining IMS/infeksi reproduksi dan menilai risiko penularan ibu–janin.	10.2 Merancang tata laksana awal/rujukan dan strategi pencegahan penularan (termasuk edukasi pasangan dan PPI).	CPMK-7	CPMK-1; CPMK-2
Bab 11. Infeksi Sistemik pada Kehamilan: Demam, Sepsis, dan Protokol Stabilisasi Pra-Rujukan	11.1 Mengidentifikasi kriteria demam/infeksi sistemik dan tanda sepsis untuk penentuan kegawatan.	11.2 Melaksanakan protokol stabilisasi pra-rujukan pada sepsis serta komunikasi rujukan terstandar.	CPMK-5	CPMK-2; CPMK-7; CPMK-1
Bab 12. Penyakit Penyerta yang Memperberat Kehamilan: Diabetes, Jantung, dan Gangguan Tiroid (Kolaborasi)	12.1 Menilai dampak penyakit penyerta terhadap risiko maternal–janin dan tanda perburukan yang perlu diwaspadai.	12.2 Menyusun rencana asuhan kolaboratif dan rujukan terintegrasi sesuai peran dan kewenangan.	CPMK-7	CPMK-2; CPMK-1
Bab 13. Pemantauan Kesejahteraan Janin pada Kehamilan dengan Komplikasi: Pertumbuhan, DJJ, dan Tanda Gawat	13.1 Melakukan pemantauan kesejahteraan janin (gerak, DJJ, pertumbuhan, tanda gawat) sesuai indikasi.	13.2 Menginterpretasi hasil pemantauan untuk menentukan kebutuhan intervensi segera, eskalasi layanan, atau rujukan.	CPMK-2	CPMK-4; CPMK-6; CPMK-7
Bab 14. Edukasi, Rencana Persalinan, dan Rujukan pada Kehamilan Komplikasi: Komunikasi, Dokumentasi, dan Continuity of Care	14.1 Menyusun edukasi dan rencana persalinan/rujukan (BPCR) bersama ibu–keluarga secara komunikatif.	14.2 Melakukan dokumentasi terstandar, handover, dan rencana continuity of care termasuk jadwal follow-up.	CPMK-7	CPMK-1; CPMK-2; CPMK-5

Tabel Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-1	Ujian tulis berbasis kasus (MCQ/SAQ)	Akurasi identifikasi risiko/tanda bahaya ≥80% pada skenario; pilihan strategi pencegahan & keselamatan tanpa kesalahan kritis	10	Lembar jawaban; ringkasan rencana pencegahan (1 halaman)
CPMK-2	OSCE pengkajian terfokus + interpretasi penunjang (checklist)	Anamnesis terfokus ≥80% item; pemeriksaan fisik & penunjang/pemantauan janin tepat; prioritas tindakan/rujukan tepat	20	Checklist OSCE; lembar interpretasi kasus
CPMK-3	Studi kasus tertulis + role-play konseling (lembar observasi)	Klasifikasi anemia & risiko tepat; rencana suplementasi/diet/monitoring sesuai; indikasi rujukan/kolaborasi tepat	10	Laporan studi kasus; lembar observasi role-play
CPMK-4	Ujian skenario + tugas algoritme pemantauan	Penetapan jenis/derajat hipertensi tepat (akurasi ≥80%); rencana pemantauan ibu–janin lengkap; kriteria eskalasi/rujukan tepat	15	Lembar ujian; algoritme pemantauan
CPMK-5	Simulasi kegawatdaruratan (OSCE) dengan checklist kritis	Langkah stabilisasi urut & aman; terapi awal sesuai protokol/kewenangan; komunikasi rujukan (SBAR) dan kesiapan transport aman	15	Checklist simulasi; form SBAR; catatan tindakan
CPMK-6	OSCE perdarahan + analisis kasus singkat	Triase & diferensial diagnosis tepat; stabilisasi syok/perdarahan tepat; menghindari tindakan kontraindikasi; keputusan rujukan tepat	15	Checklist OSCE; lembar analisis kasus
CPMK-7	Proyek rencana asuhan kolaboratif + audit dokumentasi	Care plan terintegrasi dengan trigger rujukan; edukasi BPCR & pencegahan konsisten; dokumentasi, handover, dan follow-up lengkap	15	Care plan; form audit dokumentasi; ringkasan edukasi

Tabel Rubrik CPMK (skala 1–4)

Rubrik CPMK-1

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1.1 Ketepatan identifikasi faktor risiko & tanda bahaya pada skenario kasus	Akurasi ≤60%; banyak red flag terlewat; prioritas tidak tepat	Akurasi 61–79%; beberapa red flag terlewat; prioritas kurang konsisten	Akurasi 80–89%; sebagian besar tepat; kekurangan minor	Akurasi ≥90%; lengkap, konsisten, dan memprioritaskan risiko dengan tepat
1.2 Ketepatan pemilihan strategi pencegahan & keselamatan (patient safety, PPI, K3)	Tidak sesuai pedoman; ada potensi tindakan tidak aman	Sebagian sesuai pedoman; belum lengkap/kurang mempertimbangkan PPI/K3	Sesuai pedoman; lengkap dan aman	Sangat sesuai; lengkap, antisipatif, menyertakan mitigasi risiko & komunikasi keselamatan

Rubrik CPMK-2

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
2.1 Kelengkapan anamnesis terfokus dan triase kegawatan	<60% komponen; tidak sistematis; triase keliru	60–79% komponen; cukup sistematis; triase masih ragu/kurang tepat	80–89% komponen; sistematis; triase tepat	≥90% komponen; sangat sistematis, menggali red flag; triase cepat dan tepat
2.2 Ketepatan pemeriksaan fisik dan pemilihan penunjang/pemantauan janin	Pemeriksaan tidak relevan/tidak aman; penunjang tidak tepat	Pemeriksaan cukup; ada item penting terlewat; penunjang sebagian tepat	Pemeriksaan lengkap & aman; penunjang/pemantauan sesuai indikasi	Sangat lengkap, efisien; pilihan penunjang mempertimbangkan manfaat-risiko dan konteks layanan
2.3 Ketepatan interpretasi temuan dan penentuan	Interpretasi keliru; prioritas	Interpretasi sebagian benar;	Interpretasi benar; prioritas dan rencana tindak lanjut tepat	Interpretasi sangat akurat; reasoning jelas; menetapkan

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
prioritas tindakan/rujukan	salah/berisiko	prioritas kurang jelas		eskalasi/rujukan dan monitoring secara presisi

Rubrik CPMK-3

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
3.1 Ketepatan klasifikasi anemia, interpretasi Hb, dan penilaian risiko	Salah klasifikasi; risiko tidak dinilai/keliru	Klasifikasi sebagian tepat; risiko dinilai namun belum lengkap	Klasifikasi tepat; risiko dinilai dengan baik	Klasifikasi sangat tepat; mempertimbangkan etiologi tersangka dan faktor komorbid secara komprehensif
3.2 Ketepatan rencana tata laksana awal, monitoring, dan indikasi rujukan	Rencana tidak sesuai; monitoring/rujukan tidak jelas	Rencana sebagian sesuai; monitoring/rujukan masih umum	Rencana sesuai; monitoring jelas; indikasi rujukan tepat	Rencana sangat sesuai; monitoring terukur; indikasi rujukan/kolaborasi jelas dan antisipatif (termasuk edukasi kepatuhan)

Rubrik CPMK-4

Indikator	**Skor 1 (Kurang)**	**Skor 2 (Cukup)**	**Skor 3 (Baik)**	**Skor 4 (Sangat Baik)**
4.1 Ketepatan penetapan jenis gangguan hipertensi dan derajat keparahan	Salah menetapkan; mengabaikan kriteria kunci	Sebagian tepat; ada kriteria terlewat	Tepat; kriteria utama terpenuhi	Sangat tepat; membedakan varian/derajat secara konsisten dan menyebutkan implikasi risiko
4.2 Kelengkapan rencana pemantauan (ibu–janin) dan kriteria eskalasi/rujukan	Tidak lengkap; tanpa kriteria eskalasi	Cukup; parameter belum menyeluruh; eskalasi kurang jelas	Lengkap; parameter & interval jelas; eskalasi/rujukan tepat	Sangat lengkap; parameter terukur, interval adaptif sesuai risiko; eskalasi/rujukan sangat jelas dan antisipatif

Rubrik CPMK-5

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.1 Kesesuaian langkah stabilisasi ABCDE dan pencegahan komplikasi segera	Urutan tidak tepat; ada tindakan tidak aman/terlewat kritis	Urutan cukup; masih perlu banyak arahan; ada komponen terlewat	Urutan tepat; aman; komponen utama terpenuhi	Urutan sangat tepat; cepat, aman, dan proaktif mencegah komplikasi (monitoring berkelanjutan)
5.2 Ketepatan terapi awal sesuai protokol dan kewenangan	Terapi tidak sesuai/berisiko; dosis/langkah keliru	Terapi sebagian sesuai; ada ketidaktepatan minor; monitoring kurang	Terapi sesuai protokol/kewenangan; monitoring memadai	Terapi sangat tepat; menyesuaikan kondisi klinis; monitoring ketat dan mendokumentasikan respon
5.3 Kesiapan rujukan: komunikasi SBAR, dokumentasi, keselamatan transport	SBAR/dokumen tidak lengkap; kesiapan transport tidak aman	SBAR/dokumen cukup; ada data penting terlewat; transport belum optimal	SBAR jelas; dokumentasi lengkap; transport aman	SBAR sangat sistematis; dokumentasi lengkap + ringkasan tindakan/respon; koordinasi transport dan penerimaan rujukan sangat efektif

Rubrik CPMK-6

Indikator	**Skor 1 (Kurang)**	**Skor 2 (Cukup)**	**Skor 3 (Baik)**	**Skor 4 (Sangat Baik)**
6.1 Ketepatan triase dan diferensial diagnosis perdarahan berdasarkan trimester	Triase keliru; diferensial tidak sesuai	Triase cukup; diferensial masih sempit/kurang tepat	Triase tepat; diferensial sesuai temuan	Triase sangat tepat; diferensial komprehensif dan memprioritaskan kondisi mengancam nyawa
6.2 Ketepatan stabilisasi awal dan kepatuhan tindakan aman (hindari kontraindikasi)	Stabilisasi tidak adekuat; melakukan/merencanakan tindakan kontraindikasi	Stabilisasi cukup; masih ada kekurangan; kontraindikasi	Stabilisasi adekuat; kontraindikasi dihindari; monitoring baik	Stabilisasi sangat adekuat; anticipatory management; monitoring ketat; sepenuhnya

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
		dihindari sebagian		patuh tindakan aman
6.3 Ketepatan keputusan rujukan dan monitoring ibu–janin pra-rujukan	Keputusan rujukan tidak tepat/terlambat; monitoring minim	Rujukan cukup; monitoring belum terstruktur	Rujukan tepat waktu; monitoring terstruktur	Rujukan sangat tepat; monitoring ibu–janin jelas, terdokumentasi, dan komunikasi penerimaan rujukan efektif

Rubrik CPMK-7

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
7.1 Kualitas rencana asuhan kolaboratif terintegrasi dan koordinasi layanan	Care plan tidak terintegrasi; peran/rujukan tidak jelas	Care plan cukup; integrasi/koordinasi sebagian	Care plan terintegrasi; koordinasi dan trigger rujukan jelas	Care plan sangat terintegrasi; koordinasi lintas layanan kuat; trigger rujukan, monitoring, dan mitigasi risiko sangat jelas
7.2 Kualitas edukasi dan rencana persalinan/rujukan (BPCR)	Edukasi tidak terarah; rencana tidak realistis	Edukasi cukup; rencana masih umum	Edukasi jelas; rencana disepakati dan aplikatif	Edukasi sangat efektif (teach-back); rencana rinci (tanda bahaya, transport, biaya, kontak) dan berorientasi keselamatan
7.3 Kelengkapan dokumentasi, handover, dan rencana continuity of care	Dokumentasi/handover tidak lengkap; tidak ada follow-up	Dokumentasi cukup; follow-up belum spesifik	Dokumentasi lengkap; handover jelas; follow-up terjadwal	Dokumentasi sangat lengkap dan rapi; handover

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
				terstruktur; continuity of care rinci (jadwal, indikator evaluasi, jejaring rujukan)

Uraian Materi

A. Pengertian Perdarahan

Perdarahan pada kehamilan adalah keluarnya darah melalui vagina selama masa kehamilan, baik berupa bercak (*flek*) ringan maupun darah segar dalam jumlah banyak. Perdarahan pada kehamilan lanjut atau diatas 20 minggu pada umumnya disebabkan oleh plasenta previa dan solusio plasenta. Plasenta previa adalah ketika plasenta berada di bagian bawah rahim sehingga menutupi jalan lahir. Biasanya akan terjadi perdarahan hebat tanpa rasa sakit. Adapun solusio plasenta adalah pelepasan plasenta dari tempat implementasi normalnya di rahim sebelum persalinan. Biasanya akan terjadi perdarahan dengan warna darah agak gelap dan ibu merasa kesakitan. Definisi perdarahan antepartum adalah perdarahan yang terjadi pada usia kehamilan di atas 24 minggu sampai kelahiran. Perdarahan pada kehamilan merupakan penyebab utama kematian maternal dan perinatal, berkisar 35%. Perdarahan merupakan penyebab kematian yang tertinggi terjadi pada ibu. Abortus dan Kehamilan Ektopik serta mola hidatidosa Adalah perdarahan yang terjadi pada kehamilan muda yaitu dibawah 20 minggu.

B. Abortus

Abortus adalah penghentian sebelum janin dapat hidup di luar rahim yaitu usia kurang dari 20 minggu usia kehamilan dengan berat janin kurang dari 500 gram (Prawirohardjo, S. (2020). Angka abortus sulit ditetapkan, sekitar 15 3 2%kehamilan yang diketahui secara klinis berakhir menjadi abortus spontan, dan 80 % terjadi pad trimester pertama dan satu dari tujuh wanita mengalami abortus sekitar minggu ke-14 usia gestasi.

1. Patofisiologi

   Abortus biasanya diawali oleh perdarahan desidua basalis diikuti nekrosis jaringan sekitarnya. Patofisiologi terjadinya keguguran mulai dari terlepasnya sebagian atau seluruh jaringan plasenta yang menyebabkan perdarahan sehingga janin kekurangan nutrisi dan oksigen. Bagian yang terlepas dianggap benda asing, sehingga rahim berusaha untuk mengeluarkan dengan kontraksi. Pengeluaran tersebut dapat terjadi spontan seluruhnya atau sebagian masih tertinggal yang menyebabkan berbagai penyulit. Oleh karena itu, keguguran memiliki gejala umum sakit perut karena kontraksi rahim, terjadi perdarahan, dan disertai pengeluaran seluruh atau sebagian hasil konsepsi. Stres fisik atau mental dapat menyebabkan peningkatan Sekresi Hormone Adrenokortikotropik (ACTH) dengan segera dan bermakna oleh kelenjar hipofisis anterior dan akibatnya sekresi kortisol juga akan sangat meningkat. Sekresi kortisol ini meningkat sampai 20 kali lipat. Efek ini di gambarkan dengan jelas sekali oleh respons

sekresi adrenokortikal yang cepat dan kuat setelah trauma. Rangsangan sakit yang disebabkan oleh stres fisik apapun atau kerusakan jaringan pertama dihantarkan ke atas melalui batang otak dan akhirnya ke puncak median hipotalamus. Stres mental dapat juga segera menyebabkan peningkatan sekresi ACTH. Keadaan ini dianggap sebagai akibat naiknya aktivitas dalam sistem limbik, khususnya dalam regioamigdala dan hipotalamus, yang keduanya kemudian menjalarkan sinyal ke bagian posterior medial hipotalamus.

2. Penyebab

   Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan pendarahan pada ibu hamil. Beberapa penyebab umum meliputi :

   Pendarahan pada Ibu Hamil

   a. Keguguran: Pendarahan adalah salah satu gejala utama dari keguguran yang terjadi pada tahap awal kehamilan.
   b. Plasenta previa: Ketika plasenta menempel di dekat atau menutupi sebagian atau seluruh leher rahim, bisa menyebabkan pendarahan pada kehamilan.
   c. Plasenta akreta: Plasenta tidak dapat melepaskan diri dengan normal setelah melahirkan, yang dapat menyebabkan pendarahan.

3. Klasifikasi

   Terdapat klasifikasi perdarahan pada kehamilan muda, yaitu:

   a. Abortus

      Abortus merupakan suatu proses ancaman atau pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan.

   b. Kehamilan Ektopik Terganggu (KET)

      Kehamilan ektopik terganggu adalah suatu kehamilan yang berbahaya bagi wanita yang bersangkutan berhubung dengan besarnya kemungkinan terjadi keadaan yang gawat.

   c. Mola hidatidosa

      Mola hidatidosa merupakan kehamilan abnormal dimana hampir seluruh vili korialis mengalami perubahan hidrofik.

Tabel 4.1
Diangnosis perdarahan pada kehamilan muda

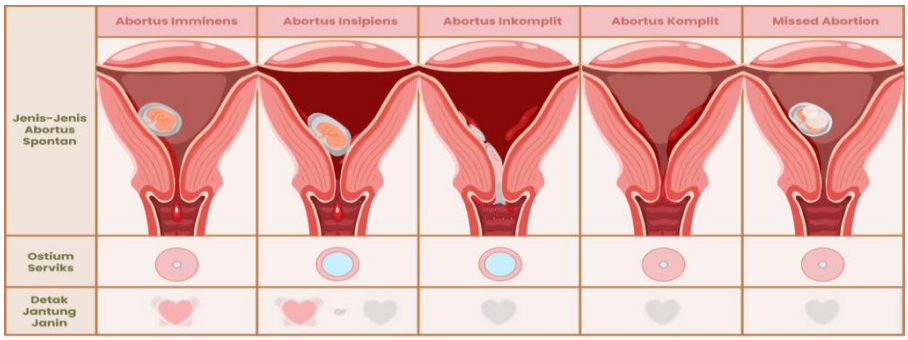
Perdarahan	Serviks	Uterus	Grjala/Tanda	Diagnosis
Bercak hingga sedang	tertutup	Sesuai dengan usia gestasi	Kram perut bawah uterus lunak	**Abortus Imminens**
		Sedikit membesar dari nprmal	Limbung atau Pingsan Nyeri perut bawah Nyeri goyang porsio Masa adneksa Cairan bebas intraabdomen	**Kehamilan Ektopik terganggu**
	Tertutup atau terbuka	Lebih kecl dari usia gestasi	Sedikit/tanpa nyeri perut bawah Riwayat ekspulsi hasil konsepsi	**Abortus Komplit**
Sedang hingga masif/banyak	Terbuka	Sesuai usia kehamilan	Kram atau nyeri perut bawah belum terjadi ekspulsi hasil konsepsi	**Abortus Insipiens**
			Kram atau nyeri perut bawah belum terjadi ekspulsi sebagian hasil konsepsi	**Abartus Inkomplit**
	terbuka	Lunak dan lebih dari usia gestasi	Mual/muntah kram perut bawah sindroma mirip	**Abortus Mola**

			preeklamsia tidak ada janin, keluar jaringan seperti anggur	

Tabel 4.2
Diangnosis dan penatalaksanaan komplikasi pada abortus

Tanda dan Gejala	Komplikasi	Penaganan
1. Nyeri abdomen bawah 2. Nyeri lepas 3. Uterus terasa lemas 4. Perdarahan berlanjut 5. Lemah/lesuh 6. Demam 7. Sekret vagina berbau 8. Sekret dan pus dari serviks 9. Nyeri oyang serviks	Infeksi/sepsis	Mulailah antibiotik sesegera mungkin sebelum melakukan aspirasi vakum manual.
1. Nyeri kaku pada abdomen 2. Nyeri lepas 3. Distensi abdomen 4. Abdomen terasa tegang dan keras 5. Nyeri pada bahu 6. Mual/muntah **7.** Demam	Perlukaan uterus, vagina dan usus	Lakukan laparotomi untuk memperbaiki perlukaan dan lakukan aspirasi vakum manual secara berurutan. Mintalah bantuan lebih lanjut jika dibutuhkan

1. Jenis-jenis Abortus



Gambar 4.1
Jenis-jenis Abortus

a. Abortus Spontan adalah penghentian kehamilan sebelum janin mencapai viabilitas (usia kehamilan 22 minggu), tahap-tahap abortu spontan:
   1) Abortus imminens (kehamilan dapat berlanjut.
   2) Abortus insipiens (kehamilan tidak adakan berlanjut dan akan berkembang menjadi abortus inkomplit/komplit.
   3) Abortus inkomplit (sebagian hasil konsepsi telah keluar).
   4) Abortus komplit (seluruh hasil konsepsi telah dikeluarkan).

b. Abortus yang disengaja: adalah suatu proses dihentikannya kehamilan sebelum janin mencapai viabilitas.
   1) Abortus tidak aman adalah suatu prosedur yang dilakukan oleh orang yang tidak berpengalaman atau dalam lingkungan yang tidak memenuhi standar medis minimal atau keduanya.
   2) Abortus septik adalah abortus yang mengalami komplikasi berupa infeksi. Sepsis dapat berasal dari infeksi jika organisme penyebab naik dari saluran kemih bawah setelah abortus spontan atau abortus tidak aman. Sepsiss cenderung akan terjadi jika terdpat sisa hasil konsepsi atau penundaan dalam pengeluaran hasil konsepsi. Sepsis merupakan komplikasi yang sering terjadi pada abortus tidak aman dengan menggunakan peralatan.

Penaganan

Jika dicurigai suatu abortus tidak aman terjadi, priksalah keadaannya tanda-tanda infeksi atau adanya perlukaan uterus, vagina dan usus serta lakukan irigasi vagina untuk mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, obat-obat lokal, atau bahan lainnya.

a. Abortus imminens (ancaman keguguran) bertujuan utama untuk mempertahankan kehamilan dan mencegah perdarahan lebih lanjut.
   1) Perawatan Mandiri dan Tirah Baring (Bed Rest)
      Langkah pertama yang paling sering dianjurkan adalah membatasi aktivitas fisik secara total untuk mengurangi tekanan pada rahim.
      a) Tirah Baring (Bed Rest): Pasien disarankan untuk berbaring di tempat tidur dan hanya bangun untuk keperluan mendesak ke kamar mandi.
      b) Istirahat di Rumah Sakit: Pada beberapa kasus, dokter mungkin menyarankan rawat inap selama 2–3 hari hingga perdarahan benar-benar berhenti.
      c) Hindari Aktivitas Berat: Tidak boleh berolahraga, mengangkat beban berat, atau melakukan perjalanan jauh.
   2) Pantangan Selama Masa Pemulihan
      Untuk menjaga stabilitas rahim, beberapa hal berikut harus dihindari sementara waktu:

a) Hubungan Seksual: Dilarang melakukan hubungan intim hingga gejala (perdarahan dan kram) benar-benar hilang.
b) Penggunaan Tampon: Hindari memasukkan benda apa pun ke dalam vagina, termasuk tampon atau pembersih kewanitaan, untuk mencegah infeksi.

3) Pemberian Obat-obatan

Dokter dapat meresepkan obat tertentu berdasarkan hasil pemeriksaan, di antaranya:

a) Penguat Kandungan (Hormon Progesteron): Diberikan untuk membantu memperkuat lapisan rahim dan mendukung kelangsungan kehamilan.
b) Suplemen: Tetap melanjutkan konsumsi zat besi dan asam folat sesuai anjuran.
c) Antispasmodik: Kadang diberikan jika terdapat kram perut yang hebat.

4) Pemantauan Medis (Follow-up)

Sangat penting untuk melakukan pemantauan rutin untuk memastikan kondisi janin tetap stabil:

a) USG (Ultrasonografi): Digunakan untuk memantau detak jantung janin dan kondisi kantong kehamilan.
b) Pemeriksaan Darah: Dilakukan untuk memantau kadar hormon kehamilan (hCG) atau memeriksa kadar hemoglobin jika terjadi perdarahan yang cukup banyak.

Segera cari bantuan medis darurat jika perdarahan semakin banyak, disertai keluarnya gumpalan jaringan, atau kram perut yang semakin hebat, karena hal tersebut bisa menandakan kondisi telah berlanjut menjadi keguguran yang tak terhindarkan.

b. Abortus Insipiens (keguguran yang sedang berlangsung dan tidak dapat dihindari) berfokus pada pengosongan rahim secara aman karena janin sudah tidak mungkin dipertahankan. Langkah penanganan medis yang diambil sesuai dengan usia kehamilan.

1) Penanganan Berdasarkan Usia Kehamilan

a) Kehamilan < 12 Minggu:
b) Prosedur Kuretase: Dilakukan untuk membersihkan sisa jaringan secara cepat guna mencegah perdarahan hebat atau infeksi.
c) Vakum Aspirasi: Penggunaan alat isap untuk mengeluarkan isi rahim, yang sering kali lebih minim trauma dibandingkan kuret tajam.
d) Kehamilan 12–23 Minggu:

e) Induksi Kontraksi: Dokter akan memberikan obat-obatan (seperti misoprostol atau infus oksitosin) untuk memicu kontraksi rahim agar janin dan jaringan keluar secara alami.
f) Jika jaringan tidak keluar sepenuhnya setelah induksi, prosedur kuretase tetap mungkin diperlukan.

2) Manajemen Ekspektan (Menunggu)
Dokter mungkin menyarankan untuk menunggu jaringan keluar dengan sendirinya secara spontan jika tidak ada tanda-tanda infeksi atau perdarahan yang membahayakan nyawa. Pasien akan dipantau secara ketat selama proses ini.

3) Penanganan Medis Pendukung
a) Pemberian Obat Pereda Nyeri: Mengingat abortus insipiens sering disertai kram perut hebat, obat analgetik seperti asam mefenamat mungkin diberikan.
b) Pencegahan Infeksi: Pemberian antibiotik dan edukasi untuk menjaga kebersihan area kewanitaan (vulva hygiene).
c) Manajemen Syok dan Anemia: Jika terjadi perdarahan berat, dokter akan melakukan resusitasi cairan melalui infus atau transfusi darah bila diperlukan.

4) Perbedaan dengan Jenis Abortus Lain
Penting untuk membedakan kondisi ini dengan jenis keguguran lainnya:
a) Abortus Imminens: Ancaman keguguran di mana janin masih bisa diselamatkan dengan istirahat total (bed rest).
b) Abortus Insipiens: Serviks (leher rahim) sudah terbuka, janin tidak bisa diselamatkan, dan proses keguguran sedang berjalan.

Vakum Aspirasi: Metode yang lebih disarankan karena risiko trauma pada rahim yang lebih rendah dibanding kuret tajam.

c. Abortus Inkomplit (keguguran tidak lengkap) bertujuan untuk mengeluarkan sisa jaringan hasil konsepsi yang masih tertinggal di dalam rahim guna mencegah komplikasi seperti perdarahan hebat atau infeksi.

1) Manajemen Aktif (Tindakan Medis)
Metode ini menggunakan obat-obatan atau prosedur bedah untuk segera membersihkan rahim:
a) Prosedur Bedah:
b) Aspirasi Vakum Manual (AVM): Menggunakan alat isap manual untuk mengeluarkan jaringan. Metode ini lebih disarankan untuk kehamilan di bawah 14 minggu karena risiko komplikasi yang lebih rendah dibandingkan kuretase tajam.

c) Dilatasi dan Kuretase (D&C): Prosedur untuk memperlebar serviks dan mengerok dinding rahim guna mengangkat sisa jaringan.
d) Obat-obatan (Medikamentosa):
e) Penggunaan obat seperti Misoprostol untuk merangsang rahim berkontraksi dan mengeluarkan sisa jaringan secara alami. Ini sering menjadi pilihan utama (drug of choice) untuk kasus tanpa komplikasi berat.

2) Manajemen Ekspektan (Observasi)

Dokter akan memantau kondisi pasien sambil menunggu sisa jaringan keluar dengan sendirinya secara alami.

a) Biasanya memakan waktu 1–2 minggu.
b) Hanya dilakukan pada kasus yang stabil, namun tetap berisiko menyebabkan perdarahan mendadak.

3) Penanganan Awal dan Darurat

Jika terjadi perdarahan hebat atau tanda-tanda syok, langkah pertama yang dilakukan meliputi:

a) Penilaian Cepat: Memeriksa tanda vital (nadi, tekanan darah, pernapasan) dan tanda-tanda syok.
b) Stabilisasi: Pemberian cairan infus atau transfusi darah jika diperlukan.
c) Antibiotik: Diberikan jika ada tanda-tanda infeksi atau sebagai profilaksis pasca tindakan.

4) Perawatan Pasca Tindakan

Setelah rahim dinyatakan bersih, pasien disarankan untuk:

a) Beristirahat total sesuai anjuran dokter.
b) Mengonsumsi obat pereda nyeri jika kram masih terasa.
c) Menghindari hubungan seksual sementara waktu (biasanya hingga perdarahan benar-benar berhenti).
d) Melakukan pemeriksaan kontrol untuk memastikan rahim telah pulih sepenuhnya.

d. Abortus Kompletus (keguguran lengkap) umumnya bersifat konservatif karena seluruh hasil konsepsi (janin dan plasenta) telah keluar dari rahim secara alami. Berbeda dengan abortus inkompletus, kondisi ini biasanya tidak memerlukan tindakan kuretase atau pembedahan.

Berikut adalah langkah-langkah penanganan dan pemulihan yang umum dilakukan:

1) Observasi Medis

a) Pemantauan Perdarahan: Dokter akan memastikan perdarahan pervaginam berkurang dan berhenti dengan cepat setelah jaringan

keluar. Jika perdarahan sangat banyak, pasien mungkin memerlukan observasi lebih lanjut untuk mencegah anemia berat.

b) Pemeriksaan Fisik: Memastikan rahim telah mengecil dan lubang leher rahim (ostium serviks) sudah menutup kembali.

c) USG (Opsional): Terkadang dilakukan untuk memastikan tidak ada sisa jaringan yang tertinggal di dalam rahim.

2) Terapi Farmakologi (Obat-obatan)

Jika diperlukan, dokter dapat memberikan obat-obatan untuk mendukung pemulihan:

a) Uterotonika: Obat untuk membantu kontraksi rahim guna menghentikan perdarahan dan memastikan rahim benar-benar bersih.

b) Suplemen Besi: Diberikan (seperti sulfas ferrosus) jika pasien mengalami anemia akibat kehilangan darah.

c) Antinyeri: Untuk meredakan kram perut atau nyeri pasca keguguran.

3) Perawatan Pasca-Abortus

a) Kebersihan Diri: Disarankan menggunakan pembalut wanita daripada tampon selama perdarahan masih berlangsung untuk mengurangi risiko infeksi.

b) Istirahat Seksual: Dianjurkan untuk menunda hubungan seksual sampai perdarahan benar-benar berhenti.

c) Dukungan Emosional: Pasien mungkin memerlukan konseling atau dukungan psikologis untuk mengatasi kehilangan.

2. Pemantauan Pasca Abortus

Sebelum pasien diperbolehkan pulang, beri tahu bahwa abortus spontan merupakan hal yang biasa terjadi paling sedikit 15% (satu dari tuju kehamilan) dari seluruh kehamialan yang diketahui secara klinis. Berilah keyakinan akan kemungkinan keberhasilan untuk kehamilan berikut kecuali jika terdapat sepsis atau adanya penyebab abortus yang dapat mempunyai efek samping pada kehamilan berikut (hal ini bisa terjadi).

Beberapa wanita mungkin ingin hamil langsung stelah suatu abortus inkomplit, ibu ini sebaiknya diminta untuk menunda kehamilan berikut sampai iya benar-benar pulih. Untuk ibu yang riwayat abortus yang tidak aman, konseling merupakan hal yang penting. Jika kehamilan tersebut merupakan kehamilan yang tidak di inginkan, ada beberapa metode kontrasepsi dapat segera dimulai (dalam waktu 7 hari) dengan syarat:

a. Tidak terdapat komplikasi berat yang membutuhkan penanganan lebih lanjut
b. Ibu menerima konseling dan bantuan secukupnya dalam memilih metode kontrasespsi yang sesuai.

Tabel 4.3
Kontrasepsi Pasca Abortus

metode	Waktu Aplikasi	keterangan
kondom	Segera	Evektifitas tergantung dari tingkat kedisiflinan pasien dapat mencegah PMS
Pil Hormonal	Segera	Cukup efektip tetapi perlu ketaatan pasien untuk minum pil secara teratur
Suntikan	Segera	Konseling untuk pilih hormon tunggal atau kombinsi
Implan	Segera	Jika pasangan tersebut mempunyai satu anak atau lebih dan ingin kotrasepsi jangka panjang
AKDR	Segera atau kondisi pasien pulih kembali	Tunda insersi jika HB kurang dari 7g/dl (anemia) atau dicurigai adanya infeksi
Tubektomi	Segera	Sesuai untuk pasangan yang ingin menghentikan fertilitas. Jika dicurigai adannya infeksi, tunda prosedur sampai keadaan jelas. Jika HB kurang dari 7g/dl, tunda sampai anemia telah diperbaiki. Sediakan artenatif seperti kondom

3. Komplikasi Abortus

Komplikasi yang berbahaya pada abortus antara lain perdarahan yang dapat diatasi dengan pengosongan uterus dan sisa-sisa hasil konsepsi dan jika perlu pemberian transfusi darah. Kematian karena perdarahan dapat terjadi apabila pertolongan tidak diberikan pada waktunya. Perforasi uterus pada kerokan dapat terjadi terutama pada uterus dalam posisi hiperretrofleksi. Infeksi dalam uterus atau sekitarnya dapat terjadi pada setiap abortus dan biasanya ditemukan pada abortus inkompletus dan lebih sering pada abortus buatan yang dikerjakan tanpa memperhatikan asepsis dan antisepsis.

Syok pada abortus bisa terjadi karena perdarahan (syok hemoragik) dan karena infeksi berat (syok endoseptik).

4. Alur Rujukan

Rujukan ibu hamil yang berisiko tinggi merupakan komponen yang penting dalam sistem pelayanan kesehatan maternal. Pemahaman sistem dan cara rujukan yang baik, tenaga kesehatan diharapkan dapat memperbaiki kualitas pelayanan pasien.

Indikasi dan Kontraindikasi Rujukan dilakukan apabila tenaga dan perlengkapan disuatu fasilitas kesehatan tidak mampu menatalaksana komplikasi yang mungkin terjadi. Dalam pelayanan kesehatan maternal dan pernatal, terdapat dua alasan untuk merujuk ibu hamil, yaitu ibu dan/atau janin yang dikandungnya. Berdasarkan sifatnya, rujukan ibu hamil dibedakan menjadi:

a. Rujukan kegawatdaruratan

   Rujukan kegawatdaruratan adalah rujukan yang dilakukan sesegera mungkin karena berhubungan dengan kondisi kegawatdaruratan yang mendesak.

b. Rujukan berencana

   Rujukan berencana adalah rujukan yang dilakukan dengan persiapan yang lebih panjang ketika keadaan umum ibu masih relatif lebih baik, misalnya di masa antenatal atau awal persalinan ketika didapati kemungkinan risiko komplikasi. Karena tidak dilakukan dalam 10 kondisi gawat darurat, rujukan ini dapat dilakukan dengan pilihan modalitas transportasi yang lebih beragam, nyaman, dan aman bagi pasien.

   Adapun rujukan sebaiknya tidak dilakukan bila:

   1) Kondisi ibu tidak stabil untuk dipindahkan
   2) Kondisi janin tidak stabil dan terancam untuk terus memburuk
   3) Persalinan sudah akan terjadi
   4) Tidak ada tenaga kesehatan terampil yang dapat menemani
   5) Kondisi cuaca atau modalitas transportasi membahayakan

c. Perencanaan Rujukan

   Komunikasikan rencana merujuk dengan ibu dan keluarganya, karena rujukan harus medapatkan pesetujuan dari ibu dan/atau keluarganya. Tenaga kesehatan perlu memberikan kesempatan, apabila situasi memungkinkan, untuk menjawab pertimbangan dan pertanyaan ibu serta keluarganya. Beberapa hal yang disampaikan sebaiknya meliputi:

   1) Diagnosis dan tindakan medis yang diperlukan
   2) Alasan untuk merujuk ibu
   3) Risiko yang dapat timbul bila rujukan tidak dilakukan
   4) Risiko yang dapat timbul selama rujukan dilakukan
   5) Waktu yang tepat untuk merujuk dan durasi yang dibutuhkan untuk merujuk
   6) Tujuan rujukan
   7) Modalitas dan cara transportasi yang digunakan
   8) Nama tenaga kesehatan yang akan menemani ibu
   9) Jam operasional dan nomer telepon rumah sakit/pusat layanan kesehatan yang dituju

10) Perkiraan lamanya waktu perawatan
11) Perkiraan biaya dan sistem pembiayaan (termasuk dokumen kelengkapan untuk Jampersal, Jamkesmas, atau asuransi kesehatan)
12) Petunjuk arah dan cara menuju tujuan rujukan dengan menggunakan modalitas transportasi lain
13) Pilihan akomodasi untuk keluarga.

C. Kehamilan Ektopik

Kehamilan ektopik adalah kondisi di mana sel telur yang telah dibuahi menempel dan berkembang di luar rahim, biasanya di tuba falopi. Kehamilan ini tidak dapat berlanjut secara normal dan berisiko menyebabkan komplikasi serius bagi ibu jika tidak segera ditangani. Pengertian Kehamilan Ektopik Kehamilan ektopik merupakan hasil dari implantasi dan pematangan konseptus di luar rongga endometrium, yang akhirnya berakhir dengan kematian janin. Jika tidak didiagnosis dini dan mendapat perawatan yang tepat waktu, maka 43 kehamilan ektopik dapat mengancam nyawa. Kehamilan ektopik ini dapat terjadi apabila terjadi ketidak normalan dalam fisiologi reproduksi manusia yang memungkinkan janin menempel atau tertanam dan matang di luar endometrium yang akhirnya dapat menimbulkan kematian pada janin.

1. Tanda dan gejala kehamilan Ektopik

   Tanda dan gejala sangat lah bervariasi tergantung pada pecah atau tidaknya kehammilan tersebut. Alat penting yang dapat digunakan untuk mendiagnosis kehamilan ektopik yang pecah adalah tes kehamilan dari serum dikombinasi dengan ultrasonogrsfi. Jika diperoleh hasil darah yang tidak membeku, segra mulai penaganan. Pada tahap awal, kehamilan ektopik mungkin menunjukkan gejala yang mirip dengan kehamilan normal, seperti telat haid, mual, dan nyeri payudara. Namun, seiring perkembangan, gejala khas kehamilan ektopik meliputi:

   a. Nyeri panggul yang tajam atau menusuk, sering kali di satu sisi perut bawah.
   b. Perdarahan vagina abnormal, yang bisa ringan hingga berat.
   c. Nyeri bahu akibat iritasi diafragma yang disebabkan oleh pendarahan internal.
   d. Rasa tidak nyaman saat buang air kecil atau buang air besar.
   e. Pusing, lemas, atau pingsan, tanda kemungkinan perdarahan dalam jumlah besar.

Tabel 4.4
Tanda dan Gejala Kehamilan ektopik

Kehamilan Ektopik	Kehamilan Ektopik Terganggu
Gejala kehamilan awal (flek atau perdarahan yang ireguler, mual, pembesaran uterus, mual, pembesaran payudara, perubahan warna pada vagina dan serviks, pembesaran uterus, frekuensi buang air kecil yang meningkat.	• Kolap dan kelelahan • Denyut nadi cepat dan lemah (110x/menit atau lebih) • Hipotensi • Hipovolemia
Nyeri pada abdomen dan pelvis	• Abdomen akut dan nyeri pelvis • Distensia abdomen • Nyeri lepas • Pucat

2. Penyebab kehamilan ektopik

   Kehamilan ektopik terjadi ketika sel telur yang telah dibuahi mengalami hambatan dalam perjalanannya menuju rahim. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko kehamilan ektopik meliputi:

   a. Infeksi atau peradangan:
      Infeksi menular seksual atau penyakit radang panggul (PID) dapat menyebabkan jaringan parut di tuba falopi.
   b. Riwayat kehamilan ektopik sebelumnya:
      Wanita yang pernah mengalami kehamilan ektopik lebih berisiko mengalami kondisi ini kembali.
   c. Operasi tuba falopi:
      Prosedur medis pada tuba falopi dapat menyebabkan perubahan struktural yang menghambat perjalanan sel telur.
   d. Penggunaan alat kontrasepsi dalam rahim (IUD):
      Meskipun sangat efektif dalam mencegah kehamilan, dalam kasus langka, jika kehamilan terjadi saat menggunakan IUD, kemungkinan kehamilan ektopik lebih tinggi.
   e. Merokok:
      Kebiasaan merokok dapat merusak silia di tuba falopi yang berfungsi membantu pergerakan sel telur.

f. Endometriosis:
   Kondisi ini dapat menyebabkan jaringan parut dan adhesi yang meningkatkan risiko kehamilan ektopik.
g. Obat hormon dan terapi kesuburan:
   Penggunaan obat penyubur atau teknologi reproduksi berbantu seperti IVF dapat sedikit meningkatkan risiko kehamilan ektopik.

3. Diagnosis kehamilan ektopik
   Dokter biasanya mendiagnosis kehamilan ektopik melalui kombinasi:
   a. Tes kehamilan untuk memeriksa kadar hormon hCG dalam darah.
   b. USG transvaginal untuk melihat lokasi implantasi janin.
   c. Pemeriksaan panggul untuk mendeteksi nyeri atau massa abnormal.
   d. Penanganan kehamilan ektopik

      Karena janin tidak dapat bertahan di luar rahim, kehamilan ektopik harus segera ditangani. Pilihan pengobatan meliputi:
   a. Obat-obatan
   b. Metotreksat: Obat ini digunakan untuk menghentikan pertumbuhan sel embrio dan memungkinkan tubuh menyerap jaringan kehamilan tanpa operasi.
   c. Prosedur bedah
   d. Laparoskopi: Operasi minimal invasif untuk mengangkat jaringan kehamilan dari tuba falopi tanpa merusaknya.
   e. Laparotomi: Operasi terbuka dalam kasus darurat untuk mengangkat tuba falopi jika terjadi kerusakan parah.
4. Komplikasi Kehamilan Ektopik
   Jika tidak segera ditangani, kehamilan ektopik dapat menyebabkan:
   a. Pecahnya tuba falopi, yang dapat menyebabkan perdarahan internal berat dan kondisi yang mengancam nyawa.
   b. Infertilitas, terutama jika salah satu atau kedua tuba falopi rusak atau diangkat.
   c. Risiko kehamilan ektopik di masa mendatang, meningkat jika seorang wanita memiliki riwayat kondisi ini.
5. Pencegahan Kehamilan Ektopik

   Meskipun tidak semua kehamilan ektopik dapat dicegah, ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengurangi risikonya:
   a. Menghindari infeksi menular seksual dengan menggunakan kondom dan menjalani pemeriksaan rutin.
   b. Berhenti merokok untuk meningkatkan kesehatan sistem reproduksi.
   c. Menjaga kesehatan tuba falopi dengan mengobati infeksi panggul secara dini dan tuntas.

d. Konsultasi dengan dokter sebelum menggunakan terapi kesuburan, terutama jika memiliki riwayat kehamilan ektopik.
e. Kehamilan ektopik adalah kondisi serius yang memerlukan diagnosis dan penanganan segera. Mengenali gejala sejak dini dan berkonsultasi dengan dokter dapat membantu menghindari komplikasi yang mengancam nyawa. Jika Anda mengalami gejala mencurigakan, segera periksakan diri ke tenaga medis untuk evaluasi lebih lanjut.

6. Penatalaksanaan

Penatalaksanaan bedah sangat penting dalam kehamilan ektopik yang ruptur. Laparotomi adalah prosedur pembedahan yang paling sering dilakukan. Prosedur laparoskopi dikaitkan dengan waktu operasi yang lebih singkat, kehilangan darah yang lebih sedikit intraoperatif, pemulihan di rumah sakit yang lebih cepat dan persyaratan analgesia yang lebih rendah. Laparotomi harus dilakukan untuk pasien yang mengalami ruptur dan dalam keadaan syok dan kompromi hipovolemik.

D. Mola Hidatidosa

Mola hidatidosa adalah plasenta vili orialis yang berkembang tidak sempurna dengan gambaran adanya pembesaran, edema, dan vili vesikuler sehingga menunjukkan berbagai ukuran trofoblas trofoblas profileratif tidak normal. Mola hidatidosa terdiri dari mola hidatidosa komplit dan mola hidatidosa parsial, perbedaan antara keduanya adalah berdasarkan morfologi, gambaran klinik patologi, dan sitogenik.

Mola hidatidosa atau yang disebut juga dengan hamil anggur adalah suatu bentuk tumor jinak dari sel-sel trofoblas (yaitu bagian dari tepi sel telur yang kelak terbentuk menjadi ari-ari janin) atau merupakan suatu hasil pembuahan yang gagal. Jadi dalam proses kehamilannya mengalami hal yang berbeda dengan kehamilan normal, dimana hasil pembuahan sel sperma dan sel telur gagal terbentuk dan berubah menjadi gelembunggelembung semakin banyak bahkan bisa berkembang secara cepat. Pada pemeriksaan laboratorium didapatkan kadar HCG (dengan pemeriksaan GM titrasi) atau dapat dilihat dari hasil laboratorium beta sub unit HGG pada ibu hamil tinggi.

1. Etiologi

Menurut Purwaningsih, 2010 penyebab terjadinya mola hidatidosa adalah pembengkakan vili (degenerasi pada hidrofibik) dan poliferasi trofoblas. Faktor yang dapat menyebabkan mola hidatidosa antara lain:

a. Faktor ovum: ovum memang sudah patologik sehingga mati, tetapi terlambat dikeluarkan. Spermatozoa memasuki ovum yang telah kehilangan nukleusnya

atau ada serum memasuki ovum tersebut sehingga akan terjadi kelainan atau gangguan dalam pembuahan

b. Imunoselektif dari trofoblas, yaitu dengan kematian fetus, pembuluh darah pada stoma vili menjadi jarang dan stroma vili menjadi sembab dan akhirnya terjadi hyperplasia sel-sel trofoblast
c. Keadaan sosio-ekonomi yang rendah, dalam masa kehamilan keperluan zat-zat gizi meningkat. Hal ini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan janin, dengan keadaan sosial ekonomi yang rendah maka untuk memenuhi gizi yang diperlukan tubuh kurang sehingga mengakibatkan gangguan dalam pertumbuhan dan perkembangan janinnya
d. Paritas tinggi, ibu multipara cenderung beresiko terjadi kehamilan mola hidatidosa karena trauma kelahiran atau penyimpangan transmisi. Secara genetic yang dapat diidentifikasi dan penggunaan stimulan drulasi seperti menotropiris (pergonal).
e. Kekurangan protein, protein adalah zat untuk membangun jaringan bagian tubuh sehubungan dengan pertumbuhan janin, rahim. Keperluan akan zat protein pada waktu hamil sangat meningkat apabila kekurangan protein dalam makanan mengakibatkan akan lahir lebih kecil dari normal. Infeksi virus dan faktor kromosom yang belum jelas, infeksi mikroba dapat mengenai semua orang termasuk wanita hamil. Masuk atau adanya mikroba dalam tubuh manusia tidak selalu akan menimbulkan penyakit. Hal ini sangat tergantung dari jumlah mikroba yang masuk virulensinya serta daya tahan tubuh.

Faktor lainnya yang diketahui adalah sosial ekonomi rendah, keguguran sebelumnya, neoplasma trofoblastik gestasional sebelumnya, dan usia yang sangat ekstrim pada masa subur. Efek usia yang sangat jelas terlihat adalah pada wanita yang berusia lebih dari 45 tahun, Poltekkes Kemenkes Padang 8 ketika frekuensi lesi yang terjadi adalah 10 kali lipat dari pada lesi yang dapat terjadi pada wanita yang berusi 20-40 tahun.

Faktor lain yang mempengaruhi wanita untuk kehamilan mola yaitu berkaitan dengan genetika dan riwayat reproduksi. Berikut faktor resiko untuk kehamilan mola hidatidosa :

a. Riwayat kehamilan mola hidatidosa sebelumnya Wanita yang pernah mengalami kehamilan mola hidatidosa memiliki resiko 2 kali lipat dibandingkan dengan yang belum pernah mengalami kehamilan mola hidatidosa.
b. Riwayat genetik Terdapat penelitian yang membuktikan bahwa kehamilan mola hidatidosa memiliki penyebab genetik terkait dengan mutasi gen.

c. Faktor makanan Asupan rendah karotene dan rendah lemak hewani dikaitkan peningkatan resiko kehamilan mola hidatidosa sempurna, termasuk juga kekurangan vitamin A.

2. Klasifikasi

Klasifikasi atau pengelompokan mola hidatidosa menurut Sastrawinata, 2007:

a. Mola hidatidosa komplet (MHK) Pada mola jenis ini, tidak terdapat adanya tanda-tanda embrio, tali pusat, atau membrane. Kematian terjadi sebelum berkembangnya sirkulasi plasenta. Vili korionik berubah menjadi vesikel hidropik yang jernih yang menggantung bergerombol pada pedikulus kecil, dan memeberi tampilan seperti seikat anggur. Ukuran vesikel bervariasi, dari yang sulit dilihat sampai yang berdiameter beberapa sentimeter. Pada kehamilan normal, trofoblas meluruhkan desidua untuk menambahkan hasil konsepsi. Hal ini berarti bahwa mola yang sedang berkembang dapat bepenetrasi ke tempat implantasi. Miometrium dapat terlibat, begitu pula dengan vena walaupun jarang terjadi ruptur uterus dengan perdarahan massif merupakan salah satu akibat yang dapat terjadi.



Gambar 4.2
Mola Hidatidosa

b. Mola hidatidosa parsial (MHP) Tanda-tanda adanya suatu embrio, kantong janin, atau kantong amnion dapat ditemukan karena kematian terjadi sekitar minggu ke-8 atau ke-9. Hiperplasia trofoblas hanya terjadi pada lapisan sinsitotrofoblas tunggal dan tidak menyebar luas dibandingkan dengan mola komplet. Kariotip umunya adalah triploid sebagai hasil pembuahan satu ovum oleh dua sperma (dispermi). Bisa berupa 69 XXX, 69 XXY, atau 69 XYY. Pada MHP, embrio biasanya mati sebelum trimester pertama. Walaupun pernah dilaporkan adanya MHP dengan bayi aterm. Secara histologi, membedakan antara mola parsial dan keguguran laten merupakan hal yang sulit dilakukan.

3. Manifestasi Klinis

Gejala mola tidak berbeda dengan kehamilan biasa, yaitu mual, muntah, pusing dan lain-lain, hanya saja derajat keluhannya sering lebih hebat. Selanjutnya, perkembangannya lebih cepat, sehingga pada umumnya besar uterus lebih besar dari pada umur kehamilan. Ada pula kasus kasus yang uterusnya lebih kecil atau sama besar walau jaringannya belum dikeluarkan. Dalam hal ini perkembangan jaringan trofoblas tidak begitu aktif sehingga perlu dipikirkan kemungkinan adanya dying mole. Pada pasien mola biasa nya akan terjadi:

a. Nyeri/kram perut
b. Muka pucat/keuning-kuningan
c. Perdarahan tidak teratur
d. Keluar jaringan mola
e. Keluar secret pervaginam
f. Muntah-muntah
g. Pembesaran uterus dan uterus lembek
h. Balotemen tidak teraba
i. Fundus uteri lebih tinggi dari kehamilan normal
j. Gerakan janin tidak terasa
k. Terdengar bunyi dan bising yang khas l. Penurunan berat badan yang khas.

4. Patofisiologi

Jonjot-jonjot tumbuh berganda dan mengandung cairan merupakan kistakista anggur, biasanya didalamnya tidak berisi embrio. Secara histopatologik kadang-kadang ditemukan jaringan mola pada plasenta dengan bayi normal. Bisa juga terjadi kehamilan ganda mola adalah: satu janin tumbuh dan yang satu lagi menjadi mola hidatidosa. Gelembung mola besarnya bervariasi, mulai dari yang kecil sampai berdiameter lebih dari 1 cm.

Mola parliasis adalah bila dijumpai janin dan gelembung-gelembung mola. Secara mikroskopik terlihat :

a. Proliferasi dan trofoblas
b. Degenerasi hidropik dari stroma villi dan kesembaban
c. Terlambat atau hilangnya pembuluh darah dan stroma.

Sel-sel langhans tampak seperti sel polidral dengan inti terang dan adanya sel sinsial giantik. Pada kasus mola banyak kita jumpai ovarium dengan kista lutein ganda berdiameter 10 cm atau lebih (25- 60%). Kista lutein akan berangsur-angsur mengecil dan kemudian hilang setelah mola hidatidosa sembuh. Sel telur seharusnya berkembang menjadi janini justru terhenti

perkembangannya karena tidak ada buah kehamilan atau degenerasi sistem aliran darah terhadap kehamilan pada usia 3-4 minggu. Pada fase ini sel seharusnya mengalami nidasi tetapi karena adanya poliferasi dari trofoblas atau pembengkakan vili atau degenerasi hidrifilik dari stroma vili dan hilangnya pembuluh darah stroma vili maka nidasi tidak terjadi. Selain itu sel trofoblas juga mengeluarkan hormon HCG yang akan mengeluarkan rasa mual dan muntah. Pada mola hidatidosa juga terjadi perdarahan pervaginam, ini dikarenakan poliferasi trofoblas yang berlebihan, pengeluaran darah ini kadang disertai juga dengan gelembuung vilus yang dapat memastikan dignosis mola hidatidosa.

5. Pemeriksaan Penunjang

   Ada beberapa pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan pada pasien mola hidatidosa

   a. HCG: nilai HCG meningkat dari normal nya. Nilai HCG normal pada ibu hamil dalam berbagai tingkatan usia kehamilan berdasarkan haid terakhir :
      1) 3 minggu: 5-50 mlU/ml
      2) 4 minggu: 5-426 mlU/ml
      3) 5 minggu: 18-7,340 mlU/ml
      4) 6 minggu: 1.080-56,500 mlU/ml
      5) 7-8 minggu: 7,650-229,000 mlU/ml
      6) 9-12 minggu: 25,700-288,000 mlU/ml
      7) 13-16 minggu: 13,300-254,000 mlU/ml
      8) 17-24 minggu: 4,060-165,400 mlU/ml
      9) 25-40 minggu: 3,640-117,000 mlU/ml
      10) Tidak hamil: < 9.5 mlU/ml
   b. Pemeriksaan rontgen: Tidak ditemukan kerangka bayi
   c. Pemeriksaan USG: Tidak ada gambaran janin dan denyu jantung janin
   d. Uji sonde: Pada hamil mola, sonde mudah masuk, sedangkan pada kehamilan biasa, ada tahanan dari janin.

6. Penatalaksanaan

   Karena mola hidatidosa adalah suatu kehamilan patologi dan tidak jarang disertai penyulit yang membahayakan jiwa, pada prinsipnya harus segera dikeluarkan. Terapi mola hidatidosa terdiri dari tiga tahap, yaitu :

   a. Perbaikan keadaan umum Adalah transfusi darah untuk mengatasi syok hipovolemik atau anemi, pengobatan terhadap penyulit, seperti pre eklampsi berat atau tirotoksikosis. Perbaikan keadaan umum pada pasien mola hidatidosa, yaitu:
      1) Koreksi dehidrasi
      2) Transfusi darah bila ada anemia (Hb 8 ggr % atau kurang)

3) ada gejala pre eklampsia dan hiperemesis gravidarum diobati sesuai dengan protokol penangan dibagian obstetrik dan gynekologi
4) Bila ada gejala-gejala tirotoksikosis, dikonsultasikan ke bagian penyakit dalam.

b. Pengeluaran jaringan mola dengan cara kuretase dan histerektomi
1) Kuretase pada pasien mola hidatidosa:
a) Dilakukan setelah pemeriksaan persiapan selesai (pemeriksaan darah rutin, kadar beta HCG dan foto toraks) kecuali bila jaringan mola sudah keluar spontan
b) Bila kanalis servikalis belum terbuka maka dilakukan pemasangan laminaria dan kuretase dilakukan 24 jam kemudian
c) Sebelum melakukan kuretase, sediakan darah 500 cc dan pasang infuse dengan tetasan oksitosin 10 IU dalam 500 cc dektrose 5%.
d) Kuretase dilakukan 2 kali dengan interval minimal 1 minggu
e) Seluruh jaringan hasil kerokan dikirim ke laboratorium PA
2) Histerektomi. Syarat melakukan histerektomi adalah: Tindakan ini dilakukan pada perempuan yang telah cukup umur dan cukup mempunyai anak. Alasan untuk melakukan histerektomi adalah karena umur tua dan paritas tinggi merupan faktor predisposisi untuk terjadinya keganasan. Batasan yang dipakai adalah umur 35 tahun dengan anak hidup tiga (Saifuddin, 2011).

7. Evakuasi

Pada umumnya evakuasi jaringan mola dilakukan dengan kuret vakum, kemudian sisanya dibersihkan dengan kuret tajam. Tindakan kuret hanya dilakukan satu kali. Kuret ulangan dilakukan hanya bila ada indikasi (Martaadisoebrata, 2007). Segerakan lakukan evakuasi jaringan mola dan sementara proses evakuasi berlangsung berikan infus 10 IU oksitosin dalam 500 ml NS atau RL dengan kecepatan 40- 60 tetes per menit (sebagai tindakan preventif terhadap perdarahan hebat dan efektifitas kontraksi terhadap pengosongan uterus secara cepat) (Saifuddin, 2014).

8. Pemeriksaan Tindak Lanjut

Pemeriksaan tindak lanjut pada pasien mola hidatidosa meliputi:

a. Lama pengawasan 1-2 tahun
b. Selama pengawasan, pasien dianjurkan untuk memakasi alat kontrasepsi kondom, pil kombinasi atau diafragma. Pemeriksaan fisik dilakukan setiap kali pasien datang untuk kontrol.
c. Pemeriksaan kadar beta HCG dilakukan setiap minggu sampai ditemukan kadarnya yang normal 3 kali berturut-turut.

d. Setelah itu pemeriksaan dilanjutkan setiap bulan sampai ditemukan kadarnya yang normal 6 kali berturut-turut.
e. Bila telah terjadi remisi spontan (kadar beta HCG, pemeriksaan fisik, dan foto toraks semuanya normal) setelah 1 tahun maka pasien tersebut dapat berhenti menggunakan kontrasepsi dan dapat hamil kembali f. Bila selama masa observasi, kadar beta HCG tetap atau meningkat dan pada pemeriksaan foto toraks ditemukan adanya tanda-tanda metastasis maka pasien harus dievaluasi dan dimulai pemberian kemoterapi.

9. Komplikasi
   a. Perdarahan yang hebat sampai syok, kalau tidak segera ditolong dapat akibat fatal
   b. Perdarahan berulang-ulang yang dapat menyebabkan anemia
   c. Infeksi sekunder
   d. Perforasi karena keganasan dan karena tindakan
   e. Menjadi ganas (PTG) pada kira-kira 18-20% kasus, akan menjadi mola destruens atau kariokarsinoma.

E. Sistem Rujukan

Sistem rujukan untuk kasus abortus, kehamilan ektopik (KET), dan mola hidatidosa di Indonesia mengikuti alur Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK), di mana pasien dari fasilitas kesehatan primer (Puskesmas/Bidan/Klinik) harus segera dirujuk ke Rumah Sakit (RS) yang memiliki fasilitas PONEK (tipe C atau B) untuk penanganan definitif karena ketiganya merupakan kondisi kegawatdaruratan maternal.

Berikut adalah panduan sistem rujukannya:

1. Prinsip Dasar Rujukan
   a. Stabilitas: Pasien harus distabilkan terlebih dahulu di fasilitas perujuk (misal: pemasangan infus/resusitasi cairan jika syok) sebelum dipindahkan.
   b. Komunikasi: Menghubungi RS tujuan untuk memastikan ketersediaan kamar, dokter, dan darah.
   c. Dokumentasi: Membawa surat rujukan, hasil pemeriksaan (USG/Lab), dan catatan asuhan kebidanan.
2. Alur Rujukan Masing-masing Kasus
   a. Abortus (Keguguran)
      1) Indikasi Rujukan: Abortus inkomplit (sisa jaringan), abortus insipiens (sedang berlangsung), atau abortus infeksiosa (demam/bau).
      2) Tindakan di Faskes Primer: Bed rest, cegah infeksi, infus, bawa ke RS.

3) Penanganan RS (PONEK): Dilatasi dan kuretase (D&C) atau vakum aspirasi untuk membersihkan sisa konsepsi.

b. Kehamilan Ektopik (Terutama KET - Kehamilan Ektopik Terganggu)
   1) Indikasi Rujukan: Nyeri perut hebat, tanda syok (pucat, nadi cepat, tensi rendah), perdarahan perut dalam.
   2) Tindakan di Faskes Primer: Ini adalah darurat tertinggi. Pasang 2 infus cairan kristaloid (NaCl/RL) dengan jarum besar, stabilisasi syok, rujuk segera.
   3) Penanganan RS (PONEK): Laparotomi (operasi segera) untuk menghentikan perdarahan dan mengangkat hasil konsepsi di luar rahim.

c. Mola Hidatidosa (Hamil Anggur)
   1) Indikasi Rujukan: Perdarahan pada kehamilan muda, uterus lebih besar dari usia kehamilan, hiperemesis gravidarum berat, kadar hCG sangat tinggi.
   2) Tindakan di Faskes Primer: Stabilisasi, cek Hb, rujuk untuk evakuasi.
   3) Penanganan RS (PONEK): Evakuasi mola (Kuretase hisap) dan pemantauan kadar hCG pasca tindakan (tindak lanjut 6-12 bulan untuk mendeteksi keganasan/koriokarsinoma).

F. Aktivitas 1 — *Knows How*

Mini-case tertulis (diskusi kelompok)

1. Kasus Abortus (Keguguran)

   Kasus:

   Ny. A, 26 tahun, G1,P1,A0, datang ke RS dengan keluhan perdarahan pervaginam sejak 4 jam yang lalu. Pasien mengeluh mulas dan nyeri perut bawah. Hasil pemeriksaan fisik menunjukkan tekanan darah 112/70 mmHg, nadi 88x/menit. Pemeriksaan dalam (inspekulo) menunjukkan adanya pengeluaran darah dari ostium uteri eksternum, namun kanalis servikalis masih tertutup. Hasil PP test positif.

   Pertanyaan:

   a. Apa diagnosis yang paling tepat untuk Ny. A?
   b. Apa perbedaan utama antara kondisi Ny. A dengan *abortus insipiens*?
   c. Sebutkan edukasi atau tatalaksana awal yang harus diberikan kepada pasien ini!

2. Kasus Kehamilan Ektopik Terganggu (KET)

   Kasus:

   Ny. B, 32 tahun, terlambat haid 2 bulan. Ia dibawa ke IGD karena tiba-tiba pingsan setelah mengeluh nyeri hebat pada perut kanan bawah. Pada pemeriksaan fisik ditemukan wajah pucat (anemis), tekanan darah 90/60 mmHg,

dan nadi cepat 110x/menit. Pemeriksaan abdomen menunjukkan adanya tanda cairan bebas dan nyeri tekan seluruh lapang perut.

Pertanyaan:

a. Mengapa pasien mengalami syok (pingsan dan tensi turun) pada kasus kehamilan ektopik?
b. Apa pemeriksaan penunjang standar emas (*gold standard*) untuk menegakkan diagnosis ini secara cepat?
c. Lokasi manakah yang paling sering menjadi tempat terjadinya kehamilan ektopik?

3. Kasus Mola Hidatidosa (Hamil Anggur)

Kasus:

Ny. C, 22 tahun, datang dengan keluhan mual muntah yang sangat hebat (hiperemesis). Pasien merasa perutnya membesar sangat cepat, tidak sesuai dengan usia kehamilannya (HPHT menunjukkan 10 minggu, namun tinggi fundus uteri sudah setinggi pusat). Pasien juga mengeluhkan keluar bercak darah yang disertai gelembung-gelembung kecil transparan.

Pertanyaan:

a. Mengapa pada kasus mola hidatidosa ukuran rahim biasanya lebih besar dari usia kehamilan yang seharusnya?
b. Hormon apa yang kadarnya akan meningkat sangat drastis pada pasien ini?
c. Apa risiko jangka panjang yang harus diwaspadai setelah pasien menjalani prosedur evakuasi (kuretase) mola?

Soal OSCE Kebidanan

No.	Komponen	Isi
1	No. Stasiun	1
2	Judul	Perdarahan Trimester I
3	Kasus	keluhan perdarahan pervaginam
4	Tujuan	Untuk mengetahui bahwa peserta dapat menunjukkan kriteria sebagai calon bidan yang kompeten dalam:
5	Kompetensi	1. Anamnesis 2. Pemeriksaan fisik dan/atau laboratorium sederhana 3. Perumusan diagnosis dan/atau masalah 4. Prosedur tindakan klinis 5. KIE/konseling 6. Kolaborasi/rujukan 7. Perilaku profesional

No.	Komponen	Isi
6	Soal: Skenario dan tugas peserta ujian	SKENARIO KLINIK Seorang ibu hamil datang ke klinik, Ny. A, usia 26 tahun, G1,P1,A0, datang ke klinik bersalin dengan keluhan perdarahan pervaginam sejak 4 jam yang lalu. Pasien mengeluh mulas dan nyeri perut bawah. Hasil pemeriksaan fisik menunjukkan tekanan darah 112/70 mmHg, nadi 88x/menit. Pemeriksaan dalam (inspekulo) menunjukkan adanya pengeluaran darah dari ostium uteri eksternum, namun **kanalis servikalis masih tertutup**. Hasil PP test positif. TUGAS 1. Lakukan anamnesis terarah sesuai kasus. 2. Lakukan pemeriksaan fisik/obstetri terfokus sesuai kasus. 3. Sampaikan diagnosis/masalah kebidanan berdasarkan data yang diperoleh. 4. Lakukan tindakan awal yang tepat pada kasus tersebut. 5. Berikan KIE singkat kepada ibu/keluarga dan jelaskan rencana kolaborasi/rujukan.
7	Instruksi penguji	INSTRUKSI UMUM 1. Pastikan identitas peserta ujian sesuai dengan kartu ujian. 2. Tulislah nomor peserta berdasarkan jumlah peserta yang ikut: a. Ujian institusi- 2 digit jika peserta berjumlah 01–99-3 digit jika peserta berjumlah 100–999-4 digit terakhir jika menggunakan NIM peserta b. Ujian nasional- 4 digit jika peserta berjumlah ribuan- atau 4 digit terakhir bila nomor mengikutkan kode area dan lebih dari 4 angka 3. Amati peserta dan beri penilaian pada lembar penilaian yang disesuaikan dengan format penilaian: - Actual mark (0/1/2/3) - Global rating (1/2/3/4) 4. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interaksi apa pun kepada peserta selain yang ditentukan. 5. Taatilah peraturan dan laksanakan tugas sebagai penguji OSCE. INSTRUKSI KHUSUS 1. Jika peserta melakukan anamnesis dengan benar, PS menjawab sesuai dialog PS. 2. Jika peserta menyatakan akan melakukan palpasi abdomen/Leopold. 3. Jika peserta meminta hasil pemeriksaan dalam atau interpretasi partograf, penguji memberikan data:- Ny. A, 26 tahun, G1P0A0, hamil 10 minggu, datang dengan keluhan flek perdarahan dari jalan lahir. Pasien merasa mulas sedikit, namun **belum ada jaringan yang keluar**. Pada pemeriksaan dalam, **kanalis servikalis (pintu rahim) masih tertutup**. 4. Tindakan awal yang diharapkan dari peserta meliputi:- Menilai ulang kondisi ibu secara cepat- Menjelaskan kondisi ibu secara singkat dan

No.	Komponen	Isi
		jelas (*Abortus Imminens* (Ancaman keguguran).- Tirah baring (bed rest) total, pemberian penguat kandungan (progesteron), dan observasi perdarahan. Kehamilan masih bisa dipertahankan karena serviks belum terbuka. 5. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi ataupun bertanya kepada peserta selain yang ditentukan. 6. Penguji memberikan data tambahan hanya jika diminta atau jika peserta melakukan langkah pemeriksaan yang sesuai. INSTRUKSI TAMBAHAN 1. Rapikan alat yang telah digunakan oleh peserta ujian seperti keadaan semula agar siap digunakan oleh peserta berikutnya. 2. Siapkan lembar baru untuk lembar habis pakai dan pastikan lembar yang sudah diisi peserta sebelumnya telah diambil dan diberi identitas peserta.
8	Kebutuhan dan instruksi PS	Instruksi PS: 5. PS berperan sebagai ibu hamil dengan kondisi abortus 6. PS tampak cemas, lelah, sesekali meringis, memegang perut bawah, dan berbicara terputus saat nyeri datang. 7. Bila peserta memberikan penjelasan atau dukungan, PS merespons kooperatif. 8. Bila peserta menyampaikan bahwa apabila terjadi kegawat daruratan ibu perlu dirujuk, PS tampak khawatir tetapi bersedia mengikuti arahan.
9	Dialog PS	Peserta: Selamat pagi/siang, Bu. PS: Pagi/siang, Bu. Peserta: Saya bidan yang akan memeriksa ibu. Apakah ibu bersedia? PS: Iya, Bu, saya bersedia. Peserta: Apa keluhan utama ibu? PS: Saya mulas kuat dari tadi malam, Bu, Peserta: Sejak kapan mulas teratur? PS: Kira-kira sudah 6 jam, Bu. Peserta: Apakah keluar darah? PS: Iya, ada bercak darah sedikit. Peserta: apakah drah yang keluar terlihat segar dan semakin banyak Ps: iya bu, semakin sayang banyak beraktifitas darah yang keluar semakin banyak. Peserta: Ini kehamilan yang ke berapa? PS: Ini kehamilan pertama saya, Bu. Peserta: Ada riwayat darah tinggi, operasi, atau penyakit lain? PS: Tidak ada, Bu. Peserta: Ibu, ini tanda-tanda abortus, tapi kita akan priksa lebih dalam lagi ya. Semoga janin ibu baik-baik saja. PS: Baik, Bu, tolong bantu saya dan bayi saya ya.

No.	Komponen	Isi
		Peserta: Saya akan melakukan tindakan awal dan menyiapkan rujukan. PS: Iya, Bu.
10	Kebutuhan manikin	-Phantom abdomen hamil/manekin Leopold - Phantom panggul/serviks untuk simulasi pemeriksaan dalam - Lembar partograf kasus
11	Kebutuhan laboran	Peran laboran: - Menyiapkan dan merapikan kembali alat serta manikin - Mengganti lembar partograf/lembar instruksi bila diperlukan - Memastikan set station siap digunakan peserta berikutnya
12	Kebutuhan alat	1. Tempat tidur/periksa — 1 2. Phantom abdomen hamil/manekin 3. Phantom panggul/serviks — 1 4. Lembar partograf kasus — 1 set 5. Tensimeter — 1 6. Stetoskop — 1 7. Doppler/Pinard — 1 8. Jam tangan/stopwatch — 1 9. Termometer — 1 10. Sarung tangan bersih — 1 pasang 11. Handrub — 1 botol 12. Kain penutup/selimut — 1 13. Tisu — 1 pack 14. Infus set dummy — 1 set 15. Cairan RL/NaCl dummy — 1 16. Abocath dummy — 1 17. Formulir rujukan — 1 lembar 18. Lembar jawaban peserta — 1 lembar 19. Pena — 1
13	Penulis	Dosen
14	Referensi	1. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Standar profesi bidan: Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/320/2020. 2. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Standar kompetensi kerja bidang kebidanan: Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1261/2022. 3. World Health Organization. (2008). Education material for teachers of midwifery: Midwifery education modules (2nd ed.): Managing prolonged and obstructed labour. 4. World Health Organization. (2018). WHO recommendations: Intrapartum care for a positive childbirth experience.

RUBRIK PENILAIAN DAN KELULUSAN

Stase 1: Perdarahan Dalam Kehamilan

KOMPETENSI 1. Pengumpulan Data Subjektif

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Keluhan utama		
2. Riwayat kehamilan sekarang (sejak kapan mulas, berapa banyak darah yang keluar)		
3. Riwayat pengeluaran pervaginam (lendir darah, dan perdarahan)		
4. Gerak janin		
5. Terasa nyeri		
6. Riwayat obstetri (GPA, usia kehamilan, ANC, persalinan sebelumnya bila ada)		
7. Riwayat kesehatan/komplikasi kehamilan/operasi/alergi/obat-obatan		
8. Aktivitas harian yang relevan dengan kondisi saat ini (asupan makan-minum, BAK terakhir, kelelahan, dukungan keluarga)		

Skoring KOMPETENSI 1

- 3= Jika peserta ujian melakukan semua 8 langkah dengan benar.
- 2= Jika peserta melakukan 5–7 dari 8 langkah dengan benar.
- 1= Jika peserta melakukan 1–4 dari 8 langkah dengan benar.
- 0= Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

KOMPETENSI 2. Prosedur Tindakan Klinis

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Persiapan		
a. Menyapa klien dengan sopan dan ramah		
b. Memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan tindakan		
c. Memastikan klien memahami prosedur dan meminta persetujuan		
d. Menjaga privasi ibu		
e. Mencuci tangan/hand hygiene		
f. Menyiapkan alat yang diperlukan		
2. Langkah-langkah		
a. Menilai keadaan umum dan kesadaran ibu		
b. Menilai tanda vital ibu		
c. Menilai his (frekuensi, durasi, kekuatan)		
d. Menilai DJJ		
e. Menilai pengeluaran darah pervaginam		
f. Melakukan pemeriksaan obstetri terfokus atau meminta data yang relevan sesuai kewenangan station		

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
g. Menilai Jumlah dara yang keluar dari vagina		
h. pantau kondisi ibu hamil		
i. Memposisikan ibu untuk istirahat - Tirah baring (bed rest) total		
j. Berikan penguat kandungan (progesteron)		
a. Observasi perdarahan. Kehamilan masih bisa dipertahankan karena serviks belum terbuka.		
l. Melakukan pemantauan ulang kondisi ibu dan janin		
m. Menyiapkan kolaborasi/rujukan segera dan aman		
3. Pasca tindakan		
a. Menjelaskan hasil tindakan awal dan rencana lanjutan		
b. Mencatat temuan penting pada partograf/catatan medis/form rujukan		
c. Mencuci tangan kembali dan merapikan alat/ibu		

Skoring KOMPETENSI 2

- 3= Jika peserta ujian melakukan 15–19 langkah dengan tepat dan sistematis.
- 2= Jika peserta melakukan 10–14 langkah dengan tepat, atau semua langkah dilakukan tetapi sebagian kecil tidak tepat.
- 1= Jika peserta melakukan 1–9 langkah dengan tepat, atau semua langkah dilakukan tetapi sebagian besar tidak tepat.
- 0= Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun, atau semua langkah dilakukan tetapi tidak tepat.

KOMPETENSI 3. KIE/Konseling

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Sapa dan salam		
2. Menjelaskan hasil pemeriksaan dan kondisi ibu/janin dengan bahasa sederhana		
3. Menjelaskan tindakan awal yang sedang/akan dilakukan		
4. Menjelaskan perlunya kolaborasi/rujukan segera		
5. Menenangkan ibu dan melibatkan keluarga/pendamping		
6. Memberi kesempatan bertanya dan menjawab pertanyaan dengan jelas		

Skoring KOMPETENSI 3

- 3= Jika peserta ujian melakukan semua 6 langkah dengan benar.
- 2= Jika peserta melakukan 4–5 dari 6 langkah dengan benar.
- 1= Jika peserta melakukan 1–3 dari 6 langkah dengan benar.
- 0= Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

KOMPETENSI 4. Perilaku Profesional

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Melaksanakan secara sistematis		
2. Menjaga privasi dan keselamatan pasien		
3. Memberikan perhatian terhadap respons ibu selama kontraksi/nyeri		
4. Suara lantang, jelas, tenang, dan informatif		
5. Percaya diri dan tidak ragu-ragu		

Skoring KOMPETENSI 4

- 3= Jika peserta ujian melakukan semua 5 langkah dengan benar.
- 2= Jika peserta melakukan 4 dari 5 langkah dengan benar.
- 1= Jika peserta melakukan 1–3 dari 5 langkah dengan benar.
- 0= Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

TOTAL SKOR DAN KELULUSAN

TOTAL SKOR = jumlah skor kompetensi 1 + 2 + 3 + 4 / 3

(dicatat di rubrik penilaian)

IV. Global Performance

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

$$\text{Nilai akhir} = \frac{\text{Jumlah total skore}}{30} \times 100 =$$

(Kota), ...

.....

Penguji:.....

Penerapan Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) pada Perdarahan Trimester I: Abortus, Kehamilan Ektopik, dan Mola—Penanganan Awal dan Rujukan

Komponen	Deskripsi	Perdarahan trimester I
Metode penilaian	DOPS merupakan penilaian berbasis observasi langsung terhadap keterampilan prosedural. Penilai mengamati tindakan yang dilakukan peserta, lalu memberikan umpan balik segera setelah prosedur selesai. Domain yang lazim dinilai mencakup informed consent, persiapan pra-tindakan, kemampuan teknis, komunikasi, profesionalisme, dan keselamatan pasien.	Pembimbing mengamati secara langsung bagaimana mahasiswa melakukan penilaian awal pada ibu abortus, lalu menilai keterampilan mahasiswa saat melakukan tindakan awal kegawatdaruratan dan menyiapkan rujukan.
Tujuan penilaian	Tujuan DOPS pada topik ini adalah menilai kemampuan mahasiswa melakukan tindakan awal yang aman, cepat, dan sistematis pada persalinan lama atau distosia, dengan tetap berpusat pada keselamatan ibu dan janin serta penghormatan pada asuhan yang bermartabat. WHO menekankan pentingnya asuhan ibu hamil dan melakukan pemeriksaan sedini mungkin pada masa kehamilan dan pemantauan perkembangan janin.	Mahasiswa tidak hanya dinilai dari pengetahuannya tentang tanda-tanda perdarahan dalam kehamilan, kemampuannya menilai kondisi ibu-janin, membaca data bahaya kehamilan, melakukan stabilisasi awal, dan menjelaskan kebutuhan kolaborasi atau rujukan.
Kasus klinik	Kasus dipilih dari situasi nyata di lahan praktik yang sesuai dengan capaian pembelajaran profesi bidan, khususnya pengenalan prolonged atau obstructed labour, identifikasi tanda bahaya, penggunaan partograf, dan pengambilan keputusan awal.	Ny. A, 26 tahun, G1P0A0, hamil 10 minggu, datang dengan keluhan flek perdarahan dari jalan lahir. Pasien merasa mulas sedikit, namun **belum ada jaringan yang keluar**. Pada pemeriksaan dalam, **kanalis servikalis (pintu rahim) masih tertutup**.
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Pada DOPS, mahasiswa diamati saat melakukan prosedur atau rangkaian tindakan klinik tertentu, bukan sekadar berdiskusi tentang kasus. Pada topik ini, keterampilan yang relevan antara lain menilai keadaan umum ibu, tanda vital, DJJ, his, kemajuan persalinan melalui partograf, menilai penurunan kepala, serta melakukan tindakan awal	Mahasiswa memperkenalkan diri, meminta persetujuan, menilai kondisi ibu dan janin. Adanya perdarahan pada kehamilan dengan kecurigaan akan terjadi abortus, memposisikan ibu Tirah baring (bed rest) total, pemberian penguat kandungan (progesteron), dan observasi perdarahan. Kehamilan masih bisa

Komponen	Deskripsi	Perdarahan trimester I
	seperti posisi miring kiri, menyiapkan infus, menjaga keseimbangan cairan, dan menyiapkan rujukan. WHO juga mencantumkan keterampilan seperti menilai penurunan kepala, mengenali obstructed labour, memasang dan memantau infus, menjaga keseimbangan cairan, serta pencatatan sebagai keterampilan penting.	dipertahankan karena serviks belum terbuka..
Aspek yang dinilai	Aspek yang dinilai meliputi pemahaman indikasi tindakan, persetujuan tindakan, persiapan pra-prosedur, kemampuan teknis, komunikasi, kemampuan mencari bantuan ketika diperlukan, rencana pascatindakan, dan profesionalisme. Pada konteks obstetri, aspek ini juga mencakup ketepatan mengenali tanda perdarahan pada kehamilan ketepatan keputusan eskalasi.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu melakukan penaganan tindakan pertolongan pada perdarahan dalam kehamilan. sebagai tanda bahwa kehamilan tidak lagi aman apabila melakukan aktifitas.
Fokus observasi pembimbing	Fokus observasi pembimbing adalah mutu performa nyata mahasiswa saat melakukan tindakan awal.	Pembimbing memperhatikan apakah mahasiswa cepat mengenali kondisi gawat, melakukan prioritas tindakan dengan urutan yang benar, menghindari intervensi yang tidak aman, serta segera meminta bantuan atau menyiapkan rujukan.
Umpan balik	Umpan balik dalam DOPS diberikan segera setelah observasi dan berisi apa yang sudah efektif serta apa yang perlu diperbaiki. Form DOPS juga menekankan komentar assessor mengenai kekuatan, area yang perlu ditingkatkan, dan rencana perbaikan.	Pembimbing dapat menyampaikan bahwa mahasiswa sudah baik dalam komunikasi dan membaca partograf, tetapi masih perlu meningkatkan ketegasan saat memutuskan eskalasi, ketelitian dalam menilai penurunan kepala, atau kelengkapan penjelasan kepada keluarga.
Keputusan penilaian	Dalam buku ajar ini, hasil DOPS dapat diringkas menjadi kompeten, perlu supervisi, atau remedial. Keputusan ditetapkan berdasarkan ketepatan langkah, keselamatan pasien, komunikasi, dan kemampuan mengambil keputusan awal.	Mahasiswa dinyatakan kompeten apabila mampu melakukan tindakan awal secara runtut, aman, dan tepat. Mahasiswa dinyatakan perlu supervisi apabila langkah utama sudah benar tetapi masih memerlukan arahan. Mahasiswa dinyatakan remedial apabila gagal mengenali kegawatan,

Komponen	Deskripsi	Perdarahan trimester I
		salah menentukan prioritas, atau tidak menyiapkan eskalasi dengan benar.
Makna dalam OBE	DOPS memberikan bukti autentik bahwa mahasiswa mampu menunjukkan capaian pembelajaran pada level does karena performanya diamati langsung saat melakukan tindakan klinik. Observasi langsung pada pasien nyata dan umpan balik segera menjadikan DOPS sangat sesuai untuk pembelajaran berbasis kompetensi.	Pada kasus perdarahan dalam kehamilan, mahasiswa dinilai bukan hanya memahami teori, tetapi mampu menerapkan tindakan awal kegawatdaruratan perdarahan dalam kehamilan secara langsung, aman, cepat, dan profesional di lahan praktik.

Portofolio

Bukti yang dikumpulkan

1. OSCE + DOPS

Catatan kasus singkat

Refleksi patient safety

Feedback CI/dosen

Catatan untuk penulis:

1. Bukan sekali ujian

Bukti konsistensi kompetensi

Tabel 4.5
Portofolio pada Perdarahan Trimester I: Abortus, Kehamilan Ektopik, dan Mola—Penanganan Awal dan Rujukan

Komponen	Deskripsi	Abortus, Kehamilan Ektopik, dan Mola—Penanganan Awal dan Rujukan
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam OBE, portofolio digunakan untuk menilai performa nyata mahasiswa dari waktu ke waktu, bukan hanya dari satu kali ujian.	Pada topik partus lama dan distosia, portofolio memuat bukti bahwa mahasiswa mampu melakukan pengkajian persalinan, menilai kemajuan persalinan dengan 133rofession, mengenali tanda bahaya ibu dan janin, melakukan tindakan awal, serta memperbaiki performa berdasarkan umpan balik.
Tujuan portofolio	Portofolio bertujuan mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, dan tindak lanjut perbaikan mahasiswa selama praktik.	Mahasiswa tidak hanya menunjukkan bahwa ia pernah menangani ibu bersalin dengan persalinan tidak maju, tetapi juga menunjukkan bagaimana kemampuannya berkembang setelah mendapat masukan dari dosen atau CI.
OSCE dan DOPS	OSCE dan DOPS dapat menjadi bagian penting dalam portofolio karena memberikan bukti keterampilan terstruktur di laboratorium dan bukti performa nyata di lahan praktik.	OSCE dapat memuat hasil ujian keterampilan interpretasi 133rofession, pengenalan distosia, dan tindakan awal pra-rujukan. DOPS memuat hasil observasi langsung saat mahasiswa melakukan penilaian ibu bersalin, stabilisasi awal, dan persiapan rujukan pada kasus partus lama di ruang bersalin.
Catatan kasus singkat	Catatan kasus singkat berisi ringkasan kasus pasien yang pernah ditangani mahasiswa, data penting, masalah kebidanan, tindakan utama, dan hasil yang dicapai.	Mahasiswa menuliskan ringkasan kasus ibu G1P0A0 usia kehamilan 39 minggu dengan pembukaan menetap 6 cm selama 4 jam, kepala masih tinggi, his adekuat, DJJ meningkat, tindakan awal yang dilakukan, dan keputusan rujukan.
Refleksi patient safety	Refleksi patient safety menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi kesalahan, dan menyusun	Mahasiswa merefleksikan pentingnya tidak menunda pengenalan persalinan tidak maju, ketelitian membaca 133rofession, pemantauan DJJ, pencegahan

Komponen	Deskripsi	**Abortus, Kehamilan Ektopik, dan Mola—Penanganan Awal dan Rujukan**
	langkah pencegahan dalam asuhan kebidanan.	keterlambatan rujukan, dan komunikasi cepat dengan keluarga pada kasus distosia.
Feedback CI/dosen	Umpan balik dari Clinical Instructor (CI) atau dosen menjadi bukti pembinaan yang menunjukkan area kekuatan dan area yang masih perlu ditingkatkan.	CI menuliskan bahwa mahasiswa sudah baik dalam mengenali partus lama dan menjelaskan rujukan, tetapi masih perlu meningkatkan ketelitian dalam menilai penurunan kepala, interpretasi ketuban, dan ketegasan saat melakukan eskalasi.
Karakteristik penilaian	Portofolio bukan penilaian sekali selesai, tetapi kumpulan bukti yang dibangun secara berulang dan berkesinambungan. Penekanan utamanya adalah konsistensi performa mahasiswa.	Mahasiswa dinilai bukan hanya dari satu kasus partus lama, tetapi dari beberapa pengalaman belajar yang menunjukkan bahwa ia konsisten mampu menilai kemajuan persalinan, mengenali distosia, dan melakukan tindakan awal secara aman.
Bukti konsistensi kompetensi	Portofolio memperlihatkan apakah mahasiswa mampu mempertahankan mutu performa pada berbagai kesempatan praktik dan pada waktu yang berbeda.	Dari hasil OSCE, DOPS, catatan kasus, refleksi, dan umpan balik, terlihat bahwa mahasiswa secara konsisten mampu menggunakan 134rofession, mengenali tanda bahaya, dan mengambil keputusan awal yang tepat pada persalinan bermasalah.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, portofolio memberikan bukti autentik bahwa capaian pembelajaran tidak hanya dimiliki secara teoritis, tetapi benar-benar tampak dalam performa yang berulang, berkembang, dan terdokumentasi.	Pada topik partus lama dan distosia, portofolio menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya paham konsep, tetapi juga konsisten mampu menerapkannya dalam praktik kebidanan nyata.

Tabel 4.6
Case Report pada Perdarahan Trimester I: Abortus, Kehamilan Ektopik, dan Mola—Penanganan Awal dan Rujukan

Komponen	Deskripsi	Abortus, Kehamilan Ektopik dan Mola Hidatidosa
Hakikat case report	Case report merupakan laporan singkat dan sistematis tentang satu kasus pasien yang ditangani mahasiswa selama praktik klinik. Dalam OBE, case report berfungsi sebagai bukti kemampuan mahasiswa dalam memahami, menganalisis, dan mendokumentasikan kasus secara ilmiah dan klinis.	Mahasiswa menyusun laporan singkat tentang seorang ibu hamil dengan keluhan perdarahan pervaginam disertai dengan rasa nyeri.
Tujuan	Case report bertujuan menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan data pengkajian, masalah kebidanan, rencana tindakan, implementasi, dan evaluasi hasil asuhan.	Mahasiswa tidak hanya menuliskan data ibu, tetapi juga menjelaskan masalah prioritas, tindakan awal yang diberikan, proses rujukan, dan perkembangan kondisi ibu serta janin setelah intervensi awal.
Isi laporan	Isi case report biasanya mencakup identitas singkat pasien, keluhan utama, data subjektif dan objektif, analisis masalah, diagnosis/masalah kebidanan, tindakan, implementasi, evaluasi, dan pembelajaran dari kasus.	Pada kasus ini, mahasiswa menuliskan Ny. A, 26 tahun, G1P0A0, hamil 10 minggu, datang dengan keluhan flek perdarahan dari jalan lahir. Pasien merasa mulas sedikit, namun **belum ada jaringan yang keluar**. Pada pemeriksaan dalam, **kanalis servikalis (pintu rahim) masih tertutup**.tindakan awal stabilisasi, dan keputusan rujukan.
Fokus penilaian	Penilaian difokuskan pada ketepatan pengkajian, relevansi analisis masalah, logika penalaran klinik, ketepatan tindakan awal, dan kemampuan mengevaluasi hasil asuhan.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu memberikan asuhan kebidanan dengan kasus ini sseta memberikan tindakan awal dan rujukan segera.
Nilai edukatif	Case report membantu mahasiswa mengembangkan clinical reasoning, keterampilan dokumentasi, dan kebiasaan merefleksikan praktik klinik secara ilmiah.	Dari kasus perdarahan dalam kehamilan, mahasiswa belajar bahwa pemantauan ibu-janin, dan keputusan eskalasi dini merupakan inti keselamatan dalam asuhan kehamilan
Makna dalam OBE	Dalam OBE, case report menjadi bukti bahwa mahasiswa mampu menerapkan teori ke dalam analisis kasus nyata secara sistematis dan bertanggung jawab.	Mahasiswa menunjukkan bahwa ia tidak hanya memahami perdarahan dalam kehamilan tetapi juga mampu menyusun laporan kasus yang

Komponen	Deskripsi	Abortus, Kehamilan Ektopik dan Mola Hidatidosa
		menggambarkan asuhan kebidanan secara utuh.

Tabel 4.7
Refleksi Patient Safety Perdarahan Trimester I: Abortus, Kehamilan Ektopik, dan Mola—Penanganan Awal dan Rujukan

Komponen	Deskripsi	Abortus, Kehamilan Ektoik dan Mola Hidatidosa
Hakikat refleksi patient safety	Refleksi patient safety merupakan tulisan singkat yang menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi masalah, dan merencanakan tindakan pencegahan.	Pada kasus partus lama, mahasiswa merefleksikan bahwa keterlambatan mengenali perdarahan dalam kehamilan dapat menyebabkan perburukan kondisi ibu dan janin.
Tujuan	Refleksi ini bertujuan menumbuhkan kesadaran mahasiswa bahwa keselamatan pasien merupakan bagian penting dari setiap tindakan kebidanan.	Mahasiswa memahami bahwa kesalahan kecil, seperti salah membaca kasus, tidak memantau DJJ dengan cermat, atau menunda rujukan, dapat berdampak besar pada keselamatan ibu dan bayi.
Fokus refleksi	Fokus refleksi meliputi identifikasi risiko, analisis penyebab, tindakan pencegahan, dan pembelajaran yang diperoleh mahasiswa dari pengalaman klinik.	Mahasiswa menuliskan bahwa risiko utama pada kasus ini adalah obstructed labour, gawat janin, kelelahan ibu, infeksi, dan keterlambatan penanganan bila perdarahan tidak dipantau dengan benar.
Risiko yang diidentifikasi	Mahasiswa perlu menunjukkan kemampuan mengenali situasi yang berpotensi membahayakan pasien.	Risiko yang dapat diidentifikasi antara lain keterlambatan diagnosis perdarahan dalam kehamilan, salah menilai pemantauan DJJ yang tidak adekuat, penggunaan stimulasi pertolongan yang tidak tepat, dan keterlambatan rujukan.
Tindakan pencegahan	Mahasiswa menjelaskan langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko keselamatan pasien.	Mahasiswa menuliskan pentingnya penggunaan 136rofession secara konsisten, pemantauan tanda vital dan DJJ, stabilisasi awal ibu, komunikasi cepat kepada keluarga, dan rujukan tepat waktu ke fasilitas yang lebih mampu.

Komponen	Deskripsi	Abortus, Kehamilan Ektoik dan Mola Hidatidosa
Pembelajaran mahasiswa	Refleksi harus menunjukkan apa yang dipelajari mahasiswa dan bagaimana hal itu akan memengaruhi praktik berikutnya.	Mahasiswa menyadari bahwa pada persalinan lama, pengkajian serial, pengambilan keputusan cepat, dan keberanian melakukan eskalasi adalah bagian penting dari praktik bidan yang aman.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, refleksi patient safety menunjukkan perkembangan sikap 137rofessional, tanggung jawab klinik, dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa terhadap keselamatan pasien.	Mahasiswa membuktikan bahwa ia tidak hanya melakukan tindakan, tetapi juga mampu mengevaluasi risiko dan meningkatkan kualitas praktik kebidanan secara berkelanjutan.

G. Ringkasan Materi

Perdarahan pada awal kehamilan adalah kondisi darurat medis yang memerlukan diagnosis cepat untuk membedakan antara keguguran biasa, kehamilan di luar rahim, atau penyakit trofoblas. Abortus (Keguguran), Terhentinya kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar kandungan (usia <20 minggu atau berat <500 gram). Gejala Utama: Perdarahan pervaginam (flek hingga gumpalan) disertai nyeri perut bawah (mulas). Jenis Utama: *Imminens:* Ancaman keguguran, ostium uteri (mulut rahim) masih tertutup, janin masih hidup.*Insipiens:* Keguguran sedang berlangsung, ostium terbuka, ketuban mungkin pecah. *Inkomplit:* Sebagian jaringan keluar, perdarahan biasanya banyak. *Komplit:* Seluruh jaringan telah keluar, rahim mengecil. Tatalaksana: Istirahat total (bedrest) untuk imminens, atau evakuasi jaringan (kuretase/medikamentosa) jika keguguran tidak lengkap.

Kehamilan Ektopik Terganggu (KET) Kehamilan di mana sel telur yang dibuahi menempel di luar rongga rahim, paling sering di saluran tuba (tuba falopi). Menjadi "Terganggu" saat saluran tersebut pecah (ruptur). Gejala Utama: Trias klasik yaitu Amenorea (telat haid), Nyeri Perut Akut (sangat hebat, hingga ke bahu), dan Perdarahan Jalan Lahir. Tanda Darurat: Tanda syok (nadi cepat, tensi turun, pucat) karena perdarahan hebat di dalam rongga perut. Diagnosis: Tes kehamilan positif, USG (rahim kosong tapi ada massa di adneksa), dan kuldosentesis (cairan darah di rongga perut). Tatalaksana: Operasi segera (salpingektomi/salpingostomi) dan stabilisasi cairan/transfusi darah.

Mola Hidatidosa (Hamil Anggur) Pembentukan vili korialis yang abnormal menyerupai bentukan gelembung-gelembung putih seperti buah anggur. Gejala Utama: Perdarahan bercak cokelat atau merah, ukuran rahim lebih besar dari usia kehamilan seharusnya, dan tidak teraba bagian janin/balotemen.Ciri Khas: Mual

muntah (hiperemesis) yang berlebihan dan kadar hormon hCG yang sangat tinggi di atas normal. Diagnosis: USG menunjukkan gambaran *"Snowstorm"* atau *"Honeycomb"* (sarang tawon) tanpa janin. Tatalaksana: Evakuasi jaringan dengan Kuret Isap dan pemantauan kadar hCG secara berkala (minimal 6-12 bulan) untuk mendeteksi risiko keganasan (Kanker Koriokarsin).

H. Alur asuhan singkat

Penilaian Awal (Stabilisasi)- Cek Tanda Vital: Pastikan tekanan darah, nadi, dan kesadaran stabil - Waspada Syok: Jika pasien pucat, nadi cepat, dan tensi turun, segera lakukan resusitasi cairan (infus).- Pemeriksaan Penunjang (Konfirmasi) - Tes Kehamilan (PP Test): Memastikan pasien benar-benar hamil - USG (Langkah Paling Krusial): - Abortus: Kantung janin di dalam rahim, bisa utuh atau sudah pecah - KET: Rahim kosong, ditemukan cairan bebas atau massa di luar rahim - Mola: Gambaran *"Snowstorm"* atau gelembung-gelembung di dalam rahim - Tatalaksana Singkat – Abortus Imminens: Istirahat total (bedrest) dan obat penguat kandungan - Abortus Inkomplit / Mola: Evakuasi sisa jaringan melalui kuretase - Kehamilan Ektopik: Operasi segera (Laparotomi/Laparoskopi) untuk mengangkat jaringan di luar rahim sebelum pecah lebih parah.

I. Tabel Red Flags & Eskalasi

Perdarahan Trimester I: Abortus, Kehamilan Ektopik, dan Mola—Penanganan Awal dan Rujukan

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
Perdarahan pervaginan menandakan adanya kelainan pada kehamilan yang diakibatkan abortus KE dan mola.	Perdarahan dalam kehamilan perlu evaluasi lebih lanjut terhadap kondisi ibu hamil tersebut	Lapor ke pembimbing/DPJP, evaluasi ulang lengkap, siapkan kolaborasi atau rujukan
Perdarahan tersebut bisa mengganggu kesehatan ibu serta pertumbuhan janin	Curiga adanya abortus, kehamilan ektopik dan mola	Jangan menunda evaluasi; siapkan rujukan ke fasilitas yang lebih mampu
DJJ <170 x/menit atau >180 x/menit	Menunjukkan kemungkinan gawat janin	Reposisi ibu, nilai cepat kondisi ibu-janin, lapor segera, percepat eskalasi
Perdarahan perpavinam	Meningkatkan kecurigaan terjadinya abortus	Pantau janin ketat, lapor segera, siapkan rujukan
Ibu tampak sangat lelah, gelisah, dehidrasi, nadi meningkat, atau suhu meningkat	Menunjukkan perburukan kondisi maternal dan risiko infeksi disertai kecemasan	Stabilisasi awal, cairan sesuai kebutuhan, pantau ketat, kolaborasi/rujukan

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
Perdarahan pervaginam abnormal	Dapat mengarah pada komplikasi obstetri yang lebih serius	Nilai cepat kondisi ibu, tangani sesuai prioritas, rujuk segera
Moulage/caput bertambah, edema serviks, atau nyeri abdomen menetap	Meningkatkan kecurigaan abortus totalis	Hentikan penundaan, lapor dan rujuk segera
Tanda syok atau penurunan kesadaran	Kegawatdaruratan	Resusitasi awal sesuai kewenangan, panggil bantuan, rujuk emergensi
Keputusan rujukan sudah jelas tetapi proses tertunda	Menambah risiko ibu dan janin	Aktifkan rencana rujukan tanpa delay, lengkapi handover, komunikasikan ke keluarga dan fasilitas penerima

Form Checklist "Saya sudah bisa..."

Bab 6: Perdarahan Trimester I: Abortus, Kehamilan Ektopik, dan Mola—Penanganan Awal dan Rujukan

Nama Mahasiswa: _____

NIM: _____

Tanggal: _____

Tempat Praktik / Skill Lab: _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah bisa menjelaskan pengertian perdarahan dalam kehamilan	☐	☐	_____
2	Saya sudah bisa menjelaskan apa-apa saja yang mengakibatkan perdaran dalam kehamilan	☐	☐	_____
3	Saya sudah bisa melakukan anamnesis terarah pada ibu hamil tentang tanda-tanda bahaya dalam kehamilan	☐	☐	_____
4	Saya sudah bisa membedakan Abortus, Kehamilan Ektopik, dan Mola Hidatidosa	☐	☐	_____
5	Saya sudah bisa mengenali perbedaan macam-macam abortus	☐	☐	_____
6	Saya sudah bisa mengidentifikasi kemungkinan penyebab berdasarkan jmlah drah yang keluar dari vagina ibu hamil	☐	☐	_____
7	Saya sudah bisa mengenali tanda bahaya ibu pada kasus perdarahan dalam kehamilan	☐	☐	_____
8	Saya sudah bisa mengenali tanda bahaya janin pada kasus abortus	☐	☐	_____

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
9	Saya sudah bisa melakukan tindakan awal yang aman sesuai kewenangan bidan	☐	☐	_____
10	Saya sudah bisa memposisikan ibu dan memberikan dukungan yang tepat saat terjadi kegawatdaruratan perdarahan	☐	☐	_____
11	Saya sudah bisa menyiapkan pemantauan ibu dan janin secara cepat dan sistematis	☐	☐	_____
12	Saya sudah bisa menjelaskan kondisi ibu dan janin kepada keluarga dengan bahasa sederhana	☐	☐	_____
13	Saya sudah bisa menentukan kapan kasus harus dikolaborasikan atau dirujuk segera	☐	☐	_____
14	Saya sudah bisa menyiapkan rujukan dan handover singkat dengan jelas	☐	☐	_____
15	Saya sudah bisa mendokumentasikan temuan dan tindakan awal secara ringkas dan tepat	☐	☐	_____
16	Saya sudah bisa menjaga privasi, keselamatan, dan perilaku profesional selama tindakan	☐	☐	_____

Refleksi singkat mahasiswa:

J. Daftar pustaka

Norma, Nita; Dwi, M. (2018) Asuhan Kebidanan Patologi. Yogyakarta: Nuha Medika.

Prawirohardjo, S. (2020) Ilmu Kebidanan. Jakarta: Pt. Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.

Dr. Hidayati dkk; (2026) Patologi Kebidanan. Cilacap: Pt.Media Pustaka Indo.

Manuaba, I. B. G. (2007). Pengantar Kuliah Obstetri. Jakarta: EGC.

Varney, H. (2007). Varney's Midwivery 4th Ed (Buku Ajar Kebidanan Ed 4). Jakarta: EGC.

Ai yehye R, lia Yuianti.(2011) Asuhan kebidanan IV (patologi kebidanan).Jakarta:CV.Trans Info Media.

https://pustaka.poltekkes-pdg.ac.id/repository/Lady_Permata_Sari(1).pdf

Tia Ananda dkk;(2024).Jurnal Tinjauan Pada Mola Hidatidosa. file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/artikel+1.pdf

Kementerian Kesehatan RI. (2013). Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan. Jakarta.

BAB 5

PERDARAHAN TRIMESTER II–III: PLASENTA PREVIA DAN SOLUSIO PLASENTA PENANGANAN AWAL DAN RUJUKAN

CPL

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menunjukkan profesionalisme, etika, dan tanggung jawab legal dalam pelayanan ibu hamil dengan komplikasi.	CPMK-1; CPMK-5; CPMK-7
CPL-2	Menerapkan komunikasi terapeutik, edukasi, dan kolaborasi interprofesional berpusat pada ibu–janin–keluarga.	CPMK-2; CPMK-5; CPMK-7
CPL-3	Menerapkan prinsip keselamatan pasien, PPI, K3, dan manajemen risiko dalam penanganan komplikasi kehamilan.	CPMK-1; CPMK-5; CPMK-6; CPMK-7
CPL-4	Melakukan pengkajian klinis serta interpretasi pemeriksaan penunjang untuk menentukan masalah dan tingkat kegawatan pada komplikasi kehamilan.	CPMK-2; CPMK-3; CPMK-4; CPMK-6
CPL-5	Merancang dan melaksanakan tata laksana awal/stabilisasi serta rujukan terstandar untuk komplikasi hipertensi, perdarahan, infeksi, dan anemia.	CPMK-3; CPMK-4; CPMK-5; CPMK-6; CPMK-7
CPL-6	Melakukan dokumentasi, rencana persalinan/rujukan, continuity of care, dan evaluasi berbasis evidence untuk peningkatan mutu layanan kehamilan komplikasi.	CPMK-1; CPMK-2; CPMK-7

CPMK

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menganalisis konsep dasar komplikasi kehamilan (hipertensi, perdarahan, infeksi, anemia) untuk deteksi dini, pencegahan, dan keselamatan ibu–janin sesuai pedoman.
CPMK-2	Melakukan pengkajian terfokus pada ibu hamil dengan komplikasi (anamnesis, pemeriksaan fisik, penunjang, dan pemantauan janin) serta menginterpretasi hasil untuk penentuan prioritas.

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-3	Menetapkan klasifikasi/derajat anemia kehamilan, melakukan skrining, menyusun tata laksana awal, serta menentukan indikasi rujukan/kolaborasi.
CPMK-4	Menetapkan diagnosis dan rencana pemantauan gangguan hipertensi kehamilan berdasarkan kriteria diagnostik dan risiko maternal–janin.
CPMK-5	Melaksanakan stabilisasi awal kegawatdaruratan terkait hipertensi berat/eclampsia dan infeksi sistemik/sepsis pada kehamilan serta menyiapkan rujukan aman dan tepat waktu.
CPMK-6	Melaksanakan penanganan awal kegawatdaruratan perdarahan trimester I–III dan menyiapkan rujukan sesuai standar.
CPMK-7	Merancang asuhan kolaboratif pada kehamilan dengan infeksi, ketuban pecah dini/persalinan prematur, dan penyakit penyerta; termasuk edukasi, rencana persalinan, dokumentasi, dan continuity of care.

Pemetaan Bab–Sub-CPMK–CPMK

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 1. Konsep Dasar Komplikasi Kehamilan: Deteksi Dini, Pencegahan, dan Keselamatan Ibu–Janin	1.1 Mengidentifikasi faktor risiko dan tanda bahaya utama komplikasi kehamilan berdasarkan trimester.	1.2 Menjelaskan strategi pencegahan primer/sekunder serta prinsip keselamatan ibu–janin (patient safety, PPI, K3) pada pelayanan antenatal.	CPMK-1	CPMK-2; CPMK-7
Bab 2. Pengkajian Ibu Hamil dengan Komplikasi: Anamnesis Terfokus, Pemeriksaan Fisik, dan Pemeriksaan Penunjang	2.1 Melakukan anamnesis terfokus dan penilaian triase kegawatan pada ibu hamil dengan keluhan komplikasi.	2.2 Menginterpretasi temuan pemeriksaan fisik dan penunjang untuk menetapkan masalah prioritas.	CPMK-2	CPMK-1; CPMK-5
Bab 3. Anemia pada Kehamilan: Klasifikasi, Skrining, Tata Laksana, dan Indikasi Rujukan	3.1 Mengklasifikasikan anemia kehamilan berdasarkan kadar Hb dan etiologi tersangka serta menilai derajat risiko.	3.2 Menyusun tata laksana awal anemia dan menentukan kriteria rujukan/kolaborasi serta rencana monitoring.	CPMK-3	CPMK-2; CPMK-7
Bab 4. Gangguan Hipertensi Kehamilan: Definisi, Kriteria	4.1 Membedakan jenis gangguan hipertensi dalam kehamilan berdasarkan	4.2 Merancang pemantauan tekanan darah, gejala, dan parameter	CPMK-4	CPMK-2; CPMK-1

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Diagnostik, dan Pemantauan	definisi dan kriteria diagnostik.	klinis/penunjang untuk deteksi perburukan.		
Bab 5. Preeklamsia Berat dan Eklampsia: Tanda Bahaya, Stabilisasi Awal, dan Rujukan	5.1 Mengidentifikasi tanda bahaya preeklamsia berat/eclampsia dan menilai prioritas stabilisasi (ABCDE).	5.2 Melaksanakan stabilisasi pra-rujukan dan menyiapkan komunikasi rujukan yang aman.	CPMK-5	CPMK-4; CPMK-2; CPMK-7
Bab 6. Perdarahan Trimester I: Abortus, Kehamilan Ektopik, dan Mola—Penanganan Awal dan Rujukan	6.1 Menilai perdarahan trimester I dan menyusun diferensial diagnosis (abortus/ektopik/mola) berbasis temuan klinis.	6.2 Melaksanakan penanganan awal (stabilisasi, pencegahan syok, persiapan rujukan) sesuai standar.	CPMK-6	CPMK-2; CPMK-5
Bab 7. Perdarahan Trimester II–III: Plasenta Previa dan Solusio Plasenta—Penanganan Awal dan Rujukan	7.1 Mengidentifikasi karakteristik perdarahan trimester II–III yang mengarah pada plasenta previa vs solusio plasenta serta risiko gawat janin.	7.2 Melaksanakan penanganan awal aman (stabilisasi, monitoring ibu–janin) dan menyiapkan rujukan emergensi.	CPMK-6	CPMK-2; CPMK-7
Bab 8. Ketuban Pecah Dini dan Persalinan Prematur: Penilaian Risiko, Pencegahan Infeksi, dan Rujukan	8.1 Menilai risiko pada KPD/persalinan prematur berdasarkan usia kehamilan, tanda infeksi, dan kondisi ibu–janin.	8.2 Menyusun tindakan awal pencegahan infeksi, edukasi kewaspadaan, dan alur rujukan/kolaborasi sesuai kriteria.	CPMK-7	CPMK-2; CPMK-1
Bab 9. Infeksi Saluran Kemih pada Kehamilan: Skrining, Tata Laksana Awal, dan Pencegahan Komplikasi	9.1 Melakukan skrining ISK pada kehamilan dan menilai risiko komplikasi (mis. pielonefritis).	9.2 Menyusun tata laksana awal dan edukasi pencegahan ISK serta rencana follow-up.	CPMK-7	CPMK-2; CPMK-1
Bab 10. Infeksi Reproduksi dan IMS pada Kehamilan: Skrining, Tata Laksana, dan Pencegahan Penularan	10.1 Mengidentifikasi indikasi skrining IMS/infeksi reproduksi dan menilai risiko penularan ibu–janin.	10.2 Merancang tata laksana awal/rujukan dan strategi pencegahan penularan (termasuk edukasi pasangan dan PPI).	CPMK-7	CPMK-1; CPMK-2

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 11. Infeksi Sistemik pada Kehamilan: Demam, Sepsis, dan Protokol Stabilisasi Pra-Rujukan	11.1 Mengidentifikasi kriteria demam/infeksi sistemik dan tanda sepsis untuk penentuan kegawatan.	11.2 Melaksanakan protokol stabilisasi pra-rujukan pada sepsis serta komunikasi rujukan terstandar.	CPMK-5	CPMK-2; CPMK-7; CPMK-1
Bab 12. Penyakit Penyerta yang Memperberat Kehamilan: Diabetes, Jantung, dan Gangguan Tiroid (Kolaborasi)	12.1 Menilai dampak penyakit penyerta terhadap risiko maternal–janin dan tanda perburukan yang perlu diwaspadai.	12.2 Menyusun rencana asuhan kolaboratif dan rujukan terintegrasi sesuai peran dan kewenangan.	CPMK-7	CPMK-2; CPMK-1
Bab 13. Pemantauan Kesejahteraan Janin pada Kehamilan dengan Komplikasi: Pertumbuhan, DJJ, dan Tanda Gawat	13.1 Melakukan pemantauan kesejahteraan janin (gerak, DJJ, pertumbuhan, tanda gawat) sesuai indikasi.	13.2 Menginterpretasi hasil pemantauan untuk menentukan kebutuhan intervensi segera, eskalasi layanan, atau rujukan.	CPMK-2	CPMK-4; CPMK-6; CPMK-7
Bab 14. Edukasi, Rencana Persalinan, dan Rujukan pada Kehamilan Komplikasi: Komunikasi, Dokumentasi, dan Continuity of Care	14.1 Menyusun edukasi dan rencana persalinan/rujukan (BPCR) bersama ibu–keluarga secara komunikatif.	14.2 Melakukan dokumentasi terstandar, handover, dan rencana continuity of care termasuk jadwal follow-up.	CPMK-7	CPMK-1; CPMK-2; CPMK-5

Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-1	Ujian tulis berbasis kasus (MCQ/SAQ)	Akurasi identifikasi risiko/tanda bahaya ≥80% pada skenario; pilihan strategi pencegahan & keselamatan tanpa kesalahan kritis	10	Lembar jawaban; ringkasan rencana pencegahan (1 halaman)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-2	OSCE pengkajian terfokus + interpretasi penunjang (checklist)	Anamnesis terfokus ≥80% item; pemeriksaan fisik & penunjang/pemantauan janin tepat; prioritas tindakan/rujukan tepat	20	Checklist OSCE; lembar interpretasi kasus
CPMK-3	Studi kasus tertulis + role-play konseling (lembar observasi)	Klasifikasi anemia & risiko tepat; rencana suplementasi/diet/monitoring sesuai; indikasi rujukan/kolaborasi tepat	10	Laporan studi kasus; lembar observasi role-play
CPMK-4	Ujian skenario + tugas algoritme pemantauan	Penetapan jenis/derajat hipertensi tepat (akurasi ≥80%); rencana pemantauan ibu–janin lengkap; kriteria eskalasi/rujukan tepat	15	Lembar ujian; algoritme pemantauan
CPMK-5	Simulasi kegawatdaruratan (OSCE) dengan checklist kritis	Langkah stabilisasi urut & aman; terapi awal sesuai protokol/kewenangan; komunikasi rujukan (SBAR) dan kesiapan transport aman	15	Checklist simulasi; form SBAR; catatan tindakan
CPMK-6	OSCE perdarahan + analisis kasus singkat	Triase & diferensial diagnosis tepat; stabilisasi syok/perdarahan tepat; menghindari tindakan kontraindikasi; keputusan rujukan tepat	15	Checklist OSCE; lembar analisis kasus
CPMK-7	Proyek rencana asuhan kolaboratif + audit dokumentasi	Care plan terintegrasi dengan trigger rujukan; edukasi BPCR & pencegahan konsisten; dokumentasi, handover, dan follow-up lengkap	15	Care plan; form audit dokumentasi; ringkasan edukasi

Rubrik CPMK (skala 1–4)

Rubrik CPMK-1

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1.1 Ketepatan identifikasi faktor risiko & tanda bahaya pada skenario kasus	Akurasi ≤60%; banyak red flag terlewat; prioritas tidak tepat	Akurasi 61–79%; beberapa red flag terlewat; prioritas kurang konsisten	Akurasi 80–89%; sebagian besar tepat; kekurangan minor	Akurasi ≥90%; lengkap, konsisten, dan memprioritaskan risiko dengan tepat
1.2 Ketepatan pemilihan	Tidak sesuai pedoman;	Sebagian sesuai pedoman; belum	Sesuai pedoman;	Sangat sesuai; lengkap, antisipatif,

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
strategi pencegahan & keselamatan (patient safety, PPI, K3)	ada potensi tindakan tidak aman	lengkap/kurang mempertimbangkan PPI/K3	lengkap dan aman	menyertakan mitigasi risiko & komunikasi keselamatan

Rubrik CPMK-2

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
2.1 Kelengkapan anamnesis terfokus dan triase kegawatan	<60% komponen; tidak sistematis; triase keliru	60–79% komponen; cukup sistematis; triase masih ragu/kurang tepat	80–89% komponen; sistematis; triase tepat	≥90% komponen; sangat sistematis, menggali red flag; triase cepat dan tepat
2.2 Ketepatan pemeriksaan fisik dan pemilihan penunjang/pemantauan janin	Pemeriksaan tidak relevan/tidak aman; penunjang tidak tepat	Pemeriksaan cukup; ada item penting terlewat; penunjang sebagian tepat	Pemeriksaan lengkap & aman; penunjang/pemantauan sesuai indikasi	Sangat lengkap, efisien; pilihan penunjang mempertimbangkan manfaat-risiko dan konteks layanan
2.3 Ketepatan interpretasi temuan dan penentuan prioritas tindakan/rujukan	Interpretasi keliru; prioritas salah/berisiko	Interpretasi sebagian benar; prioritas kurang jelas	Interpretasi benar; prioritas dan rencana tindak lanjut tepat	Interpretasi sangat akurat; reasoning jelas; menetapkan eskalasi/rujukan dan monitoring secara presisi

Rubrik CPMK-3

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
3.1 Ketepatan klasifikasi anemia, interpretasi Hb, dan	Salah klasifikasi; risiko tidak dinilai/keliru	Klasifikasi sebagian tepat; risiko dinilai namun belum lengkap	Klasifikasi tepat; risiko dinilai dengan baik	Klasifikasi sangat tepat; mempertimbangkan etiologi tersangka dan faktor komorbid secara komprehensif

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
penilaian risiko				
3.2 Ketepatan rencana tata laksana awal, monitoring, dan indikasi rujukan	Rencana tidak sesuai; monitoring/rujukan tidak jelas	Rencana sebagian sesuai; monitoring/rujukan masih umum	Rencana sesuai; monitoring jelas; indikasi rujukan tepat	Rencana sangat sesuai; monitoring terukur; indikasi rujukan/kolaborasi jelas dan antisipatif (termasuk edukasi kepatuhan)

Rubrik CPMK-4

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
4.1 Ketepatan penetapan jenis gangguan hipertensi dan derajat keparahan	Salah menetapkan; mengabaikan kriteria kunci	Sebagian tepat; ada kriteria terlewat	Tepat; kriteria utama terpenuhi	Sangat tepat; membedakan varian/derajat secara konsisten dan menyebutkan implikasi risiko
4.2 Kelengkapan rencana pemantauan (ibu–janin) dan kriteria eskalasi/rujukan	Tidak lengkap; tanpa kriteria eskalasi	Cukup; parameter belum menyeluruh; eskalasi kurang jelas	Lengkap; parameter & interval jelas; eskalasi/rujukan tepat	Sangat lengkap; parameter terukur, interval adaptif sesuai risiko; eskalasi/rujukan sangat jelas dan antisipatif

Rubrik CPMK-5

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.1 Kesesuaian langkah stabilisasi ABCDE dan pencegahan komplikasi segera	Urutan tidak tepat; ada tindakan tidak aman/terlewat kritis	Urutan cukup; masih perlu banyak arahan; ada komponen terlewat	Urutan tepat; aman; komponen utama terpenuhi	Urutan sangat tepat; cepat, aman, dan proaktif mencegah komplikasi (monitoring berkelanjutan)
5.2 Ketepatan terapi awal sesuai	Terapi tidak sesuai/berisiko; dosis/langkah keliru	Terapi sebagian sesuai; ada ketidaktepatan	Terapi sesuai protokol/kewenangan; monitoring memadai	Terapi sangat tepat; menyesuaikan kondisi klinis; monitoring ketat

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
protokol dan kewenangan		minor; monitoring kurang		dan mendokumentasikan respon
5.3 Kesiapan rujukan: komunikasi SBAR, dokumentasi, keselamatan transport	SBAR/dokumen tidak lengkap; kesiapan transport tidak aman	SBAR/dokumen cukup; ada data penting terlewat; transport belum optimal	SBAR jelas; dokumentasi lengkap; transport aman	SBAR sangat sistematis; dokumentasi lengkap + ringkasan tindakan/respon; koordinasi transport dan penerimaan rujukan sangat efektif

Rubrik CPMK-6

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
6.1 Ketepatan triase dan diferensial diagnosis perdarahan berdasarkan trimester	Triase keliru; diferensial tidak sesuai	Triase cukup; diferensial masih sempit/kurang tepat	Triase tepat; diferensial sesuai temuan	Triase sangat tepat; diferensial komprehensif dan memprioritaskan kondisi mengancam nyawa
6.2 Ketepatan stabilisasi awal dan kepatuhan tindakan aman (hindari kontraindikasi)	Stabilisasi tidak adekuat; melakukan/merencanakan tindakan kontraindikasi	Stabilisasi cukup; masih ada kekurangan; kontraindikasi dihindari sebagian	Stabilisasi adekuat; kontraindikasi dihindari; monitoring baik	Stabilisasi sangat adekuat; anticipatory management; monitoring ketat; sepenuhnya patuh tindakan aman
6.3 Ketepatan keputusan rujukan dan monitoring ibu–janin pra-rujukan	Keputusan rujukan tidak tepat/terlambat; monitoring minim	Rujukan cukup; monitoring belum terstruktur	Rujukan tepat waktu; monitoring terstruktur	Rujukan sangat tepat; monitoring ibu–janin jelas, terdokumentasi, dan komunikasi penerimaan rujukan efektif

Rubrik CPMK-7

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
7.1 Kualitas rencana asuhan kolaboratif terintegrasi dan koordinasi layanan	Care plan tidak terintegrasi; peran/rujukan tidak jelas	Care plan cukup; integrasi/koordinasi sebagian	Care plan terintegrasi; koordinasi dan trigger rujukan jelas	Care plan sangat terintegrasi; koordinasi lintas layanan kuat; trigger rujukan, monitoring, dan mitigasi risiko sangat jelas
7.2 Kualitas edukasi dan rencana persalinan/rujukan (BPCR)	Edukasi tidak terarah; rencana tidak realistis	Edukasi cukup; rencana masih umum	Edukasi jelas; rencana disepakati dan aplikatif	Edukasi sangat efektif (teach-back); rencana rinci (tanda bahaya, transport, biaya, kontak) dan berorientasi keselamatan
7.3 Kelengkapan dokumentasi, handover, dan rencana continuity of care	Dokumentasi/handover tidak lengkap; tidak ada follow-up	Dokumentasi cukup; follow-up belum spesifik	Dokumentasi lengkap; handover jelas; follow-up terjadwal	Dokumentasi sangat lengkap dan rapi; handover terstruktur; continuity of care rinci (jadwal, indikator evaluasi, jejaring rujukan)

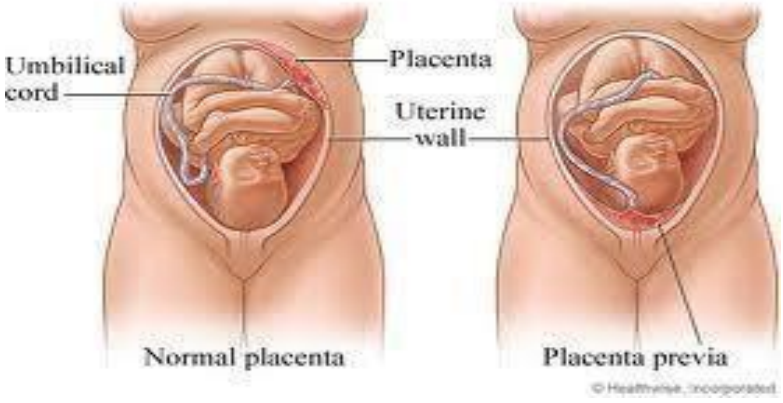
Uraian Materi

Perdarahan Trimester II-III merupakan penyebab utama kematian ibu di Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya. Perdarahan ini terjadi setelah kehamilan mencapai usia 20 minggu dan sebelum persalinan dimulai, dengan dua penyebab tersering yaitu plasenta previa dan solutio plasenta. Menurut laporan Profil Kesehatan Indonesia 2023, angka kematian ibu (AKI) di Indonesia masih berada pada angka 189 per 100.000 kelahiran hidup, dengan perdarahan sebagai kontribusi signifikan. Kondisi ini menunjukan bahwa penanganan dan pencegahan perdarahan trimester II-III masih menjadi tantangan serius dalam sistem pelayanan kesehatan ibu dan anak (BKPK, 2023).

A. Plasenta Previa

1. Definisi

   Plasenta previa adalah plasenta yang berimplantasi pada segmen bawah rahim (SBR) sehingga menutupi seluruh atau sebagian dari "*Ostium Uteri Internum* (OUI)." Seiring dengan pertumbuhan rahim dan ekspansi segmen bawah rahim menuju ke bagian atas, plasenta yang terimplan di segmen bawah rahim bisa berpindah mengikuti perkembangan tersebut, seolah-olah melakukan perpindahan tempat yang disebut migrasi. Selain itu, selama proses persalinan, dinamika Ostium Uteri yang melebar dan datar juga bisa mengubah luas area serviks yang tertutup oleh plasenta. Peristiwa ini akan memengaruhi tingkat atau klasifikasi plasenta previa saat dilakukan pemeriksaan, baik itu selama masa antenatal maupun intranatal, menggunakan ultrasonografi. Oleh karena itu pemeriksaan ultrasonografi perlu diulang secara berkala dalam asuhan antenatal maupun intranatal (Jenabi et al., 2022a; Manuaba, 2016).



Gambar 5.1
Letak Plasenta (Jenabi et al., 2022b)

Etiologi

Yang menjadi penyebab dari implantasi blastokista pada segmen bawah rahim masih belum diketahui dengan jelas. Ada kemungkinan bahwa hal ini terjadi secara kebetulan di mana blastokista secara acak menempati area desidua di segmen bawah rahim. Peningkatan plasenta previa terjadi pada kondisi ketika endometrium tidak berada dalam kondisi optimal, seperti atrofi endometrium atau kurangnya vaskularisasi pada desidua. Keadaan ini bisa ditemukan pada beberapa kondisi antara lain:

a. Multipara, terutama jika jarak kehamilannya pendek
b. Mioma uteri
c. Kuretasi yang berulang
d. Umur lanjut (diatas 35 tahun)
e. Bekas seksio sesaria
f. Riwayat abortus
g. Defek vaskularisasi pada desidua
h. Plasenta yang besar dan luas : pada kehamilan kembar, eriblastosis fetalis.
i. Wanita yang mempunyai riwayat plasenta previa pada kehamilan sebelumnya
j. Perubahan inflamasi atau atrofi misalnya pada wanita perokok atau pemakai kokain.
k. Korpus luteum bereaksi lambat, dimana endometrium belum siap menerima hasil konsepsi.
l. Konsepsi dan nidasi terlambat.
m. Ketika hipoksemia muncul karena paparan karbon monoksida (CO), plasenta akan mengalami hipertrofi sebagai upaya untuk kompensasi. Fenomena ini terutama teramati pada perokok berat yang mengonsumsi lebih dari 20 batang rokok per hari (Jenabi et al., 2022a; Podungge et al., 2023).

Keadaan endometrium yang kurang baik menyebabkan plasenta harus tumbuh menjadi luas untuk mencukupi kebutuhan janin. Plasenta yang tumbuh meluas akan mendekati atau menutupi ostoum uteri internum. Endometrium yang kurang baik juga dapat menyebabkan zigot mencari tempat implantasi yang lebih baik, yaitu di tempat yang lebih rendah dekat ostium uteri internum. Plasenta previa juga dapat terjadi pada plasenta yang besar dan yang luas seperti pada eritroblastosis, diabetes mellitus, atau kehamilan multipel (Abdul B.S, Gulardi H.W, Biran A, 2014; Jing et al., 2018).

Faktor Risiko

Faktor risiko yang meningkatkan kemungkinan terjadinya plasenta previa dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori, berdasarkan bukti dari penelitian ilmiah.

a. Riwayat Sectio Ceasarea.
    1) Faktor risiko paling dominan.
    2) Risiko meningkat seiring jumlah SC sebelumnya.
    3) Mekanisme : jaringan parut pada uterus menyebabkan gangguan integritas endometrium, sehingga plasenta lebih cenderung menempel di segmen bawah.
    4) Bukti: Penelitian menunjukan ibu dengan riwayat SC memiliki risiko beberapa kali lebih tinggi dibandingkan tanpa riwayat SC (Jauniaux et al., 2022; Kayem et al., 2024).
b. Usia Lanjut (≥ 35 tahun)
    1) Usia ibu ≥ 35 tahun meningkatkan risiko plasenta previa.
    2) Mekanisme : degenerasi endometrium dan perubahan vaskularisasi uterus memepengaruhi lokasi implantasi.
    3) Bukti : Meta-analisis menunjukan kejadian plasenta previa lebih tinggi pada kelompok usia lanjut (≥35 tahun) (Jauniaux et al., 2022).
c. Riwayat Abortus
    1) Abortus spontan atau induksi meningkatkan risiko terjadinya plasenta previa
    2) Mekanisme: prosedur kuretase dapat merusak lapisan endometrium menjadikan implantasi abnormal pada kehamilan berikutnya.
    3) Bukti: Hubungan signifikan antara riwayat abortus dan plasenta previa telah dilaporkan (Hu et al., 2024).
d. Multiparitas
    1) Ibu dengan banyak kehamilan memiliki risiko lebih tinggi
    2) Mekanisme: perubahan struktur uterus dan kualitas endometrium menurun sehingga meningkatkan kemungkinan implantasi abnormal.
    3) Bukti: Studi Kohort menunjukan hubungan antara paritas tinggi dan plasenta previa (Brandstetter et al., 2025).
e. Riwayat Operasi Uterus
    1) Contoh: miomektomi, kuretase, operasi uterus lainnya.
    2) Mekanisme: kerusakan lapisan endometrium mempermudah implantasi abnormal di segmen bawah.
    3) Bukti: Ditemukan sebagai factor risiko signifikan dalam berbagai penelitian (Sahu, 2024).

f. Merokok
   1) Kebiasaan merokok selama kehamilan meningkatkan risiko
   2) Mekanisme: hipoksia kronis pada jaringan plasenta membuat plasenta mencari lokasi dengan perfusi lebih baik
   3) Bukti: Review sistematik menunjukan merokok sebagai faktor risiko signifikan (Jauniaux et al., 2022).
g. Teknologi Reproduksi Berbantu (ART/IVF)
   1) Penggunaan ART meningkatkan risiko plasenta previa
   2) Mekanisme: perubahan pola implantasi embrio akibat prosedur ART
   3) Bukti Beberapa studi menemukan hubungan signifikan antara ART dan plasenta previa (Jauniaux et al., 2022).
h. Kehamilan Ganda
   1) Kehamilan dengan lebih dari satu janin meningkatkan risiko
   2) Mekanisme: luas permukaan plasenta lebih besar sehingga plasenta mungkin mencapai atau menutupi ostium uteri internum.
   3) Bukti: ditemukan pada beberapa penelitian sebagai faktor predisposisi (Jauniaux et al., 2022)

Tabel 5.1
Ringkasan klasifikasi Faktor Risiko Plasenta Previa :

Kategori	Faktor Risiko
Obstetri	Riwayat SC, Multiparitas, riwayat plasenta previa sebelumnya
Maternal	Usia ≥35 tahun, merokok, riwayat abortus
Kehamilan	Kehamilan ganda, ART/IVF
Anatomik	Riwayat operasi uterus

Identifikasi faktor risiko sejak awal penting untuk deteksi dini, pencegahan komplikasi dan perencanaan asuhan kebidanan yang tepat.

Patofisiologi

Plasenta previa merupakan kelainan implantasi plasenta yang terjadi akibat gangguan pada proses awal kehamilan dan perkembangan selanjutnya. Secara patofisiologis, kondisi ini diawali oleh implantasi blastokista pada segmen bawah uterus, bukan pada fundus atau korpus uteri sebagaimana terjadi pada kehamilan normal. Implantasi yang abnormal ini berkaitan dengan gangguan kualitas endometrium, terutama akibat jaringan parut pasca tindakan seperti sectio caesarea atau kuretase, serta perubahan vaskularisasi uterus yang menyebabkan lingkungan fundus menjadi kurang optimal untuk implantasi.

Selanjutnya, proses invasi trofoblas yang seharusnya berlangsung optimal pada awal kehamilan mengalami gangguan. Pada kondisi normal, trofoblas akan menginvasi arteri spiralis dan menyebabkan remodeling pembuluh darah sehingga aliran darah ke plasenta meningkat. Namun pada plasenta previa, invasi trofoblas tidak berlangsung secara adekuat sehingga remodeling vaskular menjadi tidak sempurna. Akibatnya, aliran darah uteroplasenta menjadi kurang stabil dan meningkatkan kerentanan terhadap perdarahan. Penelitian menunjukkan bahwa gangguan invasi trofoblas dan abnormalitas vaskular ini merupakan salah satu mekanisme utama dalam terjadinya plasenta previa.

Seiring bertambahnya usia kehamilan, terutama pada trimester kedua dan ketiga, segmen bawah uterus mulai terbentuk dan mengalami peregangan yang progresif. Segmen bawah uterus memiliki karakteristik lapisan miometrium yang lebih tipis dan kemampuan kontraksi yang lebih rendah dibandingkan dengan fundus. Pada plasenta previa, plasenta yang melekat pada segmen bawah ini tidak mampu mengikuti peregangan yang terjadi. Hal ini menyebabkan terjadinya pelepasan sebagian plasenta dari dinding uterus.

Pelepasan sebagian plasenta tersebut mengakibatkan terbukanya pembuluh darah maternal yang sebelumnya berada pada area perlekatan plasenta. Kondisi ini menyebabkan terjadinya perdarahan pervaginam yang khas pada plasenta previa. Perdarahan ini biasanya tidak disertai nyeri karena tidak terjadi kontraksi uterus maupun iskemia miometrium, sehingga berbeda dengan perdarahan pada solusio plasenta yang disertai nyeri.

Perdarahan pada plasenta previa cenderung bersifat berulang. Hal ini disebabkan oleh proses peregangan segmen bawah uterus yang berlangsung terus-menerus selama kehamilan. Setiap kali terjadi peregangan tambahan, plasenta dapat kembali terlepas sebagian, sehingga pembuluh darah kembali terbuka dan menimbulkan episode perdarahan berikutnya yang umumnya lebih berat.

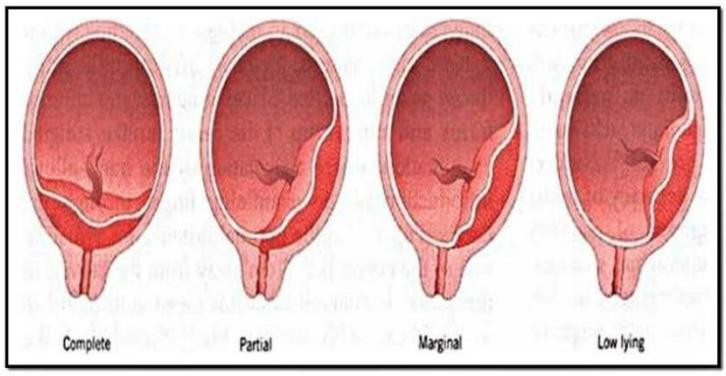
Selain itu, gangguan perfusi uteroplasenta akibat implantasi abnormal juga dapat berdampak pada janin. Penurunan aliran darah ke plasenta dapat menyebabkan hipoksia janin dan meningkatkan risiko prematuritas. Pada ibu, perdarahan berulang dapat menyebabkan anemia hingga syok hipovolemik apabila tidak ditangani dengan cepat dan tepat.

Dengan demikian, patofisiologi plasenta previa merupakan hasil interaksi antara gangguan implantasi plasenta, abnormalitas vaskular uteroplasenta, serta perubahan anatomi uterus selama kehamilan. Proses ini secara klinis bermanifestasi sebagai perdarahan antepartum tanpa nyeri yang berulang dan berpotensi menimbulkan komplikasi serius bagi ibu dan janin.

Klasifikasi

Klasifikasi dari plasenta previa (empat tingkatan):

a. Plasenta previa totalis atau komplit adalah kondisi di mana plasenta menutupi seluruh ostium uteri internum. Pada jenis ini, kelahiran normal tidak mungkin dilakukan karena akan mengakibatkan risiko perdarahan yang sangat besar.
b. Plasenta previa parsialis adalah ketika plasenta menutupi sebagian dari ostium uteri internum. Meskipun hanya menutupi sebagian, tetapi risiko perdarahan tetap tinggi dan seringkali kelahiran normal pada kondisi tersebut sangat mustahil.
c. Plasenta previa marginalis adalah kondisi di mana tepi plasenta berada di pinggir ostium uteri internum, dengan hanya sebagian kecil plasenta yang menutupi jalan lahir. Meskipun demikian, janin masih memiliki peluang untuk dilahirkan secara normal, namun risiko perdarahan yang dihasilkan akan tetap besar.
d. Plasenta letak rendah, plasenta lateralis, atau kadang disebut juga "*dangerous placenta"* adalah ketika plasenta terimplan di segmen bagian bawah rahim sehingga tepi bawahnya berada sekitar 2 cm atau kurang dari ostium uteri internum. Jarak yang melebih 2 cm dianggap sebagai plasenta posisi yang normal. Risiko perdarahan tetap ada namun tidak besar, dan janin bisa dilahirkan secara normal asal tetap berhati-hati. Klasifikasi plasenta previa menurut Browne adalah:



Gambar 5.2
Klasifikasi Plasenta Previa (King et al., 2020)

1) Tingkat 1, *Lateral plasenta previa*: Pinggir bawah plasenta berinsersi sampai ke segmen bawah rahim, namun tidak sampai ke pinggir pembukaan.
2) Tingkat 2, *Marginal plasenta previa*: Plasenta mencapai pinggir pembukaan (Ostium).

3) Tingkat 3, *Complete placenta previa*: plasenta menutupi ostium waktu tertutup dan tidak menutupi bila pembukaan hamper lengkap.
4) Tingkat 4, *Central placenta previa*: plasenta menutupi seluruh ostium pada pembukaan hampir lengkap.

Tanda dan Gejala

Berdasarkan berbagai penelitian, tanda dan gejala plasenta previa dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Perdarahan Pervaginam Tanpa Nyeri

Perdarahan pervaginam tanpa nyeri merupakan gejala utama dan paling khas pada plasenta previa. Perdarahan biasanya terjadi secara tiba-tiba tanpa disertai kontraksi uterus. Perdarahan ini disebabkan oleh :

1) Pelepasan sebagian plasenta dari segmen bawah uterus
2) Terbukanya pembuluh darah maternal

Darah yang kelaur umumnya berwarna merah segar karena berasal dari sirkulasi maternal. Penelitian menunjukan bahwa sebagian besar kasus plasenta previa diawali dengan perdarahan tanpa nyeri pada trimester II dan trimester III.

b. Perdarahan Berulang

Perdarahan pada plasenta previa cenderung bersifat berulang dengan intensitas yang semakin meningkat. Hal ini terjadi karena peregangan segmen bawah uterus yang terus berlangsung dan pelepasan plasenta yang terjadi secara bertahap. Setiap episode perdarahan berikutnya dapat lebih berat dibandingkan sebelumnya.

c. Perdarahan terjadi pada Trimester II dan III

Gejala biasanya muncul setelah usia kehamilan memasuki trimester kedua atau ketiga, terutama setelah terbentuknya segemen bawah uterus. Penelitian menunjukan bahwa sebagian besar kasus terjadi setelah usia kehamilan ≥20 minggu.

d. Tidak disertai Nyeri Abdomen

Perdarahan pada plasenta previa tidak disertai nyeri. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya kontraksi uterus tidak terjadi iskemia myometrium. Kondisi ini menjadi pembeda klinis penting dalam diagnosis banding perdarahan antepartum.

e. Letak Janin Tidak Normal

Pada plasenta previa, bagian terbawah janin sering tidak menempati pintu atas panggul. Manifestasi yang dapat ditemukan presentasi sungsang, letak lintang, kepala janin belum masuk PAP. Hal ini disebabkan oleh posisi plasenta yang menghalangi jalan lahir.

f. Uterus Lunak dan Tidak Nyeri Saat Palpasi

Pada pemeriksaan abdomen uterus teraba lunak dan tidak terdapat nyeri tekan. Kondisi ini mencerminkan tidak adanya aktivitas kontraksi uterus yang signifikan.

g. Denyut Jantung Janin (DJJ) Awalnya Normal

Pada tahap awal DJJ dalam batas normal. Namun, jika berlanjut dapat terjadi gangguan perfusi plasenta dan muncul tanda distress janin

h. Tanda Anemia atau Syok (Pada Kasus Berat)

Jika perdarahan berlangsung masif atau berulang, ibu akan terlihat pucat, mengalami takikardia dan hipotensi. Bahkan pada kondisi lanjut dapat terjadi syok hipovolemik. Penelitian menunjukan bahwa perdarahan berat merupakan penyebab utama morbiditas maternal pada plasenta previa.

Pemeriksaan Penunjang

Pemeriksaan penunjang pada plasenta previa bertujuan untuk menegakkan diagnosis secara akurat, menentukan lokasi plasenta, serta menilai kondisi ibu dan janin. Pemeriksaan dilakukan secara hati-hati untuk mencegah komplikasi, terutama perdarahan.

a. Ultrasonografi (USG)

USG merupakan pemeriksaan utama dalam diagnosis plasenta previa

1) USG Transabdonimal
   a) Digunakan sebagai pemeriksaan awal (skrining)
   b) Bersifat non-invasif dan mudah dilakukan
   c) Memberikan gambaran awal lokasi plasenta
2) USG Transvadinal
   a) Memiliki akurasi lebih tinggi dibandingkan transabdominal
   b) Dapat menentukan jarak plasenta dengan ostium uteri internum secara lebih tepat.
   c) Aman dilakukan dengan teknik yang benar.

Berdasarkan penelitian USG transvaginal memiliki sensitivitas dan spesifisitas tinggi sehingga direkomendasikan sebagai standar diagnosis.

b. Magnetic Resonance Imaging (MRI)

MRI digunakan sebagai pemeriksaan tambahan pada kasus tertentu.

Indikasi menggunakan MRI yaitu:

1) Hasil USG tidak jelas
2) Kecurigaan plasenta akreta spektrum
3) Evaluasi invasi plasenta ke myometrium

Adapun manfaat menggunakan MRI adalah memberikan gambaran anatomi yang lebih detail dan membangu perencanaan Tindakan operatif. Studi

menunjukan MRI efektid dalam menilai kedalaman invasi plasenta dan risiko perdarahan.

c. Pemeriksaan Laboratorium

Pemeriksaan laboratorium dilakukan untuk menilai kondisi ibu dan kesiapan menghadapi perdarahan.

Jenis pemeriksaan laboratorium yang dilakukan adalah :

1) Hemoglobin (Hb) dan hematokrit, untuk menilai derajat anemia.
2) Golongan darah dan crossmatch, untuk persiapan transfuse darah
3) Pemeriksaan koagulasi, untuk mendeteksi gangguan pembekuan darah

Penelitian menunjukan pemantauan parameter hematologic dalam mencegah komplikasi maternal.

d. Kardiotokografi (CTG)

CTG digunakan untuk memantau kondisi janin dengan tujuan menilai denyut jnatung janin (DJJ) dan mendeteksi distress janin. Gangguan perfusi plasenta dapat menyebabkan perubahan pola denyut jantung janin yang terdeteksi melalui CTG.

e. Doppler Ultrasonografi

Pemeriksaan Doppler digunakan untuk menilai aliran darah uteroplasenta yang memiliki manfaat untuk mengevaluasi perfusi plasenta dan membantu memprediksi risiko komplikasi. Beberapa studi menunjukan doppler bermanfaat dalam menilai kondisi vascular plasenta.

f. Pemeriksaan fisik sebagai pendukung

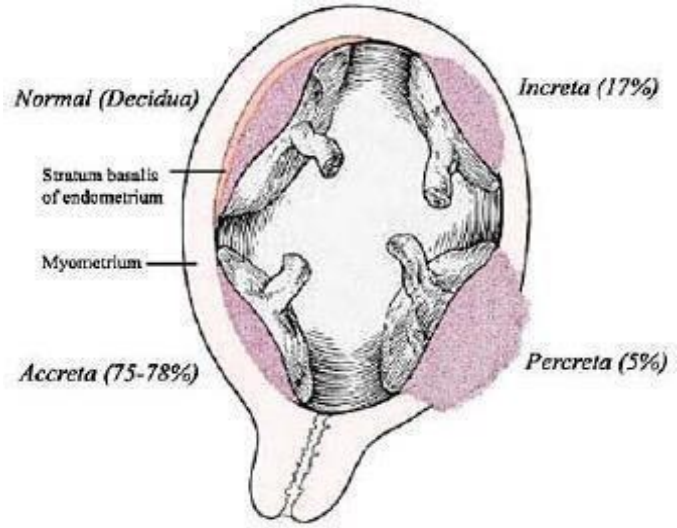
Pemeriksaan fisik tetap dilakukan untuk melengkapi diagnosis dengan temuan klinis berupa uterus lunak, tidak nyeri tekan dan letak janin abnormal. Pemeriksaan vaginal atau pemeriksaan dalam dilarang sebelum diagnosis pasti ditegakkan karena dapat memicu perdarahan hebat.

Komplikasi

Kemungkinan besar terjadinya infeksi nifas meningkat karena luka plasenta berada lebih dekat dengan ostium, yang menjadi pintu masuk infeksi yang mudah dijangkau. Selain itu, pasien biasanya mengalami anemia karena perdarahan, sehingga sistem kekebalan tubuhnya melemah. Bahaya plasenta previa adalah (Jain et al., 2020) :

a. Anemia dan syok hipovolemik karena pembentukan segmen rahim terjadi secara ritmik, maka pelepasan plasenta dari tempat melekatnya diuterus dapat berulang dan semakin banyak dan perdarahan yang terjadi itu tidak dapat dicegah.
b. Implantasi plasenta pada segmen bawah rahim, yang memiliki karakteritik tipis, memungkinkan jaringan trofoblas dengan kemampuan invasifnya

menembus ke dalam miometrium bahkan mencapai perimetrium, yang kemudian menjadi penyebab terjadinya plasent inkreta bahkan plasenta perkreta. Plasenta akreta merupakan kondisi yang paling ringan, di mana plasenta melekat lebih kuat tetapi vilusnya belum menembus ke dalam miometrium. Meskipun tidak seluruh permukaan maternal plasenta mengalami akreta atau inkreta, hal ini dapat menyebabkan retensio plasenta dan perdarahan dalam pada kala tiga setelah bagian plasenta yang telah terlepas. Komplikasi ini lebih sering terjadi pada uterus yang telah menjalani seksio sesaria sebelumnya. Dilaporkan bahwa plasenta akreta terjadi pada sekitar 10%-35% dari pasien yang telah menjalani seksio sesaria satu kali, dan angka ini meningkat hingga 60-65% pada pasien yang telah menjalani seksio sesaria sebanyak tiga kali.



Gambar 5.3
Jenisa Plasenta Previa (Jain et al., 2020)

c. Serviks dan segmen bawah rahim yang rapuh dan memiliki banyak pembuluh darah rentan terhadap robekan yang disertai perdarahan yang signifikan. Oleh karena itu, sangat penting untuk berhati-hati saat melakukan tindakan manual di area ini, seperti saat mengeluarkan bayi melalui insisi pada segmen bawah rahim atau ketika mengeluarkan plasenta dengan tangan untuk mengatasi retensio plasenta. Jika terjadi perdarahan yang tidak dapat dikendalikan oleh metode sederhana seperti "penjahitan segmen bawah rahim, ligasi a.uterina, ligasi a.ovarika, pemasangan tampon, atau ligasi a.hipogastrika," maka langkah yang sangat kritis adalah melakukan histerektomi total. Morbiditas yang terkait dengan semua tindakan ini tentu saja merupakan komlikasi tidak langsung dari plasenta previa.

d. Pada plasenta previa, kelainan letak janin lebih sering terjadi. Kondisi ini seringkali membutuhkan tindakan operasi yang lebih sering dilakukan, dengan segala konsekuensinya yang menyertainya.
e. Kehamilan prematur dan risiko komplikasi pada janin seringkali tidak dapat dihindari karena tindakan terminasi kehamilan yang diperlukan sebelum waktu yang tepat. Pada kehamilan kurang dari 37 minggu, amniosentesis dapat dilakukan untuk menilai kematangan paru-paru janin, sementara pemberian kortikosteroid bertujuan untuk mempercepat pematangan paruparu janin sebagai upaya antisipatif.
f. Solusio plasenta
g. Kematian maternal akibat perdarahan
h. Disseminated intravascular coagulation (DIC)
i. Infeksi sepsis (Jain et al., 2020; King et al., 2020; Sulistyawati, 2014).

Penatalaksanaan

Pada penderita plasenta previa yang datang dengan keluhan adanya perdarahan pervaginam pada saat kehamilan trimester II dan trimester III. Penanganan plasenta previa dapat dibagi dalam 2 golongan :

a. Terapi Ekspektatif (pasif)

   Tujuan ekspektatif yaitu agar janin tidak terlahir premature, penderita dirawat tanpa melakukan pemeriksaan dalam melalui kanalis servisis. Upaya diagnosis dilakukan secara non invasif dan pemantauan klinis dilakukan secara ketat dan baik. Syarat-syarat terapi ekspektatif adalah kehamilan preterm dengan perdarahan sedikit yang kemudian berhenti, keadaan umum ibu cukup baik (kadar hemoglobin dalam batas normal), belum ada tanda-tanda inpartu dan janin masih hidup.

b. Terapi Aktif

   Pada Wanita hamil di atas 20 minggu dengan perdarahan pervaginam yang aktif dan banyak, harus dilaksanakan segera untuk tatalaksananya secara aktif tanpa memandang maturitas janin. Cara menyelesaikan persalinan dengan plasenta previa.

   1) Seksio sesaria

      Prinsip utama dalam melakukan seksio sesaria adalah untuk menyelamatkan ibu, sehingga walaupun janin meninggal atau tak punya harapan untuk hidup, Tindakan ini tetap dilakukan. Digunakan seksio sesaria agar dapat mengosongkan Rahim untuk menghentikan perdarahan dan mengadakan kontraksi.

   2) Melahirkan pervaginam

Perdarahan akan berhenti jika ada penekanan pada plasenta dengan demikian pembuluh-pembuluh darah yang terbuka akan menutup. Biasanya pada persalinan pervaginam dilakukan pada plasenta previa marginalis dengan presentasi kepala.

Asuhan Kebidanan

Asuhan kebidanan pada plasenta previa merupakan upaya komprehensif yang meliputi pengkajian, penegakan diagnosis, perencanaan, implementasi, dan evaluasi, dengan tujuan menjaga keselamatan ibu dan janin serta mencegah komplikasi akibat perdarahan antepartum.

a. Pengkajian

Pengkajian merupakan langka awal dalam asuhan kebidanan yang dilakukan secara menyeluruh

1) Data Subjektif
   a) Keluhan Utama : perdarahan pervaginam tanpa nyeri
   b) Waktu, frekuensi, dan jumlah perdarahan
   c) Riwayat obstetri (gravida, para, abortus)
   d) Riwayat section caesarea atau operasi uterus
   e) Riwayat plasenta previa sebelumnya
2) Data Objektif
   a) Tanda-tanda vital (Tekanan darah, Nadi, Pernapasan, Suhu)
   b) Keadaan umum ibu (pucat, kesadaran)
   c) Pemeriksaan Abdomen (TFU, letak janin)
   d) Denyut Jantung Janin (DJJ)
   e) Hasil USG (lokasi dan jenis plasenta previa)
   f) Hasil laboratorium (Hb, hematokrit)

Penelitian menunjukan bahwa pengkajian yang lengkap sangat penting dalam menentukan tingkat keparahan dan risiko komplikasi.

b. Diagnosis Kebidanan

Berdasarkan hasil pengkajian, ditegakkan diagnosis kebidanan berupa :

1) Plasenta Previa (sesuai kalsifikasi)
2) Masalah actual : perdarahan antepartum
3) Masalah potensial : anemia, syok hipovolemik, distress janin

c. Perencanaan Asuhan

Perencanaan dilakukan berdasarkan kondisi ibu dan usia kehamilan.

1) Pada kondisi stabil (konservatif)
   a) Tirah baring
   b) Monitoring tanda vital dan perdarahan
   c) Pemantauan DJJ

d) Pemberian kortikosteroid (jika prematur)
e) Edukasi tanda bahaya

2) Pada kondisi tidak stabil
a) Persiapan Tindakan segera
b) Kolaborasi dengan dokter spesialis
c) Persiapan transfuse darah
d) Persiapan terminasi kehamilan

Studi menunjukan bahwa perencanaan berbasis kondisi klinis dapat menurunkan morbiditas maternal.

d. Implementasi (Tindakan Kebidanan)

Pelaksanaan asuhan dilakukan sesuai rencana yang telah disusun.

Tindakan Utama:

1) Monitoring ketat kondisi ibu (TTV, perdarahan)
2) Pemasangan jalur intravena
3) Pemberian caiaran dan terapi sesuai indikasi
4) Observasi kesejahteraan janin (DJJ/CTG)
5) Persiapan rujukan bila diperlukan

Tidak dilakukan pemeriksaan dalam sebelum diagnosis pasti.

e. Evaluasi

Evaluasi dilakukan secara berkelanjutan untuk mneilai efektivitas asuhan. Yang dievaluasi yaitu :

1) Perubahan jumlah perdarahan
2) Stabilitas hemodinamik ibu
3) Kondisi janin
4) Respons terhadap terapi

Evalusi berkala terbukti penting untuk mencegah perburukan kondisi.

f. Edukasi dan konseling

Edukasi merupakan bagian penting dalam asuhan kebidanan. Materi edukasi yang diberikan pada kasus plasenta previa adalah :

1) Tanda bahaya (perdarahan ulang, nyeri, penurunan gerak janin)
2) Pentingnya tirah baring
3) Kepatuahn control antenatal
4) Persiapan persalinan di fasilitas kesehatan

g. Kolaborasi dan Rujukan

Asuhan kebidanan pada plasenta previa memerlukan pendekatan kolaboratif. Indikasi dilakukan kolaborasi/rujukan :

1) Perdarahan aktif atau berat
2) Kondisi ibu tidak stabil

3) Distres janin
4) Keterbatasan fasilitas

Tindakan yang dilakukan sebelum rujukan adalah :

1) Stabilisasi ibu sebelum rujukan
2) Koordinasi dengan fasilitas rujukan
3) Pendampingan selama transportasi

Penelitian menunjukan bahwa rujukan tepat waktu menurunkan risiko kematian ibu dan janin.

h. Dokumentasi

Seluruh asuhan harus didokumentasikan secara sistematis.

Asuhan kebidanan pada plasenta previa harus dilakukan secara komprehensif dan berkesinambungan dengan pendekatan evidence-based. Deteksi dini, monitoring ketat, serta kolaborasi yang tepat merupakan kunci utama dalam menurunkan risiko komplikasi maternal dan perinatal.

Red Flags dan Rujukan

Penatalaksanaan plasenta previa memerlukan kewaspadaan tinggi terhadap tanda bahaya (red flags) yang dapat mengancam keselamatan ibu dan janin. Indentisikasi dini terhadap kondisi ini sangat penting untuk menentukan kebutuhan rujukan secara cepat dan tepat.

a. Red Flags pada plasenta previa

Red flags merupakan tanda klinis yang menunjukkan adanya kondisi gawat darurat atau potensi komplikasi serius.

1) Perdarahn pervaginam masif
   a) Perdarahan banyak, tiba-tiba, dan tidak terkendali
   b) Darah berwarna merah segar
   c) Dapat menyebabkan penurunan tekanan darah

   Penelitian menunjukan bahwa perdarahan masif merupakan penyebab utama mordbitas dan mortalitas pada plasenta previa
2) Tanda syok hipovolemik
   a) Tekanan darah menurun (hipotensi)
   b) Nadi cepat dan lemah (takikardia)
   c) Pucat, dingin, dan berkeringat
   d) Penurunan kesadaran

   Kondisi ini menunjukkan kehilangan darah yang dignifikan dan memerlukan penanganan segera.
3) Perdarahan berulang dengan intensitas meningkat
   a) Episode perdarahan yang semakin sering

b) Volume perdarahan meningkat dari waktu ke waktu

Studi menunjukan meningkatkan bahwa pola perdarahan berulang meningkatkan risiko komplikasi berat

4) Tanda distress janin
   a) Penurunan atau tidak terdeteksi denyut jantung janin
   b) Gerakan janin berkurang
   c) Pola abnormal pada CTG

   Menunjukkan gangguan perfusi uteroplasenta
5) Usia kehamilan preterm dengan perdarahan
   a) Perdarahan pada usia kehamilan , <37 minggu
   b) Risiko tinggi terhadap prematuritas
6) Kecurigaan Akreta Spektrum
   a) Riwayat section caesarea berulang
   b) Hasil USG menunjukan invasi plasenta

   Kondisi ini meningkatkan risiko perdarahan masif saat persalinan

b. Indikasi Rujukan

Rujukan harus dilakukan segera apabila ditemukan kondisi berikut :

1) Perdarahan aktif atau masif
2) Tanda syok atau ketidakstabilan hemodinamik
3) Distress janin
4) Kecurigaan plasenta akreta
5) Keterbatasan fasilitas pelayanan kesehatan
6) Kebutuhan Tindakan operatif (section caesarea)

Penelitian menunjukkan bahwa rujukan tepat waktu dapat menurunkan angka kematian ibu dan janin

c. Prinsip Rujukan pada Plasenta Previa

Rujukan harus dilakukan secara terencana dan aman dengan memperhatikan prinsip berikut :

1) Stabilisasi sebelum rujukan
   a) Pemasangan jalur intravena
   b) Pemberian cairan intravena
   c) Persiapan transfuse darah jika diperlukan
   d) Monitoring tanda vital
2) Pendampingan selama rujukan
   a) Tenaga kesehatan mendampingi pasien
   b) Membawa perlengkapan emergensi
   c) Memantau kondisi ibu dan janin selama perjalanan

3) Komunikasi dengan fasilitas rujukan
   a) Memberikan informasi kondisi pasien
   b) Menyampaikan Tindakan yang telah dilakukan
   c) Memastikan kesiapan fasilitas tujuan
4) Dokumentasi Rujukan
   a) Indikasi rujukan
   b) Kondisi ibu dan janin saat dirujuk
   c) Waktu dan tempat rujukan
   d) Tindakan yang telah diberikan

d. Edukasi tanda bahaya kepada ibu

Sebagai bagian dari asuhan kebidanan, ibu harus diberikan edukasi mengenai tanda bahaya :

1) Perdarahan pervaginam
2) Nyeri atau kontraksi
3) Penurunan Gerakan janin
4) Pusing atau lemas

Edukasi ini penting untuk mendorong ibu segera mencari pertolongan medis

Dokumentasi

Dokumentasi dalam penatalaksanaan plasenta previa merupakan bagian integral dari asuhan kebidanan yang bertujuan untuk menjamin kesinambungan pelayanan, menignkatkan keselamtan ibu dan janin, serta memenuhi aspek legal dan professional. Dokumentasi harus dilakukan secara lengkap, akurat, objektif, dan bekesinambungan sesuai dengan perkembangan kondisi klinis pasien.

a. Prinsip Umum Dokumentasi

Dokumentasi harus memenuhi prinsip sebagai berikut:

1) Akurat: sesuai dengan kondisi klinis yang sebenarnya
2) Lengkap: mencakup seluruh proses asuhan
3) Objektif: berdasarkan hasil pemeriksaan dan observasi
4) Tepat waktu: dicatat segera setelah tindakan dilakukan
5) Berkesinambungan: mengikuti perkembangan kondisi pasien

Penelitian menunjukan bahwa dokumentasi yang sistematis dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan menurunkan risiko kesalahan klinis.

b. Dokumentasi Data Subjektif (S)

Data subjektif diperoleh melalui anamnesis

Hal yang harus didokumentasikan:

1) Keluhan utama : perdarhaan pervaginam tanpa nyeri
2) Waktu onset, frekuensi, dan jumlah perdarahan
3) Karakteristik darah (warna merah segar, adanya bekuan)

4) Riwayat obstetri (gravida, para, abortus)
5) Riwayat sectio caesarea atau operasi uterus
6) Riwayat plasenta previa sebelumnya
7) Riwayat penyakit penyerta

c. Dokumentasi Data Objektif (O)

Data objektif diperoleh dari pemeriksaan fisik dan penunjang

Hal yang harus didokumentasikan:

1) Tanda vital (tekanan darah, nadi, respirasi, suhu)
2) Keadaan umum ibu (pucat, kesadaran, tanda syok)
3) Pemeriksaan abdomen (tinggi fundus uteri, letak dan presentasi janin)
4) Denyut jantung janin (DJJ)
5) Hasil ultrasonografi (lokasi plasenta dan klasifikasi plasenta previa)
6) Hasil laboratorium (Hb, hematokrit, koagulasi, golongan darah)

Studi menunjukan bahwa pencatatan data objektif yang lengkap penting untuk menilai tingkat keparahan dan risiko komplikasi.

d. Dokumentasi Assessment (A)

Assessment merupakan interpretasi klinis berdasarkan data yang diperoleh.

Yang harus dituliskan:

1) Diagnosis kebidanan: plasenta previa
2) Klasifikasi (totalis, parsialis, marginalis, atau low-lying placenta)
3) Kondisi ibu (stabil atau tidak stabil)
4) Kondisi janin (normal atau distres)
5) Masalah aktual dan potensial (anemia, syok, prematuritas)

e. Dokumentasi Plan (P)

Plan merupakan rencana asuhan dan Tindakan yang akan dilakukan.

Yang harus didokumentasikan:

1) Tindakan konservatif (tirah baring, monitoring)
2) Terapi yang diberikan (cairan, obat, kortikosteroid)
3) Rencana pemeriksaan lanjutan
4) Rencana persalinan (sectio caesarea)
5) Indikasi dan rencana rujukan

Penelitian menunjukan bahwa dokumentasi rencana yang jelas meningkatkan koordinasi antar tenaga kesehatan

f. Dokumentasi Implementasi

Setiap tindakan yang dilakukan harus dicatat secara rinci. Meliputi :

1) Waktu dan jenis tindakan
2) Pemberian terapi dan dosis obat
3) Tindakan emergensi yang dilakukan

4) Respons ibu dan janin terhadap tindakan

g. Dokumentasi Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk menilai perkembangan kondisi pasien. Hal yang dievaluasi:

1) Perubahan jumlah perdarahan
2) Stabilitas hemodinamik ibu
3) Kondisi janin (DJJ, Gerakan janin)
4) Respons terhadap terapi

Evaluasi berkelanjutan penting untuk mencegah perburukan

h. Dokumentasi Rujukan

Jika dilakukan rujukan, harus didokumentasikan secara lengkap. Meliputi :

1) Indikasi rujukan
2) Kondisi ibu dan janin saat dirujuk
3) Tindakan yang telah dilakukan
4) Waktu dan tempat rujukan
5) Pendamping selama rujukan

i. Format Dokumentasi

Dokumentasi pada kasus plasenta previa umumnya menggunakan :

1) SOAP (Subjective, Objective, Assessment, Plan)
2) Rekam medis terintegrasi
3) Partograf (jika dalam proses persalinan)

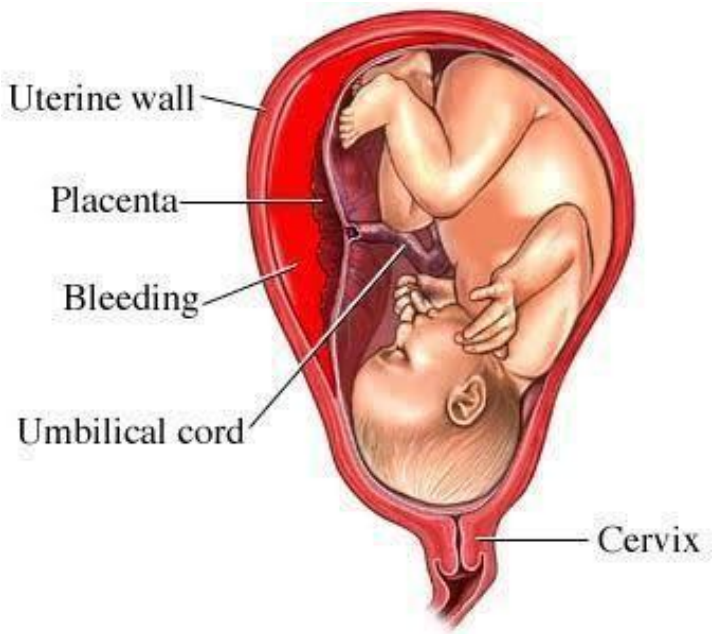
B. Solutio Plasenta

1. Definisi

Solutio plasenta adalah terlepasnya sebagian atau seluruh permukaan maternal plasenta dari tempat implantasinya yang normal pada lapisan desidua endometrium sebelum waktunya yakni sebelum anak lahir.

Solutio plasenta dalam bahasa inggris disebut concealed hemorrhage atau perdarahan tersembunyi dalam bahasa indonesia, pada solusio plasenta darah tersimpan dalam kavum uteri. hal ini disebabkan oleh lepasnya plasenta. plasenta dapat terlepas secara komplit (20% kasus) maupun inkomplit (80% kasus).

Solusio plasenta adalah terlepasnya sebagian atau keseluruhan plasenta dari implantasi normalnya (korpus uteri) setelah kehamilan 20 minggu dan sebelum janin lahir.



Gambar 5.1
Solutio Plasenta

Etiologi

Faktor resiko untuk solution plasenta adalah sebagai berikut :

a. Riwayat solution plasenta
b. Ketuban pecah preterm/korioamnionitis
c. Preeklampsia
d. Hipertensi kronik
e. Merokok
f. Pemakaianan kokain
g. Mioma dibelakang plasenta
h. Plasenta sirkumvalata

(Sawarno, 2013)

Penyebab primer belum diketahui pasti, namun ada beberapa faktor yang menjadi predisposisi

a. Faktor kardio-reno-vaskular

   Glomerulonefritis kronik, hipertensi esensial, sindroma preeklampsia dan eklampsia. pada penelitian di parkland ditemukan bahwa terdapat hipertensi pada separuh kasus solusio plasenta berat, dan separuh dari wanita yang hipertensi tersebut mempunyai penyakit hipertensi kronik, sisanya hipertensi yang disebabkan oleh kehamilan.

b. Faktor Trauma
   1) Dekompresi uterus pada hidramnion dan gemelli
   2) Tarikan pada tali pusat yang pendek akibat pergerakan janin yang banyak atau bebas, versi luar atau Tindakan pertolongan persalinan
   3) Trauma langsung, seperti jatuh dan lain-lain
c. Faktor Paritas Ibu

   Lebih banyak dijumpai pada multipara daripada primipara. beberapa penelitian menerangkan bahwa makin tinggi paritas ibu makin kurang baik keadaan endrometrium.
d. Faktor Usia

   Makin tua usia ibu, makin tinggi frekuensi hipertensi menahun.
e. Leiomioma uteri (uterine leiomyoma)

   Leiomioma uteri dapat menyebabkan solusio plasenta apabila plasenta berimplantasi di atas bagian yang mengandung leiomioma.
f. Faktor penggunaan kokain

   Penggunaan kokain mengakibatkan peninggian tekanan darah atau peningkatan pelepasan katekolamin yang bertanggung jawab atas terjadinya vasospasme pembuluh darah uterus dan berakibat terlepasnya plasenta. Namun, hipotesis ini belum terbukti secara deginitif
g. Faktor kebiasaan merokok

   Ibu yang merokok juga merupakan penyebab peningkatan kasus solusio plasenta sampai dengan 25% yaitu pada ibu yang merokok ≥ 1 bungkus perhari, ini dapat diterangkan sebagi berikut, pada ibu yang perokok plasenta menjadi tipis, diameter lebih luas, dan terdapat beberapa abnormalitas pada mikrosirkulasinya
h. Riwayat solution plasenta sebelumnya

   Bahwa resiko berulangnya kejadian ini pada kehamilan berikutnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan ibu hamil yang tidak memiliki riwayat solusio plasenta.
i. Pengaruh lain

   Seperti anemia, malnutrisi/defisiensi gizi, tekanan uterus pada vena kava inferior dikarenakan pembesaran ukuran uterus oleh adanya kehamilan, dan lain-lain.

Faktor Risiko

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa faktor risiko solusio plasenta berkaitan dengan gangguan vaskular, trauma, serta kondisi maternal yang memengaruhi perfusi uteroplasenta.

a. Riwayat Solusio Plasenta Sebelumnya
   1) Riwayat solusio plasenta merupakan faktor risiko paling kuat.
   2) Risiko kekambuhan meningkat pada kehamilan berikutnya.

   Mekanisme: Adanya kelainan vaskular uterus yang persisten meningkatkan kemungkinan terjadinya pelepasan plasenta kembali. Studi kohort menunjukkan peningkatan risiko berulang hingga beberapa kali lipat pada ibu dengan riwayat sebelumnya.
b. Hipertensi dalam kehamilan

   Termasuk hipertensi kronis, preeklampsia, dan eclampsia

   Mekanisme:
   1) Vasospasme arteri uteroplasenta
   2) Kerusakan endotel pembuluh darah
   3) Penurunan perfusi plasenta

   Penelitian menunjukan hipertensi merupakan faktor risiko utama yang paling sering ditemukan pada kasus solution plasenta
c. Trauma Abdomen

   Trauma akibat kecelakaan, jatuh, atau kekerasan

   Mekanisme: gaya mekanik menyebabkan pelepasan plasenta dari dinding uterus. Studi menunjukan trauma berhubungan signifikan dengan kejadian solution plasenta akut
d. Merokok dan penggunaan zat

   Termasuk merokok dan penggunaan kokain

   Mekanisme: vasokonstriksi pembuluh darah dan hipoksia jaringan plasenta. Meta analisis menunjukan peningkatan risiko solution plasenta pada ibu perokok
e. Usia Ibu Lanjut (≥ 35 tahun)

   Risiko meningkatkan pada usia maternal lanjut.

   Mekanisme: penurunan fungsi vascular dan degenerasi endometrium. Penelitian menunjukan hubungan antara usia ibu lanjut dan peningkatan kejadian solution plasenta.
f. Multiparitas

   Ibu dengan paritas tinggi memiliki risiko lebih besar. Mekanisme : perubahan struktur uterus dan penurunan elastisitas pembulu darah

g. Ketuban Pecah Dini (KPD)

   Pecahnya ketuban sebelum waktunya. Mekanisme: penurunan tekanan intrauterine secara tiba-tiba dan memicu pelepasan plasenta. Studi menunjukan KPD berhubungan dengan peningkatan risiko solution plasenta.

h. Kehamilan Ganda

   Risiko meningkat pada Kehamilan kembar. Mekanisme: peregangan uterus berlebihan dan perubahan tekanan intrauterine

i. Polihidramnion dan dekompresi uterus mendadak

   Pengeluaran cairan ketuban secara tiba-tiba. Mekanisme: perubahan tekanan intrauterine yang cepat dan memicu pelepasan plasenta.

j. Gangguan koagulasi

   Kelainan pembekuan darah dapat meningkatkan risiko. Mekanisme: perdarahan pada desisua basalis dan pembentukan hematoma retroplasenta

Patofisiologi

Sesungguhnya solusio plasenta merupakan hasil akhir dari suatu proses yang bermula dari suatu kaadaan yang mampu memisahkan vili-vili korialis plasenta dari tempat implantasinya pada desidua basalis sehingga terjadi perdarahan. Oleh karena itu patofisiologinya bergantung pada etiologi. Pada trauma abdomen etiologinya jelas karena robeknya pembuluh darah di desidua.

Dalam banyak kejadian perdarahan berasal dari kematian sel atau apoktosis yang disebabkan oleh iskemia dan hipoksia. Semua penyakit ibu yang dapat menyebabkan pembentukan thrombosis dalam pembuluh darah desidua atau dalam vascular vili dapat berujung kepada iskemia dan hipoksia setempat yang menyebabkan kematian sejumlah sel yang mengakibatkan perdarahan sebagai hasil akhir. Perdarahan tersebut menyebabkan desidua basalis terlepas kecuali selapisan tipis yang tetap melekat pada myometrium. Dengan demikian, pada tingkat permulaan sekali dari proses terdiri atas pembentukan hematom yang bisa menyebabkan pelapasan yang lebih luas, kompresi dan kerusakan pada bagian plasenta sekelilingnya yang berdekatan. Pada awalnya mungkin belum ada gejala kecuali terdapat hematom pada bagian belakang plasenta yang baru lahir. Dalam beberapa kejadian pembentukan hematom retroplasenta disebabkan oleh putusnya arteria spiralis dalam desidua hematoma retroplasenta mempengaruhi penyampaian nutrisi dan oksigen dari sirkulasi maternan atau plasenta ke sirkulasi janin. Hematoma yang terbentuk dengan cepat meluas dan melepaskan plasenta lebih luas atau banyak sampai kepinggir sehingga darah yang keluar merembes antara selaput ketuban dan myometrium untuk selanjutnya keluar melalui serviks ke vagina (revealed hemorrhage). Perdarahan tidak bisa berhenti Karena uterus yang lagi mengandung tidak mampu

berkontraksi untuk menjepit pembuluh arteria spiralis yang terputus. Walaupun jarang terdapat perdarahan tinggal terperangkap didalam uterus (choncealed hemorrhage).

Klasifikasi

Trijatmo rachimhadhi membagi solusio plasenta menurut derajat pelepasan plasenta. Solusio plasenta totalis (plasenta terlepas seluruhnya), solusio plasenta partialis (plasenta terlepas sebagian), ruptura sinus marginalis.

Pritchard JA membagi solusio plasenta menurut bentuk perdarahan, solusio plasenta dengan perdarahan keluar, solusio plasenta dengan perdarahan tersembunyi yang membentuk hematoma (retroplacenter), solusio plasenta yang perdarahannya masuk ke daman kantong amnion (sebagian kecil pinggir plasenta yang terlepas).

Plasenta dapat terlepas dari pinggirnya saja (rupture sinus marginalis), dapat pula terlepas lebih luas (solusio plasenta parsialis), atau bisa seluruh permukaan maternal plasenta terlepas (solusio plasenta totalis). Perdarahan yang terjadi dalam banyak kejadian akan merembes antara plasenta dan myometrium untuk seterusnya menyelinap dibawah selaput ketuban dan akhirnya memperoleh jalan ke kanalis servikalis dan keluar melalui vagina (revealed hemorrhage) akan tetapi ada kalanya walaupun jarang perdarahan tersebut tidak keluar melalui vagina (concealed hemorrhage).

a. Bagian plasenta sekitar perdarahan masih melekat pada dinding Rahim
b. Selaput ketuban masih melekat pada dinding Rahim
c. Perdarahan masuk ke dalam kantong ketuban setelah selaput ketuban pecah karenanya
d. Bagian terbawah janin, umumnya kepala, menempel ketat pada segemen bawah Rahim
e.

Solutio plasenta di bagi kedalam berat ringannya gambaran klinik sesuai dengan lausnya permukaan plasenta yang terlepas yaitu :

a. Plasenta tingkat ringan

   Luas plasenta yang terlepas tidak sampai 25% atau ada yang menyebutkan kurang dari 1/6 bagian. jumlah darah yang keluar biasanya kurang dari 250 ml berwarna kecoklatan. komplikasi pada ibu dan janin belum ada. hal 504 pada keadaan yang sangat ringan tidak ada gejala kecuali hematoma yang berukuran beberapa sentimeter terdapat pada permukaan maternal plasenta, rasa nyeri pada perut masih ringan dan darah yang keluar masih sedikit, tanda-tanda vital dan keadaan umum ibu ataupun janin masih baik, pada saat palpasi

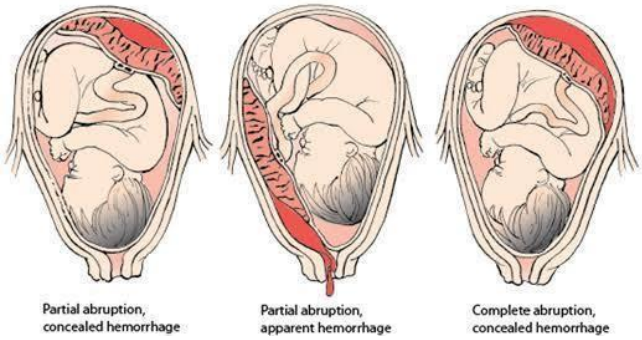
sedikit terasa nyeri lokal pada tempat terbentuknya hematoma dan perut sedikit tegang tapi bagian-bagian janin masih dapat dikenal.

b. Plasenta tingkat sedang

Luas plasenta yang terlepas telah melebihi 25% tetapi belum separuhnya (50%). Jumlah darah yang keluar lebih dari 250 ml tetapi belum mencapai 1.000 ml berwarna kehitaman. tanda dan gejala pada tingkat sedang sudah jelas seperti rasa nyeri pada perut terus menerus, denyut jantung janin biasanya telah menunjukan gawat janin, perdarahan tampak keluar lebih banyak, takikardia, hipotensi, kulit dingin dan berkeringat, oluguria mulai ada, nyeri dan tegang pada perut ketika dipalpasi, sulit menentukan bagian-bagian janin ketika leopold, rasa nyeri datangnya akut kemudian menetap tidak bersifat hilang timbul seperti pada his yang normal.

c. Plasenta tingkat berat

Luas plasenta yang terlepas telah melibihi 50%. jumlah darah yang keluar mencapi 1.000 ml atau lebih. tanda gejala pada tingkat berat ini diantaranya keadaan umum penderita buruk disertai syok, perut sangat nyeri dan tegang serta keras seperti papan disertai perdarahan berwarna hitam, rahim kelihatan membulat dan kulit diatasnya kencang dan mengkilat, denyut jantung janin tidak terdengar, hipofibrinogenemia dan oliguria.



Gambar 5.2
Macam-macam Solutio Plasenta

Tanda dan Gejala

Manifestasi klinis solusio plasenta terjadi akibat pelepasan sebagian atau seluruh plasenta dari dinding uterus sebelum persalinan, yang menyebabkan perdarahan dan gangguan perfusi uteroplasenta. Tanda dan gejala yang muncul dapat bervariasi tergantung derajat keparahan, namun secara umum memiliki karakteristik khas sebagai berikut:

a. Perdarahan Pervaginam Disertai Nyeri

Perdarahan merupakan gejala utama pada solusio plasenta, namun berbeda dengan plasenta previa, perdarahan pada kondisi ini biasanya disertai nyeri.

1) Darah berwarna merah tua
2) Dapat sedikit atau banyak (tergantung jenis solusio)
3) Nyeri abdomen menyertai perdarahan

Mekanisme: Perdarahan berasal dari pelepasan plasenta dan pembentukan hematoma retroplasenta. Penelitian menunjukan bahwa perdarahan dan nyeri merupakan tanda khas solusio plasenta.

b. Nyeri Abdomen Hebat dan Mendadak

Nyeri merupakan gejala penting pada solusio plasenta.

1) Nyeri muncul tiba-tiba
2) Bersifat terus-menerus (bukan hilang timbul)
3) Dapat menjalar ke punggung

Mekanisme : Iritasi myometrium akibat hematoma dan kontraksi uterus.

c. Uterus tegang dan nyeri tekan

Pada pemeriksaan abdomen ditemukan :

1) Uterus teraba keras (board-like uterus)
2) Nyeri tekan yang jelas
3) Tonus uterus meningkat

Studi menunjukkan bahwa peningkatan tonus uterus merupakan tanda penting pada solusio plasenta.

d. Perdarahan Tersembunyi (Concealed Hemorrhage)

Pada beberapa kasus, darah tidak keluar melalui vagina. Perdarahan terjadi di belakang plasenta dan tidak tampak perdarahan eksternal. Kondisi ini berbahaya karena dapat menyebabkan keterlambatan diagnosis.

e. Tanda Distres Janin

Gangguan perfusi plasenta dapat menyebabkan:

1) Penurunan denyut jantung janin
2) Pola abnormal pada CTG
3) Penurunan gerakan janin

Penelitian menunjukkan bahwa solusio plasenta sering berhubungan dengan hipoksia janin.

f. Tanda Syok Tidak Sesuai dengan Perdarahan

Pada kasus berat Ibu tampak syok (hipotensi, takikardia) dan jumlah darah yang keluar tidak mencerminkan kehilangan darah sebenarnya. Hal ini disebabkan oleh perdarahan tersembunyi.

g. Kontraksi Uterus yang Tidak Terkoordinasi

Kontraksi sering terjadi terus-menerus dan tidak relaksasi sempurna di antara kontraksi

Pemeriksaan Penunjang

Pemeriksaan penunjang pada solusio plasenta bertujuan untuk mendukung diagnosis klinis, menilai derajat keparahan, serta mengevaluasi kondisi ibu dan janin. Meskipun diagnosis solusio plasenta terutama bersifat klinis, pemeriksaan penunjang tetap memiliki peran penting dalam menentukan penatalaksanaan.

a. Ultrasonografi (USG)

Ultrasonografi digunakan sebagai pemeriksaan awal untuk mengevaluasi kondisi plasenta dan menyingkirkan diagnosis banding seperti plasenta previa.

Temuan yang dapat ditemukan:

1) Hematoma retroplasenta
2) Penebalan plasenta
3) Area hipoekoik di belakang plasenta

Keterbatasan:

1) Sensitivitas rendah dalam mendeteksi solusio plasenta ringan
2) Tidak semua kasus dapat terdeteksi

Penelitian menunjukkan bahwa USG lebih bermanfaat untuk menyingkirkan penyebab perdarahan lain dibandingkan menegakkan diagnosis definitif.

b. Kardiotokografi (CTG)

CTG digunakan untuk memantau kondisi janin secara kontinu. Tujuan:

1) Menilai denyut jantung janin
2) Mendeteksi distres janin.

Temuan:

1) Bradikardia janin
2) Variabilitas menurun
3) Deselerasi lambat

Gangguan perfusi plasenta pada solusio plasenta sering menyebabkan perubahan pola denyut jantung janin.

c. Pemeriksaan Laboratorium

Pemeriksaan laboratorium sangat penting untuk menilai kondisi ibu dan komplikasi yang mungkin terjadi. Jenis pemeriksaan:

1) Hemoglobin (Hb) dan hematokrit untuk menilai kehilangan darah
2) Golongan darah dan crossmatch untuk persiapan transfusi darah
3) Pemeriksaan koagulasi (PT, aPTT, fibrinogen) untuk deteksi gangguan koagulasi seperti DIC
4) Kadar fibrinogen untuk melihat penurunan kadar menunjukkan risiko perdarahan berat

Penelitian menunjukkan bahwa gangguan koagulasi sering terjadi pada solusio plasenta berat.

d. Pemeriksaan Fungsi Ginjal dan Elektrolit

Dilakukan pada kasus berat untuk menilai dampak sistemik. Tujuan:

1) Menilai perfusi organ
2) Deteksi komplikasi seperti gagal ginjal akut

e. Pemeriksaan Urinalisis

1) Untuk mendeteksi proteinuria (terkait preeklamsia)
2) Menilai kondisi penyerta yang dapat memperberat keadaan

Patofisiologi

Sesungguhnya solusio plasenta merupakan hasil akhir dari suatu proses yang bermula dari suatu kaadaan yang mampu memisahkan vili-vili korialis plasenta dari tempat implantasinya pada desidua basalis sehingga terjadi perdarahan. Oleh karena itu patofisiologinya bergantung pada etiologi. Pada trauma abdomen etiologinya jelas karena robeknya pembuluh darah di desidua.

Dalam banyak kejadian perdarahan berasal dari kematian sel atau apoktosis yang disebabkan oleh iskemia dan hipoksia. Semua penyakit ibu yang dapat menyebabkan pembentukan thrombosis dalam pembuluh darah desidua atau dalam vascular vili dapat berujung kepada iskemia dan hipoksia setempat yang menyebabkan kematian sejumlah sel yang mengakibatkan perdarahan sebagai hasil akhir. Perdarahan tersebut menyebabkan desidua basalis terlepas kecuali selapisan tipis yang tetap melekat pada myometrium. Dengan demikian, pada tingkat permulaan sekali dari proses terdiri atas pembentukan hematom yang bisa menyebabkan pelapasan yang lebih luas, kompresi dan kerusakan pada bagian plasenta sekelilingnya yang berdekatan. Pada awalnya mungkin belum ada gejala kecuali terdapat hematom pada bagian belakang plasenta yang baru lahir. Dalam beberapa kejadian pembentukan hematom retroplasenta disebabkan oleh putusnya arteria spiralis dalam desidua hematoma retroplasenta mempengaruhi penyampaian nutrisi dan oksigen dari sirkulasi maternan atau

plasenta ke sirkulasi janin. Hematoma yang terbentuk dengan cepat meluas dan melepaskan plasenta lebih luas atau banyak sampai kepinggir sehingga darah yang keluar merembes antara selaput ketuban dan myometrium untuk selanjutnya keluar melalui serviks ke vagina (revealed hemorrhage). Perdarahan tidak bisa berhenti Karena uterus yang lagi mengandung tidak mampu berkontraksi untuk menjepit pembuluh arteria spiralis yang terputus. Walaupun jarang terdapat perdarahan tinggal terperangkap didalam uterus (choncealed hemorrhage).

Komplikasi

koagulopati konsumtif, nekrosis tubulus dan korteks ginjal, dan atonia uteri yang menyebabkan perdarahan post partum.

a. Syok perdarahan

   Perdarahan antepartum dan intrapartum pada solusio plasenta hampir tidak dapat dicegah, kecuali dengan menyelesaikan persaliann segera. bila persalinan telah diselesaikan, penderita belum bebas dari perdarahan post partum karena kontraksi uterus yang tidak kuat untuk menghentikan perdarahan pada kala III. pada solusio plasenta berat keadaan syok sering tidak sesuai dengan jumlah perdarahan yang terlihat.

b. Gagal Ginjal

   Gagal ginjal merupakan komplikasi yang sering terjadi pada penderita solusio plasenta, pada dasarnya disebabkan oleh hipovolemia karna perdarahan terjadi. biasanya terjadi nekrosis tubuli ginjal yang mendadak, yang umumnya masih dapat ditolong dengan penanganan yang baik.

c. Kelainan Pembekuan Darah

   Kelainan pembekuan darah biasanya disebabkan oleh hipofibrinogenemia.

d. Apopkexi uteroplacental (uterus Couvelaire)

   Pada solusio plasenta yang berat terjadi perdarahan dalam otot rahim dan dibawah perimetrium kadang-kadang juga dalam ligamentum latum. perdarahan ini menyebabkan gangguan kontraktilitas uterus dan warna uterus berubah menjadi biru atau ungu yang biasanya disebut uterus convelaire.

   Komplikasi yang dapat terjadi pada janin antara lain, fetal distress, gangguan pertumbuhan atau perkembangan, hipoksia, anemia, kematian.

Penatalaksanaan

Pasien yang didiagnosis solution plasena harus dirawat inap di rumah sakit yang berfasiltas cukup. Ketika masuk segera dilakukan pemeriksaan darah lengkap termasuk kadar Hemoglobin dan golongan darah.

Pasien dengan kecurigaan solution plasenta dirujuk ke spesialis osbtetri dan ginekologi. Pilihan metode kelahiran pada kasus ini tergantung kepada kondisi ibu serta janin. Partus pervaginam dilakukan pada kondisi derajat pemisahan plasenta sedikit serta hasil CTG reassuring, derajat pemisahan plasenta luas tetapi janin sudah meninggal.

a. Solutio plasenta tingkat ringan

   Bila usia kehamilan kurang dari 36 minggu dan bila ada perbaikan (perdarahan berhenti, perut sakit, uterus tegang, janin hidup) dengan tirah baring dan observasi ketat, kemudian tunggu persalinan spontan.

   Bila ada perburukan (perdarahan belangsung terus, gejala plasenta makin lama makin jelas, pada pemantauan dengan USG daerah solution plasenta bertambah luas), maka kehamilan harus segera diakhiri. Bila janin hidup, lakukan section ceasarea, bila janin mati lakukan amniotomy kemudian infus oksitosin untuk mempercepat persalinan.

b. Solution plasenta tingkat sedang dan berat

   Apabila tanda dan gejala klinis solusio plasenta jelas ditemukan, penanganan dirumah sakit meliputi transfusi darah, amniotomi, infus oksitosin dan jika perlu SC. apabila diagnosis solusio plasenta dapat ditegakkan berarti perdarahan telah terjadi sekuarang-kuranagnya 1.000 ml, maka transfusi darah harus segera diberikan, amniotomi akan merangsang persalinan dan mengurangi tekanan intrauterin.

   Dengan melakukan persalinan secepatnya dan transfusi darah kelaian pembekuan darah dapat dicegah, persalian diharapkan dalam 6 jam sejak berlangsungnya solusio plasenta, tetapi jika tidak memungkin, walaupun sudah dilakukan amniotomi dan infus oksitosin, maka salah satunya cara adalah SC.

   Apoplexi uteroplacenta tidak merupakan indikasi histerektomi. tetapi jika perdarahan tidak dapat dikendalikan setelah SC maka histerektomi perlu dilakukan.

   1) Terapi Spesifik
      a) Atasi syok
         (1) Infus larutan NS/RL untuk restorasi cairan, berikan 500 ml dalam 15 menit pertama dan 2 L dalam 2 jam pertama
         (2) Berikan transfuse dengan darah segar untuk memperbaiki faktor pembekuan akibat koagulapati

b) Atasi anemia

(3) Darah segar merupakan bahan terpilih untuk mengatasi anemia karena disamping mengandung butir-butir darah merah, juga mengandung unsur pembekuan darah

(4) Bila restorasi cairan telah tercapai dengan baik tetapi pasien madih dalam kondisi anemia berat, berikan packed cell

2) Tindakan Obstetrik

a) Seksio Cesarea

(1) SC dilakukan apabila

(a) Janin hidup dan pembukaan belum lengkap

(b) Janin hidup, gawat janin tetapi persalinan pervaginanm tidak dapat dilaksanakan dengan segera

(c) Janin mati tetapi kondisi serviks tidak memungkinkan persalinan pervaginam dapat berlangung dalam waktu yang singkat.

- Persiapan untuk seksio sesarea, cukup dilakukan penanggulangan awal (stabilisasi dan tatalaksana komplikasi) dan segera lahirkan bayi karena operasi merupakan satu-satunya cara efektif untuk menghentikan perdarahan
- Hematoma myometrium tidak mengganggu kontraksi uterus
- Observasi ketat kemungkinan perdarahan ulang (koagulapati)

b) Partus Pervaginam

Partus pervaginam dilakukan apabila :

(1) Janin hidup, gawat janin, pembukaan lengkap dan bagian terendah didasar panggul

(2) Janin telah meninggal dan pembukaan serviks > 2 cm

(a) Amniotomi bila ketuban belum pecah kemudian percepat kala II dengan ekstraksi forceps atau vakum

(b) Lakukan amniotomy bila ketuban belum pecah kemudian akselerasi dengan 5 unit oksitosin dalam dekstrose 5% atau RL, tetesan diatur sesuai dengan kondisi kontraksi uterus

(c) Setelah persalinan, gangguan pembekuan darah akan membaik dalam waktu 24 jam, kecuali bila jumlah trombosit sangat rendah (perbaikan baru terjadi dalam 2-4 hari kemudian).

Asuhan Kebidanan

Asuhan kebidanan pada solusio plasenta merupakan tindakan komprehensif yang dilakukan secara cepat dan tepat untuk mencegah komplikasi serius pada ibu dan janin. Pendekatan asuhan meliputi pengkajian, diagnosis, perencanaan, implementasi, dan evaluasi secara berkesinambungan.

a. Pengkajian (Assessment)

Pengkajian dilakukan secara cepat dan menyeluruh untuk menilai kondisi ibu dan janin.

Data Subjektif

1) Keluhan utama: perdarahan pervaginam disertai nyeri abdomen
2) Waktu onset dan karakter nyeri (tiba-tiba, menetap)
3) Riwayat trauma atau hipertensi dalam kehamilan
4) Riwayat obstetri sebelumnya

b. Data Objektif

1) Tanda vital (tekanan darah, nadi, respirasi, suhu)
2) Keadaan umum ibu (pucat, gelisah, tanda syok)
3) Pemeriksaan abdomen (uterus tegang, nyeri tekan)
4) Denyut jantung janin (DJJ)
5) Hasil pemeriksaan penunjang (Hb, koagulasi, CTG)

Penelitian menunjukkan bahwa pengkajian cepat sangat penting dalam menentukan derajat keparahan dan tindakan segera.

c. Diagnosa Kebidanan

Diagnosis ditegakkan berdasarkan data klinis dan penunjang. Diagnosis yang mungkin:

1) Solusio plasenta
2) Perdarahan antepartum
3) Masalah aktual: syok hipovolemik, distres janin
4) Masalah potensial: DIC, kematian janin, gagal ginjal

d. Perencanaan Asuhan (Planning)

Perencanaan difokuskan pada stabilisasi ibu dan penyelamatan janin. Tujuan utama:

1) Menstabilkan kondisi hemodinamik ibu
2) Menghentikan atau mengendalikan perdarahan
3) Menjaga oksigenasi dan perfusi janin
4) Menentukan waktu dan metode persalinan

e. Implementasi (Tindakan Kebidanan)

1) Stabilisasi Ibu
2) Pemasangan jalur intravena besar
3) Pemberian cairan kristaloid
4) Persiapan dan pemberian transfusi darah
5) Pemberian oksigen

Penanganan awal yang cepat terbukti menurunkan risiko kematian maternal

f. Monitoring Intensif
   1) Pemantauan tanda vital secara berkala
   2) Observasi jumlah perdarahan
   3) Pemantauan DJJ atau CTG
   4) Evaluasi output urin
g. Kolaborasi Medis
   1) Kolaborasi dengan dokter spesialis obstetri
   2) Persiapan tindakan operatif (sectio caesarea)
   3) Persiapan penanganan komplikasi (DIC, syok)
h. Penatalaksanaan Persalinan
   1) Persalinan segera dilakukan pada kondisi berat
   2) Sectio caesarea menjadi pilihan utama pada janin hidup dengan kondisi gawat
   3) Persalinan pervaginam dapat dipertimbangkan pada kondisi tertentu (janin meninggal dan ibu stabil)

   Studi menunjukkan bahwa terminasi kehamilan tepat waktu sangat menentukan luaran ibu dan janin.
i. Evaluasi

   Evaluasi dilakukan secara kontinu untuk menilai respon terhadap tindakan. Yang dievaluasi:
   1) Stabilitas hemodinamik ibu
   2) Perubahan jumlah perdarahan
   3) Kondisi janin
   4) Respons terhadap terapi
j. Edukasi dan Konseling

   Edukasi diberikan kepada ibu dan keluarga mengenai:
   1) Kondisi kegawatdaruratan yang terjadi
   2) Tindakan yang akan dilakukan
   3) Risiko dan komplikasi
   4) Pentingnya penanganan segera di fasilitas kesehatan
k. Kolaborasi dan Rujukan

   Rujukan dilakukan jika fasilitas tidak memadai. **Prinsip rujukan:**
   1) Stabilisasi sebelum rujukan
   2) Pendampingan oleh tenaga kesehatan
   3) Komunikasi dengan fasilitas rujukan

   Penelitian menunjukkan bahwa rujukan cepat dan tepat dapat menurunkan angka kematian ibu dan janin.

l. Dokumentasi

Seluruh asuhan harus dicatat secara sistematis menggunakan format SOAP untuk menjamin kesinambungan pelayanan.

Red Flags dan Rujukan

Solusio plasenta merupakan salah satu kegawatdaruratan obstetri yang dapat mengancam keselamatan ibu dan janin. Oleh karena itu, identifikasi dini terhadap tanda bahaya (*red flags*) serta keputusan rujukan yang cepat dan tepat sangat penting dalam menurunkan angka morbiditas dan mortalitas.

a. Red Flags pada Solusio Plasenta

Red flags adalah tanda klinis yang menunjukkan kondisi gawat darurat dan memerlukan penanganan segera.

1) Nyeri Abdomen Hebat dan Mendadak
   a) Nyeri bersifat kontinu dan tidak hilang dengan istirahat
   b) Dapat menjalar ke punggung

   Menunjukkan iritasi miometrium akibat hematoma retroplasenta.
2) Perdarahan Pervaginam Disertai Nyeri
   a) Darah berwarna merah tua
   b) Dapat sedikit atau banyak
   c) Tidak selalu mencerminkan jumlah perdarahan sebenarnya

   Penelitian menunjukkan bahwa perdarahan pada solusio plasenta dapat bersifat tersembunyi *(concealed hemorrhage).*
3) Uterus Tegang dan Nyeri Tekan
   a) Uterus teraba keras *(board-like uterus)*
   b) Tonus uterus meningkat

   Merupakan tanda khas solusio plasenta berat.
4) Tanda Syok Hipovolemik
   a) Hipotensi
   b) Takikardia
   c) Kulit pucat, dingin, dan berkeringat
   d) Penurunan kesadaran

   Syok dapat terjadi meskipun perdarahan eksternal tampak sedikit.
5) Distres Janin
   a) Denyut jantung janin tidak normal
   b) Gerakan janin menurun
   c) Pola abnormal pada CTG

   Menunjukkan gangguan perfusi uteroplasenta.

6) Perdarahan Tersembunyi
   a) Tidak terdapat perdarahan pervaginam yang jelas
   b) Namun kondisi ibu memburuk

   Kondisi ini berisiko tinggi terlambat dikenali.
7) Gangguan Koagulasi (DIC)
   a) Perdarahan dari tempat lain (gusi, luka tusukan)
   b) Hasil laboratorium menunjukkan gangguan pembekuan

   Penelitian menunjukkan bahwa DIC merupakan komplikasi serius pada solusio plasenta.

b. Indikasi Rujukan

Rujukan harus dilakukan segera apabila ditemukan kondisi berikut:
1) Perdarahan sedang hingga berat
2) Tanda syok atau ketidakstabilan hemodinamik
3) Nyeri abdomen hebat dengan uterus tegang
4) Distres janin atau kematian janin intrauterin
5) Kecurigaan komplikasi (DIC, gagal ginjal)
6) Keterbatasan fasilitas pelayanan kesehatan

Studi menunjukkan bahwa rujukan yang cepat dan tepat berperan penting dalam menurunkan angka kematian ibu dan janin.

c. Prinsip Rujukan pada Solusio Plasenta

Rujukan harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keselamatan ibu dan janin.
1) Stabilisasi Sebelum Rujukan
   a) Pemasangan jalur intravena besar
   b) Pemberian cairan kristaloid
   c) Persiapan transfusi darah
   d) Pemberian oksigen
2) Monitoring Selama Rujukan
   a) Pemantauan tanda vital
   b) Observasi perdarahan
   c) Pemantauan kondisi janin (jika memungkinkan)
3) Pendampingan oleh Tenaga Kesehatan
   a) Pasien harus didampingi oleh tenaga kesehatan terlatih
   b) Membawa perlengkapan emergensi
4) Komunikasi dan Koordinasi
   a) Memberikan informasi kondisi pasien kepada fasilitas rujukan
   b) Menyampaikan tindakan yang telah dilakukan
   c) Memastikan kesiapan tempat rujukan

5) Dokumentasi Rujukan
   a) Indikasi rujukan
   b) Kondisi ibu dan janin saat dirujuk
   c) Tindakan yang telah dilakukan
   d) Waktu dan tempat rujukan

d. Edukasi Tanda Bahaya

Sebagai bagian dari asuhan kebidanan, ibu dan keluarga perlu diberikan edukasi mengenai:

1) Nyeri perut hebat
2) Perdarahan pervaginam
3) Penurunan gerakan janin
4) Pusing atau lemas

Edukasi ini penting untuk mempercepat pengambilan keputusan mencari pertolongan medis.

Dokumentasi

Dokumentasi pada kasus solusio plasenta merupakan bagian penting dari asuhan kebidanan yang berfungsi untuk menjamin kesinambungan pelayanan, mendukung pengambilan keputusan klinis, serta menjadi bukti legal dalam pelayanan kesehatan. Mengingat kondisi ini merupakan kegawatdaruratan obstetri, dokumentasi harus dilakukan secara cepat, akurat, dan berkesinambungan.

a. Prinsip Umum Dokumentasi

Dokumentasi harus memenuhi prinsip:

1) Akurat: sesuai kondisi klinis ibu dan janin
2) Lengkap: mencakup seluruh proses asuhan
3) Objektif: berdasarkan hasil pemeriksaan
4) Tepat waktu: dicatat segera setelah tindakan
5) Berkelanjutan: mengikuti perkembangan kondisi pasien

Penelitian menunjukkan bahwa dokumentasi yang sistematis dapat meningkatkan keselamatan pasien dan kualitas pelayanan.

b. Dokumentasi Data Subjektif (S)

Data subjektif diperoleh dari anamnesis singkat yang terarah. Hal yang harus didokumentasikan:

1) Keluhan utama: nyeri abdomen hebat disertai perdarahan
2) Waktu onset dan karakter nyeri (tiba-tiba, terus-menerus)
3) Riwayat trauma atau kejadian sebelumnya
4) Riwayat hipertensi atau preeklamsia
5) Riwayat obstetri (gravida, para, abortus)

c. Dokumentasi Data Objektif (O)

Data objektif diperoleh dari pemeriksaan fisik dan penunjang. Hal yang harus didokumentasikan:

1) Tanda vital (tekanan darah, nadi, respirasi, suhu)
2) Keadaan umum ibu (pucat, gelisah, tanda syok)
3) Pemeriksaan abdomen (uterus tegang, nyeri tekan)
4) Jumlah dan karakter perdarahan
5) Denyut jantung janin (DJJ)
6) Hasil CTG (jika tersedia)
7) Hasil laboratorium (Hb, hematokrit, koagulasi)

Studi menunjukkan bahwa pencatatan kondisi hemodinamik sangat penting dalam kasus kegawatdaruratan.

d. Dokumentasi Assessment (A)

Assessment merupakan interpretasi klinis berdasarkan data yang diperoleh. yang harus dituliskan:

1) Diagnosis kebidanan: solusio plasenta
2) Derajat keparahan (ringan, sedang, berat)
3) Kondisi ibu (stabil/tidak stabil)
4) Kondisi janin (normal, distres, atau IUFD)
5) Masalah aktual dan potensial (syok, DIC, gagal ginjal)

e. Dokumentasi Plan (P)

Plan mencakup rencana tindakan segera dan lanjutan. yang harus didokumentasikan:

1) Tindakan stabilisasi (infus, cairan, oksigen)
2) Persiapan transfusi darah
3) Rencana terminasi kehamilan
4) Kolaborasi dengan dokter spesialis
5) Rencana rujukan (jika diperlukan)

Penelitian menunjukkan bahwa dokumentasi rencana yang jelas membantu koordinasi tim medis dalam kondisi emergensi.

f. Dokumentasi Implementasi

Setiap tindakan harus dicatat secara rinci. Meliputi:

1) Waktu dan jenis tindakan
2) Terapi yang diberikan (cairan, obat, transfusi)
3) Tindakan emergensi yang dilakukan
4) Respons ibu dan janin terhadap tindakan

g. Dokumentasi Evaluasi

Evaluasi dilakukan secara kontinu untuk menilai efektivitas asuhan. Hal yang harus dicatat:

1) Perubahan kondisi hemodinamik ibu
2) Perubahan jumlah perdarahan
3) Perkembangan kondisi janin
4) Respons terhadap terapi

Evaluasi berkelanjutan penting untuk mendeteksi perburukan kondisi secara dini.

h. Dokumentasi Rujukan

Jika dilakukan rujukan, dokumentasi harus lengkap dan jelas. **Meliputi:**

1) Indikasi rujukan
2) Kondisi ibu dan janin saat dirujuk
3) Tindakan yang telah dilakukan
4) Waktu dan tempat rujukan
5) Pendamping selama rujukan

i. Format Dokumentasi

Dokumentasi pada kasus solusio plasenta umumnya menggunakan:

1) SOAP (Subjective, Objective, Assessment, Plan)
2) Rekam medis terintegrasi
3) Catatan emergensi kebidanan

C. Aktivitas 1 — *Knows How*

Mini-case tertulis (diskusi kelompok)

Kasus 1: Plasenta Previa

Seorang wanita, usia 33 tahun, G3P2A0, usia kehamilan 34 tahun, dating ke IGD dengan keluhan keluar darah dari jalan lahir sejak 1 jam yang lalu. Darah berwarna merah segar, keluar tiba-tiba, dan tidak disertai nyeri perut. Pasien mengatakan tidak ada riwayat trauma atau hubungan seksual sebelumnya. Pada pemeriksaan, tekahanan darah 110/70 mmHg, nadi 82 x/menit, dan uterus teraba lunak. Denyut Jantung Janin (DJJ) 142 x/menit. Bagian terbawah janin belum masuk panggul.

Pertanyaan Diskusi :

1. Apa diagnosis paling mungkin pada kasus di atas?

Sebutkan faktor risiko yang mungkin dimiliki pasien!

Mengapa pemeriksaan dalam (vaginal toucher) tidak dianjurkan pada kasus ini?

Apa pemeriksaan penunjang yang paling tepat untuk menegakkan diagnosis?

Bagaimana penanganan awal pada kasus ini?

Kapan pasien perlu dirujuk?

Kasus 2: Solusio Plasenta

Seorang perempuan usia 29 tahun G2P1A0, usia kehamilan 36 minggu, datang dengan keluhan nyeri perut hebat sejak 2 jam yang lalu disertai perdarahan dari jalan lahir. Pasien juga mengeluh janin terasa kurang bergerak. Riwayat hipertensi dalam kehamilan (+). Pada pemeriksaan, tekanan darah 150/100 mmHg, nadi 100 x/menit, uterus teraba tegang dan nyeri tekan. DJJ sulit didengar.

Pertanyaan Diskusi:

1. Apakah diagnosis paling mungkin pada kasus ini?

Apa factor risiko utama pada pasien ini?

Jelaskan perbedaan utama gejala kasus ini dengan plasenta previa?

Mengapa jumlah darah yang keluar tidak selalu mencerminkan kondisi sebenarnya?

Apa komplikasi yang dapat terjadi pada ibu dan janin?

Bagaimana penanganan awal pada kasus ini?

Soal OSCE Kebidanan

No.	Komponen	Isi
1	No. Stasiun	1
2	Judul	Kehamilan : Perdarahan Trimester I-III
3	Kasus	Ibu hamil dengan plasenta previa
4	Tujuan	Untuk mengetahui bahwa peserta dapat menunjukkan kriteria sebagai calon bidan yang kompeten dalam:
5	Kompetensi	1. Anamnesis 2. Pemeriksaan fisik dan/atau laboratorium sederhana 3. Perumusan diagnosis dan/atau masalah 4. Prosedur tindakan klinis 5. KIE/konseling 6. Kolaborasi/rujukan 7. Perilaku profesional
6	Soal: Skenario dan tugas peserta ujian	SKENARIO KLINIK Seorang perempuan, usai 30 tahun, G1P0A0, hamil 37 minggu. Datang ke puskemas PONED dengan keluhan perdarahan segar tanpa disertai nyeri. Hasil pemeriksaan: TD 120/80 mmHg, N 88 x//menit, P 24 x/menit, S 37,6°C, DJJ 138 x/menit, kepala janin masih tinggi. TUGAS 1. Lakukan anamnesis terarah sesuai kasus. 2. Lakukan pemeriksaan fisik/obstetri terfokus sesuai kasus. 3. Sampaikan diagnosis/masalah kebidanan berdasarkan data yang diperoleh. 4. Lakukan tindakan awal yang tepat pada kasus tersebut. 5. Berikan KIE singkat kepada ibu/keluarga dan jelaskan rencana kolaborasi/rujukan.
7	Instruksi penguji	INSTRUKSI UMUM 1. Pastikan identitas peserta ujian sesuai dengan kartu ujian. 2. Tulislah nomor peserta berdasarkan jumlah peserta yang ikut: a. Ujian institusi- 2 digit jika peserta berjumlah 01–99-3 digit jika peserta berjumlah 100–999-4 digit terakhir jika menggunakan NIM peserta b. Ujian nasional- 4 digit jika peserta berjumlah ribuan- atau 4 digit terakhir bila nomor mengikutkan kode area dan lebih dari 4 angka 3. Amati peserta dan beri penilaian pada lembar penilaian yang disesuaikan dengan format penilaian: - Actual mark (0/1/2/3) - Global rating (1/2/3/4) 4. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interaksi apa pun kepada peserta selain yang ditentukan. 5. Taatilah peraturan dan laksanakan tugas sebagai penguji OSCE. INSTRUKSI KHUSUS

No.	Komponen	Isi
		1. Jika peserta melakukan anamnesis dengan benar, PS menjawab sesuai dialog PS. 2. Jika peserta menyatakan akan melakukan palpasi abdomen/Leopold, penguji memberikan data:- TFU 34 cm- Punggung kiri- Presentasi kepala- Kepala 4/5 di atas PAP 3. Jika peserta meminta hasil pemeriksaan, penguji memberikan data:- terlihat perdarahan berwarna merah segar-tidak ada nyeri tekan- tidak ada kontraksi uterus 4. Tindakan awal yang diharapkan dari peserta meliputi:- Menilai ulang kondisi ibu dan janin secara cepat- Menjelaskan kondisi ibu secara singkat dan jelas- Memposisikan ibu miring kiri- Menyiapkan/memasang infus cairan sesuai kewenangan dan fasilitas- Melakukan pemantauan DJJ dan tanda vital- Menyiapkan kolaborasi/rujukan segera- Memberikan dukungan emosional dan KIE singkat 5. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi ataupun bertanya kepada peserta selain yang ditentukan. 6. Penguji memberikan data tambahan hanya jika diminta atau jika peserta melakukan langkah pemeriksaan yang sesuai. INSTRUKSI TAMBAHAN 1. Rapikan alat yang telah digunakan oleh peserta ujian seperti keadaan semula agar siap digunakan oleh peserta berikutnya. 2. Siapkan lembar baru untuk lembar habis pakai dan pastikan lembar yang sudah diisi peserta sebelumnya telah diambil dan diberi identitas peserta.
8	Kebutuhan dan instruksi PS	Instruksi PS: 9. PS berperan sebagai ibu hamil. 10. PS tampak cemas dan ketakutan akibat perdarahan yang dilihatnya. 11. Bila peserta memberikan penjelasan atau dukungan, PS merespons kooperatif. 12. Bila peserta menyampaikan bahwa ibu perlu dirujuk, PS tampak khawatir tetapi bersedia mengikuti arahan.
9	Dialog PS	Peserta: Selamat pagi/siang, Bu. PS: Pagi/siang, Bu. Peserta: Saya bidan yang akan memeriksa ibu. Apakah ibu bersedia? PS: Iya, Bu, saya bersedia. Peserta: Apa keluhan utama ibu? PS: Saya tadi malam buang air kecil, tiba-tiba melihat darah segar keluar dari jalan lahir saya, tapi saya tidak merasakan sakit bu. Saya sangan khawatir dengan janin saya. Peserta: Sejak kapan darah keluar ? PS: Kira-kira sudah 10 jam, Bu.

No.	Komponen	Isi
		Peserta: Apakah darahnya keluar terus menerus dan banyak? PS: darah keluar pertama pada saat saya buang air kecil semalam setelah itu darah keluar sedikit-sedikit bila saya banyak bergerak dan beraktivitas. Peserta: Apakah ibu merasa nyeri dan kencang-kencang pada perut ibu? PS: tidak bu. Peserta: Apakah ibu merasa pusing ? PS: tidak, Bu. Peserta: Bagaimana gerakan bayi? PS: Bayi sering bergerak, Bu. Peserta: Ini kehamilan yang ke berapa? PS: Ini kehamilan pertama saya, Bu. Peserta: Ada riwayat keguguran, operasi, atau penyakit lain? PS: Tidak ada, Bu. Peserta: Ibu, dilihat dari tanda dan gejala yang ibu alami kemungkinan ibu mengalami perleketan ari-ari atau plasenta ibu dibagian bawah, sehingga ketika kepala janin mulai turun dan menekan kebawah, plasenta ibu bisa bergeser dan menimbulkan perdarahan, biasanya dalam kebidanan dikatankan plasenta previa PS: Baik, Bu, tolong bantu saya dan bayi saya ya. Peserta: Saya akan melakukan tindakan awal dan menyiapkan rujukan. PS: Iya, Bu. Catatan: Jika ada pertanyaan lain terkait riwayat penyakit, riwayat obstetri-ginekologi, sosial, spiritual, ekonomi, dan ADL, PS memberi jawaban normatif dan tidak mengarah ke diagnosis lain.
10	Kebutuhan manikin	-Phantom abdomen hamil/manekin Leopold - Phantom panggul/serviks untuk simulasi melihat darah yang keluar
11	Kebutuhan laboran	Peran laboran: - Menyiapkan dan merapikan kembali alat serta manikin - Mengganti lembar lembar instruksi bila diperlukan - Memastikan set station siap digunakan peserta berikutnya
12	Kebutuhan alat	1. Tempat tidur/periksa — 1 2. Phantom abdomen hamil/manekin Leopold — 1 3. Phantom panggul/serviks — 1 4. Tensimeter — 1 5. Stetoskop — 1 6. Doppler/Pinard — 1 7. Jam tangan/stopwatch — 1 8. Termometer — 1 10. Sarung tangan bersih — 1 pasang 11. Handrub — 1 botol 12. Kain penutup/selimut — 1 13. Tisu — 1 pack

No.	Komponen	Isi
		14. Infus set dummy — 1 set 15. Cairan RL/NaCl dummy — 1 16. Abocath dummy — 1 17. Formulir rujukan — 1 lembar 18. Lembar jawaban peserta — 1 lembar 19. Pena — 1
13	Penulis	.....
14	Referensi	1. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Standar profesi bidan: Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/320/2020. 2. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Standar kompetensi kerja bidang kebidanan: Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1261/2022. 3. World Health Organization. (2008). Education material for teachers of midwifery: Midwifery education modules (2nd ed.): Managing prolonged and obstructed labour. 4. World Health Organization. (2018). WHO recommendations: Intrapartum care for a positive childbirth experience.

RUBRIK PENILAIAN DAN KELULUSAN

Stase 1: Perdarahan Kehamilan Trimester II-III

KOMPETENSI 1. Pengumpulan Data Subjektif

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Keluhan utama		
2. Riwayat perdarahan (sejak kapan keluar dara, pola perdarahan)		
3. Riwayat nyeri dan kontraksi (ada/tidak)		
4. Gerak janin		
5. Rasa cemas dan ketakutan		
6. Riwayat obstetri (GPA, usia kehamilan, ANC, persalinan sebelumnya bila ada)		
7. Riwayat kesehatan/komplikasi kehamilan/operasi/alergi/obat-obatan		
8. Aktivitas harian yang relevan dengan kondisi saat ini (asupan makan-minum, BAK terakhir, kelelahan, dukungan keluarga)		

Skoring KOMPETENSI 1

- 3= Jika peserta ujian melakukan semua 8 langkah dengan benar.
- 2= Jika peserta melakukan 5–7 dari 8 langkah dengan benar.
- 1= Jika peserta melakukan 1–4 dari 8 langkah dengan benar.
- 0= Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

KOMPETENSI 2. Prosedur Tindakan Klinis

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Persiapan		
a. Menyapa klien dengan sopan dan ramah		
b. Memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan tindakan		
c. Memastikan klien memahami prosedur dan meminta persetujuan		
d. Menjaga privasi ibu		
e. Mencuci tangan/hand hygiene		
f. Menyiapkan alat yang diperlukan		
2. Langkah-langkah		
a. Menilai keadaan umum dan kesadaran ibu		
b. Menilai tanda vital ibu		
c. Menilai nyeri dan kontraksi		
d. Menilai DJJ		
e. Menilai pengeluaran darah pervaginam		
f. Melakukan pemeriksaan obstetri terfokus atau meminta data yang relevan sesuai kewenangan station		
g. Menyimpulkan adanya plasenta previa		

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
h. Memposisikan ibu miring kiri		
i. Menyiapkan/memasang infus cairan sesuai kewenangan dan fasilitas		
j. Melakukan pemantauan ulang kondisi ibu dan janin		
k. Menyiapkan kolaborasi/rujukan segera dan aman		
3. Pasca tindakan		
a. Menjelaskan hasil tindakan awal dan rencana lanjutan		
b. Mencatat temuan penting pada catatan medis/form rujukan		
c. Mencuci tangan kembali dan merapikan alat/ibu		

Skoring KOMPETENSI 2

- 3= Jika peserta ujian melakukan 15–19 langkah dengan tepat dan sistematis.
- 2= Jika peserta melakukan 10–14 langkah dengan tepat, atau semua langkah dilakukan tetapi sebagian kecil tidak tepat.
- 1= Jika peserta melakukan 1–9 langkah dengan tepat, atau semua langkah dilakukan tetapi sebagian besar tidak tepat.
- 0= Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun, atau semua langkah dilakukan tetapi tidak tepat.

KOMPETENSI 3. KIE/Konseling

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Sapa dan salam		
2. Menjelaskan hasil pemeriksaan dan kondisi ibu/janin dengan bahasa sederhana		
3. Menjelaskan tindakan awal yang sedang/akan dilakukan		
4. Menjelaskan perlunya kolaborasi/rujukan segera		
5. Menenangkan ibu dan melibatkan keluarga/pendamping		
6. Memberi kesempatan bertanya dan menjawab pertanyaan dengan jelas		

Skoring KOMPETENSI 3

- 3= Jika peserta ujian melakukan semua 6 langkah dengan benar.
- 2= Jika peserta melakukan 4–5 dari 6 langkah dengan benar.
- 1= Jika peserta melakukan 1–3 dari 6 langkah dengan benar.
- 0= Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

KOMPETENSI 4. Perilaku Profesional

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Melaksanakan secara sistematis		
2. Menjaga privasi dan keselamatan pasien		
3. Memberikan perhatian terhadap respons ibu selama kontraksi/nyeri		
4. Suara lantang, jelas, tenang, dan informatif		
5. Percaya diri dan tidak ragu-ragu		

Skoring KOMPETENSI 4

- 3= Jika peserta ujian melakukan semua 5 langkah dengan benar.
- 2= Jika peserta melakukan 4 dari 5 langkah dengan benar.
- 1= Jika peserta melakukan 1–3 dari 5 langkah dengan benar.
- 0= Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

TOTAL SKOR DAN KELULUSAN

TOTAL SKOR = jumlah skor kompetensi 1 + 2 + 3 + 4 / 3

(dicatat di rubrik penilaian)

IV. Global Performance

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

$$\text{Nilai akhir} = \frac{\text{Jumlah total skore}}{30} \times 100 =$$

(Kota), ...

.....

Penguji :.....

Contoh Penerapan Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) pada Kegawatdaruratan Persalinan: Partus Lama, Distosia, dan Tindakan Awal

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Plasenta Previa
Metode penilaian	DOPS merupakan penilaian berbasis observasi langsung terhadap keterampilan prosedural. Penilai mengamati tindakan yang dilakukan peserta, lalu memberikan umpan balik segera setelah prosedur selesai. Domain yang lazim dinilai mencakup informed consent, persiapan pra-tindakan, kemampuan teknis, komunikasi, profesionalisme, dan keselamatan pasien.	Pembimbing mengamati secara langsung bagaimana mahasiswa melakukan penilaian awal pada ibu inpartu dengan kemajuan persalinan tidak memuaskan, lalu menilai keterampilan mahasiswa saat melakukan tindakan awal kegawatdaruratan dan menyiapkan rujukan.
Tujuan penilaian	Tujuan DOPS pada topik ini adalah menilai kemampuan mahasiswa melakukan tindakan awal yang aman, cepat, dan sistematis pada plasenta previa, dengan tetap berpusat pada keselamatan ibu dan janin serta penghormatan pada asuhan yang bermartabat. WHO menekankan pentingnya asuhan antepartum yang evidence-based, woman-centred, dan pemantauan kehamilan yang baik.	Mahasiswa tidak hanya dinilai dari pengetahuannya tentang plasenta previa, tetapi dari kemampuannya menilai kondisi ibu-janin, membaca data kemajuan kehamilan, melakukan stabilisasi awal, dan menjelaskan kebutuhan kolaborasi atau rujukan.
Kasus klinik	Kasus dipilih dari situasi nyata di lahan praktik yang sesuai dengan capaian pembelajaran profesi bidan, khususnya pengenalan prolonged atau obstructed labour, identifikasi tanda bahaya, dan pengambilan keputusan awal.	Seorang perempuan, usai 30 tahun, G1P0A0, hamil 37 minggu. Dating ke puskemas PONED dengan keluhan perdarahan segar tanpa disertai nyeri. Hasil pemeriksaan: TD 120/80 mmHg, N 88 x//menit, P 24 x/menit, S 37,6°C, DJJ 138 x/menit, kepala janin masih tinggi.
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Pada DOPS, mahasiswa diamati saat melakukan prosedur atau rangkaian tindakan klinik tertentu, bukan sekadar berdiskusi tentang kasus. Pada topik ini, keterampilan yang relevan antara lain menilai keadaan umum ibu, tanda vital, DJJ, menilai penurunan kepala, serta melakukan tindakan awal seperti posisi miring kiri, menyiapkan infus, menjaga keseimbangan cairan, dan	Mahasiswa memperkenalkan diri, meminta persetujuan, menilai kondisi ibu dan janin, membaca hasil pengkajian, menyimpulkan adanya plasenta previa, memposisikan ibu miring kiri, menyiapkan cairan intravena, lalu menjelaskan perlunya rujukan segera.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Plasenta Previa
	menyiapkan rujukan. WHO juga mencantumkan keterampilan seperti menilai penurunan kepala, mengenali obstructed labour, memasang dan memantau infus, menjaga keseimbangan cairan, serta pencatatan sebagai keterampilan penting.	
Aspek yang dinilai	Aspek yang dinilai meliputi pemahaman indikasi tindakan, persetujuan tindakan, persiapan pra-prosedur, kemampuan teknis, komunikasi, kemampuan mencari bantuan ketika diperlukan, rencana pascatindakan, dan profesionalisme. Pada konteks obstetri, aspek ini juga mencakup ketepatan mengenali tanda plasenta previa dan ketepatan keputusan eskalasi.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menghubungkan perarahan merah segar, tidak ada nyeri tekan, kepala masih tinggi, tidak ada kontraksi uterus, ibu terlihat cemas dan ketakutan, dan DJJ meningkat sebagai tanda bahwa ibu tersebut perlu dilakukan rujukan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Fokus observasi pembimbing	Fokus observasi pembimbing adalah mutu performa nyata mahasiswa saat melakukan tindakan awal. Pada persalinan lama atau obstruktif, WHO menekankan identifikasi tanda, dan langkah penanganan yang efektif.	Pembimbing memperhatikan apakah mahasiswa cepat mengenali kondisi gawat, melakukan prioritas tindakan dengan urutan yang benar, menghindari intervensi yang tidak aman, serta segera meminta bantuan atau menyiapkan rujukan.
Umpan balik	Umpan balik dalam DOPS diberikan segera setelah observasi dan berisi apa yang sudah efektif serta apa yang perlu diperbaiki. Form DOPS juga menekankan komentar assessor mengenai kekuatan, area yang perlu ditingkatkan, dan rencana perbaikan.	Pembimbing dapat menyampaikan bahwa mahasiswa sudah baik dalam komunikasi dan membaca hasil pengkajian, tetapi masih perlu meningkatkan ketegasan saat memutuskan eskalasi, ketelitian dalam menilai penurunan kepala, atau kelengkapan penjelasan kepada keluarga.
Keputusan penilaian	Dalam buku ajar ini, hasil DOPS dapat diringkas menjadi kompeten, perlu supervisi, atau remedial. Keputusan ditetapkan berdasarkan ketepatan langkah, keselamatan pasien, komunikasi, dan kemampuan mengambil keputusan awal.	Mahasiswa dinyatakan kompeten apabila mampu melakukan tindakan awal secara runtut, aman, dan tepat. Mahasiswa dinyatakan perlu supervisi apabila langkah utama sudah benar tetapi masih memerlukan arahan. Mahasiswa dinyatakan remedial apabila gagal mengenali kegawatan,

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Plasenta Previa
		salah menentukan prioritas, atau tidak menyiapkan eskalasi dengan benar.
Makna dalam OBE	DOPS memberikan bukti autentik bahwa mahasiswa mampu menunjukkan capaian pembelajaran pada level does karena performanya diamati langsung saat melakukan tindakan klinik. Observasi langsung pada pasien nyata dan umpan balik segera menjadikan DOPS sangat sesuai untuk pembelajaran berbasis kompetensi.	Pada kasus partus lama dan distosia, mahasiswa dinilai bukan hanya memahami teori, tetapi mampu menerapkan tindakan awal kegawatdaruratan persalinan secara langsung, aman, cepat, dan profesional di lahan praktik.

Portofolio

Bukti yang dikumpulkan

1. OSCE + DOPS

Catatan kasus singkat

Refleksi patient safety

Feedback CI/dosen

Catatan untuk penulis:

1. Bukan sekali ujian

Bukti konsistensi kompetensi

Tabel 5.2
Portofolio pada Perdarahan Kehamilan Trimester II-III Plasenta Previa-Solutio Plasenta-Penangan Awal-Rujukan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Plasenta Previa
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam OBE, portofolio digunakan untuk menilai performa nyata mahasiswa dari waktu ke waktu, bukan hanya dari satu kali ujian.	Pada topik plasenta previa, portofolio memuat bukti bahwa mahasiswa mampu melakukan pengkajian kehamilan, menilai kemajuan kehamilan dengan profesional, mengenali tanda bahaya ibu dan janin, melakukan tindakan awal, serta memperbaiki performa berdasarkan umpan balik.
Tujuan portofolio	Portofolio bertujuan mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, dan tindak lanjut perbaikan mahasiswa selama praktik.	Mahasiswa tidak hanya menunjukkan bahwa ia pernah menangani ibu hamil dengan plasenta previa, tetapi juga menunjukkan bagaimana kemampuannya berkembang setelah mendapat masukan dari dosen atau CI.
OSCE dan DOPS	OSCE dan DOPS dapat menjadi bagian penting dalam portofolio karena memberikan bukti keterampilan terstruktur di laboratorium dan bukti performa nyata di lahan praktik.	OSCE dapat memuat hasil ujian keterampilan interpretasi 198rofession, pengenalan plasenta previa, dan tindakan awal pra-rujukan. DOPS memuat hasil observasi langsung saat mahasiswa melakukan penilaian ibu hamil,

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Plasenta Previa
		stabilisasi awal, dan persiapan rujukan pada kasus plasenta previa di Puskesmas.
Catatan kasus singkat	Catatan kasus singkat berisi ringkasan kasus pasien yang pernah ditangani mahasiswa, data penting, masalah kebidanan, tindakan utama, dan hasil yang dicapai.	Mahasiswa menuliskan ringkasan kasus perempuan, usai 30 tahun, G1P0A0, hamil 37 minggu. Datang ke puskemas PONED dengan keluhan perdarahan segar tanpa disertai nyeri. Hasil pemeriksaan: TD 120/80 mmHg, N 88 x//menit, P 24 x/menit, S 37,6°C, DJJ 138 x/menit, kepala janin masih tinggi tindakan awal yang dilakukan, dan keputusan rujukan.
Refleksi patient safety	Refleksi patient safety menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi kesalahan, dan menyusun langkah pencegahan dalam asuhan kebidanan.	Mahasiswa merefleksikan pentingnya tidak menunda pengenalan persalinan tidak maju, ketelitian membaca 199rofession, pemantauan DJJ, pencegahan keterlambatan rujukan, dan komunikasi cepat dengan keluarga pada kasus plasenta previa.
Feedback CI/dosen	Umpan balik dari Clinical Instructor (CI) atau dosen menjadi bukti pembinaan yang menunjukkan area kekuatan dan area yang masih perlu ditingkatkan.	CI menuliskan bahwa mahasiswa sudah baik dalam mengenali partus lama dan menjelaskan rujukan, tetapi masih perlu meningkatkan ketelitian dalam menilai perdarahan, nyeri, kontraksi, dan ketegasan saat melakukan eskalasi.
Karakteristik penilaian	Portofolio bukan penilaian sekali selesai, tetapi kumpulan bukti yang dibangun secara berulang dan berkesinambungan. Penekanan utamanya adalah konsistensi performa mahasiswa.	Mahasiswa dinilai bukan hanya dari satu kasus plasenta previa, tetapi dari beberapa pengalaman belajar yang menunjukkan bahwa ia konsisten mampu menilai kemajuan kehamilan, mengenali plasenta previa, dan melakukan tindakan awal secara aman.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Plasenta Previa
Bukti konsistensi kompetensi	Portofolio memperlihatkan apakah mahasiswa mampu mempertahankan mutu performa pada berbagai kesempatan praktik dan pada waktu yang berbeda.	Dari hasil OSCE, DOPS, catatan kasus, refleksi, dan umpan balik, terlihat bahwa mahasiswa secara konsisten mampu menggunakan 200rofession, mengenali tanda bahaya, dan mengambil keputusan awal yang tepat pada kehamilan bermasalah.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, portofolio memberikan bukti autentik bahwa capaian pembelajaran tidak hanya dimiliki secara teoritis, tetapi benar-benar tampak dalam performa yang berulang, berkembang, dan terdokumentasi.	Pada topik plasenta previa, portofolio menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya paham konsep, tetapi juga konsisten mampu menerapkannya dalam praktik kebidanan nyata.

Tabel 5.3
Case Report pada Perdarahan Kehamilan Trimester II-III Plasenta Previa-Solutio Plasenta-Penangan Awal-Rujukan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Plasenta Previa
Hakikat case report	Case report merupakan laporan singkat dan sistematis tentang satu kasus pasien yang ditangani mahasiswa selama praktik klinik. Dalam OBE, case report berfungsi sebagai bukti kemampuan mahasiswa dalam memahami, menganalisis, dan mendokumentasikan kasus secara ilmiah dan klinis.	Mahasiswa menyusun laporan singkat tentang seorang ibu hamil primigravida dengan plasenta previa
Tujuan	Case report bertujuan menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan data pengkajian, masalah kebidanan, rencana tindakan, implementasi, dan evaluasi hasil asuhan.	Mahasiswa tidak hanya menuliskan data ibu, tetapi juga menjelaskan masalah prioritas, tindakan awal yang diberikan, 200rofess rujukan, dan perkembangan kondisi ibu serta janin setelah intervensi awal.
Isi laporan	Isi case report biasanya mencakup identitas singkat pasien, keluhan utama, data subjektif dan objektif, analisis masalah, diagnosis/masalah kebidanan,	Pada kasus ini, mahasiswa menuliskan perdarahan berwarna merah segar, tidak ada nyeri, tidak kontraksi, DJJ 138 x/menit, analisis

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Plasenta Previa
	tindakan, implementasi, evaluasi, dan pembelajaran dari kasus.	plasenta previa, tindakan awal stabilisasi, dan keputusan rujukan.
Fokus penilaian	Penilaian difokuskan pada ketepatan pengkajian, relevansi analisis masalah, logika penalaran klinik, ketepatan tindakan awal, dan kemampuan mengevaluasi hasil asuhan.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menghubungkan kemajuan kehamilan yang tidak memuaskan, perdarahan berwarna merah segar, tidak ada nyeri, tidak ada kontraksi kepala yang belum turun, sebagai kondisi yang memerlukan tindakan awal dan rujukan segera.
Nilai edukatif	Case report membantu mahasiswa mengembangkan clinical reasoning, keterampilan dokumentasi, dan kebiasaan merefleksikan praktik klinik secara ilmiah.	Dari kasus plasenta previa, mahasiswa belajar bahwa 201rofession, pemantauan ibu-janin, dan keputusan eskalasi dini merupakan inti keselamatan dalam asuhan kehamilan.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, case report menjadi bukti bahwa mahasiswa mampu menerapkan teori ke dalam analisis kasus nyata secara sistematis dan bertanggung jawab.	Mahasiswa menunjukkan bahwa ia tidak hanya memahami konsep plasenta previa, tetapi juga mampu menyusun laporan kasus yang menggambarkan asuhan kebidanan secara utuh.

Tabel 5.4
Refleksi Patient Safety pada Perdarahan Kehamilan Trimester II-III Plasenta Previa-Solutio Plasenta-Penanganan Awal-Rujukan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Plasenta Previa
Hakikat refleksi patient safety	Refleksi patient safety merupakan tulisan singkat yang menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi masalah, dan merencanakan tindakan pencegahan.	Pada kasus plasenta previa, mahasiswa merefleksikan bahwa keterlambatan mengenali perarahan dapat menyebabkan perburukan kondisi ibu dan janin.
Tujuan	Refleksi ini bertujuan menumbuhkan kesadaran mahasiswa bahwa keselamatan pasien merupakan bagian penting dari setiap tindakan kebidanan.	Mahasiswa memahami bahwa kesalahan kecil, seperti salah membaca 201rofession, tidak memantau DJJ dengan cermat, atau menunda rujukan,

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Plasenta Previa
		dapat berdampak besar pada keselamatan ibu dan bayi.
Fokus refleksi	Fokus refleksi meliputi identifikasi risiko, analisis penyebab, tindakan pencegahan, dan pembelajaran yang diperoleh mahasiswa dari pengalaman klinik.	Mahasiswa menuliskan bahwa risiko utama pada kasus ini adalah obstructed labour, gawat janin, kelelahan ibu, infeksi, dan keterlambatan penanganan bila peradarahn tidak dipantau dengan benar.
Risiko yang diidentifikasi	Mahasiswa perlu menunjukkan kemampuan mengenali situasi yang berpotensi membahayakan pasien.	Risiko yang dapat diidentifikasi antara lain keterlambatan diagnosis plasenta previa, salah menilai nyeri dan kontraksi, penurunan kepala, pemantauan DJJ yang tidak adekuat, penggunaan stimulasi perdarahan yang tidak tepat, dan keterlambatan rujukan.
Tindakan pencegahan	Mahasiswa menjelaskan langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko keselamatan pasien.	Mahasiswa menuliskan pentingnya penggunaan 202rofession secara konsisten, pemantauan tanda vital dan DJJ, stabilisasi awal ibu, komunikasi cepat kepada keluarga, dan rujukan tepat waktu ke fasilitas yang lebih mampu.
Pembelajaran mahasiswa	Refleksi harus menunjukkan apa yang dipelajari mahasiswa dan bagaimana hal itu akan memengaruhi praktik berikutnya.	Mahasiswa menyadari bahwa pada plasenta previa, pengkajian serial, pengambilan keputusan cepat, dan keberanian melakukan eskalasi adalah bagian penting dari praktik bidan yang aman.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, refleksi patient safety menunjukkan perkembangan sikap 202rofessional, tanggung jawab klinik, dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa terhadap keselamatan pasien.	Mahasiswa membuktikan bahwa ia tidak hanya melakukan tindakan, tetapi juga mampu mengevaluasi risiko dan meningkatkan kualitas praktik kebidanan secara berkelanjutan.

D. Ringkasan Materi

Perdarahan Trimester II-III merupakan penyebab utama kematian ibu di Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya. Perdarahan ini terjadi setelah kehamilan mencapai usia 20 minggu dan sebelum persalinan dimulai, dengan dua penyebab tersering yaitu plasenta previa dan solutio plasenta. Menurut laporan Profil Kesehatan Indonesia 2023, angka kematian ibu (AKI) di Indonesia masih berada pada angka 189 per 100.000 kelahiran hidup, dengan perdarahan sebagai kontribusi signifikan. Kondisi ini menunjukan bahwa penanganan dan pencegahan perdarahan trimester II-III masih menjadi tantangan serius dalam sistem pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Plasenta previa adalah plasenta yang berimplantasi pada segmen bawah rahim (SBR) sehingga menutupi seluruh atau sebagian dari "*Ostium Uteri Internum* (OUI)." Seiring dengan pertumbuhan rahim dan ekspansi segmen bawah rahim menuju ke bagian atas, plasenta yang terimplan di segmen bawah rahim bisa berpindah mengikuti perkembangan tersebut, seolah-olah melakukan perpindahan tempat yang disebut migrasi.

Solutio plasenta adalah terlepasnya sebagian atau seluruh permukaan maternal plasenta dari tempat implantasinya yang normal pada lapisan desidua endometrium sebelum waktunya yakni sebelum anak lahir. Solutio plasenta dalam bahasa inggris disebut concealed hemorrhage atau perdarahan tersembunyi dalam bahasa indonesia, pada solusio plasenta darah tersimpan dalam kavum uteri. hal ini disebabkan oleh lepasnya plasenta. Solusio plasenta adalah terlepasnya sebagian atau keseluruhan plasenta dari implantasi normalnya (korpus uteri) setelah kehamilan 20 minggu dan sebelum janin lahir.

Pada penderita plasenta previa yang datang dengan keluhan adanya perdarahan pervaginam pada saat kehamilan trimester II dan trimester III. Penanganan plasenta previa dapat dibagi dalam 2 golongan yaitu terapi ekspektatif (pasif) dan terapi aktif. Sedangkan pasien yang didiagnosis solution plasena harus dirawat inap di rumah sakit yang berfasiltas cukup. Ketika masuk segera dilakukan pemeriksaan darah lengkap termasuk kadar Hemoglobin dan golongan darah. Pasien dengan kecurigaan solution plasenta dirujuk ke spesialis osbtetri dan ginekologi. Pilihan metode kelahiran pada kasus ini tergantung kepada kondisi ibu serta janin. Partus pervaginam dilakukan pada kondisi derajat pemisahan plasenta sedikit serta hasil CTG reassuring, derajat pemisahan plasenta luas tetapi janin sudah meninggal.

E. Alur asuhan singkat

Ibu hamil dengan perdarahan pada kehamilan trimester II-III → nilai cepat ibu dan janin → telaah hasil pengkajian dan hasil pemeriksaan → identifikasi kemungkinan plasenta previa → lakukan stabilisasi awal dan dukungan → tentukan kebutuhan kolaborasi/rujukan → dokumentasi dan handover yang jelas.

F. Tabel Red Flags & Eskalasi

Perdarahan Kehamilan Trimester II-III Plasenta Previa-Solutio Plasenta-Penanganan Awal-Rujukan

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
Perdarahan pervaginam masif menunjukan adanya kondisi gawat darurat	Kehamilan trimester II-III dengan perdarahan perlu evaluasi lebih lanjut terhadap kemungkinan adanya plasenta previa atau solution plasenta	Lapor ke pembimbing/DPJP, evaluasi ulang lengkap, siapkan kolaborasi atau rujukan
Tidak adanya nyeri tekan pada bagian perut ibu	Curiga plasenta previa	Jangan menunda evaluasi; siapkan rujukan ke fasilitas yang lebih mampu
DJJ <110 x/menit atau >160 x/menit	Menunjukkan kemungkinan gawat janin	Reposisi ibu, nilai cepat kondisi ibu-janin, lapor segera, percepat eskalasi
Perdarahan pervaginam abnormal	Dapat mengarah pada komplikasi obstetri yang lebih serius	Nilai cepat kondisi ibu, tangani sesuai prioritas, rujuk segera
Keputusan rujukan sudah jelas tetapi proses tertunda	Menambah risiko ibu dan janin	Aktifkan rencana rujukan tanpa delay, lengkapi handover, komunikasikan ke keluarga dan fasilitas penerima

Form Checklist "Saya sudah bisa..."

Bab: Perdarahan Kehamilan Trimester II-III Plasenta Previa-Solutio Plasenta-Penanganan Awal- Rujukan

Nama Mahasiswa : _____

NIM : _____

Tanggal : _____

Tempat Praktik / Skill Lab : _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah bisa menjelaskan pengertian plasenta previa	☐	☐	_____
2	Saya sudah bisa menjelaskan bahwa perdarahan pada trimester II dan III dapat dicurigai adanya kasus plasenta previa atau solution plasenta	☐	☐	_____
3	Saya sudah bisa melakukan anamnesis terarah pada ibu hamil dengan kehamilan yang disertai perdarahan	☐	☐	_____
4	Saya sudah bisa menilai perdarahan pada Kehamilan secara klinis dari data yang tersedia	☐	☐	_____
5	Saya sudah bisa mengidentifikasi kemungkinan penyebab berdasarkan tanda dan gejala	☐	☐	_____
6	Saya sudah bisa mengenali tanda bahaya ibu pada kasus plasenta previa	☐	☐	_____
7	Saya sudah bisa mengenali tanda bahaya janin pada kasus plasenta previa	☐	☐	_____
8	Saya sudah bisa melakukan tindakan awal yang aman sesuai kewenangan bidan	☐	☐	_____
9	Saya sudah bisa memposisikan ibu dan memberikan dukungan yang tepat saat terjadi kegawatdaruratan kehamilan	☐	☐	_____
10	Saya sudah bisa menyiapkan pemantauan ibu dan janin secara cepat dan sistematis	☐	☐	_____
11	Saya sudah bisa menjelaskan kondisi ibu dan janin kepada keluarga dengan bahasa sederhana	☐	☐	_____
12	Saya sudah bisa menentukan kapan kasus harus dikolaborasikan atau dirujuk segera	☐	☐	_____
13	Saya sudah bisa menyiapkan rujukan dan handover singkat dengan jelas	☐	☐	_____
14	Saya sudah bisa mendokumentasikan temuan dan tindakan awal secara ringkas dan tepat	☐	☐	_____
15	Saya sudah bisa menjaga privasi, keselamatan, dan perilaku profesional selama tindakan	☐	☐	_____

Refleksi singkat mahasiswa:

G. Referensi

BKPK (2023). *Survey Kesehatan Indonesia 2023*. In Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Jauniaux, E., et al. (2022). *The risk factors associated with placenta previa: An umbrella review*. Placenta.

Brandstetter, M., et al. (2025). *Risk factors and pregnancy outcomes of placenta previa*. Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine.

Hu, H., et al. (2024). *Risk factors of severe postpartum hemorrhage in placenta previa*. BMC Pregnancy and Childbirth.

Kayem, G., et al. (2024). *Placenta previa and prior cesarean section*. European Journal of Obstetrics & Gynecology.

Sahu, S. A. (2024). *Maternal and perinatal outcomes in placenta previa*. Cureus.

Jauniaux, E., et al. (2022). *Pathophysiology of placenta previa and placenta accreta spectrum*. Placenta.

Silver, R. M. (2023). *Abnormal placentation and uterine scarring*. Obstetrics & Gynecology. Sahu, S. A. (2024). *Maternal and perinatal outcomes in placenta previa*. Cureus.

Hu, H., et al. (2024). *Risk factors and outcomes in placenta previa*. BMC Pregnancy and Childbirth.

Kayem, G., et al. (2024). *Placental implantation disorders*. European Journal of Obstetrics & Gynecology.

Jauniaux, E., et al. (2022). *Placenta previa: Epidemiology and clinical features*. Placenta.

Sahu, S. A. (2024). *Maternal and perinatal outcomes in placenta previa*. Cureus.

Hu, H., et al. (2024). *Clinical characteristics and outcomes of placenta previa*. BMC Pregnancy and Childbirth.

Kayem, G., et al. (2024). *Placenta previa and maternal outcomes*. European Journal of Obstetrics & Gynecology.

Silver, R. M. (2023). *Abnormal placentation and clinical implications*. Obstetrics & Gynecology.

Tikkanen, M. (2023). *Placental abruption: Diagnosis and management*. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica.

Ananth, C. V., et al. (2022). *Placental abruption and maternal outcomes*. Obstetrics & Gynecology.

Downes, K. L., et al. (2023). *Clinical and diagnostic features of placental abruption*. BJOG.

Oyelese, Y., & Ananth, C. V. (2022). *Placental abruption review*. Obstetrics & Gynecology.

Hladunewich, M. A., et al. (2024). *Placental abruption and hypertensive disorders*. American Journal of Obstetrics & Gynecology.

PROFIL PENULIS



Bdn. Imelda Diana Marsilia, SST., SKM., M.Keb. Lahir dibandung 03 Maret 1980, Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu menyelesaikan Pendidikan DIII Kebidanan di RSPAD Gatot Soebroto Jakarta tahun 2001, dilanjutkan Pendidikan DIV Kebidanan di Universitas Padjadjaran tahun 2003, kemudian melanjutkan S1 Kesehatan Masyarakat di STIKes Mitra Ria Husada Jakarta tahun 2012, menyeleseikan Pendidikan S2 Program studi Magister Kebidanan di Universitas Padjadjaran tahun 2013 dan menyelesaikan pendidikan profesi Bidan di STIKes Abdi Nusantara pada tahun 2023 serta saat ini penulis sedang menempuh Pendidikan S3 di Prodi DKM Universitas Diponegoro. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2001 penulis bekerja di TPMB Sri Pasar Minggu, kemudian tahun 2003 bekerja sebagai Dosen tidak tetap di Akbid Istara Nusantara dan Tahun 2004 bekerja di STIKes Mitra RIA Husada Jakarta sampai sekarang. Saat ini penulis mengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan Pada Kehamilan, Asuhan kebidanan pada Persalinan, Asuhan Kebidanan Neonatus Bayi Balita dan Anak Prasekolah, Asuhan Kebidanan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal, Asuhan Kebidanan Komplementer Evidance Based Midwifery. Penulis aktif dibeberapa organisasi, kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pengajaran dan mengembangkan diri melalui penulisan buku Kebidanan dan aktif dalam kegiatan seminar, *workshop* dan pelatihan serta publikasi artikel jurnal dalam jurnal Nasional terakreditasi. Penulis telah Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: imeldadiana33@gmail.com



Hikma, S.ST, SKM., M.,Kes., Lahir di Jongkang 12 Maret 1982. Menyelesaikan pendidikan D3 kebidanan di Akademi Kebidanan tahun 2004, Pendidikan D-4 Bidan Pendidik di Poltekkes Makassar tahun 2006. Menyelesaikan S1 Gizi & Kesehatan Reproduksi tahun 2010 di Universitas Muslim Indonesia. Pendidikan S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat (Manajemen Kesehatan Ibu dan Anak) tahun 2013 di Universitas Diponegoro Semarang. Posisi saat ini sebagai Dosen tetap di Program Studi S1 Kebidanan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail:hikmasita@med.unismuh.ac.id

PROFIL PENULIS



Bdn. Yulia Fatma Nasution, SST., M.Keb., Lahir di Pekan Selesai, 16 Agustus 1991. Penulis menyelesaikan pendidikan D-IV Bidan Pendidik di di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Helvetia Medan dan berkesempatan untuk bekerja sebagai dosen pengajar di Akademi Kebidanan Bina Husada Serang, Banten pada Prodi DIII Kebidanan sampai tahun 2015. Untuk memperluas pengetahuan dan wawasan, penulis melanjutkan pendidikan di Program Pascasarjana Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Padang, yang diselesaikannya pada tahun 2019. Pada tahun 2022 sampai saat ini penulis bekerja sebagai dosen pengajar di Prodi Kebidanan Program Sarjana dan Pendidikan Profesi Bidan STIKes FLORA Medan. Kemudian melanjutkan Pendidikan Profesi Bidan di STIKes SENIOR Medan selesai pada tahun 2024. Beberapa buku yang sudah diterbitkan oleh penulis pada Tahun 2024 dengan judul buku Pelayanan Komplementer dalam Asuhan Kebidanan. Pada Tahun 2026 dengan judul Kumpulan Soal UKOM Terstandar nasional Berbasis Kasus dan Pembahasan mendalam, dan Buku dengan Judul Terapi Komplementer pada Persalinan.
Penulis aktif dibeberapa organisasi, kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pengajaran dan mengembangkan diri melalui penulisan buku Kebidanan dan aktif dalam kegiatan seminar, *workshop* dan pelatihan serta publikasi artikel jurnal dalam jurnal Nasional terakreditasi. Penulis telah Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: yuliafatmanst@gmail.com



Rya Anastasya Siregar, SST., M.Kes., Penulis lahir di kota Padangsidimpuan Tanggal 02 Januari 1984. Penulis menyelesaikan pendidikan DIII kebidana di Politeknik Kesehatan Medan tahun 2007. DIV Bidan Pendidik di Universitas Sumatera Utara tahun 2009. S2 Kesehatan Masyarakat di STIKES Helvetia Medan tahun 2015. Penulis pernah bekerja sebagai stap pengajar di STIKES Flora Medan. AKBID Bakti Indonesia. Saat ini penulis bekerja di Universitas Aufa Royhan Padangsidimpuan sebagai dosen tetap di Prodi DIII Kebidanan. Penulis dapat dihubugi melalui: e-mail: ryaanastasya3@gmail.com

PROFIL PENULIS



Ika Lestari Salim, S.ST., M.Keb., Lahir di Raha 16 November 1991, Pendidikan Tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu menyelesaikan Pendidikan DIII Kebidanan Di STIK Avicenna tahun 2012, dilanjutkan Pendidikan DIV Bidan Pendidik di STIKes 'Aisyiyah Yogyakarta tahun 2014, kemudian melanjutkan S2 Kebidanan di Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin tahun 2018. Riwayat pekerjaan diawali di BPM Sitti Samsah pada tahun 2012, kemudian menjadi Bidan sukarela di Puskesmas Polinggona Kolaka pada Tahun 2012, dan tahun 2014 bekerja di Akademi Kebidanan Buton Raya yang saat ini telah menjadi Institut Kesehatan dan Teknologi Buton Raya sampai sekarang, serta menjadi bidan sukarela di Puskemas Lakologou dari tahun 2020 sampai sekarang. Saat ini penulis mengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan pada Kehamilan, Asuhan Kebidanan pada Ibu Nifas dan Menyusui dan mata kuliah Komunikasi dalam Praktik Kebidanan. Penulis aktif dibeberapa organisasi, kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pengajaran dan mengembangan diri melalui penulisan buku kebidanan dan aktif dalam kegiatan seminar, workshop dan pelatihan serta publikasi artikel jurnal dalam jurnal Nasional terakreditasi. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: ikalestarimaryam@gmail.com

Sinopsis

Buku *Komplikasi Kehamilan: Hipertensi, Perdarahan, Infeksi, dan Anemia* disusun sebagai sumber pembelajaran yang membahas berbagai kondisi komplikasi dalam kehamilan yang berisiko terhadap keselamatan ibu dan janin. Buku ini memberikan pemahaman mengenai pentingnya deteksi dini, pencegahan, pengkajian yang tepat, penanganan awal, serta rujukan yang cepat dan sesuai dalam menghadapi komplikasi kehamilan.

Pembahasan diawali dengan konsep dasar komplikasi kehamilan, meliputi pengertian, faktor risiko, tanda bahaya, prinsip deteksi dini, upaya pencegahan, serta keselamatan ibu dan janin. Materi ini menjadi dasar penting bagi pembaca untuk memahami bahwa komplikasi kehamilan dapat terjadi secara tiba-tiba dan memerlukan kewaspadaan tinggi dari tenaga kesehatan.

Selanjutnya, buku ini menguraikan pengkajian ibu hamil dengan komplikasi melalui anamnesis terfokus, pemeriksaan fisik, serta pemeriksaan penunjang yang relevan. Pengkajian yang sistematis sangat diperlukan agar tenaga kesehatan mampu mengenali masalah secara cepat, menentukan prioritas tindakan, dan mengambil keputusan klinis yang tepat sesuai kondisi ibu hamil.

Buku ini juga membahas gangguan hipertensi dalam kehamilan, termasuk definisi, klasifikasi, kriteria diagnostik, pemantauan tekanan darah, pemantauan kondisi ibu dan janin, serta prinsip penanganan awal. Gangguan hipertensi kehamilan merupakan salah satu komplikasi serius yang perlu dikenali sejak dini karena dapat berkembang menjadi kondisi yang mengancam jiwa.

Selain itu, buku ini mengulas perdarahan pada trimester I, seperti abortus, kehamilan ektopik, dan mola hidatidosa. Pembahasan mencakup tanda dan gejala, faktor risiko, penanganan awal, serta indikasi rujukan. Materi dilanjutkan dengan perdarahan trimester II–III, seperti plasenta previa dan solusio plasenta, yang termasuk kegawatdaruratan obstetri dan membutuhkan penanganan cepat, tepat, serta koordinasi rujukan yang baik.

Melalui penyajian materi yang sistematis dan aplikatif, buku ini diharapkan dapat membantu mahasiswa kebidanan, dosen, bidan, serta tenaga kesehatan lainnya dalam memahami dan menerapkan prinsip pelayanan kebidanan pada ibu hamil dengan komplikasi. Buku ini juga menekankan pentingnya keselamatan pasien, komunikasi yang efektif, kolaborasi antar tenaga kesehatan, dan pengambilan keputusan yang berorientasi pada keselamatan ibu dan janin.

Dengan hadirnya buku ini, pembaca diharapkan mampu meningkatkan kemampuan dalam mengenali tanda bahaya kehamilan, melakukan pengkajian secara tepat, memberikan penanganan awal yang aman, serta melakukan rujukan sesuai

kebutuhan. Buku ini menjadi salah satu kontribusi dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak, khususnya dalam pencegahan dan penanganan komplikasi kehamilan.

Buku Komplikasi Kehamilan: Hipertensi, Perdarahan, Infeksi, dan Anemia disusun sebagai sumber pembelajaran yang membahas berbagai kondisi komplikasi dalam kehamilan yang berisiko terhadap keselamatan ibu dan janin. Buku ini memberikan pemahaman mengenai pentingnya deteksi dini, pencegahan, pengkajian yang tepat, penanganan awal, serta rujukan yang cepat dan sesuai dalam menghadapi komplikasi kehamilan.

Pembahasan diawali dengan konsep dasar komplikasi kehamilan, meliputi pengertian, faktor risiko, tanda bahaya, prinsip deteksi dini, upaya pencegahan, serta keselamatan ibu dan janin. Materi ini menjadi dasar penting bagi pembaca untuk memahami bahwa komplikasi kehamilan dapat terjadi secara tiba-tiba dan memerlukan kewaspadaan tinggi dari tenaga kesehatan.

Selanjutnya, buku ini menguraikan pengkajian ibu hamil dengan komplikasi melalui anamnesis terfokus, pemeriksaan fisik, serta pemeriksaan penunjang yang relevan. Pengkajian yang sistematis sangat diperlukan agar tenaga kesehatan mampu mengenali masalah secara cepat, menentukan prioritas tindakan, dan mengambil keputusan klinis yang tepat sesuai kondisi ibu hamil.

Buku ini juga membahas gangguan hipertensi dalam kehamilan, termasuk definisi, klasifikasi, kriteria diagnostik, pemantauan tekanan darah, pemantauan kondisi ibu dan janin, serta prinsip penanganan awal. Gangguan hipertensi kehamilan merupakan salah satu komplikasi serius yang perlu dikenali sejak dini karena dapat berkembang menjadi kondisi yang mengancam jiwa.

Selain itu, buku ini mengulas perdarahan pada trimester I, seperti abortus, kehamilan ektopik, dan mola hidatidosa. Pembahasan mencakup tanda dan gejala, faktor risiko, penanganan awal, serta indikasi rujukan. Materi dilanjutkan dengan perdarahan trimester II–III, seperti plasenta previa dan solusio plasenta, yang termasuk kegawatdaruratan obstetri dan membutuhkan penanganan cepat, tepat, serta koordinasi rujukan yang baik.

Melalui penyajian materi yang sistematis dan aplikatif, buku ini diharapkan dapat membantu mahasiswa kebidanan, dosen, bidan, serta tenaga kesehatan lainnya dalam memahami dan menerapkan prinsip pelayanan kebidanan pada ibu hamil dengan komplikasi. Buku ini juga menekankan pentingnya keselamatan pasien, komunikasi yang efektif, kolaborasi antar tenaga kesehatan, dan pengambilan keputusan yang berorientasi pada keselamatan ibu dan janin.

Dengan hadirnya buku ini, pembaca diharapkan mampu meningkatkan kemampuan dalam mengenali tanda bahaya kehamilan, melakukan pengkajian secara tepat, memberikan penanganan awal yang aman, serta melakukan rujukan sesuai kebutuhan. Buku ini menjadi salah satu kontribusi dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak, khususnya dalam pencegahan dan penanganan komplikasi kehamilan.

Penerbit:
PT OPTIMAL UNTUK NEGERI
Kencana Tower Lt. Mezzanine
Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005
Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

ISBN 978-634-7927-95-8 (PDF)
9 786347 927958